DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 1

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Mots-clés : Santé publique, Promotion de la santé, Politiques nutritionnelles

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 1 · La santé publique et la promotion de la santé en nutrition · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 96 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 5 à 100

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 10 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 101 à 110

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 93 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 111 à 203

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 27 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 204 à 230

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours 5

1.1 Compétences mobilisées 7
1.2 Croisement référentiel × précisions × indications 8
1.3 Cours 10
1.4 Approfondissements 74
1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 79
1.7 L'essentiel à retenir 81
1.8 Entraînement 83
1.9 Glossaire 96
1.10 Renvois bibliographiques par notion 98
1.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils 101

Fiche de révision du chapitre 1 103
1. Les définitions à savoir par cœur 103
2. Les classifications à ne pas confondre 104
3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3 104
4. Les dates et textes à jour (octobre 2026) 104
5. Chiffres-clés 105
6. Les pièges classiques 105
7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases 105
8. Auto-test (réponses en bas de page) 105
9. Flashcards à découper 106
Fiches-outils du chapitre 1 106
O1.1 – Qualifier mon action 107
O1.2 – Portrait express de mon territoire 107
O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire 108
O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur 108
O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa 109
O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public 109
O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles 110
O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support 110

3 · Cahier d'exercices 111

Cahier d'exercices – Chapitre 1 114
Partie 1 – Les concepts de santé 115
Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 126
Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection 138
Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique 148
Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 159
Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale 170
Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique 181
Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet 191
Bilan : grille d'auto-évaluation 203

4 · Annales E5 204

Cahier d'annales E5 – chapitre 1 206
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 207
Partie II – Les corrigés détaillés 215
Grille d'auto-évaluation 230

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique | Promotion de la santé | Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

1.1 Compétences mobilisées 7

1.2 Croisement référentiel × précisions × indications 8

1.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 8

1.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 9

1.3 Cours 10

1.3.1 Les concepts de santé : du modèle biomédical à « Une seule santé » 10

1.3.2 La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 16

1.3.3 Problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection 22

1.3.4 Les modes d'intervention en santé publique 24

1.3.5 Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 35

1.3.6 Les politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre et déclinaison territoriale 43

1.3.7 Les politiques nutritionnelles de santé publique 49

1.3.8 Le diététicien-nutritionniste en santé publique 56

1.3.9 Fil rouge : le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » du centre social des Tilleuls 58

1.4 Approfondissements 74

1.4.1 Les données probantes en promotion de la santé 74

1.4.2 Les théories du changement de comportement : premier aperçu 75

1.4.3 Le débat sur les aliments ultra-transformés 75

1.4.4 Promotion de la santé et non-stigmatisation du poids 76

1.4.5 Santé publique, alimentation et climat 77

1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78

1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 79

Méthode 1 – Présenter le cadre de son action en deux minutes (oral E5) 80

Méthode 2 – Lire de façon critique un document de santé publique 81

1.7 L'essentiel à retenir 81

1.8 Entraînement 83

1.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 83

1.8.2 Exercices 85

1.8.3 Questions de réflexion 90

1.8.4 Étude de cas 92

1.8.5 Mises en situation express 92

1.9 Glossaire 96

1.10 Renvois bibliographiques par notion 98

1.12 Bibliographie numérotée 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la santé selon différents modèles (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial, santé globale, « Une seule santé / One Health ») et expliquer leurs conséquences pour l'action du diététicien ;
- définir la santé publique, ses missions et son approche populationnelle, et situer les activités du diététicien dans le cadre institutionnel et politique (objectif du guide 2025) ;
- distinguer problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection ;
- distinguer les modes d'intervention en santé publique : surveillance et veille sanitaire, promotion de la santé, prévention (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ; universelle, sélective, indiquée), éducation pour la santé (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle), et les différencier de l'éducation thérapeutique du patient (BC1) ;
- citer les cinq axes et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa (1986) et les illustrer en nutrition ;
- identifier les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition, et ceux qui recueillent et produisent des données ;
- expliquer comment une politique publique de santé est élaborée, pilotée et mise en œuvre, et comment elle est déclinée sur un territoire (ARS, PRS, CLS, PAT) ;
- présenter les politiques nutritionnelles en vigueur au 26 octobre 2026 (SNANC 2025-2030, PNNS 5 2026-2030, PNA 4, EGalim, Nutri-Score, repères alimentaires) et leur histoire ;
- relier ces notions à un projet réel (cas fil rouge) en utilisant les fiches-outils F1 à F14.

1.1 Compétences mobilisées

Ce chapitre est le **socle** de tout le BC3 : il donne le vocabulaire et le cadre institutionnel dans lesquels s'inscrivent les autres chapitres.

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Concepts, modes d'intervention, politiques et acteurs pour poser un diagnostic, justifier des priorités et des objectifs, choisir le bon type d'action	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs adaptés au contexte ; règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées
C3.2	Inscrire l'atelier culinaire dans un projet d'éducation pour la santé (éducation alimentaire et sensorielle)	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés
C3.3	Connaître les organismes producteurs de données et les grandes enquêtes	Contexte et problématique de l'étude identifiés
C3.4	Identifier les textes de référence à jour (SNANC, PNNS 5, PNA 4) et les sources institutionnelles fiables	Sources d'informations fiables repérées et connues
C3.5	Adapter le discours au public selon la démarche de promotion de la santé (pouvoir d'agir, non-stigmatisation)	Supports et contenus adaptés au public

1.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (référentiel et guide)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Concepts de santé	Définir la santé (OMS 1946) ; comparer les modèles biomédical, biopsychosocial, global ; expliquer « Une seule santé »	Citer la définition de l'OMS mot pour mot ; pas d'histoire détaillée de la médecine
Santé publique : définition et missions	Définir la santé publique ; citer ses missions ; expliquer l'approche populationnelle	Connaître la définition de Winslow et celle du Code de la santé publique (art. L. 1411-1)
Problèmes de santé : danger, risque, facteur de risque	Distinguer ces notions et les illustrer en nutrition	Les déterminants et leurs niveaux sont développés au chapitre 2
Modes d'intervention : surveillance, veille sanitaire, promotion, prévention, éducation pour la santé (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle)	Distinguer et illustrer chaque mode ; classer une action ; distinguer éducation pour la santé et ETP	Classifications de l'OMS (1948) et de Gordon (1983) exigibles ; Charte d'Ottawa : 5 axes + 3 stratégies
Organismes de recueil et de production de données	Citer les principaux organismes et leur rôle	Les études elles-mêmes (INCA, ESTEBAN, NutriNet-Santé) sont détaillées au chapitre 17
Politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre	Décrire le circuit d'une politique (loi, stratégie, plan, programme)	Pas de droit constitutionnel ; connaître SNS, ARS, PRS, CLS
Politiques nutritionnelles de santé publique	Présenter le PNNS (historique, PNNS 5), la SNANC, le PNA, EGalim, le Nutri-Score, les repères	Le guide 2025 recommande de s'appuyer sur le PNNS ; utiliser la version en vigueur (PNNS 5)
Déclinaison territoriale	Expliquer le rôle de l'ARS, du PRS, des CLS, des PAT, des contrats de ville	Savoir où trouver ces documents pour son lieu de stage

1.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Enjeux de santé publique ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60). Toutes les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des textes au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 1.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 60	Concepts de santé ; danger, risque, facteur de risque ; mesure de l'état de santé ; santé publique ; modes d'intervention ; organismes producteurs de données ; politiques de santé et politiques nutritionnelles (s'appuyer sur le PNNS) ; déclinaison territoriale	1.3.1 à 1.3.7, dans l'ordre du guide (voir le tableau 1.2) ; définitions et calculs des indicateurs et des déterminants au chapitre 2
Référentiel, C3.1	Analyse et diagnostic de situation ; priorités et objectifs adaptés ; règles éthiques, juridiques et déontologiques	1.3.9 (fil rouge) ; 1.6 ; méthodes de présentation du cadre
Référentiel, C3.4	Sources d'informations fiables repérées et connues	1.3.5, 1.3.7 et 1.10 (sources datées, textes en vigueur)
Référentiel, C3.5	Supports et contenus adaptés au public	1.4.4 (non-stigmatisation du poids) ; 1.3.4 (approches éducatives)
Référentiel, activité 3.1	Contexte institutionnel ; données sur le territoire et les déterminants	1.3.5 et 1.3.6 ; le détail des déterminants est au chapitre 2

1.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport aux fascicules du CNED qui traitent de la santé publique :

- *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022), module 1, séquences 1 « Notion de santé » (p. 3 à 7), 2 « Outils, ressources et méthodologies en santé publique » (p. 8 à 12) et 3 « Politique de santé, pilotage et mise en œuvre » (p. 13 à 16) ;
- *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 3 « Santé, politique de santé, système de santé (1re partie) » (p. 25 à 30), pour le passage sur le Nutri-Score.

Toutes les notions de ces passages sont reprises. Les autres parties de ces séquences sont traitées aux chapitres 2, 3, 5 et 17.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S1 §1 (p. 3)	Définition de la santé de l'OMS (1946) ; exemples de l'alimentation et du sport ; santé « notion relative », « état dynamique »	1.3.1 (définition, critiques, santé relative et dynamique)
Essentiels M1 S1 §2 (p. 3)	Définition de la santé publique attribuée à l'OMS (1952) et cinq moyens d'action collective	1.3.2 (définition de Winslow et missions)
Essentiels M1 S1 §3 (p. 4)	Évolution historique de la santé publique, de l'Antiquité au XXIe siècle	1.3.2 (brève histoire de la santé publique, frise)
Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)	« Risque sanitaire » ; veille et sécurité sanitaire ; prévention primaire, secondaire, tertiaire (OMS) ; promotion de la santé ; éducation pour la santé et ETP ; restauration de la santé	1.3.3 (risque) ; 1.3.4 (modes d'intervention, sécurité sanitaire et restauration de la santé, ETP)
Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8)	Organismes en charge des données : INDS et SNDS, ANSES, EFSA	1.3.5 (ANSES, EFSA) ; 1.3.6 (données qui éclairent les politiques, Plateforme des données de santé)
Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14)	Politique de santé publique ; quatre types d'acteurs (consultatifs, décideurs, opérationnels, financeurs) ; priorité sanitaire, programme, planification	1.3.5 (typologie des acteurs) ; 1.3.6 (priorités, programmes et planification)
Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15)	Durée des plans ; niveaux régional, national, européen, mondial ; ARS ; HCSP, CNS, CNA	1.3.5 (acteurs par niveau) ; 1.3.6 (PRS, déclinaison territoriale)
Essentiels M1 S3 §1.5 (p. 15)	Démocratie sanitaire : loi du 4 mars 2002, droits individuels et collectifs	1.3.5 (la démocratie sanitaire : la place des usagers)
Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 15 et 16)	L'OMS, fondée en 1948 : missions	1.3.5 (niveau international)
Essentiels M1 S3 §2 et §3 (p. 16)	Stratégie nationale de santé 2018-2022 ; planification sanitaire ; rôle de l'État et de l'ARS	1.3.6 (stratégie nationale de santé, planification descendante et ascendante)
Synthèse 1re année M3 S1 §2 (p. 29)	Information nutritionnelle : étiquetage (règlement de 2011) et Nutri-Score prévu par la loi de 2016	1.3.7 (frise des politiques nutritionnelles, Nutri-Score)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Définition de la santé** (p. 3) : le fascicule écrit « bien-être physique, social et mental » et « l'absence de maladie ». Le texte exact de la Constitution de l'OMS est : « un état de complet bien-être physique,

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». À l'examen, on cite le texte exact.

- **Définition de la santé publique** (p. 3) : elle est de **Charles-Edward A. Winslow (1920)** ; le comité d'experts de l'OMS l'a reprise en 1952. On la présente donc comme la définition de Winslow, reprise par l'OMS.
- **Veille sanitaire** (p. 5) : elle n'est pas « propre à chaque département ». Elle est organisée au niveau national par **Santé publique France**, avec des cellules régionales, et les ARS reçoivent les signalements.
- **Prévention primaire** (p. 5) : elle ne se limite pas à « informer la population ». Elle agit aussi sur l'environnement (offre alimentaire, réglementation) et sur les compétences des personnes.
- **INDS et CNAMTS** (p. 8) : l'Institut national des données de santé a été remplacé en 2019 par la **Plateforme des données de santé (Health Data Hub)** (loi du 24 juillet 2019). La CNAMTS s'appelle aujourd'hui la **Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)**.
- **HCSP** (p. 15) : le sigle désigne le **Haut Conseil de la santé publique**, créé par la loi du 9 août 2004 (et non le « Haut Comité »). Il n'existe pas de « CNSP » : seule la **Conférence nationale de santé (CNS)** existe au niveau national.
- **CRAS** (p. 14) : depuis la loi HPST de 2009, l'instance régionale est la **Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA)**. Les « territoires de santé » sont devenus, avec la loi du 26 janvier 2016, les **territoires de démocratie sanitaire**.
- **Stratégie nationale de santé** (p. 16) : la SNS 2018-2022 reste la dernière adoptée. Le projet de **SNS 2023-2033**, soumis à consultation à l'automne 2023, n'était **pas encore adopté** selon une réponse du ministère publiée le 12 mai 2026. Les textes nutritionnels en vigueur sont la **SNANC 2025-2030** (publiée le 11 février 2026), le **PNNS 5 (2026-2030)** et le **PNA 4 (2026-2030)**, lancés le 8 avril 2026.
- **Nom du ministère** (p. 16) : il change avec les gouvernements ; on écrit « ministère chargé de la santé ».
- **Nutri-Score** (1re année, p. 29) : la loi du 26 janvier 2016 a prévu un logo nutritionnel facultatif ; le **Nutri-Score** a été choisi par l'**arrêté du 31 octobre 2017**, et son algorithme a été révisé par l'**arrêté du 14 mars 2025**.

1.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

1.3.1 Les concepts de santé : du modèle biomédical à « Une seule santé »

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §1 (p. 3)

Le mot « santé » paraît simple ; il recouvre pourtant des conceptions très différentes, qui changent la façon d'agir. Un diététicien qui pense que la santé est seulement « l'absence de maladie » limitera son action aux personnes malades ; s'il considère que la santé est une **ressource** qui dépend des conditions de vie, il agira aussi sur l'environnement alimentaire d'un quartier, sur les menus d'une école ou sur le pouvoir d'agir des habitants.

Le modèle biomédical

Dominant du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, le **modèle biomédical** définit la santé de façon **négative** : être en bonne santé, c'est ne pas être malade. La maladie est expliquée par une cause biologique (microbe, lésion d'organe), diagnostiquée et traitée par le médecin. Ce modèle a permis des progrès considérables (vaccins, antibiotiques, chirurgie), mais il ignore le vécu de la personne et les causes sociales des maladies. Appliqué à la nutrition, il conduit à ne voir dans l'obésité qu'un déséquilibre entre apports et dépenses énergétiques, sans tenir compte du revenu, du stress, de l'offre alimentaire ou du marketing.

La définition de l'Organisation mondiale de la santé (1946)

Définition – La santé selon l'OMS

> « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, adoptée par la Conférence internationale de la santé à New York (19 juin – 22 juillet 1946), signée le 22 juillet 1946 et entrée en vigueur le 7 avril 1948 (date devenue la Journée mondiale de la santé). Cette définition n'a pas été modifiée depuis.

Cette définition est **révolutionnaire** pour trois raisons : elle est **positive** (la santé est un état de bien-être, pas seulement l'absence de maladie) ; elle est **multidimensionnelle** (physique, mentale, sociale) ; elle fait de la santé un **droit** : la Constitution affirme que « la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

Attention – Les critiques de la définition de l'OMS

- Le « complet » bien-être est un **idéal** presque inatteignable : avec cette définition, presque personne n'est en bonne santé, notamment les personnes vivant avec une maladie chronique (diabète, maladie cœliaque) qui peuvent pourtant mener une vie pleinement satisfaisante.
- Elle décrit un **état** figé, alors que la santé est un **équilibre dynamique**.
- Elle ne dit rien de la **capacité d'adaptation** de la personne. D'où la proposition de Machteld Huber et coll. (*BMJ*, 2011) : la santé comme « capacité à s'adapter et à se prendre en charge face aux défis sociaux, physiques et émotionnels ».

Le modèle biopsychosocial et la santé comme ressource

En 1977, le psychiatre George Engel propose le **modèle biopsychosocial** : la santé et la maladie résultent de l'interaction de facteurs **biologiques** (génétique, physiologie), **psychologiques** (émotions, représentations, stress) et **sociaux** (revenu, travail, culture, entourage). En 1986, la **Charte d'Ottawa** prolonge cette vision : la santé est « une **ressource de la vie quotidienne**, et non le but de la vie » ; c'est « un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et personnelles, et les capacités physiques ». Pour l'atteindre, il faut des **conditions préalables** : la paix, un abri, l'éducation, la nourriture, un revenu, un écosystème stable, des ressources durables, la justice sociale et l'équité.

Lien diététique – Ce que cela change pour le diététicien

Dans le modèle biopsychosocial, une consultation ou un atelier ne peut pas se limiter à « donner des conseils ». Une mère de famille qui sert des boissons sucrées au goûter n'ignore pas forcément qu'elles sont trop sucrées : son choix peut s'expliquer par le prix, la demande des enfants, la publicité, la peur que l'enfant « ne mange rien », ou une habitude culturelle. Le diététicien doit **explorer ces dimensions** avant de proposer une action (chapitres 3 et 4).

Santé perçue, santé objective, santé positive

On distingue la **santé objective**, mesurée par des indicateurs (IMC, glycémie, mortalité) et la **santé perçue**, déclarée par la personne (« Comment jugez-vous votre état de santé ? »). La santé perçue est un indicateur utilisé en santé publique (Baromètre de Santé publique France, enquête européenne EHIS) : elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux. La **santé positive** (bien-être, qualité de vie, santé mentale positive) est valorisée par la promotion de la santé.

La santé globale et l'approche « Une seule santé / One Health »

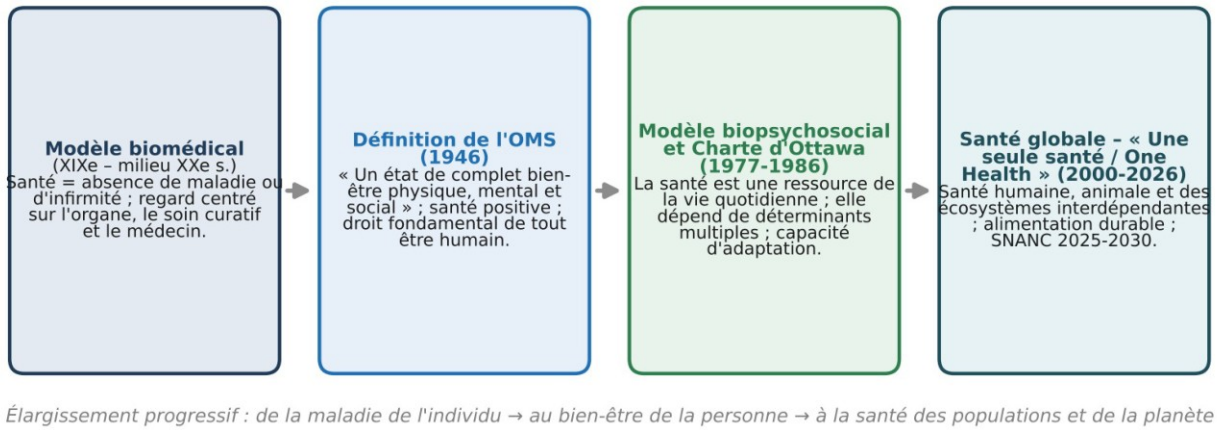


Figure 1.1 – Évolution des concepts de santé

Comprendre le schéma – Figure 1.1

1. Modèle biomédical : la santé est définie négativement, par l'absence de maladie ; l'action est curative et individuelle.

2. Définition de l'OMS (1946) : la santé devient positive (bien-être), multidimensionnelle (physique, mentale, sociale) et un droit fondamental.

3. Modèle biopsychosocial (Engel, 1977) et Charte d'Ottawa (1986) : la santé est une ressource de la vie quotidienne, influencée par de nombreux déterminants ; l'action vise aussi les conditions de vie.

4. Santé globale et « Une seule santé » : la santé humaine est indissociable de la santé animale et de celle des écosystèmes ; l'alimentation durable est au carrefour des trois.

5. La flèche du bas résume le mouvement : on passe de l'individu malade à la population, puis à la planète.

Le concept **« Une seule santé » (One Health)** est né au début des années 2000 (principes de Manhattan, 2004) à partir d'un constat : environ 60 % des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale (zoonoses), la résistance aux antibiotiques circule entre élevage, environnement et humains, et le changement climatique modifie la production alimentaire. En 2022, l'OMS, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), réunis en **« Quadripartite »**, ont adopté un plan d'action conjoint One Health (2022-2026) et une définition commune.

Définition – Une seule santé (One Health) – définition du panel d'experts OHHLEP, 2021, adoptée par la Quadripartite « Une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large (y compris les écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante. »

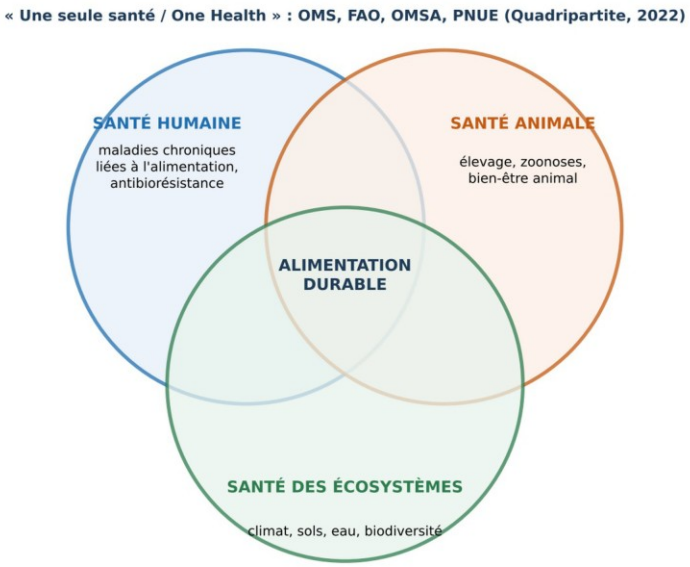


Figure 1.2 – « Une seule santé » : l'alimentation durable au carrefour de trois santés

Comprendre le schéma – Figure 1.2

1. Le cercle bleu représente la **santé humaine** : maladies chroniques liées à l'alimentation (obésité, diabète, cancers), carences, résistance aux antibiotiques.
2. Le cercle orange représente la **santé animale** : conditions d'élevage, bien-être animal, maladies transmissibles à l'humain (zoonoses), usage des antibiotiques en élevage.
3. Le cercle vert représente la **santé des écosystèmes** : climat, qualité des sols et de l'eau, biodiversité, contamination par les pesticides.
4. Les zones de chevauchement montrent les **interdépendances** ; au centre, l'**alimentation durable** agit sur les trois à la fois (par exemple, manger plus de légumineuses et moins de viande améliore la santé humaine, réduit les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les élevages).

Le guide d'accompagnement du BTS (2025) place explicitement **toute intervention en santé publique en nutrition** dans cette approche pluridisciplinaire de l'**alimentation globale « Une seule santé »**. En France, la **SNANC 2025-2030** relie santé publique, transition écologique et souveraineté alimentaire, et le PNNS 5 et le PNA 4 ont été lancés le 8 avril 2026, à l'occasion du **One Health Summit** organisé à Lyon du 5 au 7 avril 2026.

Exemple – Une action de nutrition lue avec les lunettes « Une seule santé »

Une école élémentaire remplace une fois par semaine le plat carné par un plat à base de légumineuses (obligation de la loi EGalim d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire). **Santé humaine** : plus de fibres, moins d'acides gras saturés. **Santé des écosystèmes** : moins d'émissions de gaz à effet de serre (les légumineuses fixent l'azote de l'air et émettent beaucoup moins que la viande de bœuf). **Santé animale** : moindre pression sur l'élevage intensif. Le rôle du diététicien : garantir l'équilibre nutritionnel (apport en protéines, en fer), l'acceptabilité (recettes appréciées des enfants) et la lutte contre le gaspillage.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1

Classez chacune de ces affirmations dans le modèle qu'elle illustre (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial/Ottawa, One Health) : **a)** « Monsieur D. est en bonne santé puisque ses analyses sont normales. » **b)** « La réduction des antibiotiques en élevage protège aussi l'efficacité des traitements chez l'humain. » **c)** « Madame K. a un diabète bien équilibré, travaille, fait du sport et se sent bien : elle s'estime en bonne santé. » **d)** « Pour être en bonne santé, il faut un logement, un revenu et l'accès à une alimentation de qualité. »

Corrigé

a) Modèle biomédical : la santé est réduite à des résultats biologiques normaux, sans prise en compte du vécu. **b) One Health** : lien entre santé animale (usage d'antibiotiques en élevage), environnement (diffusion des bactéries résistantes) et santé humaine. **c) Modèle biopsychosocial / santé comme capacité d'adaptation** : malgré une maladie chronique, la personne a une bonne santé perçue et fonctionnelle ; la définition de l'OMS (« complet » bien-être) l'exclurait, ce qui montre sa limite. **d) Charte d'Ottawa** : ce sont les « conditions préalables à la santé » (abri, revenu, nourriture…).

La santé, une notion relative et dynamique

Aucune définition ne suffit à dire ce qu'est la santé pour chacun. Les cours du CNED et les manuels de santé publique insistent sur trois idées que le jury attend dans un exposé.

1. La santé est une notion individuelle. Chacun juge sa santé selon ses connaissances, ses expériences, son âge, son sexe et ses attentes. Une personne de 80 ans qui marche avec une canne peut se dire « en bonne santé » ; un sportif de 25 ans peut se dire « en mauvaise santé » après une entorse.

2. La santé est une notion variable. Elle change selon les époques, les cultures, les groupes sociaux et le niveau de développement du pays. Au XIXe siècle, être « bien en chair » était un signe de santé et d'aisance ; aujourd'hui, le surpoids est un facteur de risque. Dans certains groupes, une maladie chronique bien équilibrée n'empêche pas de se dire en bonne santé.

3. La santé est un état dynamique. C'est un équilibre instable et temporaire entre la personne et son environnement. Il faut le reconquérir sans cesse : une rupture (perte d'emploi, deuil, déménagement) peut déséquilibrer l'alimentation, le sommeil et la santé mentale en quelques semaines.

Définition – Deux formules célèbres à connaître

René Leriche (chirurgien, 1936) : « La santé, c'est la vie dans le silence des organes. » C'est une vision biomédicale : on est en bonne santé tant qu'on ne ressent rien.

Georges Canguilhem (philosophe, « Le normal et le pathologique », 1943) : être en bonne santé, c'est pouvoir **tomber malade et s'en relever** ; c'est la capacité de s'adapter et de créer de nouvelles normes de vie. C'est une vision dynamique, proche de la santé « ressource » de la Charte d'Ottawa.

Attention – Une limite de la définition de l'OMS

La définition de 1946 parle d'un « état de complet bien-être ». Ce mot « complet » est souvent critiqué : presque personne n'est en « complet bien-être », et la définition peut faire de chacun un malade. Les approches récentes (santé positive, santé comme capacité d'adaptation) répondent à cette critique. Savoir citer cette limite montre au jury une **analyse critique** (C3.4).

Exemple – La même personne, trois regards sur sa santé

Mme Diallo, 58 ans, a un diabète de type 2 équilibré par un traitement. **Regard biomédical** : elle est malade (pathologie chronique). **Regard de l'OMS** : son bien-être social est bon (associative, entourée), son bien-être mental aussi ; seul le volet physique est touché. **Regard dynamique** : elle a adapté son alimentation et marche chaque jour ; elle se dit « en forme ». Pour le diététicien en santé publique, ce regard dynamique est le plus utile : il s'appuie sur les **ressources** de la personne et non sur ses manques.

Mesurer l'état de santé d'une population : premiers repères

Le guide d'accompagnement 2025 place la **mesure de l'état de santé** dans les « enjeux de santé publique ». Pour savoir si une population est en bonne santé, on utilise des **indicateurs** : des données chiffrées, calculées à date

régulière, qui rendent les situations comparables (natalité, mortalité, mortalité infantile, espérance de vie, prévalence, incidence, indice de développement humain). Ils sont produits par l'Insee, la Drees, Santé publique France ou les observatoires régionaux de la santé. Leurs définitions et leurs calculs sont présentés au chapitre 2.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1 bis – Santé relative

Citez les trois caractéristiques qui font de la santé une notion relative et illustrez chacune par un exemple lié à l'alimentation.

Corrigé – Exercice 1.1 bis

Individuelle : une personne âgée qui mange avec plaisir malgré une dentition fragile se dit en bonne santé. **Variable** : la minceur valorisée aujourd'hui ne l'était pas au XIXe siècle. **Dynamique** : un étudiant qui quitte le foyer familial peut voir son alimentation se dégrader en quelques semaines, puis la rééquilibrer.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.1 – Les concepts de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez la définition de la santé de l'OMS (1946) et citez une critique de cette définition.
2. Associez chaque modèle à sa date : modèle biopsychosocial ; Charte d'Ottawa ; constitution de l'OMS. Dates : 1946, 1977, 1986.
3. Vrai ou faux : « Pour le modèle biomédical, une personne diabétique bien équilibrée est en bonne santé. » Justifiez.
4. Expliquez en deux phrases pourquoi la santé est une notion relative et dynamique.
5. Citez les trois santés reliées par l'approche « Une seule santé » et donnez un exemple en alimentation.
6. Citez trois indicateurs de l'état de santé d'une population et deux organismes qui les produisent.

Corrigé – Point d'étape 1.3.1

1. « Un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. » Critique : le mot « complet » rend l'objectif presque inatteignable ; la définition est statique.
2. Modèle biopsychosocial : 1977 (Engel) ; Charte d'Ottawa : 1986 ; constitution de l'OMS : 1946 (en vigueur en 1948).
3. Faux : pour le modèle biomédical, la santé est l'absence de maladie ; la personne a une maladie chronique, elle est donc « malade ». Seules les approches globales et dynamiques permettent de dire qu'elle se sent en bonne santé.
4. Relative : elle dépend de chaque personne (âge, expérience, attentes) et varie selon les époques et les cultures. Dynamique : c'est un équilibre instable avec l'environnement, à reconquérir sans cesse.
5. Santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes. Exemple : réduire la viande rouge et diversifier les protéines (légumineuses) est bon pour la santé humaine et réduit l'impact environnemental.
6. Par exemple : taux de mortalité, espérance de vie, prévalence d'une maladie ; Insee, Drees, Santé publique France, observatoires régionaux de la santé.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.2 La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §2 (p. 3) ; Essentiels M1 S1 §3 (p. 4)

Définitions

Définition – Santé publique – définition de C.-E. A. Winslow (1920)

« La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité physiques à travers les efforts coordonnés de la communauté pour l'assainissement de l'environnement, le contrôle des infections dans la population, l'éducation de l'individu aux principes de l'hygiène personnelle, l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies, le développement des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien de la santé. »

Cette définition centenaire contient déjà tout : **prévenir**, **promouvoir**, agir **collectivement** (« efforts coordonnés de la communauté ») et agir sur les **conditions de vie** (« niveau de vie adéquat »). On retiendra une formulation courte : la santé publique est l'ensemble des **savoirs, des savoir-faire et des actions organisées** qui visent à **maintenir et améliorer la santé de la population**, en agissant de façon collective sur ses déterminants.

Définition – La politique de santé dans le Code de la santé publique (art. L. 1411-1)

La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la responsabilité de l'État ; elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes, et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins. Elle comprend notamment la surveillance et l'observation de l'état de santé et de ses déterminants, la promotion de la santé, la prévention collective et individuelle, l'organisation des parcours de santé, la sécurité sanitaire, l'information et l'éducation à la santé (article issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; formulation résumée).

Définition – Santé publique – définition de l'OMS (1952)

En 1952, le comité d'experts de l'OMS sur l'administration de la santé publique reprend et complète la définition de Winslow : « La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité physiques et mentales des individus, par le moyen d'une action collective concertée visant à assainir le milieu, à lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale, à enseigner à l'individu les règles de l'hygiène personnelle, à organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies, ainsi qu'à mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. L'objet final est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. » (formulation reprise par le CNED, Environnement professionnel)

Méthode – Lire la définition de 1952 avec un regard de diététicien

Ce que dit la définition	Exemple en nutrition aujourd'hui
Assainir le milieu	Qualité de l'eau de boisson ; sécurité sanitaire des aliments ; environnement alimentaire (offre autour des écoles)
Lutter contre les maladies qui ont une importance sociale	Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, dénutrition de la personne âgée
Enseigner les règles d'hygiène personnelle	Éducation pour la santé : repères du PNNS, ateliers culinaires, hygiène en cuisine

Ce que dit la définition	Exemple en nutrition aujourd'hui
Organiser des services en vue du diagnostic précoce	Repérage du rebond d'adiposité en PMI ; dépistage de la dénutrition en EHPAD
Mesures sociales et niveau de vie	Aide alimentaire, tarification sociale de la cantine, chèques alimentaires, épiceries solidaires
Droit inné à la santé	Lien avec l'équité et la réduction des inégalités sociales de santé

Brève histoire de la santé publique

La santé publique n'est pas née avec l'OMS. Elle s'est construite par étapes, en réponse aux grandes menaces de chaque époque. Connaître cette histoire aide à comprendre pourquoi nos dispositifs actuels sont organisés ainsi.

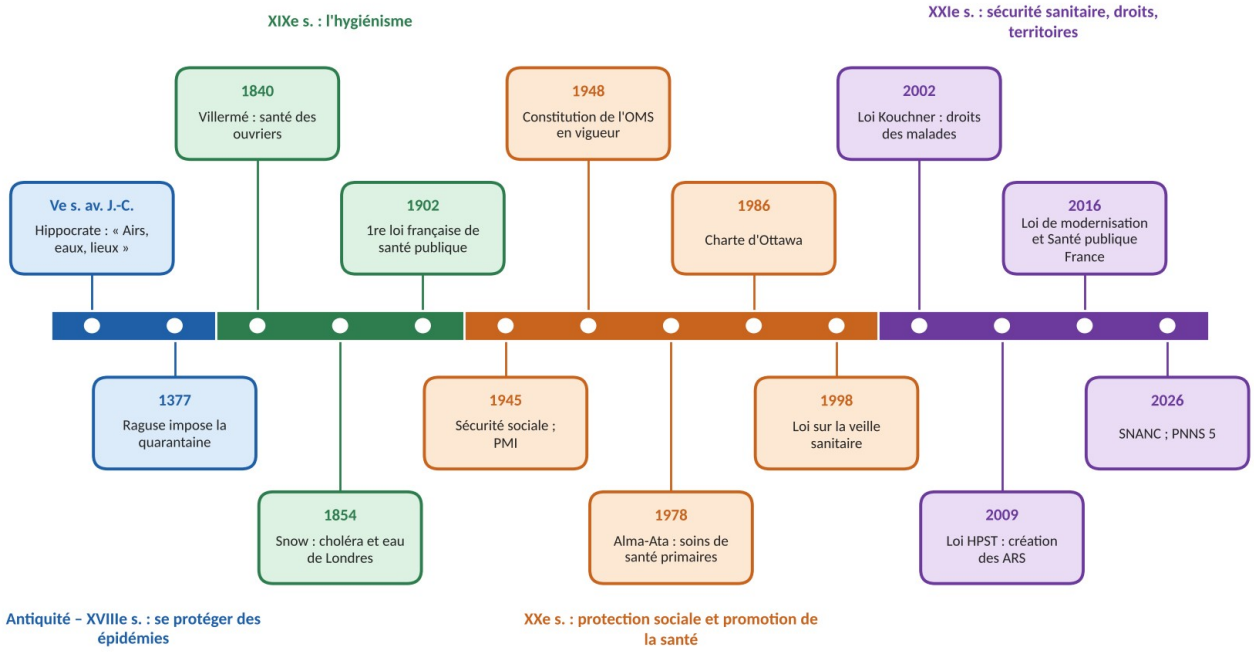


Figure 1.2 bis – Les grandes étapes de la santé publique, de l'Antiquité à aujourd'hui

Comprendre le schéma – Figure 1.2 bis

1. La frise est divisée en **quatre périodes** de couleur : chaque période répond à une préoccupation dominante.
2. **En bleu (Antiquité – XVIIIe siècle)** : on cherche surtout à **éviter la propagation des épidémies** (peste, choléra) par l'isolement et la quarantaine ; Hippocrate relie déjà la santé à l'air, à l'eau et aux lieux.
3. **En vert (XIXe siècle)** : le **mouvement hygiéniste** montre que la misère, le logement insalubre et l'eau polluée tuent ; l'État commence à légiférer (loi de 1902).
4. **En orange (XXe siècle)** : la santé devient un **droit** ; la protection sociale (1945), l'OMS (1948), puis les chartes d'Alma-Ata (1978) et d'Ottawa (1986) élargissent la santé publique à la **promotion de la santé**.
5. **En violet (XXIe siècle)** : après des crises (sang contaminé, vache folle, canicule de 2003, Covid-19), l'accent est mis sur la **sécurité sanitaire**, les **droits des usagers** et l'organisation par **territoires** (ARS).
6. Les dates en orange et en violet sont à connaître pour l'oral : elles permettent de situer le cadre réglementaire d'une action.

Période	Préoccupation dominante	Repères et textes	Ce qu'il en reste en nutrition
Antiquité – Moyen Âge – Renaissance	Survivre aux épidémies dans un contexte de religion toute-puissante, d'instabilité politique et d'absence de médecine curative	Hippocrate (Ve s. av. J.-C.), *Airs, eaux, lieux* ; quarantaine à Raguse (1377) ; lazarets	L'idée que l'environnement fait la santé
XVIIIe siècle	Influence des idées des Lumières et de la Révolution ; la santé du peuple devient l'affaire de l'État	Premières statistiques de population ; vaccination antivariolique (Jenner, 1796)	L'idée de compter pour agir (données)
XIXe siècle	Lutter contre la mortalité ; surveiller les épidémies ; éduquer	Villermé, *Tableau de l'état physique et moral des ouvriers* (1840) ; Snow et le choléra de Londres (1854) ; Pasteur (microbiologie) ; loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique	Hygiène des aliments, eau potable, lait propre pour les nourrissons (« gouttes de lait »)
XXe siècle	Protéger tout le monde ; passer du curatif au préventif puis à la promotion de la santé	Ordonnances de 1945 (Sécurité sociale, PMI) ; OMS (1948) ; Alma-Ata (1978) ; Ottawa (1986) ; loi du 1er juillet 1998 sur la veille sanitaire	PMI, médecine scolaire, premières campagnes d'éducation nutritionnelle
XXIe siècle	Sécurité sanitaire, droits des usagers, inégalités, territoires, climat	Loi du 4 mars 2002 ; loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; loi HPST du 21 juillet 2009 (ARS) ; loi du 26 janvier 2016 ; SNS 2018-2022 (projet 2023-2033 non adopté en mai 2026)	PNNS (2001 à 2030), Nutri-Score, EGalim, SNANC

À retenir

La santé publique est passée de la **protection contre les épidémies** (isoler, assainir) à la **promotion de la santé** (agir sur les déterminants, renforcer le pouvoir d'agir). Les grandes lois françaises à citer sont : **1902** (première loi de santé publique), **2002** (droits des malades), **2004** (politique de santé publique), **2009** (ARS), **2016** (modernisation du système de santé, Nutri-Score).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1 ter – Situer une action dans l'histoire

Une diététicienne prépare l'exposé d'un projet « Bien boire, bien manger » dans une école. Le jury lui demande : « En quoi votre action est-elle l'héritière de l'histoire de la santé publique ? » Rédigez une réponse de 6 à 8 lignes qui cite au moins trois périodes et deux textes.

Corrigé – Exercice 1.1 ter (exemple de réponse)

« Mon action s'inscrit d'abord dans l'héritage **hygiéniste** du XIXe siècle : l'accès à une eau potable gratuite à l'école répond au souci d'assainir le milieu, déjà présent dans la loi de **1902**. Elle reprend ensuite l'approche du **XXe siècle** : avec la Charte d'**Ottawa** (1986), on ne se contente plus d'informer, on agit sur l'environnement (fontaines, menus) et on renforce les compétences des enfants. Enfin, elle relève du **XXIe siècle** : elle répond à une priorité du **PNNS 5** et du projet régional de santé de l'ARS, créée par la loi **HPST** (2009), et elle associe les parents, ce qui rejoint l'esprit de la démocratie sanitaire. » Le correcteur valorise : trois périodes nommées, deux textes datés, le lien avec l'action.

Les caractéristiques de l'approche de santé publique

Caractéristique	Approche clinique (BC1)	Approche de santé publique (BC3)
Cible	Un individu (le patient)	Une population ou un groupe (habitants d'un quartier, élèves, salariés, résidents)
Point de départ	Une demande de soin, une prescription médicale	Un diagnostic de situation : données épidémiologiques, besoins normatifs, exprimés, ressentis et observés
Objectif	Guérir, soulager, accompagner la personne	Maintenir et améliorer la santé du groupe, réduire les inégalités
Leviers	Bilan, diagnostic diététique, plan de soin, ETP	Environnements, politiques, communication, éducation, partenariats, plaidoyer
Acteurs	Équipe soignante	Équipe pluridisciplinaire et intersectorielle : santé, social, éducation, collectivités, associations, agriculture
Évaluation	Évolution clinique du patient	Indicateurs de processus et de résultats sur le groupe
Exemple en nutrition	Consultation diététique pour un enfant en situation d'obésité	Programme « goûters sains » dans toutes les écoles d'un quartier

Les missions de la santé publique

L'OMS et son bureau régional pour l'Europe ont décrit des **opérations essentielles de santé publique**, que l'on peut regrouper en grandes missions :

1. Observer et surveiller l'état de santé de la population et ses déterminants (données, indicateurs, enquêtes).

2. Veiller et alerter : détecter et répondre aux menaces sanitaires (épidémies, toxi-infections alimentaires collectives, contaminations).

3. Protéger : sécurité sanitaire des aliments, de l'eau, de l'environnement (réglementation, contrôles).

4. Promouvoir la santé : agir sur les déterminants, créer des environnements favorables, renforcer le pouvoir d'agir.

5. Prévenir les maladies et leurs complications (vaccination, dépistage, prévention nutritionnelle).

6. Éduquer et informer la population.

7. Organiser le système de santé et l'accès aux soins et à la prévention.

8. Former les professionnels, **chercher** et **évaluer** (recherche, données probantes, évaluation des politiques).

9. Gouverner : élaborer des politiques, les financer, coordonner les acteurs (gouvernance intersectorielle).



Figure 1.2 ter – Les neuf grandes missions de la santé publique

Comprendre le schéma – Figure 1.2 ter

1. Les neuf missions sont disposées en **cercle** : aucune n'est plus importante que les autres, elles s'enchaînent et se renforcent.
2. **Observer, veiller, protéger** : ce sont les missions de connaissance et de défense (données, alertes, sécurité sanitaire).
3. **Promouvoir, prévenir, éduquer** : ce sont les missions d'action auprès de la population ; c'est là que se situe surtout le diététicien.
4. **Organiser, former et évaluer, gouverner** : ce sont les missions qui donnent un cadre, des moyens et des règles.
5. Pour l'oral, retenez une phrase : « mon action relève surtout de la mission "promouvoir" ou "éduquer", et elle s'appuie sur les données de la mission "observer". »

Pourquoi agir sur toute la population ? Le paradoxe de la prévention

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible) En 1985, l'épidémiologiste britannique **Geoffrey Rose** a montré qu'un **grand nombre de personnes exposées à un petit risque** peut générer **plus de cas** qu'un petit nombre de personnes exposées à un risque élevé. C'est le **paradoxe de la prévention** : une mesure qui apporte beaucoup à la population peut apporter peu à chaque individu qui y participe.

Exemple – Le paradoxe de Rose appliqué au sel

Imaginons une population de 100 000 adultes. 5 000 d'entre eux ont une hypertension sévère (risque élevé d'accident vasculaire cérébral) ; 95 000 ont une pression artérielle normale ou modérément élevée (risque

faible). Supposons, à titre pédagogique, que sur 10 ans, il survienne 10 AVC pour 1 000 personnes dans le groupe à haut risque et 2 pour 1 000 dans le groupe à faible risque. **Étape 1 – AVC dans le groupe à haut risque** : 5 000 × 10 / 1 000 = **50 AVC**. **Étape 2 – AVC dans le groupe à faible risque** : 95 000 × 2 / 1 000 = **190 AVC**. **Étape 3 – Total** : 50 + 190 = **240 AVC**, dont 190 / 240 = 0,79, soit **79 %** dans le groupe dit « à faible risque ». **Interprétation** : traiter uniquement les personnes à haut risque ne pourrait éviter, au mieux, que 21 % des AVC. Une mesure **populationnelle** (réduction du sel dans le pain, accord de filière, étiquetage) qui baisse légèrement la pression artérielle de tous agit sur la grande majorité des cas. C'est pourquoi les politiques nutritionnelles combinent stratégie **populationnelle** et stratégie **à haut risque** (dépistage et prise en charge).

À retenir

La santé publique s'intéresse à la **population** et pas seulement aux individus malades ; elle agit **collectivement** et **en amont**, sur les **déterminants** de la santé ; elle combine actions pour toute la population et actions ciblées (paradoxe de Rose).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.2 – La santé publique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les auteurs et les dates des deux définitions de la santé publique étudiées.
2. Citez cinq missions de la santé publique.
3. Complétez : l'approche clinique vise ….. ; l'approche de santé publique vise ….. .
4. Expliquez le paradoxe de la prévention de Geoffrey Rose (1985) en trois lignes.
5. Citez trois lois françaises de santé publique avec leur date.
6. Calcul : 80 000 adultes dont 4 000 à haut risque (15 cas pour 1 000) et 76 000 à faible risque (3 cas pour 1 000). Quelle part des cas survient dans le groupe à faible risque ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.2

1. Winslow (1920) ; OMS (1952), qui reprend et complète Winslow.
2. Observer et surveiller ; veiller et alerter ; protéger ; promouvoir la santé ; prévenir ; éduquer et informer ; organiser le système ; former, chercher, évaluer ; gouverner (cinq au choix).
3. Clinique : un individu (le patient), pour le soigner. Santé publique : une population, pour maintenir et améliorer sa santé et réduire les inégalités.
4. Beaucoup de personnes exposées à un petit risque produisent plus de cas que peu de personnes exposées à un risque élevé. Une mesure pour toute la population évite donc plus de cas, même si elle apporte peu à chaque individu.
5. Loi du 15 février 1902 (protection de la santé publique) ; loi du 4 mars 2002 (droits des malades) ; loi du 9 août 2004 (politique de santé publique) ; loi HPST du 21 juillet 2009 ; loi du 26 janvier 2016 (trois au choix).
6. Haut risque : 4 000 × 15 / 1 000 = 60 cas. Faible risque : 76 000 × 3 / 1 000 = 228 cas. Total : 288 cas. Part : 228 / 288 × 100 = 79,2 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.3 Problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Pour définir des priorités, le diététicien doit nommer précisément ce qu'il cherche à éviter. Ces notions sont indispensables au diagnostic de situation (chapitre 7) et seront approfondies avec les déterminants (chapitre 2).

Notion	Définition	Exemple en nutrition
Problème de santé	Situation qui altère ou menace la santé d'une population, mesurable par des indicateurs (fréquence, gravité, coût, retentissement)	Obésité infantile, dénutrition des personnes âgées, carence en fer chez l'adolescente, insécurité alimentaire
Danger	Agent ou situation capable de provoquer un effet néfaste (propriété intrinsèque)	Listeria monocytogenes dans un fromage au lait cru ; excès de sel ; allergène (arachide)
Exposition	Contact entre la population et le danger (durée, fréquence, dose)	Consommation quotidienne de pain et de plats préparés riches en sel
Risque	Probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition : risque = danger × exposition	Probabilité de développer une hypertension dans une population qui consomme en moyenne 8 g de sel/jour
Facteur de risque	Caractéristique ou exposition associée à une probabilité accrue de maladie (sans être forcément la cause unique)	Sédentarité, consommation fréquente de boissons sucrées, tabagisme, faible revenu
Facteur de protection	Caractéristique associée à une probabilité réduite de maladie	Allaitement maternel, consommation de fruits, légumes et fibres, activité physique, soutien social
Population à risque	Groupe plus exposé ou plus vulnérable	Femmes enceintes (Listeria), personnes âgées isolées (dénutrition), enfants de familles précaires (obésité)

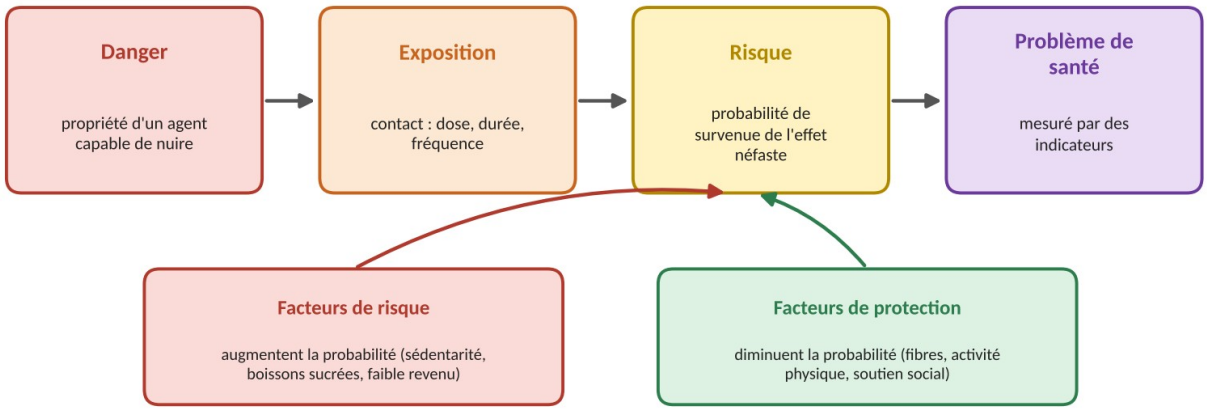


Figure 1.3 bis – Du danger au problème de santé : la chaîne du risque

Comprendre le schéma – Figure 1.3 bis

1. Le **danger** est une propriété de l'agent (le sel, une bactérie) : il existe même si personne n'y est exposé.
2. L'**exposition** décrit le contact avec le danger : dose, durée, fréquence.
3. Le **risque** naît de la rencontre du danger et de l'exposition : c'est une **probabilité**.
4. Quand le risque se réalise dans une population, il devient un **problème de santé**, que l'on mesure par des indicateurs (prévalence, incidence).
5. Sur les côtés, les **facteurs de risque** augmentent cette probabilité et les **facteurs de protection** la

diminuent : une action de santé publique cherche à réduire les premiers et à renforcer les seconds.

Attention – Facteur de risque n'est pas cause

Un facteur de risque est **associé statistiquement** à une maladie ; il n'en est pas forcément la cause directe. Par exemple, le fait de vivre dans un quartier prioritaire est associé à une plus forte prévalence d'obésité : ce n'est pas le quartier en lui-même qui « cause » l'obésité, mais un ensemble de déterminants (revenus, offre alimentaire, espaces pour l'activité physique, stress…). Les méthodes de l'épidémiologie (chapitre 16) permettent de discuter la causalité (critères de Bradford Hill).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.2

Dans la situation suivante, identifiez le danger, l'exposition, le risque, deux facteurs de risque et un facteur de protection : « Dans un foyer d'hébergement, des résidents âgés de plus de 75 ans mangent seuls dans leur chambre ; certains ont des difficultés de mastication ; les repas sont livrés froids. On craint une dénutrition. »

Corrigé

- **Problème de santé visé** : la dénutrition des personnes âgées.
- **Danger** : des apports alimentaires insuffisants en énergie et en protéines (situation capable de provoquer une dénutrition).
- **Exposition** : repas pris seuls, en chambre, à chaque repas, de façon prolongée.
- **Risque** : probabilité qu'un résident devienne dénutri dans les mois à venir (plus élevée que dans une population qui mange en salle commune avec des textures adaptées).
- **Facteurs de risque** : âge > 75 ans, isolement social au moment du repas, troubles de la mastication, repas peu appétissants (froids).
- **Facteur de protection** : repas pris en commun (convivialité), textures adaptées, enrichissement des repas, surveillance du poids (lien BC1 : critères HAS/FFAMCO 2021 de la dénutrition de la personne de 70 ans et plus).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.3 – Danger, risque, facteurs de risque

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez danger, exposition et risque.
2. Classez en facteur de risque ou facteur de protection : allaitement maternel ; sédentarité ; soutien social ; boissons sucrées quotidiennes.
3. Vrai ou faux : « Un facteur de risque est toujours la cause de la maladie. » Justifiez.
4. Donnez un exemple de population à risque pour la listériose et pour la dénutrition.
5. Dans la situation « des étudiants sautent le petit déjeuner et achètent des viennoiseries au distributeur », nommez le problème de santé visé et l'exposition.

Corrigé – Point d'étape 1.3.3

1. Danger : agent ou situation capable de provoquer un effet néfaste. Exposition : contact entre la population et le danger (durée, fréquence, dose). Risque : probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition.
2. Facteurs de protection : allaitement maternel, soutien social. Facteurs de risque : sédentarité, boissons sucrées quotidiennes.
3. Faux : un facteur de risque est associé statistiquement à la maladie ; il n'en est pas forcément la cause

directe (exemple du quartier prioritaire).

4. Listériose : femmes enceintes (et personnes âgées ou immunodéprimées). Dénutrition : personnes âgées isolées.
5. Problème de santé : déséquilibre alimentaire pouvant favoriser surpoids et baisse de concentration. Exposition : consommation répétée de produits gras et sucrés au distributeur, le matin, plusieurs fois par semaine.

Mon score	Ce que je fais
5 ou 4 sur 5	Je passe à la suite.
2 ou 3 sur 5	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 2 sur 5	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.4 Les modes d'intervention en santé publique

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Le guide d'accompagnement (2025) distingue quatre modes d'intervention : la **surveillance et la veille sanitaire**, la **promotion de la santé**, la **prévention** et l'**éducation pour la santé** (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle). Ils ne s'opposent pas : un projet bien construit les combine. Mais il faut savoir les **nommer précisément**, car le jury de l'épreuve E5 attend que vous qualifiiez correctement votre action.

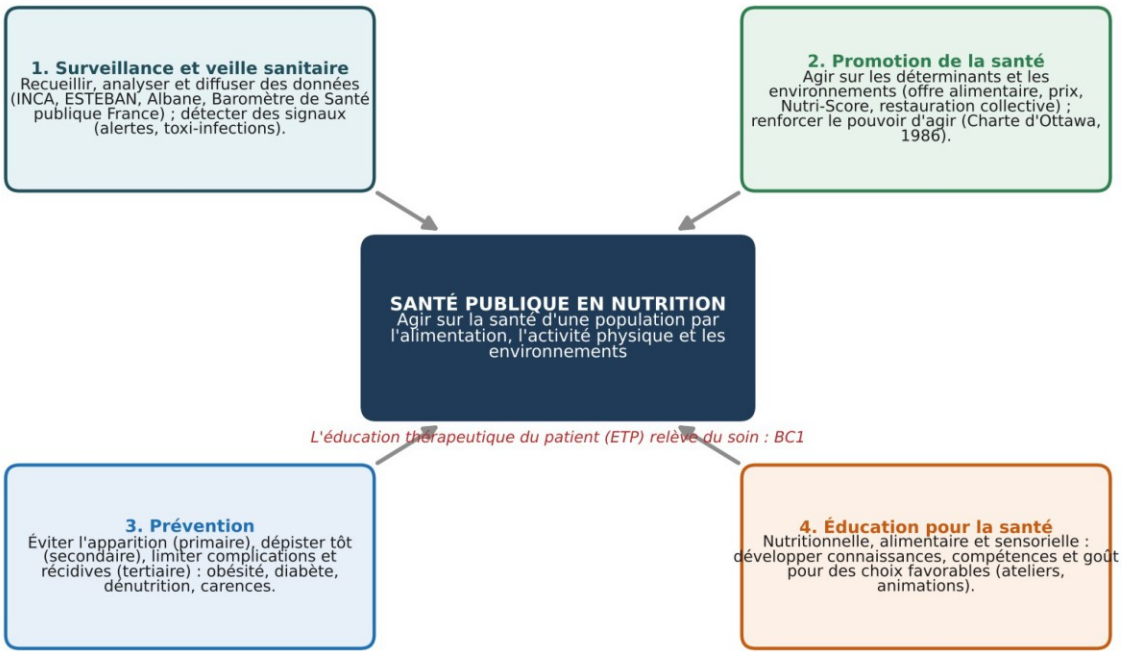


Figure 1.3 – Les quatre modes d'intervention en santé publique en nutrition

Comprendre le schéma – Figure 1.3

1. Au centre, la **santé publique en nutrition** : agir sur la santé d'une population par l'alimentation, l'activité physique et les environnements.
2. En haut à gauche, la **surveillance et la veille sanitaire** produisent les données qui permettent de connaître les problèmes et de suivre leur évolution.
3. En haut à droite, la **promotion de la santé** agit sur les déterminants et les environnements, et renforce le pouvoir d'agir.
4. En bas à gauche, la **prévention** cible un problème de santé précis, à différents moments de son histoire

naturelle.

5. En bas à droite, l'**éducation pour la santé** développe connaissances, compétences et goût chez les personnes.
6. La mention en rouge rappelle que l'**éducation thérapeutique du patient** relève du soin (BC1) et non de l'éducation pour la santé.

Mode 1 – La surveillance et la veille sanitaire

Définition – Surveillance épidémiologique

Collecte **systématique et continue** de données sur l'état de santé d'une population et ses déterminants, leur **analyse**, leur **interprétation** et leur **diffusion** aux personnes qui en ont besoin, afin d'orienter l'action (définition classique des Centers for Disease Control, reprise par Santé publique France).

Définition – Veille sanitaire

Ensemble des actions visant à **détecter le plus tôt possible** tout événement sanitaire anormal (« signal ») représentant un risque pour la santé de la population, à l'**évaluer** et à **alerter** les autorités pour qu'elles agissent. En France, la veille sanitaire est confiée à **Santé publique France** (créée le 1er mai 2016 par regroupement de l'InVS, de l'INPES, de l'EPRUS et d'Adalis).

En nutrition, la **surveillance** repose sur des enquêtes répétées : études **INCA** (ANSES ; INCA 3 réalisée en 2014-2015, publiée en 2017), **ESTEBAN** (Santé publique France, 2014-2016), cohorte **NutriNet-Santé** (depuis 2009), **Baromètre de Santé publique France**, enquêtes de santé scolaire de la Drees (grande section, CM2, 3e), et désormais l'enquête **Albane**, lancée en juin 2025 par Santé publique France et l'ANSES, qui associera tous les deux ans questionnaires, carnets alimentaires de trois jours, accéléromètres et examens de santé avec prélèvements biologiques (premiers résultats attendus début 2028). La **veille sanitaire** concerne surtout la sécurité des aliments : déclaration obligatoire des **toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)** auprès de l'ARS, alertes et rappels de produits (site **RappelConso**, depuis avril 2021), nutrivigilance de l'ANSES (effets indésirables des compléments alimentaires).

Lien diététique – Le diététicien et la surveillance

Le diététicien est **utilisateur** des données de surveillance (pour poser un diagnostic, chapitre 2) et parfois **producteur** : enquêteur dans une étude nationale, participation aux enquêtes de consommation en restauration collective, signalement d'une TIAC dans un établissement, déclaration d'un effet indésirable en nutrivigilance.

Mode 2 – La promotion de la santé

Définition – Promotion de la santé – Charte d'Ottawa (OMS, 21 novembre 1986)

« La promotion de la santé est le **processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci**. Cette démarche relève d'un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. » Charte adoptée lors de la première Conférence internationale pour la promotion de la santé, Ottawa (Canada), 17-21 novembre 1986.

La promotion de la santé ne vise pas une maladie particulière : elle vise à **améliorer la santé et le bien-être** en agissant sur l'ensemble des **déterminants** (revenus, logement, éducation, offre alimentaire, environnement…) et

en renforçant la **capacité des personnes et des communautés à agir** (*empowerment*, ou pouvoir d'agir). Elle est **positive** (on cherche à développer des ressources) et **politique** (on agit sur les politiques publiques, pas seulement sur les comportements).

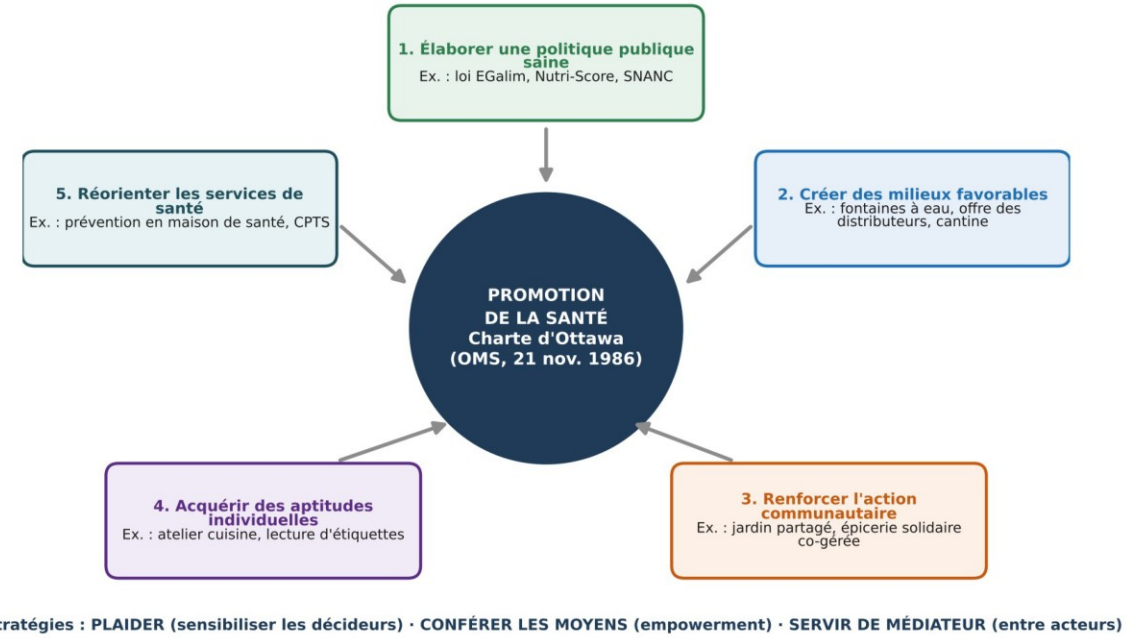


Figure 1.4 – Les cinq domaines d'action et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa, illustrés en nutrition

Comprendre le schéma – Figure 1.4

1. Élaborer une politique publique saine : la santé doit être inscrite à l'ordre du jour de tous les décideurs, dans tous les secteurs (agriculture, éducation, urbanisme, économie). Exemples : loi EGalim, Nutri-Score, SNANC.

2. Créer des milieux favorables : rendre les choix sains plus faciles dans les lieux de vie (école, travail, quartier). Exemples : fontaines à eau, suppression des distributeurs de boissons sucrées dans les écoles (loi du 9 août 2004), offre de fruits.

3. Renforcer l'action communautaire : les habitants participent à la définition des priorités et à l'action. Exemples : jardin partagé, épicerie solidaire co-gérée, groupe de parents.

4. Acquérir des aptitudes individuelles : informer, éduquer, développer les compétences. Exemples : atelier cuisine, lecture d'étiquettes, éducation au goût.

5. Réorienter les services de santé : passer d'un système centré sur le soin à un système qui intègre la prévention. Exemples : prévention en maison de santé pluriprofessionnelle, CPTS, rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie.

6. Le bandeau du bas rappelle les **trois stratégies** : **plaider** (convaincre les décideurs), **conférer les moyens** (donner aux personnes les moyens d'agir) et **servir de médiateur** (concilier les intérêts des différents acteurs).

À retenir – Charte d'Ottawa : 5 + 3

5 domaines d'action : politique publique saine ; milieux favorables ; action communautaire ; aptitudes individuelles ; réorientation des services de santé. **3 stratégies** : plaider, conférer les moyens (habiliter), servir de médiateur. Moyen mnémotechnique : « **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement » (Politique, Milieux, Communautaire, Aptitudes, Réorienter).

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible)

Les conférences et chartes qui ont suivi Ottawa

Année et lieu	Apport principal
1978 – Alma-Ata	Déclaration sur les soins de santé primaires : « la santé pour tous en l'an 2000 » ; participation de la population ; la santé dépend du développement économique et social
1986 – Ottawa	Charte de la promotion de la santé (5 domaines, 3 stratégies)
1988 – Adélaïde	Politiques publiques favorables à la santé ; l'alimentation et la nutrition sont un domaine prioritaire
1997 – Jakarta	Partenariats, implication du secteur privé, investissement dans la santé
2005 – Bangkok	Charte de Bangkok : promotion de la santé à l'heure de la mondialisation ; engagement des entreprises
2010 – Adélaïde	Santé dans toutes les politiques (Health in All Policies), réaffirmée à Helsinki en 2013
2016 – Shanghai	Déclaration de Shanghai : promotion de la santé et Objectifs de développement durable (2030), villes-santé, littératie en santé
2021 – Genève	Charte de Genève pour le bien-être : sociétés du bien-être, santé de la planète

Les principes d'action de la promotion de la santé

- **Agir sur les déterminants** plutôt que sur les seuls comportements (chapitre 2). Le modèle des déterminants de Dahlgren et Whitehead (1991) est l'outil de référence pour les visualiser.
- **Participation** des personnes concernées à toutes les étapes du projet (du diagnostic à l'évaluation) : on fait **avec** les personnes, pas **pour** elles.
- **Renforcement du pouvoir d'agir** (*empowerment*) individuel et collectif.
- **Intersectorialité** : santé, social, éducation, urbanisme, agriculture, économie.
- **Réduction des inégalités sociales de santé** : selon le principe de l'**universalisme proportionné**.
- **Approche par milieux de vie** (*settings*) : écoles promotrices de santé, entreprises, villes-santé de l'OMS (réseau français des Villes-Santé, créé en 1990).
- **Non-stigmatisation** : on ne culpabilise pas les personnes (par exemple, on parle de « personnes vivant avec une obésité » et on évite les messages qui opposent « bons » et « mauvais » aliments de façon moralisatrice).

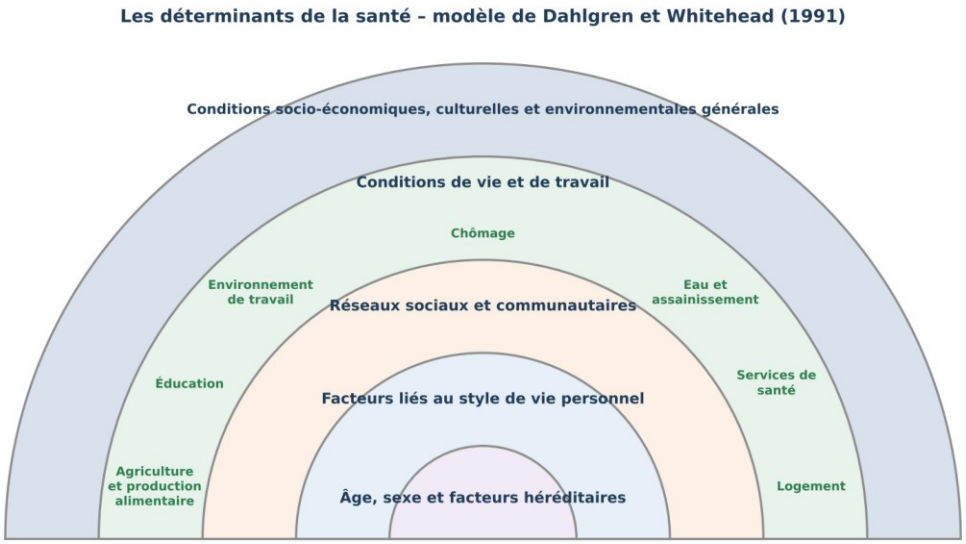


Figure 1.5 – Les déterminants de la santé selon Dahlgren et Whitehead (1991)

Comprendre le schéma – Figure 1.5

1. Au centre, les **facteurs individuels non modifiables** : âge, sexe, facteurs héréditaires.

2. Deuxième couche : les **facteurs liés au style de vie personnel** (alimentation, activité physique, tabac, alcool, sommeil). C'est là que se situent les « comportements », mais ils sont influencés par toutes les couches extérieures.
3. Troisième couche : les **réseaux sociaux et communautaires** (famille, amis, voisinage, soutien social).
4. Quatrième couche : les **conditions de vie et de travail** : agriculture et production alimentaire, éducation, environnement de travail, chômage, eau et assainissement, services de santé, logement.
5. Couche extérieure : les **conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales** (politiques économiques, fiscales, culture, climat).
6. Lecture : plus on agit sur les couches **extérieures**, plus l'action touche de personnes et réduit les inégalités ; agir seulement au centre (« manger mieux ») sans agir sur les couches externes (prix, offre, revenus) a un effet limité et peut accroître les inégalités. Ce modèle sera détaillé au chapitre 2.

Définition – Universalisme proportionné (Michael Marmot, *Fair Society, Healthy Lives*, 2010)

Principe selon lequel les actions doivent être **universelles** (destinées à toute la population), mais avec une **intensité proportionnelle au niveau de désavantage** social. Il évite deux écueils : l'action universelle seule, qui profite surtout aux plus favorisés (qui ont plus de ressources pour s'en saisir), et l'action ciblée seule, qui stigmatise et oublie le **gradient social** (la santé se dégrade progressivement à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement chez les plus pauvres).

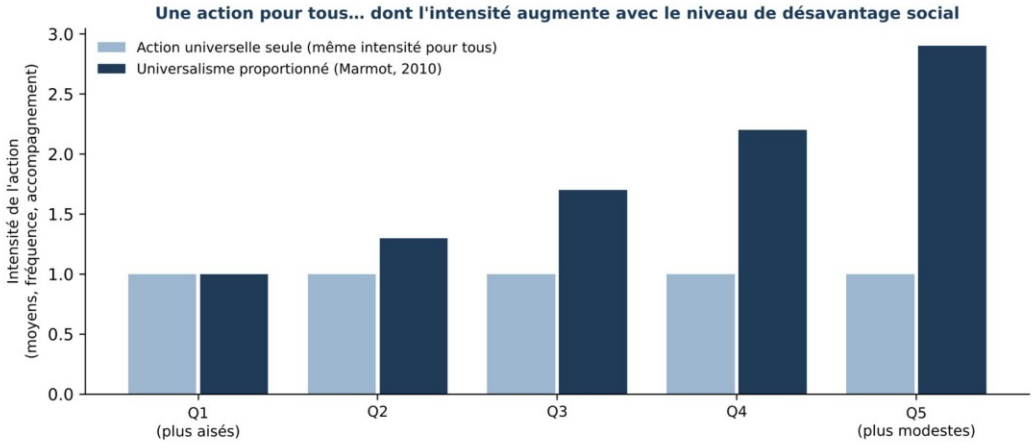


Figure 1.6 – L'universalisme proportionné : une action pour tous, plus intense pour les plus défavorisés

Comprendre le schéma – Figure 1.6

1. L'axe horizontal classe la population en cinq groupes (quintiles) du plus aisé (Q1) au plus modeste (Q5).
2. Les barres claires représentent une **action universelle seule** : la même intensité pour tous.
3. Les barres foncées représentent l'**universalisme proportionné** : l'action existe pour tous, mais son intensité (moyens, fréquence, accompagnement) augmente avec le désavantage.
4. Exemple : une cantine scolaire ouverte à tous (universel), avec une **tarification sociale** (les familles les plus modestes paient moins, dispositif de la « cantine à 1 euro » soutenu par l'État pour les communes rurales éligibles depuis 2019) et un accompagnement renforcé dans les écoles des quartiers prioritaires.

Mode 3 – La prévention

Définition – Prévention – OMS (1948)

« Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. » La prévention part toujours d'un **problème de santé défini** que l'on cherche à éviter ou à limiter.

La classification de l'OMS selon le moment de l'intervention

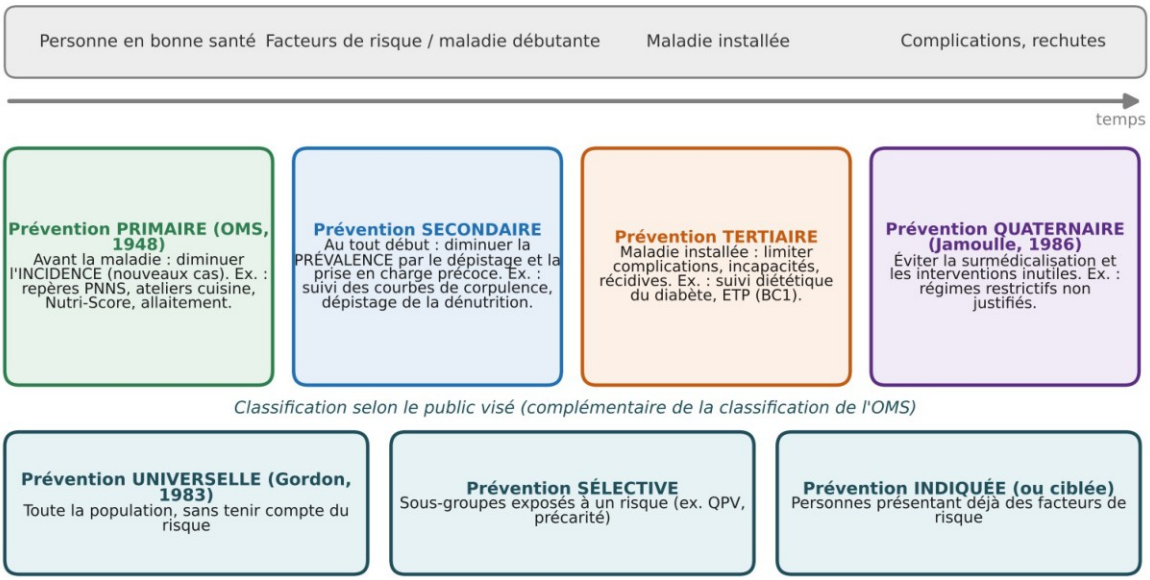


Figure 1.7 – Les niveaux de prévention selon l'OMS et selon Gordon

Comprendre le schéma – Figure 1.7

1. La bande grise représente l'**histoire naturelle de la maladie** dans le temps : bonne santé → facteurs de risque ou maladie débutante → maladie installée → complications.

2. **Prévention primaire** (vert) : intervient **avant** l'apparition de la maladie ; elle vise à diminuer l'**incidence** (le nombre de nouveaux cas). En nutrition : repères du PNNS, éducation alimentaire, promotion de l'allaitement, ateliers cuisine, Nutri-Score, réduction du sel dans le pain.

3. **Prévention secondaire** (bleu) : intervient **au tout début** de la maladie, souvent avant les symptômes ; elle vise à diminuer la **prévalence** (le nombre de cas existants) en réduisant la durée de la maladie par un dépistage et une prise en charge précoces. En nutrition : suivi des courbes de corpulence par le médecin ou la PMI (repérage du rebond d'adiposité précoce), dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD, dépistage du diabète de type 2.

4. **Prévention tertiaire** (orange) : intervient quand la maladie est **installée** ; elle vise à réduire les **complications, les incapacités et les récidives**. En nutrition : prise en charge diététique du diabète, de l'insuffisance rénale, réhabilitation nutritionnelle ; l'ETP en fait partie (BC1).

5. **Prévention quaternaire** (violet) : notion proposée par Marc Jamoulle (1986) ; elle vise à protéger les personnes de la **surmédicalisation** et des interventions inutiles ou nocives. En nutrition : éviter les régimes restrictifs non justifiés, les compléments alimentaires inutiles, les exclusions alimentaires sans diagnostic.

6. En bas, la **classification de Gordon (1983)**, fondée sur le **public visé** : universelle (toute la population), sélective (sous-groupes exposés à un risque), indiquée (personnes présentant déjà des facteurs de risque).

La classification de Gordon selon la population visée

Type	Public visé	Exemple en nutrition
Universelle	Toute la population, sans distinction de risque	Campagne « Manger Bouger », repères PNNS, Nutri- Score, menu végétarien hebdomadaire à l'école
Sélective	Sous-groupes exposés à un risque particulier, sans signe de maladie	Ateliers cuisine petit budget pour les familles d'un quartier prioritaire ; prévention de la carence en fer chez les adolescentes ; actions « 1000 premiers jours » auprès des femmes enceintes en situation de précarité
Indiquée (ou ciblée)	Personnes présentant déjà des facteurs de risque ou des signes précoces	Programme d'activité physique et d'alimentation pour les enfants en surpoids repérés par la santé scolaire (par exemple dispositif « Mission : retrouve ton cap », prise en charge pluridisciplinaire du surpoids de l'enfant financée par l'Assurance maladie)

Une troisième classification : la prévention globale (Robert San Marco, 2003)

Robert San Marco distingue la prévention **« de maladies »** (centrée sur un risque, souvent descendante) et la prévention **« globale »** ou **positive**, centrée sur la **personne** et sa qualité de vie, qui rejoint la promotion de la santé. Cette distinction est utile pour critiquer les campagnes uniquement fondées sur la peur.

Attention – Les erreurs classiques sur la prévention

- Confondre **incidence** (nouveaux cas, que la prévention primaire fait baisser) et **prévalence** (cas existants, que la prévention secondaire fait baisser en raccourcissant la durée de la maladie).
- Classer un **dépistage** en prévention primaire : le dépistage repère une maladie ou un facteur de risque **déjà présent** ; il relève de la prévention secondaire.
- Classer l'**ETP** en éducation pour la santé : l'ETP s'adresse à des **patients** ayant une maladie chronique ; elle relève du soin et de la prévention tertiaire (BC1).
- Croire qu'une action « universelle » est forcément équitable : sans universalisme proportionné, elle peut **creuser les inégalités**.

Mode 4 – L'éducation pour la santé

Définition – Éducation pour la santé (définition reprise par l'INPES puis Santé publique France)

L'éducation pour la santé « a pour but que chaque citoyen acquière, tout au long de sa vie, les **compétences** et les **moyens** lui permettant de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité » (Plan national d'éducation pour la santé, 2001). Elle comprend toute combinaison d'expériences d'apprentissage visant à faciliter l'adoption **volontaire** de comportements favorables à la santé.

L'éducation pour la santé est **une composante** de la promotion de la santé (domaine « acquérir des aptitudes individuelles ») et un **moyen** de la prévention. Elle respecte la **liberté** des personnes : elle ne cherche pas à imposer un comportement, mais à donner les moyens de faire des choix éclairés. Le guide du BTS (2025) distingue trois formes en nutrition.

Forme	Contenu	Exemples d'actions
Éducation nutritionnelle	Connaissances sur les nutriments, les besoins, les repères, les liens alimentation-santé	Atelier « lire une étiquette et comprendre le Nutri-Score » ; jeu des familles d'aliments ; quiz sur les repères PNNS

Forme	Contenu	Exemples d'actions
Éducation alimentaire	Pratiques concrètes : choisir, acheter, conserver, cuisiner, organiser ses repas, gérer un budget, limiter le gaspillage ; dimensions culturelles et sociales	Atelier culinaire « repas complet à moins de 2 € » ; visite d'un marché ; atelier « batch cooking » ; atelier anti-gaspillage
Éducation sensorielle (éducation au goût)	Découverte des cinq sens, du vocabulaire sensoriel, du plaisir de manger ; lutte contre la néophobie	Classes du goût (méthode de Jacques Puisais, 1975, Institut du goût) ; ateliers d'éveil sensoriel en maternelle ; dégustations à l'aveugle ; « Semaine du goût » (depuis 1990, en octobre)

Les approches éducatives : de l'information à la participation

Approche	Principe	Limite	Exemple
Informative	Transmettre des connaissances (« savoir pour bien faire »)	Savoir ne suffit pas à changer : beaucoup de personnes savent qu'il faut manger 5 fruits et légumes	Affiche, dépliant, conférence
Persuasive (ou comportementale)	Convaincre de changer un comportement, parfois par la peur	Culpabilise, peut renforcer les inégalités et la stigmatisation	Campagne choc, injonction
Participative (ou humaniste, d'empowerment)	Partir des représentations et des besoins des personnes ; développer leurs compétences et leur pouvoir d'agir	Plus longue, demande des compétences d'animation	Atelier où les parents choisissent les recettes ; photolangage ; débat ; co-construction d'un livret

À retenir

En santé publique, on privilégie l'**approche participative** et le développement des **compétences psychosociales (CPS)** : Santé publique France a publié en 2022 un **référentiel des CPS** (compétences cognitives, émotionnelles et sociales) et une stratégie nationale de développement des CPS des enfants et des jeunes (2022-2037) ; ces compétences sont un déterminant majeur de la santé et du bien-être (chapitre 3).

Deux autres modes souvent cités : la sécurité sanitaire et la restauration de la santé

Les cours du CNED et de nombreux manuels présentent **cinq ou six** modes d'intervention, alors que le guide 2025 en retient quatre. Il n'y a pas de contradiction : les deux modes supplémentaires sont, soit inclus dans un mode du guide, soit hors du champ du BC3. Il faut savoir les reconnaître si un document ou un membre du jury les cite.

Définition – Sécurité sanitaire

Ensemble des mesures qui **protègent la population contre les risques** liés aux produits de santé, aux aliments, à l'eau, à l'environnement et aux soins. Elle associe la **veille** (détecter), l'**expertise** (évaluer le risque), la **gestion** (décider et agir : retrait, rappel, interdiction) et la **communication**. Elle repose sur le **principe de précaution** (article 5 de la Charte de l'environnement, 2005).

Définition – Restauration de la santé

Actions qui visent à **rétablir la santé** quand la maladie est installée : soins curatifs, réadaptation, réinsertion. Elle correspond à la prévention **tertiaire** de l'OMS et à l'**éducation thérapeutique du patient** ; elle relève surtout du soin (BC1 et BC2).

Mode cité par le CNED ou un manuel	Où le placer avec les quatre modes du guide 2025	Exemple en nutrition
Veille et sécurité sanitaire	Mode 1 (surveillance et veille) pour la détection ; mission « protéger » de la santé publique pour la gestion	Rappel d'un lot de préparation infantile contaminée ; enquête sur une TIAC dans une cantine
Restauration de la santé	Hors BC3 : soin (BC1) ; prévention tertiaire	Prise en charge diététique d'un patient après un infarctus ; programme d'ETP diabète
Promotion de la santé	Mode 2	Projet alimentaire territorial, fontaines à eau dans un quartier
Prévention	Mode 3	Dépistage de la dénutrition en EHPAD
Éducation pour la santé	Mode 4	Ateliers culinaires, éducation sensorielle

Exemple – La sécurité sanitaire des aliments : une chaîne d'acteurs

1. Le signal : trois enfants d'une même école ont des diarrhées et des vomissements le même soir. Le médecin déclare une **TIAC** (au moins deux cas groupés, symptômes similaires, même origine alimentaire) à l'**ARS**.

2. L'enquête : l'ARS et la direction départementale chargée de la protection des populations (DDPP ou DDETSPP) enquêtent sur le repas suspect ; Santé publique France analyse les données ; le laboratoire analyse les plats témoins.

3. L'évaluation : l'**ANSES** (créée en 2010) apporte l'expertise scientifique sur le danger.

4. La gestion : la préfecture ou le ministère décide du retrait ou du rappel des produits ; le rappel est publié sur **RappelConso**.

5. Le rôle du diététicien de la cuisine centrale : fournir les plats témoins conservés 5 jours, les fiches de traçabilité et le plan de maîtrise sanitaire (chapitre 13).

À retenir

Retenez les **quatre modes du guide 2025** pour qualifier votre action à l'épreuve E5. Sachez aussi que la **sécurité sanitaire** protège la population contre les risques (aliments, eau, produits) et que la **restauration de la santé** relève du soin. Ces deux notions existent, mais elles ne remplacent pas les quatre modes.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.2 bis – Classer des actions

Classez chaque action dans l'un des quatre modes du guide 2025, ou indiquez qu'elle relève de la sécurité sanitaire ou de la restauration de la santé.

a) L'ANSES publie un avis sur les risques liés aux boissons énergisantes.

b) Une diététicienne anime six séances d'ETP pour des patients insuffisants rénaux.

c) Une commune installe des fontaines à eau dans tous ses parcs.

d) Un lot de fromage contaminé par *Listeria* est rappelé sur RappelConso.

e) Santé publique France publie les résultats de l'étude Esteban sur la corpulence.

f) Un atelier « goûter maison » est proposé aux parents d'une crèche.

Corrigé – Exercice 1.2 bis

a) **Sécurité sanitaire** (évaluation du risque par une expertise) ; elle prépare une décision de gestion.

b) **Restauration de la santé** : ETP, prévention tertiaire, champ du soin (BC1).

c) **Promotion de la santé** : on rend l'environnement favorable (choix facile de l'eau).

d) **Sécurité sanitaire** (gestion du risque : retrait et rappel).

e) **Surveillance** (mode 1) : données répétées sur l'état de santé de la population.

f) **Éducation pour la santé** (mode 4) : développer des compétences des parents.

Distinguer promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé et ETP

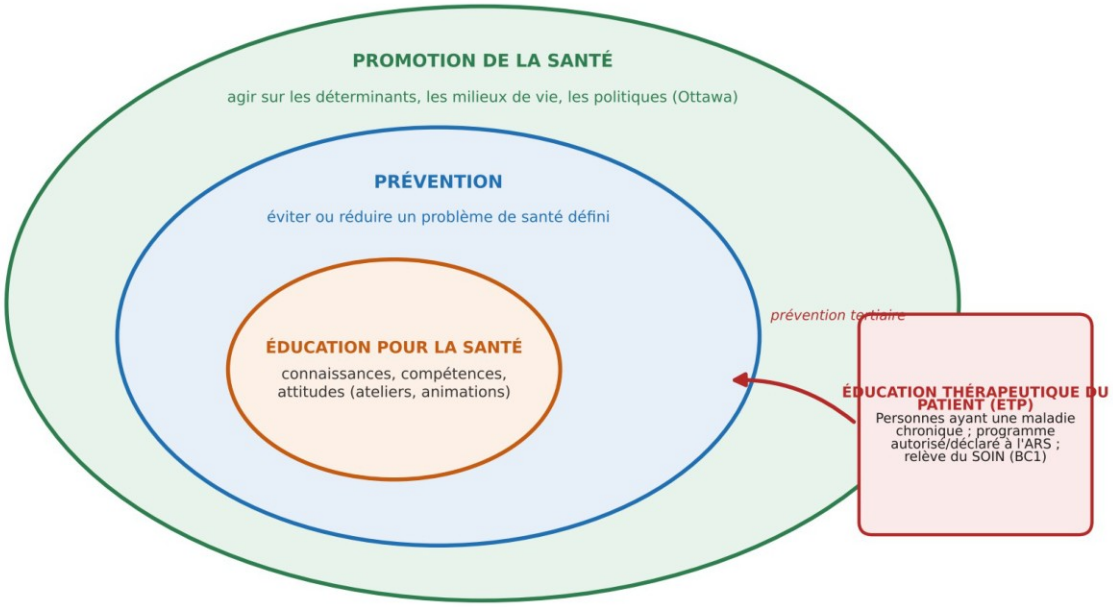


Figure 1.8 – Emboîtement des notions : promotion, prévention, éducation pour la santé et éducation thérapeutique du patient

Comprendre le schéma – Figure 1.8

1. La grande ellipse verte, la **promotion de la santé**, est la notion la plus large : elle agit sur tous les déterminants et sur les politiques.
2. L'ellipse bleue, la **prévention**, est incluse dans la promotion : elle vise des problèmes de santé définis.
3. L'ellipse orange, l'**éducation pour la santé**, est l'un des moyens de la prévention et de la promotion : elle développe les compétences des personnes.
4. Le cadre rouge, l'**ETP**, se situe à part, du côté du **soin** : elle s'adresse à des patients ayant une maladie chronique, dans un programme déclaré à l'ARS ; la flèche rappelle qu'elle participe à la **prévention tertiaire**.

Critère	Promotion de la santé	Prévention	Éducation pour la santé	ETP (BC1)
Cible	Population, milieux de vie, décideurs	Population ou groupe exposé à un problème	Personnes, groupes (bien portants)	Patient atteint d'une maladie chronique et son entourage
Objectif	Améliorer la santé et le bien-être, réduire les inégalités, renforcer le pouvoir d'agir	Éviter ou réduire un problème de santé défini	Développer connaissances, compétences, attitudes	Acquérir des compétences d'autosoins et d'adaptation pour gérer sa maladie
Point de départ	Déterminants de santé	Maladie ou facteur de risque	Besoins éducatifs du public	Diagnostic éducatif (bilan éducatif partagé)

Critère	Promotion de la santé	Prévention	Éducation pour la santé	ETP (BC1)
Leviers	Politiques, environnements, action communautaire, éducation, services	Information, dépistage, vaccination, éducation, réglementation	Ateliers, animations, outils pédagogiques	Programme structuré (séances individuelles et collectives)
Cadre	Charte d'Ottawa ; SNS ; PRS	OMS 1948 ; Gordon 1983	PNES 2001 ; Santé publique France	Loi HPST du 21 juillet 2009 (art. L. 1161-1 CSP) ; HAS 2007 ; programmes déclarés à l'ARS (depuis 2021)
Exemple	Charte « Ville active PNNS », plan alimentaire territorial	Dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD	Atelier cuisine parents-enfants	Séance « adapter son alimentation à son diabète » pour des patients d'un service hospitalier

Exemple – Un même thème, quatre modes d'intervention : la consommation de boissons sucrées chez les enfants

- **Surveillance** : les enquêtes de santé scolaire et ESTEBAN mesurent la consommation et la corpulence des enfants ; les données montrent un gradient social.
- **Promotion de la santé** : taxe sur les boissons sucrées (en France depuis 2012, rendue progressive en fonction de la teneur en sucres en 2018 et renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025) ; installation de fontaines à eau dans les écoles ; interdiction des distributeurs automatiques payants dans les établissements scolaires (loi du 9 août 2004).
- **Prévention** (primaire, sélective) : programme dans les écoles d'un quartier où la prévalence du surpoids est élevée.
- **Éducation pour la santé** : atelier « fabriquer des eaux aromatisées et des goûters maison » avec les parents et les enfants ; jeu sur la quantité de sucre dans les boissons.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 – Qualifier une action

Pour chaque action, indiquez le ou les mode(s) d'intervention, le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon) : **a)** Une mairie signe la charte « Ville active du PNNS » et rénove l'offre de sa cantine. **b)** Une infirmière scolaire mesure poids et taille des élèves de grande section et oriente les enfants dont la courbe de corpulence monte. **c)** Une diététicienne anime 6 ateliers cuisine petit budget pour les familles d'une épicerie solidaire. **d)** Un service de diabétologie organise des séances collectives sur le comptage des glucides pour des patients diabétiques de type 1. **e)** Santé publique France diffuse un spot télévisé sur les repères « Manger Bouger ».

Corrigé

a) Promotion de la santé (politique publique locale saine, milieu favorable) ; prévention **primaire**, **universelle** (tous les enfants de la commune). **b) Prévention secondaire** (repérage précoce du surpoids, avant les complications) ; **indiquée** pour les enfants orientés (ils présentent déjà un signe : la courbe qui monte) ; c'est aussi de la **surveillance** si les données sont agrégées. **c) Éducation pour la santé** (alimentaire et nutritionnelle) au service de la **prévention primaire**, **sélective** (public exposé à un risque du fait de la précarité) ; elle relève aussi de la **promotion de la santé** si les familles participent au choix des thèmes (renforcement du pouvoir d'agir) et si le projet agit sur l'offre (partenariat avec l'épicerie). **d) Éducation thérapeutique du patient** (BC1), **prévention tertiaire** : il ne s'agit pas d'éducation pour la santé, car les participants sont des patients atteints d'une maladie chronique, dans un programme de soin. **e) Éducation pour la santé** de type **informative** (communication de masse), **prévention primaire universelle**.

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible)

Le marketing social et les « nudges »

Le **marketing social** applique les techniques du marketing commercial (connaissance du public, segmentation, produit, prix, distribution, communication : les « 4 P ») pour favoriser un comportement favorable à la santé (par exemple, le programme anglais *Change4Life*). Les **nudges** (« coups de pouce », Thaler et Sunstein, 2008) modifient l'**architecture du choix** sans interdire ni culpabiliser : placer les fruits à hauteur des yeux et en début de chaîne au self, proposer l'eau par défaut au menu enfant, servir des portions adaptées. Ils sont efficaces pour des comportements quotidiens, mais ne remplacent pas l'action sur les déterminants structurels (prix, revenus, offre).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.4 – Les modes d'intervention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre modes d'intervention du guide 2025.
2. Citez les cinq domaines d'action et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa.
3. Classez selon l'OMS (primaire, secondaire, tertiaire) : dépistage de la dénutrition en EHPAD ; atelier cuisine pour des familles sans maladie ; ETP d'un patient diabétique.
4. Classez selon Gordon (universelle, sélective, indiquée) : un message pour tous les élèves d'un collège ; un atelier pour les familles d'un quartier prioritaire ; un suivi pour des enfants déjà en surpoids.
5. Quelle différence faites-vous entre la sécurité sanitaire et la restauration de la santé ?
6. Citez les trois formes d'éducation pour la santé en nutrition et donnez un exemple pour chacune.

Corrigé – Point d'étape 1.3.4

1. Surveillance et veille sanitaire ; promotion de la santé ; prévention ; éducation pour la santé.
2. Domaines : élaborer une politique publique saine ; créer des milieux favorables ; renforcer l'action communautaire ; acquérir des aptitudes individuelles ; réorienter les services de santé. Stratégies : promouvoir (plaider), conférer les moyens, servir de médiateur.
3. Dépistage : secondaire. Atelier cuisine : primaire. ETP : tertiaire.
4. Tous les élèves : universelle. Quartier prioritaire : sélective. Enfants déjà en surpoids : indiquée.
5. La sécurité sanitaire protège la population contre les risques (aliments, eau, produits) : veille, expertise, gestion, communication. La restauration de la santé rétablit la santé d'une personne malade (soins, réadaptation, ETP) : elle relève du soin.
6. Nutritionnelle (lire une étiquette, comprendre le Nutri-Score) ; alimentaire (atelier culinaire petit budget) ; sensorielle (classes du goût, dégustation à l'aveugle).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.5 Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition

Module · Référentiel : C3.4, activité 3.1 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14) ; Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15) ; Essentiels M1 S3 §1.5 (p. 15) ; Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 15 et 16)

La santé publique en nutrition est **intersectorielle** : elle mobilise la santé, mais aussi l'agriculture, l'éducation, l'économie, l'environnement, la cohésion sociale. Connaître les acteurs est indispensable pour trouver des **données** (diagnostic), des **financements** (appels à projets), des **partenaires** (parties prenantes) et des **ressources** (outils pédagogiques validés).

Une typologie des acteurs selon leur rôle

Avant de présenter les acteurs par niveau (international, européen, national, régional, local), il est utile de les classer selon leur **rôle** dans une politique de santé. Le CNED retient **quatre types d'acteurs**. Un même organisme peut jouer plusieurs rôles : l'ARS décide (elle arrête le PRS), finance (fonds d'intervention régional) et pilote la mise en œuvre.

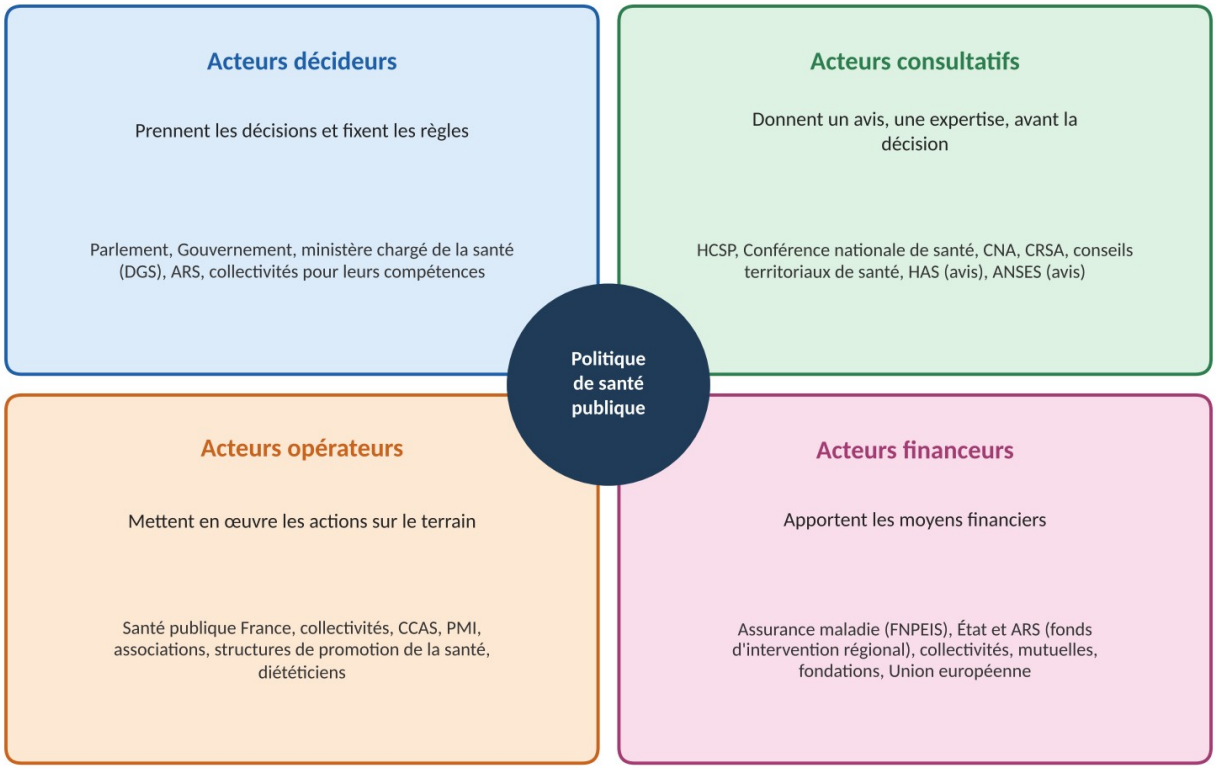


Figure 1.8 bis – Les quatre types d'acteurs d'une politique de santé publique

Comprendre le schéma – Figure 1.8 bis

1. Au centre, la **politique de santé publique** : elle a besoin des quatre types d'acteurs pour exister.
2. **En bleu, les décideurs** : ils sont à l'origine des décisions (lois, plans, arrêtés, choix des priorités).
3. **En vert, les consultatifs** : ils sont consultés **avant** la décision ; ils rendent des avis, des rapports, des recommandations.
4. **En orange, les opérateurs** : ils **mettent en œuvre** la politique décidée, sur le terrain. Le diététicien est un opérateur.
5. **En rose, les financeurs** : ils apportent les crédits (subventions, appels à projets, remboursements).
6. Pour un projet de stage, identifiez au moins un acteur de chaque couleur : c'est la base des **partenariats** (C3.3).

Type d'acteur	Définition (CNED)	Exemples nationaux	Exemples régionaux et locaux
Décideur	Est à l'origine des décisions	Parlement (lois), Gouvernement, ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé), ministère de l'Agriculture (Direction générale de l'alimentation)	ARS (projet régional de santé), conseil départemental (PMI), commune (restauration scolaire)
Consultatif	Est consulté pour prendre des décisions	Haut Conseil de la santé publique (HCSP), Conférence nationale de santé (CNS), Conseil national de l'alimentation (CNA)	Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), conseils territoriaux de santé

Type d'acteur	Définition (CNED)	Exemples nationaux	Exemples régionaux et locaux
Opérateur	Met en œuvre la politique décidée	Santé publique France, Assurance maladie (actions de prévention), associations nationales	Collectivités, CCAS, PMI, écoles, centres sociaux, structures régionales de promotion de la santé, diététiciens, associations locales
Financeur	Apporte les moyens financiers	Assurance maladie (Fonds national de prévention, d'éducation et d'information en santé, FNPEIS), État	ARS (fonds d'intervention régional, FIR), conseils départementaux et régionaux, communes, conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, mutuelles, fondations

Attention – Mettre à jour les sigles des cours anciens

Certains supports citent encore le « Haut **Comité** de santé publique », les « Conférences régionales de santé (CRS) » ou les « territoires de santé ». Depuis la loi du 9 août 2004, on parle du **Haut Conseil de la santé publique (HCSP)** ; depuis la loi HPST de 2009, de la **CRSA** ; depuis la loi du 26 janvier 2016, des **territoires de démocratie sanitaire** et des **conseils territoriaux de santé**. Utiliser le sigle à jour montre au jury que vos sources sont actualisées (C3.4).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 bis – Identifier le rôle des acteurs d'un projet

Le projet « Petits déjeuners pour tous » d'une ville de 25 000 habitants réunit : l'ARS (qui a lancé l'appel à projets et verse 6 000 €), la CRSA (qui a rendu un avis favorable sur le PRS où figure la priorité « nutrition des enfants »), la commune (qui décide d'offrir le petit déjeuner dans 4 écoles et apporte 9 000 €), l'association « Bouge et mange » (qui anime les ateliers), une diététicienne libérale (qui conçoit les menus) et une mutuelle (2 500 €).

1. Classez chaque acteur selon la typologie (un acteur peut avoir deux rôles).
2. Calculez la part de chaque financeur dans le budget total.

Corrigé – Exercice 1.3 bis

1. **ARS** : décideur (elle arrête le PRS et choisit les projets retenus) et financeur. **CRSA** : consultatif. **Commune** : décideur (pour l'école) et financeur. **Association** : opérateur. **Diététicienne** : opérateur. **Mutuelle** : financeur.
2. Budget total : 6 000 + 9 000 + 2 500 = **17 500 €**. ARS : 6 000 / 17 500 = **34,3 %** ; commune : 9 000 / 17 500 = **51,4 %** ; mutuelle : 2 500 / 17 500 = **14,3 %**. Vérification : 34,3 + 51,4 + 14,3 = 100,0 %.

Le niveau international

Organisme	Rôle en nutrition
OMS – Organisation mondiale de la santé (Genève, 1948)	Agence de l'ONU pour la santé ; définit des normes et recommandations (sucres libres < 10 % de l'apport énergétique, idéalement < 5 % – 2015 ; sel < 5 g/jour ; allaitement exclusif 6 mois) ; plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles ; Bureau régional de l'Europe (Copenhague)
FAO – Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Rome, 1945)	Sécurité alimentaire mondiale, systèmes alimentaires durables ; avec l'OMS : Conférences internationales sur la nutrition (CIN2, Rome 2014) ; Décennie d'action des Nations unies pour la nutrition (2016-2025)

Organisme	Rôle en nutrition
Codex alimentarius (FAO/OMS, 1963)	Normes alimentaires internationales (étiquetage, additifs, hygiène, contaminants)
UNICEF	Nutrition de l'enfant et de la mère ; promotion de l'allaitement (initiative « Hôpital ami des bébés » avec l'OMS)
ONU – Objectifs de développement durable (2015- 2030)	ODD 2 « Faim zéro », ODD 3 « Bonne santé et bien-être », ODD 12 « Consommation et production responsables »
Quadripartite One Health	OMS, FAO, OMSA (ex-OIE) et PNUE : plan d'action conjoint « Une seule santé » 2022-2026

Le niveau européen

Organisme	Rôle en nutrition
Commission européenne (DG SANTE)	Propose la réglementation alimentaire (règlement INCO n° 1169/2011 sur l'information des consommateurs : déclaration nutritionnelle obligatoire, 14 allergènes ; règlement n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé)
EFSA – Autorité européenne de sécurité des aliments (Parme, 2002)	Évaluation scientifique des risques alimentaires ; valeurs nutritionnelles de référence (Dietary Reference Values) ; avis sur les allégations, additifs, contaminants
Système d'alerte rapide (RASFF)	Échange d'alertes sur les denrées dangereuses entre États membres
EUFIC	Information des consommateurs sur l'alimentation (organisme financé en partie par l'industrie : vérifier les conflits d'intérêts)

Le niveau national

Acteur	Rôle
Ministère chargé de la Santé – Direction générale de la santé (DGS)	Pilote la politique de santé publique et le PNNS ; prépare les lois et règlements ; coordonne les agences
Ministère chargé de l'Agriculture – Direction générale de l'alimentation (DGAL)	Pilote le PNA et la sécurité sanitaire des aliments (contrôles, alertes) ; restauration collective (EGalim, plateforme « ma cantine »)
Ministère de l'Économie – DGCCRF	Loyauté des pratiques commerciales, étiquetage, allégations, sécurité des produits ; RappelConso (avec la DGAL)
Ministère de l'Éducation nationale	Éducation à l'alimentation dans les programmes, santé scolaire, restauration scolaire (avec les collectivités), « Écoles promotrices de santé »
Ministère de la Transition écologique	Copilote de la SNANC ; lutte contre le gaspillage (loi AGEC)
Santé publique France (2016)	Surveillance, veille et alerte ; prévention et promotion de la santé ; programme « Manger Bouger » ; Nutri-Score (gestion du logo en France) ; registre des interventions probantes ; données (Géodes)
ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (2010)	Évaluation des risques ; références nutritionnelles (ANC puis RNP, actualisation des repères 2016-2021) ; études INCA ; table Ciqual de composition des aliments ; observatoire Oqali (avec INRAE) ; nutrivigilance

Acteur	Rôle
HAS – Haute Autorité de santé (2004)	Recommandations de bonne pratique (surpoids et obésité de l'enfant 2022 et de l'adulte, dénutrition 2019 et 2021), ETP, évaluation des pratiques
HCSP – Haut Conseil de la santé publique (2004)	Expertise pour la décision publique ; avis sur les repères alimentaires (2017 adultes, 2020 enfants) ; recommandations pour le PNNS 5 (juin 2025) ; évaluation des plans
CNA – Conseil national de l'alimentation (1985)	Instance consultative de concertation entre acteurs (production, transformation, distribution, consommateurs, santé) ; avis (n° 90 sur les nouveaux comportements alimentaires)
INCa – Institut national du cancer	Prévention nutritionnelle des cancers (avec le réseau NACRe)
Assurance maladie (CNAM, CPAM)	Prévention (examens de prévention, « Mission : retrouve ton cap »), financement d'actions, données du SNDS
Recherche : Inserm, INRAE, universités, EREN (équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle)	Production de connaissances ; cohorte NutriNet-Santé (EREN, depuis 2009)
Producteurs de données statistiques : Insee, Drees, CépiDc (Inserm), FNORS et ORS, Crédoc	Données démographiques, sociales, de mortalité (causes de décès), d'état de santé, de consommation

Le niveau régional

Acteur	Rôle
ARS – Agence régionale de santé (loi HPST du 21 juillet 2009, créées en 2010)	Pilote la politique de santé en région : élabore le projet régional de santé (PRS), finance des actions de prévention (fonds d'intervention régional, FIR), lance des appels à projets (nutrition, précarité, ETP), signe les contrats locaux de santé, autorise les établissements, reçoit les déclarations des programmes d'ETP, coordonne la veille sanitaire (signalements, TIAC)
CRSA – Conférence régionale de la santé et de l'autonomie	« Parlement régional de la santé » : donne un avis sur le PRS
DRAAF – Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt	Déclinaison régionale du PNA ; reconnaissance et financement des projets alimentaires territoriaux (PAT) ; appels à projets PNA
DREETS / DDETS	Cohésion sociale, aide alimentaire (programme « Mieux manger pour tous », depuis 2023)
Conseil régional	Lycées (restauration), formation, agriculture, aménagement
Promotion Santé (structures régionales, ex-IREPS)	Appui méthodologique aux porteurs de projets, formation, centres de ressources documentaires, outils pédagogiques
ORS – Observatoire régional de la santé	Diagnostics et portraits de territoire, indicateurs locaux
Dispositifs régionaux d'appui : réseaux de prévention, CSO (centres spécialisés de l'obésité)	Appui aux professionnels, filières de soins

Le niveau départemental et local

Acteur	Rôle
Conseil départemental	Protection maternelle et infantile (PMI) ; action sociale ; aide aux personnes âgées (APA) et en situation de handicap ; collèges (restauration)

Acteur	Rôle
Communes et intercommunalités	Restauration scolaire (écoles primaires), CCAS (centres communaux d'action sociale : épiceries sociales, aide alimentaire, portage de repas), ateliers santé ville, contrats locaux de santé, PAT, politique de la ville (contrats de ville des quartiers prioritaires, « Engagements Quartiers 2030 »)
CAF – Caisse d'allocations familiales	Financement des centres sociaux (agrément « animation collective familles »), soutien à la parentalité
Éducation nationale et services de santé scolaire	Infirmiers, médecins scolaires ; comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE)
Professionnels de santé de ville	Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS, mission de prévention), centres de santé
Associations	Banques alimentaires, Restos du cœur, Secours populaire, Croix-Rouge ; associations de patients ; associations sportives ; associations d'éducation populaire ; jardins partagés
Entreprises et mutuelles	Santé au travail, restauration d'entreprise, actions de prévention des mutuelles
Diététiciens-nutritionnistes	Libéraux, salariés de collectivités, de centres sociaux, d'associations, de mutuelles, de réseaux ; chargés de missions de santé publique (référentiel du BTS 2024)

Lien diététique – Trouver les acteurs de son lieu de stage

Dès la première semaine de stage, établissez une **carte des acteurs** (fiche F1, rubrique « ressources du territoire ») : ARS et sa délégation départementale, contrat local de santé de la commune, PAT du territoire, contrat de ville si le quartier est prioritaire, structure régionale Promotion Santé, ORS, PMI, CCAS, centres sociaux, épiceries solidaires, associations. Ce travail nourrit le diagnostic, le choix des partenaires et la recherche de financements.

À retenir – Organismes de recueil et de production de données (à connaître pour l'examen)

Insee (démographie, revenus, pauvreté, recensement) ; **Drees** (état de santé, enquêtes de santé scolaire, établissements) ; **CépiDc-Inserm** (causes médicales de décès) ; **Santé publique France** (surveillance, ESTEBAN, Baromètre, Géodes, Albane) ; **ANSES** (INCA, Ciqual, Oqali) ; **Assurance maladie** (SNDS : consommations de soins, ALD) ; **ORS/FNORS** (diagnostics locaux, Score-santé) ; **Crédoc** (consommation, précarité alimentaire) ; **Inserm/EREN** (NutriNet-Santé). Leur fonctionnement et l'exploitation de leurs données sont détaillés aux chapitres 2 et 17.

La démocratie sanitaire : la place des usagers

Définition – Démocratie sanitaire

Démarche qui vise à **associer l'ensemble des acteurs du système de santé**, et en particulier les **usagers** (patients, habitants, associations), à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de dialogue et de concertation (définition du ministère chargé de la santé).

La **loi n° 2002-303 du 4 mars 2002** relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite **loi Kouchner**, est le texte fondateur. Elle répond à une crise de confiance née d'affaires sanitaires (sang contaminé

dans les années 1980). Elle reconnaît aux malades et à leurs associations deux catégories de droits, complétées par la loi HPST de 2009 et par la loi du 26 janvier 2016.

Droits individuels (reconnus à toute personne dans sa relation avec le système de santé)	Droits collectifs (reconnus aux usagers en tant que groupe)
Accès aux soins et à la prévention, sans discrimination	Représentation des usagers par des **associations agréées**
Respect de la dignité et de la vie privée ; secret des informations	Présence de représentants des usagers dans les instances des établissements (commission des usagers)
Information sur son état de santé ; **consentement libre et éclairé**	Participation aux instances consultatives nationales, régionales et territoriales
Accès direct à son dossier médical	Participation à l'élaboration des politiques de santé (avis sur le PRS, débats publics)
Prise en charge de la douleur ; désignation d'une personne de confiance	Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, **France Assos Santé** (créée par la loi de 2016, active depuis 2017)

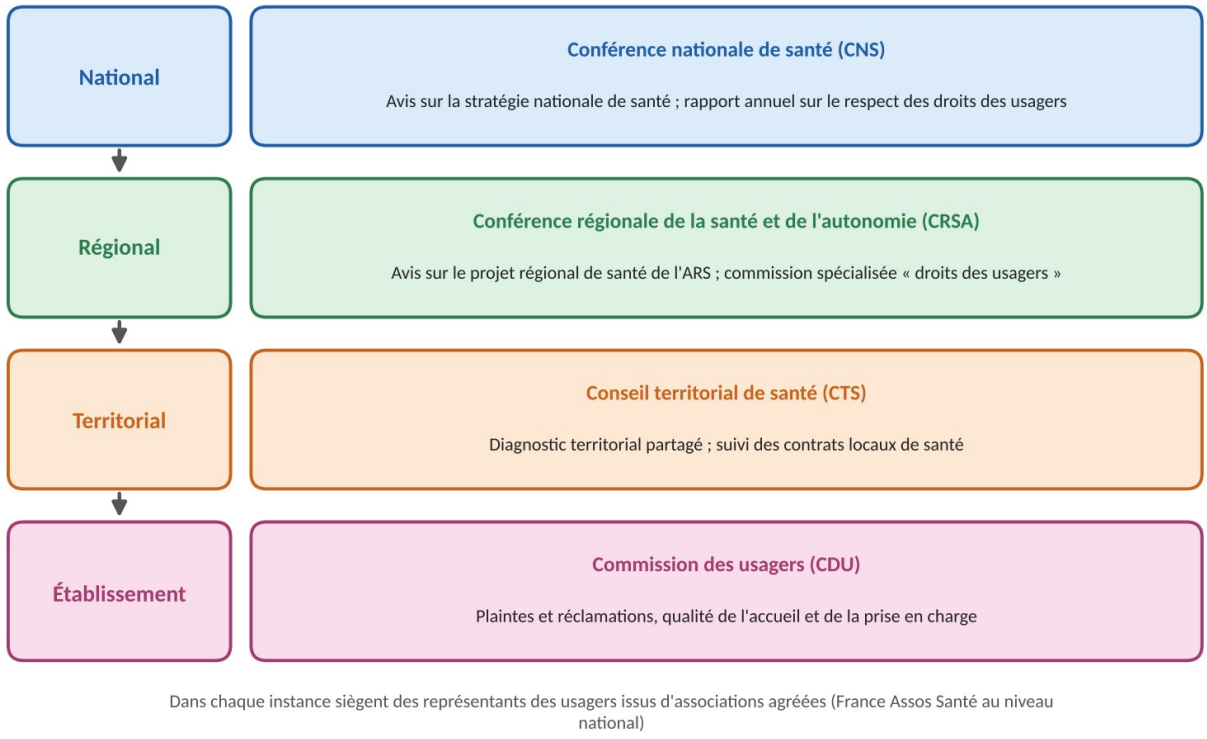


Figure 1.8 ter – Les instances de la démocratie sanitaire, du national à l'établissement

Comprendre le schéma – Figure 1.8 ter

1. Chaque **niveau** du système de santé (à gauche) a son instance de concertation (à droite).
2. **National** : la Conférence nationale de santé donne son avis sur la stratégie nationale de santé et rend chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers.
3. **Régional** : la CRSA, créée par la loi HPST, donne son avis sur le projet régional de santé de l'ARS.
4. **Territorial** : le conseil territorial de santé, créé par la loi de 2016, participe au diagnostic territorial partagé et suit les contrats locaux de santé.
5. **Établissement** : la commission des usagers (CDU) examine les plaintes et propose des améliorations de l'accueil et de la prise en charge.
6. Les flèches indiquent la déclinaison du national vers le local ; dans toutes ces instances siègent des représentants des usagers.

Lien diététique – Pourquoi la démocratie sanitaire concerne le diététicien en santé publique

La démocratie sanitaire justifie la **participation des habitants** à toutes les étapes d'un projet : recueil des besoins exprimés, choix des recettes d'un atelier, évaluation. Le principe de **participation** de la Charte d'Ottawa et la démocratie sanitaire vont dans le même sens. À l'oral, dire « j'ai associé deux mères de famille au comité de pilotage » est un argument fort.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 ter – Droits individuels ou collectifs ?

Classez chaque situation et nommez l'instance ou le droit concerné.

a) Une patiente demande à lire les comptes rendus de ses consultations diététiques à l'hôpital.

b) L'association départementale des diabétiques désigne un représentant pour siéger à la commission des usagers de l'hôpital.

c) La CRSA rend un avis sur le projet régional de santé 2023-2028.

d) Un résident d'EHPAD refuse l'enrichissement de ses repas après avoir reçu des explications.

Corrigé – Exercice 1.3 ter

a) **Droit individuel** : accès direct au dossier médical (loi du 4 mars 2002). Les transmissions diététiques font partie du dossier.

b) **Droit collectif** : représentation des usagers par une association agréée au sein de la **commission des usagers**.

c) **Droit collectif** : participation à l'élaboration de la politique régionale via une instance consultative, la **CRSA**.

d) **Droit individuel** : consentement libre et éclairé ; le refus doit être respecté, tracé, et la proposition renouvelée sous une autre forme (chapitre 6, éthique).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.5 – Les acteurs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre types d'acteurs selon le CNED et donnez un exemple de chacun.
2. Quel organisme pilote la veille sanitaire en France ? Depuis quand ?
3. Quel organisme évalue les risques sanitaires liés à l'alimentation et gère la table Ciqual ?
4. Citez trois droits individuels et deux droits collectifs reconnus par la loi du 4 mars 2002.
5. Nommez l'instance de démocratie sanitaire au niveau national, régional, territorial et dans un hôpital.
6. Calcul : un projet reçoit 4 200 € de l'ARS, 2 800 € de la commune et 1 000 € d'une fondation. Quelle est la part de l'ARS ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.5

1. Décideur : ARS, ministère. Consultatif : HCSP, CNS, CRSA. Opérateur : Santé publique France, associations, diététicien. Financeur : Assurance maladie, ARS (fonds d'intervention régional), collectivités.
2. Santé publique France, créée le 1er mai 2016 (regroupement de l'InVS, de l'INPES, de l'EPRUS et d'Adalis).
3. L'ANSES (créée en 2010).
4. Individuels : accès aux soins ; information et consentement libre et éclairé ; accès direct au dossier médical ; secret ; prise en charge de la douleur. Collectifs : représentation par des associations agréées ; présence dans les instances (commission des usagers, CRSA, CNS).
5. National : Conférence nationale de santé. Régional : CRSA. Territorial : conseil territorial de santé. Hôpital : commission des usagers.

6. Total : 4 200 + 2 800 + 1 000 = 8 000 €. Part de l'ARS : 4 200 / 8 000 × 100 = 52,5 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.6 Les politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre et déclinaison territoriale

Module · Référentiel : activité 3.1 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14) ; Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15) ; Essentiels M1 S3 §2 et §3 (p. 16)

Qu'est-ce qu'une politique publique de santé ?

Définition – Politique publique

Ensemble coordonné de décisions et d'actions conduites par les pouvoirs publics (État, collectivités) pour répondre à un **problème reconnu comme public**, avec des **objectifs**, des **moyens** (juridiques, financiers, humains) et des **acteurs** chargés de sa mise en œuvre. Elle se traduit par des **lois**, des **stratégies**, des **plans** ou **programmes**, des **règlements** et des **financements**.

Outil	Définition	Exemples en nutrition
Loi	Texte voté par le Parlement, de portée générale et obligatoire	Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (création des distributeurs interdits dans les écoles, inscription du PNNS) ; loi EGalim (2018) ; loi Climat et résilience (2021)
Règlement (décret, arrêté)	Texte du Gouvernement ou d'un ministre qui précise l'application d'une loi	Arrêté du 31 octobre 2017 sur le Nutri-Score, modifié par l'arrêté du 14 mars 2025 (nouvel algorithme) ; décret du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas scolaires
Stratégie	Cadre pluriannuel qui fixe les grandes orientations et priorités	Stratégie nationale de santé (dernière adoptée : 2018-2022) ; SNANC 2025-2030
Plan ou programme	Déclinaison opérationnelle d'une stratégie, avec des actions, des pilotes, un calendrier, des indicateurs	PNNS 5 2026-2030 ; PNA 4 2026-2030
Financement	Crédits attribués aux acteurs	Fonds d'intervention régional des ARS ; appels à projets PNA ; programme « Mieux manger pour tous »

Les étapes d'une politique publique

1. Mise à l'agenda : un problème devient « public » sous l'effet de données (surveillance épidémiologique), d'alertes d'experts (avis du HCSP), de médias, d'associations, d'événements (crise sanitaire). Exemple : l'augmentation de la prévalence de l'obésité infantile dans les années 1990 conduit au premier PNNS en 2001.

2. Élaboration : diagnostic, consultation des experts (HCSP, ANSES, CNA), concertation des parties prenantes, consultation publique (le projet de SNS 2023-2033 a fait l'objet d'une consultation publique à l'automne 2023 ; il n'était pas encore adopté en mai 2026), arbitrages interministériels.

3. Décision et adoption : loi, décret, publication d'une stratégie ou d'un programme.

4. Mise en œuvre : par les administrations centrales, les agences, les **ARS** et les collectivités, avec des **financements** et des **partenaires** (associations, professionnels).

5. Pilotage et suivi : comités de pilotage, indicateurs, tableaux de bord, rapports annuels.

6. Évaluation : par des instances indépendantes (HCSP, Inspection générale des affaires sociales – IGAS, Cour des comptes) ; elle prépare le plan suivant. Exemple : l'évaluation du PNNS 4 et l'avis du HCSP de juin 2025 ont servi à construire le PNNS 5.

L'organisation de la politique de santé en France

- **La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé** a fait de la **prévention** et de la **promotion de la santé** des priorités de la politique de santé et a créé le **Nutri-Score** (article 14 : possibilité d'un étiquetage nutritionnel simplifié, facultatif).
- **La Stratégie nationale de santé (SNS)** (article L. 1411-1-1 du Code de la santé publique) fixe les priorités de la politique de santé pour plusieurs années. La dernière SNS adoptée couvre **2018-2022** (décret du 29 décembre 2017). Le **projet de SNS 2023-2033**, soumis à consultation à l'automne 2023, met l'accent sur la prévention tout au long de la vie, l'accès aux soins, la réduction des inégalités et la santé environnementale (« Une seule santé ») ; selon une réponse du ministère publiée au *Journal officiel* le 12 mai 2026, il n'avait pas encore été adopté par le Gouvernement. Dans un dossier, on s'appuie donc sur la SNANC 2025-2030 et le PNNS 5, et l'on présente la SNS 2023-2033 comme un projet.
- **Le Comité interministériel pour la santé** (créé en 2014) coordonne les politiques des différents ministères ayant un impact sur la santé.
- **Les agences sanitaires** (Santé publique France, ANSES, HAS) apportent l'expertise et la mise en œuvre opérationnelle.

Priorités, programmes et planification sanitaire

Définition – Les mots de la planification

Priorité sanitaire : décision des pouvoirs publics de mettre en place des mesures pour résoudre un problème de santé identifié (par exemple, le surpoids des enfants).

Plan ou **programme** : ensemble organisé d'actions, avec des objectifs, des acteurs, des partenaires, des moyens et un calendrier, pour atteindre un objectif commun (le PNNS est un programme ; les plans nationaux durent en général 4 à 5 ans).

Planification sanitaire : démarche qui consiste à **prévoir** les actions à mener pour atteindre des objectifs de santé, **selon un ordre de priorité**, en adaptant l'offre de soins et de prévention aux besoins de la population. Elle doit respecter le cadre fixé par la **stratégie nationale de santé** ; dans chaque région, c'est l'ARS qui la conduit au travers du PRS.

Territoire de démocratie sanitaire : découpage de la région, arrêté par l'ARS depuis la loi du 26 janvier 2016, à l'échelle duquel siège un conseil territorial de santé. Il a remplacé les anciens « territoires de santé ».

Méthode – La logique descendante et la logique ascendante

La planification est **descendante** : la SNS fixe les priorités, le PRS les décline, le contrat local de santé les traduit en fiches-actions. Mais elle est aussi **ascendante** : les diagnostics locaux (diagnostic territorial partagé, observatoire régional de santé) remontent les besoins, et les instances de démocratie sanitaire donnent leur avis. Un bon projet de stage montre les **deux logiques** : « mon action répond à la priorité n° X du PRS » (descendant) et « elle répond aux besoins exprimés par les habitants » (ascendant).

Les données qui éclairent les politiques de santé

Une politique se décide à partir de données. Les grands producteurs de données et les enquêtes nutritionnelles sont étudiés au chapitre 17. Retenez ici deux dispositifs souvent cités dans les cours.

Dispositif	Ce que c'est	Intérêt pour la santé publique
Système national des données de santé (SNDS)	Base qui rassemble, depuis la loi du 26 janvier 2016, les données de l'Assurance maladie (remboursements, SNIIRAM), des hôpitaux (PMSI) et les causes médicales de décès (Inserm-CépiDc) ; il est géré par la Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam)	Connaître le recours aux soins, le nombre de personnes traitées pour un diabète, l'évolution d'une maladie dans un territoire
Plateforme des données de santé (Health Data Hub)	Groupement d'intérêt public créé par la loi du 24 juillet 2019 ; il a remplacé l'Institut national des données de santé (INDS, 2017-2019)	Faciliter l'accès sécurisé des chercheurs et des agences aux données de santé, dans le respect du RGPD (chapitre 20)

Attention – Une donnée de remboursement n'est pas une donnée de santé complète

Le SNDS compte les personnes **traitées** et **remboursées**. Une personne diabétique non diagnostiquée, ou qui ne consulte pas, n'y figure pas. Pour l'obésité, qui ne donne pas lieu à un remboursement spécifique, on utilise surtout des **enquêtes** (Esteban, OFÉO, santé scolaire). Il faut toujours dire **d'où vient** un chiffre et **ce qu'il mesure** (C3.4).

La déclinaison territoriale

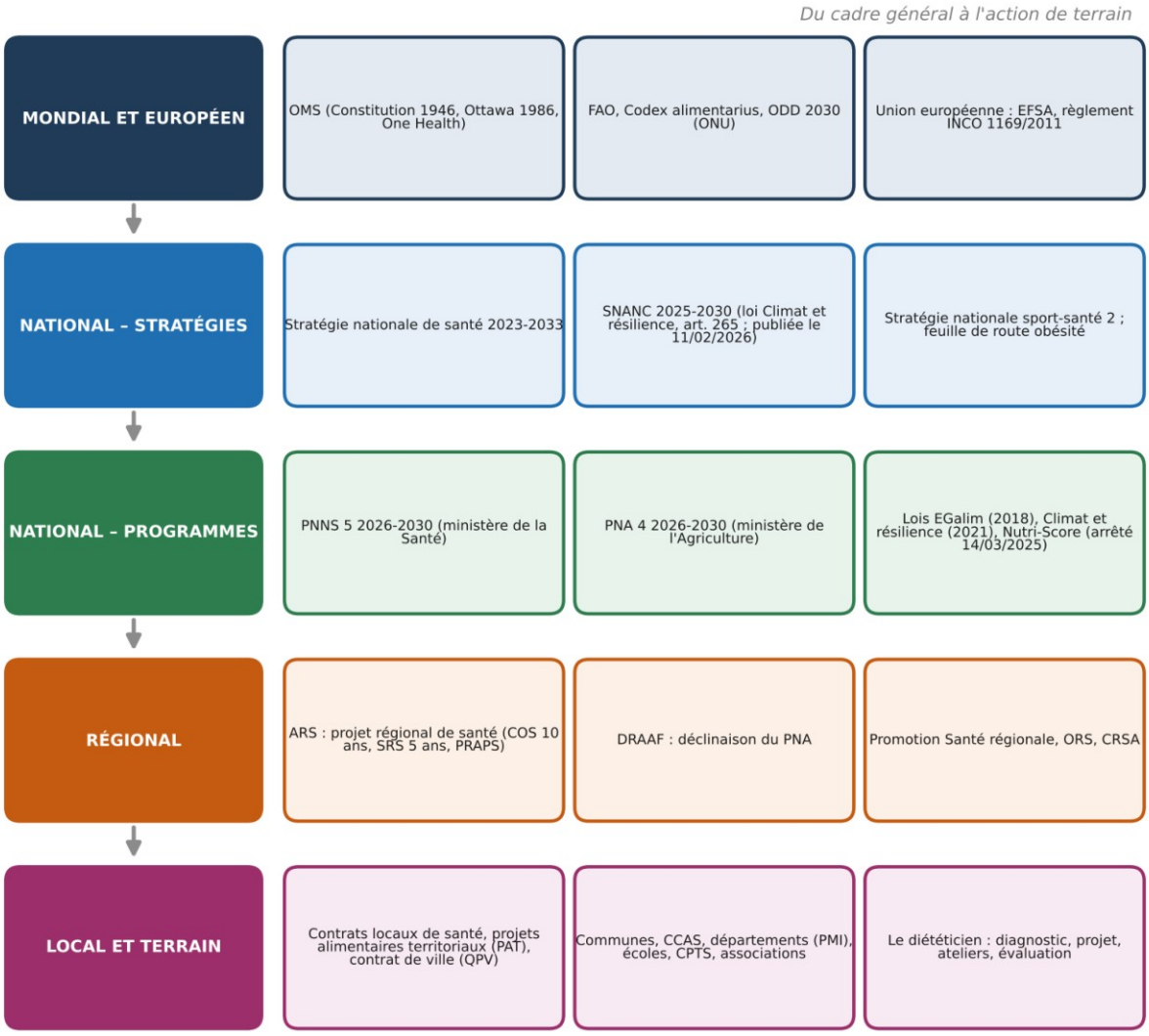


Figure 1.9 – De la stratégie internationale à l'action de terrain : architecture des politiques nutritionnelles en 2026

Comprendre le schéma – Figure 1.9

1. Mondial et européen : l'OMS, la FAO, les ODD et l'Union européenne fixent un cadre (définitions, recommandations, réglementation de l'étiquetage).

2. National – stratégies : la SNS fixe les priorités de santé (dernière adoptée : 2018-2022 ; projet 2023-2033 non adopté en mai 2026) ; la SNANC 2025-2030 relie alimentation, nutrition et climat ; d'autres stratégies complètent (sport-santé, obésité).

3. National – programmes : le PNNS 5 (Santé) et le PNA 4 (Agriculture) déclinent la SNANC en actions ; les lois (EGalim, Climat et résilience) et les règlements (Nutri-Score) les rendent obligatoires.

4. Régional : l'ARS traduit ces orientations dans le PRS ; la DRAAF décline le PNA ; les structures régionales de promotion de la santé et l'ORS apportent l'appui méthodologique et les données.

5. Local et terrain : contrats locaux de santé, PAT, contrats de ville, communes, CCAS, PMI, écoles, CPTS et associations mettent en œuvre ; le diététicien conçoit et anime les actions et les évalue.

6. Les flèches montrent que chaque niveau **s'appuie** sur le niveau supérieur : en stage, vous devez pouvoir relier votre action locale à ces différents textes.

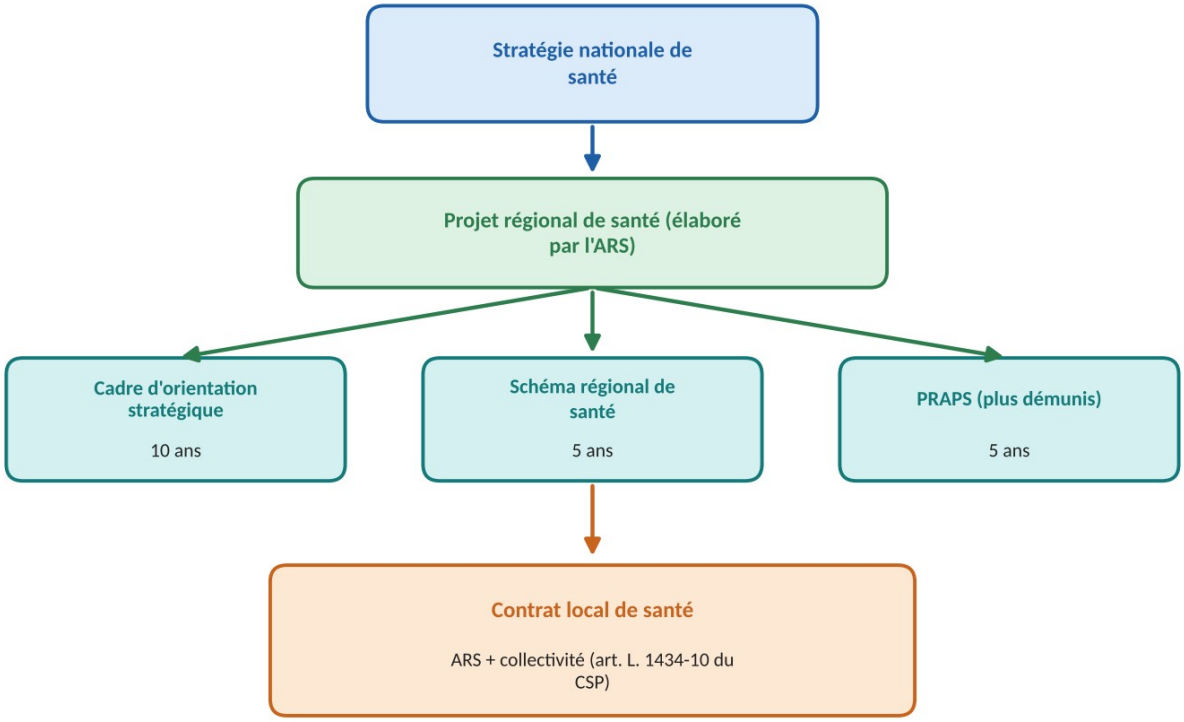


Figure 1.9 bis – De la stratégie nationale au contrat local de santé

Comprendre le schéma – Figure 1.9 bis

1. En haut, la **stratégie nationale de santé** fixe les priorités (dernière adoptée : 2018-2022 ; le projet 2023-2033 n'était pas adopté en mai 2026).
2. Chaque **ARS** élabore un **projet régional de santé** qui la décline dans la région.
3. Le PRS comprend trois documents : le **cadre d'orientation stratégique** (10 ans), le **schéma régional de santé** (5 ans) et le **PRAPS** pour les plus démunis (5 ans).
4. En bas, le **contrat local de santé** est signé entre l'ARS et une collectivité ; il traduit le PRS en fiches-actions sur un territoire (article L. 1434-10 du Code de la santé publique).
5. Un projet de stage cite au moins le **niveau régional** (objectif du PRS) et, s'il existe, le **CLS** du territoire.

Dispositif	Contenu
Projet régional de santé (PRS) – art. L. 1434-1 CSP	Élaboré par l'ARS ; comprend un cadre d'orientation stratégique (COS) sur 10 ans, un schéma régional de santé (SRS) sur 5 ans (prévention, offre de soins, médico-social) et un programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS). Les PRS dits « de 3e génération » couvrent généralement la période 2023-2028 (COS jusqu'en 2033)
Contrat local de santé (CLS) – art. L. 1434-10 CSP	Contrat entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants ; volet nutrition fréquent
Projet alimentaire territorial (PAT) – loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014	Démarche collective qui rapproche producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités et consommateurs pour développer une alimentation locale, durable et accessible ; reconnu par le ministère de l'Agriculture ; au 1er juillet 2025, environ 450 PAT étaient reconnus et la SNANC fixe l'objectif d'au moins 80 % du territoire couvert

Dispositif	Contenu
Contrat de ville (politique de la ville)	Concerne les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ; nouvelle génération « Engagements Quartiers 2030 » (2024-2030) ; volet santé souvent porté par un atelier santé ville (ASV)
Conseil local de santé mentale, CPTS, MSP	Coordination des acteurs de santé de proximité

Exemple – Comment une orientation nationale devient une action dans un quartier

1. National : le PNNS 5 (2026-2030) fait de la réduction des inégalités sociales en nutrition et de la santé des enfants des priorités ; il se donne pour objectif de réduire de 30 % la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (20 % chez ceux issus de familles défavorisées).

2. Régional : le PRS de l'ARS inscrit la nutrition des enfants dans les quartiers prioritaires parmi ses priorités de prévention et lance chaque année un **appel à projets** « prévention – promotion de la santé ».

3. Local : le contrat local de santé de la commune de Valmont (fictive) prévoit une fiche-action « Bien manger dans les quartiers ».

4. Terrain : le centre social des Tilleuls répond à l'appel à projets avec l'appui d'une diététicienne et d'une stagiaire de BTS ; il obtient une subvention de 1 500 € (cas fil rouge, fiche F4).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.4

Pour votre futur lieu de stage (ou, à défaut, pour votre commune), recherchez sur internet : a) le PRS de votre région et l'objectif qui concerne la nutrition ; b) l'existence d'un contrat local de santé ; c) l'existence d'un PAT ; d) la présence de quartiers prioritaires (site de l'ANCT, *sig.ville.gouv.fr*). Présentez le résultat dans un tableau de 4 lignes : dispositif / existe ? / référence (titre, date) / ce qui concerne la nutrition.

Corrigé – Méthode de correction

- Le PRS se trouve sur le site de l'ARS (rubrique « Projet régional de santé ») ; repérez dans le **SRS** le chapitre « prévention » ou « nutrition » et notez l'objectif précis, avec sa date.
- Les CLS sont listés sur le site de l'ARS ou de la collectivité ; vérifiez qu'il est **en cours** (dates de début et de fin).
- Les PAT sont recensés sur le site du ministère de l'Agriculture et sur France PAT (Réseau national des PAT, RnPAT).
- Les QPV se vérifient sur le système d'information géographique de la politique de la ville (*sig.ville.gouv.fr*), à partir d'une adresse.
- Exemple de ligne rédigée : « CLS de Valmont 2024-2028 – oui – fiche-action 3 "Bien manger dans les quartiers" – actions d'éducation alimentaire dans les centres sociaux, financement ARS. » Chaque ligne doit comporter un **titre**, une **date** et une **source** : c'est l'attendu de l'indicateur « sources d'informations fiables repérées et connues » (C3.4).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.6 – Politiques publiques et territoires

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les étapes d'une politique publique.

2. Que fixe la stratégie nationale de santé ? Où en est la SNS 2023-2033 ?

3. Citez les trois composantes du projet régional de santé et leur durée.

4. Qu'est-ce qu'un contrat local de santé ? Qui le signe ?

5. Définissez la planification sanitaire.

6. Vrai ou faux : « Le SNDS permet de connaître le nombre exact de personnes en situation d'obésité. » Justifiez.

Corrigé – Point d'étape 1.3.6

1. Mise à l'agenda ; élaboration ; décision et adoption ; mise en œuvre ; pilotage et suivi ; évaluation (qui prépare le plan suivant).

2. Elle fixe les priorités de la politique de santé ; la dernière adoptée couvre 2018-2022, et le projet 2023-2033 n'était pas encore adopté en mai 2026.

3. Cadre d'orientation stratégique (10 ans), schéma régional de santé (5 ans), programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS).

4. Un contrat entre l'ARS et une collectivité (commune ou intercommunalité) pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants.

5. Démarche qui consiste à prévoir les actions à mener pour atteindre des objectifs de santé, selon un ordre de priorité, dans le cadre de la stratégie nationale de santé.

6. Faux : le SNDS contient des données de remboursement et d'hospitalisation ; l'obésité n'est pas repérée par un remboursement spécifique. On utilise des enquêtes (Esteban, OFÉO).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.7 Les politiques nutritionnelles de santé publique

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §2 (p. 29)

Pourquoi une politique nutritionnelle ? Les enjeux en chiffres

La nutrition (alimentation et activité physique) est un **déterminant majeur** des principales maladies chroniques : obésité, diabète de type 2, maladies cardio-neurovasculaires, plusieurs cancers, ostéoporose, et, à l'autre extrémité, dénutrition et carences. Ces maladies sont **fréquentes**, **graves**, **coûteuses** et **socialement inégalitaires** : elles justifient une politique publique.

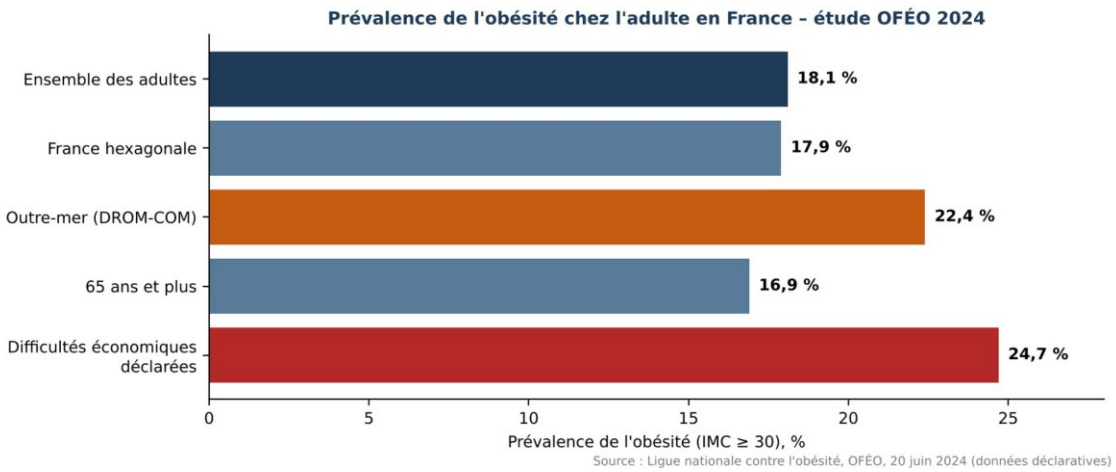


Figure 1.10 – Prévalence de l'obésité chez l'adulte en France selon le territoire, l'âge et la situation économique (OFÉO, 2024)

Comprendre le schéma – Figure 1.10

1. En 2024, **18,1 %** des adultes vivant en France déclarent un IMC ≥ 30 kg/m², soit environ **10 millions** de

personnes (étude OFÉO de la Ligue nationale contre l'obésité, présentée le 20 juin 2024, successeur de l'étude ObÉpi-Roche 2020 qui trouvait 17 %).

2. La prévalence est plus élevée **en outre-mer** (22,4 %) qu'en France hexagonale (17,9 %) : c'est une **inégalité territoriale**.
3. Elle atteint **24,7 %** chez les personnes déclarant des **difficultés économiques** : c'est une **inégalité sociale**.
4. Ces données sont **déclaratives** (poids et taille déclarés), ce qui sous-estime en général la prévalence ; les données **mesurées** de l'étude ESTEBAN (2014-2016) donnaient 17 % d'obésité et 49 % de surpoids (obésité comprise) chez les 18-74 ans.
5. Lecture pour le diététicien : ces écarts justifient le principe d'**universalisme proportionné** et la priorité donnée par le PNNS 5 aux enfants des familles défavorisées et aux territoires ultramarins.

Indicateur	Valeur et source
Obésité de l'adulte (déclarée)	18,1 % en 2024 ; 22,4 % en outre-mer ; 24,7 % en cas de difficultés économiques (OFÉO, Ligue nationale contre l'obésité, juin 2024)
Surpoids (obésité comprise) et obésité mesurés, adultes 18-74 ans	49 % dont 17 % d'obésité (ESTEBAN 2015, Santé publique France, 2017)
Surpoids (obésité comprise) des enfants de 6 à 17 ans	17 % dont 4 % d'obésité (ESTEBAN 2015)
Adultes atteignant les 5 fruits et légumes par jour	environ 30 % des adultes et 20 % des enfants (HCSP, recommandations pour le PNNS 5, juin 2025)
Apports en fibres	90 % des adultes n'atteignent pas 25 g/jour (HCSP, juin 2025)
Viande rouge	4 hommes sur 10 et 1 femme sur 4 dépassent le repère de 500 g par semaine (HCSP, juin 2025)
Sel	Consommation moyenne d'environ 9 g/jour chez l'homme et 7 g/jour chez la femme (INCA 3, ANSES 2017), pour un repère OMS < 5 g/jour
Activité physique des jeunes	42 % des 6-17 ans atteignaient 60 minutes par jour en 2016 ; près d'un adulte sur trois reste assis plus de 7 heures par jour en 2024 (HCSP, juin 2025)
Précarité alimentaire	16 % des Français déclarent ne pas avoir assez à manger (souvent ou parfois) en 2022, contre 9 % en 2016 (Crédoc, 2023)
Espérance de vie à la naissance (2025)	85,9 ans pour les femmes, 80,3 ans pour les hommes (Insee, Bilan démographique 2025, janvier 2026)
Inégalités sociales de mortalité	Environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % d'hommes les plus aisés et les 5 % les plus modestes (Insee Première n° 1687, février 2018)
Vieillissement	22,2 % de la population a 65 ans ou plus au 1er janvier 2026 (Insee) : enjeu de prévention de la dénutrition

Attention – Bien lire un chiffre de santé publique

Avant de citer un chiffre dans un dossier, vérifiez : **l'année** de recueil (et pas seulement l'année de publication) ; la **population** (adultes ? 18-74 ans ? France entière ?) ; la **méthode** (mesuré ou déclaré) ; la **source** (institutionnelle, associative, industrielle). Par exemple, 17 % d'obésité (ESTEBAN, mesuré, 2015) et 18,1 % (OFÉO, déclaré, 2024) ne sont pas directement comparables.

Historique : du PNNS 1 au PNNS 5

Période	Repères principaux
2001-2005 – PNNS 1	Lancé en janvier 2001 à la suite des États généraux de l'alimentation (2000) et du rapport du HCSP ; 9 objectifs nutritionnels prioritaires chiffrés (augmenter la consommation de fruits et légumes, de calcium, de glucides complexes et de fibres ; réduire les lipides totaux sous 35 % de l'apport énergétique et les acides gras saturés ; réduire l'alcool, la cholestérolémie, la pression artérielle ; réduire de 20 % l'obésité de l'adulte et stopper l'augmentation chez l'enfant ; augmenter l'activité physique) ; guide « La santé vient en mangeant » (2002)
2004	Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : le PNNS devient un programme quinquennal inscrit dans la loi ; interdiction des distributeurs automatiques payants de boissons et produits alimentaires dans les établissements scolaires (à partir de 2005) ; messages sanitaires obligatoires sur les publicités alimentaires (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », 2007)
2006-2010 – PNNS 2	Actions sur l'offre alimentaire : chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnel des industriels (2008) ; création de l'Oqali (2008) ; actions auprès des populations défavorisées
2010	Loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 : création du Programme national pour l'alimentation (PNA) ; Plan obésité 2010-2013
2011-2015 (prolongé jusqu'en 2018) – PNNS 3	Réduction des inégalités sociales de santé en nutrition ; activité physique ; dénutrition ; articulation avec le Plan obésité
2016	Loi de modernisation de notre système de santé : base légale du Nutri-Score (adopté en France par arrêté du 31 octobre 2017)
2017	Avis du HCSP sur la révision des repères alimentaires des adultes (février) ; actualisation des repères par l'ANSES (décembre 2016) ; résultats d'INCA 3 et d'ESTEBAN
2018	Loi EGalim (30 octobre 2018)
2019-2023 – PNNS 4	Lancé en septembre 2019 ; 5 axes, 55 actions ; nouveaux repères alimentaires de Santé publique France (janvier 2019) ; extension du Nutri-Score ; PNA 3 (2019-2023) ; PNNS 4 et PNA 3 réunis dans le Programme national de l'alimentation et de la nutrition (PNAN)
2021	Loi Climat et résilience (22 août 2021) : prévoit une stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (article 265) ; menu végétarien hebdomadaire pérennisé en restauration scolaire
2025	Avis du HCSP pour le PNNS 5 (juin) ; nouvel algorithme du Nutri-Score (arrêté du 14 mars 2025) ; lancement de l'enquête Albane (juin)
2026	SNANC 2025-2030 publiée le 11 février 2026 ; PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés le 8 avril 2026 au One Health Summit de Lyon

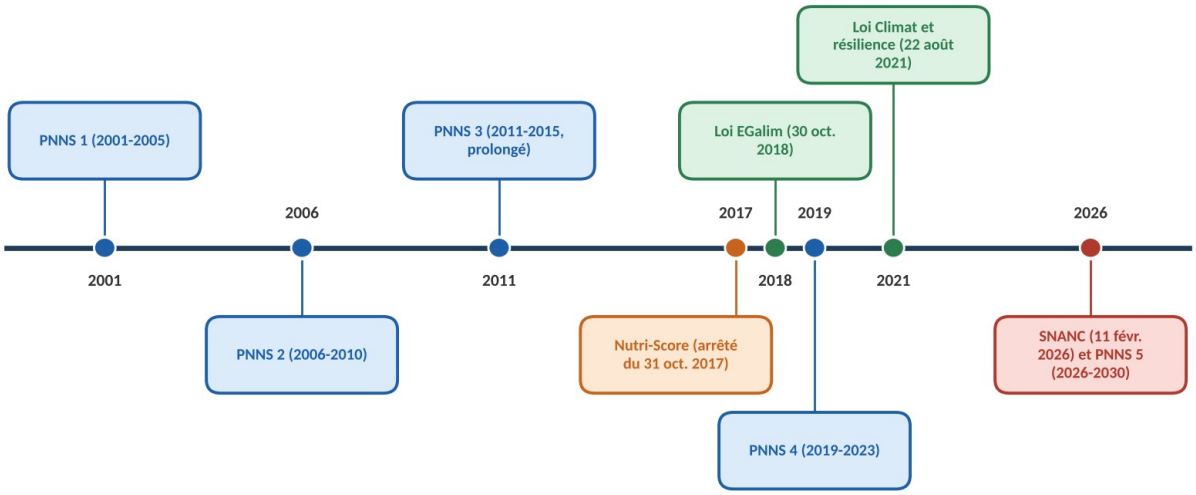


Figure 1.10 bis – Vingt-cinq ans de politiques nutritionnelles en France (2001-2026)

Comprendre le schéma – Figure 1.10 bis

1. En **bleu**, les cinq programmes nationaux nutrition santé : ils se succèdent depuis 2001.
2. En **orange**, le **Nutri-Score**, adopté en France par l'arrêté du 31 octobre 2017.
3. En **vert**, les lois qui agissent sur l'offre alimentaire : **EGalim** (30 octobre 2018) et **Climat et résilience** (22 août 2021).
4. En **rouge**, l'étape actuelle : la **SNANC**, publiée le 11 février 2026, et le **PNNS 5** (2026-2030).
5. La frise montre une évolution : on est passé d'une politique de **messages** (PNNS 1) à une politique qui agit aussi sur l'**environnement alimentaire** et le **climat**.

La Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) 2025-2030

Définition – SNANC

Stratégie prévue par l'**article 265 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021** portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi « Climat et résilience »). Elle fixe les **orientations de la politique de l'alimentation durable**, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et alimentaires et garante de la souveraineté alimentaire, ainsi que les orientations de la **politique de la nutrition**. Elle détermine les orientations du **PNNS** et du **PNA**. Attendue en 2023, elle a été publiée le **11 février 2026** pour la période **2025-2030**.

La SNANC articule **trois enjeux** : **santé publique**, **transition écologique** et **souveraineté alimentaire**. Elle s'organise autour de trois grands axes (présentation gouvernementale du 11 février 2026) :

1. Permettre à tous l'accès à une alimentation plus saine : renforcer la prévention nutritionnelle, encourager des produits de qualité, diversifiés et durables, lutter contre la précarité alimentaire, améliorer l'information du consommateur.

2. Réduire l'impact de l'alimentation sur le climat : pratiques agricoles durables, réduction du gaspillage alimentaire, relocalisation de certaines productions, adaptation de toute la chaîne alimentaire au changement climatique.

3. Soutenir les agriculteurs et les filières : transition agroécologique, valorisation des productions françaises, résilience et innovation. Elle insiste sur l'**action territoriale** (objectif d'au moins **80 % du territoire couvert par des PAT**) et rappelle les obligations EGalim en restauration collective. Le PNNS 5 et le PNA 4 en sont les **déclinaisons opérationnelles**.

Le Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5)

État de la veille – PNNS 5 – ce qu'il faut savoir (état au 26 octobre 2026)

- **Pilotage** : ministère chargé de la Santé (DGS), en articulation interministérielle avec le PNA 4 ; programme élaboré avec l'IGAS, le CGAAER, le HCSP et une large concertation (ARS, société civile, chercheurs).
- **Trois axes** : 1) « garantir à tous l'accès à des environnements nutritionnels durables favorables à la santé » ; 2) « encourager des comportements nutritionnels sains et durables » ; 3) « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé » (entreprises, établissements scolaires et d'enseignement supérieur).
- **20 mesures** (contre 55 actions dans le PNNS 4), dont des actions spécifiques pour les **enfants et adolescents** et pour les **territoires ultramarins**.
- **Objectifs chiffrés annoncés** : réduire de **30 %** la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (et de **20 %** chez ceux issus de familles défavorisées) ; atteindre **12 %** de consommation de produits bio ; **40 %** des Français utilisant le Nutri-Score (contre 33 %) et **75 %** du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score (contre 62 %) ; **85 %** d'enfants allaités à la naissance.
- **Mesures phares** : protection des enfants face au marketing alimentaire (charte ARCOM 2025-2029, réflexion sur des restrictions autour des écoles) ; accord collectif demandé aux filières pour réduire les **sucres** dans les produits destinés aux enfants (viennoiseries, biscuits) ; Nutri-Score étendu (non-préemballé, restauration hors foyer en test) ; promotion de l'allaitement et alimentation des « 1000 premiers jours » ; prévention de la **dénutrition** des personnes âgées ; **nouvelles recommandations alimentaires saines et durables** pour la population générale et des publics spécifiques (femmes en désir de grossesse, personnes âgées…).
- **Ce qui change** : l'activité physique relève désormais principalement de la **Stratégie nationale sport- santé** et la prise en charge de l'obésité d'une feuille de route dédiée ; les aliments **ultra-transformés** sont reconnus comme un enjeu majeur, l'ANSES étant chargée d'en proposer une définition opérationnelle.

Sources : présentation officielle du 8 avril 2026 et synthèses publiées (Réseau national nutrition santé, Vidal, avril 2026). **À vérifier dans le texte intégral** sur le site du ministère de la Santé ou sur mangerbouger.fr avant toute citation chiffrée dans un dossier.

Le Programme national pour l'alimentation 2026-2030 (PNA 4)

Piloté par le **ministère de l'Agriculture**, le PNA (créé par la loi du 27 juillet 2010, art. L. 1 du Code rural et de la pêche maritime) décline la SNANC sur les volets **offre alimentaire**, **restauration collective**, **lutte contre le gaspillage**, **éducation alimentaire** (notamment à l'école) et **justice sociale** (accès de tous à une alimentation de qualité). Il soutient les **PAT** et lance des **appels à projets** nationaux et régionaux (via les DRAAF) dont peuvent bénéficier des projets d'éducation alimentaire.

Les repères alimentaires en vigueur (adultes)

Les repères de **Santé publique France (janvier 2019)**, issus de l'avis du HCSP (février 2017) et de l'actualisation de l'ANSES (décembre 2016), sont présentés sur **mangerbouger.fr** en trois catégories :

Catégorie	Repères
Augmenter	Fruits et légumes : au moins 5 portions par jour (une portion ≈ 80 à 100 g) ; légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches) : au moins 2 fois par semaine ; fruits à coque sans sel ajouté : une petite poignée par jour ; activité physique : au moins 30 minutes d'activité dynamique par jour
Aller vers	Féculents complets (pain, pâtes, riz) : au moins un par jour ; huiles de colza, de noix, d'olive ; poisson : 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; produits laitiers : 2 par jour ; aliments de saison et produits locaux, bio si possible ; fait maison

Catégorie	Repères
Réduire	Alcool : au maximum 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours sans consommation ; boissons sucrées (sodas, jus de fruits) : au maximum un verre par jour ; produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés ; charcuterie : 150 g par semaine maximum ; viande (hors volaille) : 500 g par semaine maximum ; sel ; temps passé assis

Attention – Repères et populations spécifiques

Les repères ci-dessus concernent les **adultes**. Il existe des repères spécifiques pour les **enfants de 0 à 17 ans** (HCSP, juin 2020 ; déclinaisons Santé publique France), les **femmes enceintes et allaitantes** et les **personnes âgées** (ANSES 2019 ; révisions annoncées par le PNNS 5). En atelier, adaptez toujours les messages au public (chapitres 4 et 10).

Les autres leviers réglementaires et programmes

Levier	Contenu
Loi EGalim (n° 2018-938 du 30 octobre 2018) et loi Climat et résilience (2021)	En restauration collective publique (et privée depuis 2024) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio (en valeur d'achat HT, depuis le 1er janvier 2022) ; depuis le 1er janvier 2024, 60 % de produits durables et de qualité pour les viandes et poissons (100 % pour l'État) ; menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire ; plan pluriannuel de diversification des protéines (plus de 200 couverts par jour) ; information des convives ; lutte contre le gaspillage (diagnostic, dons) ; suppression progressive du plastique. Les achats sont télédéclarés sur la plateforme « ma cantine ». Le bilan publié en 2024 (achats 2023) montrait environ 25,5 % de produits durables et de qualité et 12,1 % de bio : les objectifs ne sont pas atteints
Nutri-Score	Logo nutritionnel à 5 couleurs et lettres (A à E), développé par l'équipe EREN, adopté en France le 31 octobre 2017, facultatif (le droit européen ne permet pas de l'imposer) ; utilisé dans 7 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse) ; nouvel algorithme adopté par le comité de pilotage européen (2022-2023) et rendu applicable en France par l'arrêté du 14 mars 2025, avec 2 ans de transition : meilleur classement des huiles riches en acides gras insaturés (colza, olive, noix), des poissons gras, des céréales complètes ; classement plus sévère des produits salés et sucrés et des boissons édulcorées ; seule l'eau est classée A parmi les boissons
Fiscalité	Contribution sur les boissons sucrées (2012), progressive selon la teneur en sucres depuis 2018, et sur les boissons édulcorées
Encadrement du marketing	Loi du 20 décembre 2016 (suppression de la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique depuis 2018) ; chartes alimentaires de l'ARCOM (charte 2025-2029)
1000 premiers jours	Programme lancé en 2020 (rapport de la commission présidée par Boris Cyrulnik) : alimentation de la femme enceinte et du jeune enfant, allaitement, accompagnement des parents ; site 1000-premiers-jours.fr
Aide alimentaire	Programme « Mieux manger pour tous » (depuis 2023) : améliorer la qualité nutritionnelle et l'accès à des produits frais et locaux dans l'aide alimentaire ; projets alimentaires de territoire solidaires

Levier	Contenu
Restauration scolaire	Tarification sociale (« cantine à 1 € », 2019) ; petits-déjeuners gratuits dans les écoles des territoires prioritaires (2019) ; programme européen « lait et fruits à l'école »
Labels et chartes PNNS	Collectivités actives PNNS (villes, départements), établissements actifs, entreprises actives ; logo PNNS sur les supports conformes ; Réseau national nutrition santé

Lien diététique – Utiliser les politiques nutritionnelles dans son dossier E5

Dans la partie « contexte » de votre dossier, montrez que votre projet **s'inscrit** dans les politiques en vigueur : citez la **SNANC 2025-2030**, l'axe et l'action du **PNNS 5** concernés, l'objectif du **PRS** de votre région, le **CLS** ou le **PAT** du territoire. Une phrase type : « Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 du PNNS 5 (2026-2030), "encourager des comportements nutritionnels sains et durables", et dans l'objectif de réduction des inégalités sociales de santé du PRS de la région… ». Le jury valorise la **cohérence** entre le diagnostic local et ces priorités.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.5 – Calculer un taux EGalim

Une cantine scolaire a acheté sur l'année 120 000 € HT de denrées, dont 18 000 € de produits bio, 21 000 € de produits sous label Rouge ou AOP/IGP (non bio), et 6 000 € de produits issus de la pêche durable (écolabel). Calculez le taux de produits bio et le taux de produits durables et de qualité. La cantine respecte-t-elle la loi EGalim ?

Corrigé

Formule : taux (%) = montant des achats de la catégorie / montant total des achats × 100. **Étape 1 – Taux de bio** : 18 000 / 120 000 × 100 = **15 %**. L'objectif est d'au moins 20 % : **non atteint** (il manque 5 points, soit 0,05 × 120 000 = 6 000 € d'achats bio supplémentaires à budget constant). **Étape 2 – Produits durables et de qualité** (le bio en fait partie) : 18 000 + 21 000 + 6 000 = 45 000 € ; 45 000 / 120 000 × 100 = **37,5 %**. L'objectif est d'au moins 50 % : **non atteint** (il manque 12,5 points, soit 15 000 €). **Interprétation** : la cantine est en progression mais ne respecte pas les deux seuils EGalim ; le diététicien peut proposer de remplacer une partie des achats conventionnels par des produits bio de saison (moins chers en saison) et de financer ces achats par la diversification des protéines (plats à base de légumineuses, moins coûteux) et la réduction du gaspillage.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.7 – Les politiques nutritionnelles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les périodes des cinq PNNS.
2. Quelle loi prévoit la SNANC ? Quand la SNANC a-t-elle été publiée ?
3. Quels sont les trois axes du PNNS 5 ?
4. Quelles sont les obligations EGalim en restauration collective (produits durables et bio) ?
5. Citez quatre repères « Augmenter » de Santé publique France.
6. Calcul : un restaurant scolaire achète 82 000 € HT de denrées, dont 15 600 € de produits bio et 23 400 € d'autres produits durables et de qualité. Les objectifs EGalim sont-ils atteints ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.7

1. PNNS 1 : 2001-2005 ; PNNS 2 : 2006-2010 ; PNNS 3 : 2011-2015 (prolongé jusqu'en 2018) ; PNNS 4 : 2019-2023 ; PNNS 5 : 2026-2030.

2. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 (article 265) ; publication le 11 février 2026.

3. Environnements nutritionnels durables et favorables à la santé ; comportements nutritionnels sains et durables ; mobilisation des milieux de vie et des acteurs clés.

4. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio, en valeur d'achat HT.

5. Fruits et légumes (au moins 5 par jour) ; légumes secs (au moins 2 fois par semaine) ; fruits à coque sans sel ajouté (une petite poignée par jour) ; activité physique (au moins 30 minutes par jour).

6. Bio : 15 600 / 82 000 × 100 = 19,0 % (objectif de 20 % non atteint). Durables et de qualité, bio compris : (15 600 + 23 400) / 82 000 × 100 = 47,6 % (objectif de 50 % non atteint). Il manque 0,20 × 82 000 − 15 600 = 800 € de bio et 0,50 × 82 000 − 39 000 = 2 000 € de produits durables.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.8 Le diététicien-nutritionniste en santé publique

Module · Référentiel et guide : voir 1.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 1.2.2)

Le cadre réglementaire de la profession

Définition – Diététicien – article L. 4371-1 du Code de la santé publique

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée. Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux **activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition**. »

Le titre de diététicien est **protégé** : seuls peuvent l'utiliser les titulaires du BTS Diététique et nutrition, du BUT Génie biologique parcours diététique et nutrition (ou des anciens diplômes équivalents) ou d'une autorisation d'exercice, **enregistrés au répertoire ADELI puis RPPS** (répertoire partagé des professionnels de santé). Le terme « nutritionniste », lui, n'est pas protégé : c'est pourquoi on emploie l'expression **diététicien- nutritionniste**.

Les missions en santé publique

Le référentiel du BTS (2024) cite, parmi les emplois accessibles, celui de **chargé de missions en santé publique** sur des programmes pilotés par des collectivités territoriales. Le guide de l'AFDN « Le diététicien dans les actions de santé publique » (version 2, 2022) décrit les missions suivantes :

- réaliser ou participer à un **diagnostic** de santé nutritionnelle d'un territoire ou d'une population ;
- **concevoir, coordonner, animer et évaluer** des projets et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation nutritionnelle ;
- concevoir des **outils pédagogiques** et des **supports de communication** adaptés (littératie) ;
- **former** des relais (animateurs, enseignants, aides à domicile, bénévoles d'associations) ;
- **conseiller** les décideurs (élus, directeurs de structures) sur la qualité de l'offre alimentaire (restauration scolaire, distributeurs, aide alimentaire) ;
- participer à des **études** et à la **recherche** (enquêteur, analyse de données) ;
- assurer une **veille** et diffuser des informations validées ;

- participer à des **réseaux** et à des instances (CLS, PAT, comités de pilotage).

Les cadres d'exercice

Employeur	Exemples de missions de santé publique
Collectivités territoriales (communes, CCAS, départements, régions)	Coordination d'un volet nutrition de CLS, PMI (1000 premiers jours), restauration scolaire, portage de repas, PAT
Centres sociaux, associations d'éducation populaire, épiceries solidaires	Ateliers cuisine, accompagnement de familles, éducation alimentaire
Associations de prévention, structures régionales Promotion Santé, réseaux	Conception de programmes, formation de relais, appui méthodologique
Mutuelles, Assurance maladie, entreprises (santé au travail)	Programmes de prévention pour les adhérents ou les salariés
Éducation nationale, enseignement supérieur	Interventions en classes, projets d'« écoles promotrices de santé », services de santé étudiante
Clubs et fédérations sportives	Nutrition du sportif, prévention des troubles du comportement alimentaire
Libéral	Interventions ponctuelles rémunérées par des structures (conventions de prestation)

La posture professionnelle en santé publique

- **Respecter** les personnes, leurs cultures, leurs choix et leurs contraintes ; ne pas juger ni culpabiliser (pas de « bons » et de « mauvais » aliments assénés de façon moralisatrice ; vocabulaire non stigmatisant).
- **Partir des besoins** et des représentations du public, et non de ce que le professionnel croit savoir.
- **Travailler en partenariat** et reconnaître les compétences des autres acteurs (animateurs, travailleurs sociaux, enseignants).
- **Transmettre des informations validées**, datées et sourcées, indépendantes des intérêts commerciaux ; déclarer et éviter les **conflits d'intérêts** (par exemple, ne pas faire la promotion d'une marque lors d'un atelier).
- **Respecter le secret professionnel** et le **RGPD** (données des participants, photos : droit à l'image).
- **S'auto-évaluer** et ajuster sa pratique (indicateur du référentiel).

Attention – Ce qu'un diététicien ne fait pas en santé publique

- Poser un **diagnostic médical** ou dépister une maladie sans cadre (le repérage se fait selon des protocoles et avec orientation vers un médecin).
- Prescrire un **régime thérapeutique** à un participant d'atelier : en cas de pathologie, on oriente vers une consultation (BC1).
- Utiliser des outils ou des messages d'une **marque** sans analyse critique (conflit d'intérêts).
- Diffuser des **photos** de participants sans autorisation écrite.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.8 – Le diététicien en santé publique et le projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois missions du diététicien en santé publique.
2. Donnez la définition d'un projet selon l'Afnor.
3. Distinguez projet, action et atelier avec un exemple.
4. Citez les quatre types de besoins de Bradshaw.
5. Citez trois choses qu'un diététicien ne fait pas en santé publique.
6. Citez les six étapes de la démarche de projet.

Corrigé – Point d'étape 1.3.8

1. Réaliser un diagnostic de santé nutritionnelle ; concevoir, animer et évaluer des projets et des actions ; concevoir des outils pédagogiques ; former des relais ; conseiller les décideurs sur l'offre alimentaire ; participer à des études ; assurer une veille ; participer à des réseaux (trois au choix).
2. « Processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources. »
3. Projet : « Bien manger, petit budget » sur six mois. Action : cycle de 4 ateliers culinaires (un objectif opérationnel). Atelier : la séance n° 3 « Repas complet petit budget ».
4. Normatif, ressenti, exprimé, comparatif.
5. Poser un diagnostic médical ; prescrire un régime thérapeutique à un participant d'atelier ; promouvoir une marque ; diffuser des photos sans autorisation écrite.
6. Analyse de situation et diagnostic ; priorités et objectifs ; conception et plan d'action ; mise en œuvre et pilotage ; évaluation ; valorisation.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.9 Fil rouge : le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » du centre social des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 1.2.2)

Ce cas, entièrement **fictif** mais construit à partir de situations réelles et d'ordres de grandeur nationaux, accompagne tout le BC3 (comme le cas de Mme L. dans le BC1). Il montre comment une étudiante de BTS, **Inès**, mène un projet de santé publique pendant son stage de six semaines, de l'analyse de situation à la valorisation, en remplissant les **14 fiches-outils** (F1 à F14). Les méthodes de chaque étape sont détaillées aux chapitres 7, 8 et 9 ; ici, l'objectif est de voir le **projet dans son ensemble** et de relier chaque étape aux notions du chapitre 1.

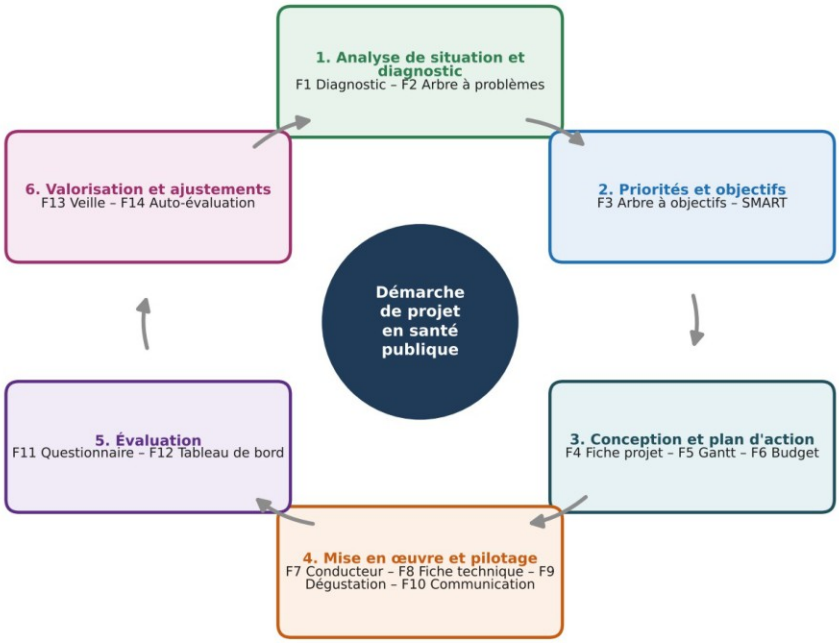


Figure 1.11 – La démarche de projet en santé publique et les fiches-outils F1 à F14

Comprendre le schéma – Figure 1.11

1. Analyse de situation et diagnostic : on rassemble les données sur le territoire et le public (F1) et on identifie le problème central, ses causes et ses conséquences (F2, arbre à problèmes).

2. Priorités et objectifs : on transforme l'arbre à problèmes en arbre à objectifs (F3) et on rédige des objectifs SMART.

3. Conception et plan d'action : on rédige la fiche projet (F4), le planning (F5, Gantt) et le budget (F6).

4. Mise en œuvre et pilotage : on prépare et anime chaque séance (F7 conducteur, F8 fiche technique d'atelier, F9 grille de dégustation) et on communique (F10).

5. Évaluation : on recueille et on analyse les données (F11 questionnaire, F12 tableau de bord).

6. Valorisation et ajustements : on diffuse les résultats, on assure la veille (F13) et on s'auto-évalue (F14).

7. Au centre, la démarche est un **cycle** : l'évaluation nourrit un nouveau diagnostic et l'amélioration du projet.

Le projet en santé publique : définitions et vocabulaire

Définition – Projet (Afnor)

Un projet est un « processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources » (définition reprise de la norme NF EN ISO 9000, citée par le CNED).

Un **projet de santé publique** ajoute trois caractéristiques à cette définition : il part d'un **diagnostic de situation** partagé, il vise une **population** (et non un individu) et il est **évalué** au regard de ses objectifs et de son effet sur les inégalités de santé. Il respecte le cadre légal : Code de la santé publique, recommandations officielles, code de déontologie, éthique et secret professionnel.

Notion	Définition	Exemple dans le fil rouge
Projet	Ensemble coordonné d'actions, sur une durée définie, qui répond à un problème identifié par un diagnostic, avec des objectifs, des moyens et une évaluation	« Bien manger, petit budget, grand plaisir » (septembre 2027 – mars 2028)
Action	Ensemble d'activités qui répond à **un objectif opérationnel** du projet	Cycle de 4 ateliers culinaires pour les parents ; exposition « goûters malins »
Atelier (ou séance)	Temps concret d'animation, avec un public, un lieu, une durée et un déroulé ; c'est une **modalité** d'une action	Atelier n° 3 « Repas complet petit budget » du 21 mars 2028
Appel à projets	Procédure par laquelle un financeur (ARS, Assurance maladie, collectivité, fondation) publie un **cahier des charges** (priorités, publics, critères, montant, date limite) et sélectionne les projets qu'il finance	Appel à projets « prévention – promotion de la santé » de l'ARS
Parties prenantes	Toutes les personnes et organisations concernées par le projet : l'**équipe** projet, les **partenaires** (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier), les **usagers** (bénéficiaires)	Inès, Mme Martin et Mme Benali ; épicerie solidaire, PMI, CCAS ; parents du quartier
Valorisation	Faire connaître le projet et ses résultats aux participants, aux partenaires et aux financeurs, **tout au long** du projet	Article dans le journal municipal, bilan présenté au comité de pilotage
Capitalisation	Transformer l'expérience en **connaissances et en outils réutilisables** pour d'autres projets	Livret de recettes et fiche « comment monter un atelier » transmis au centre social

Erreur fréquente – Appeler « projet » un simple atelier

Un atelier culinaire isolé n'est pas un projet : il n'a ni diagnostic, ni objectifs hiérarchisés, ni évaluation d'ensemble. À l'oral, dites « l'atelier n° 3 est **une des actions** de mon projet », et non « mon projet, c'est un atelier ».

Méthode – Démarche d'étude et démarche de projet

La **démarche d'étude** analyse un sujet, une population ou un territoire à partir de données ; elle **produit de la connaissance** (chapitre 18). La **démarche de projet** utilise cette connaissance pour **agir**. L'étude recueille des données « **froides** » (statistiques, rapports d'activité, bilans) et des données « **chaudes** » (questionnaires, entretiens, observations, réunions). Le diagnostic d'un projet combine toujours les deux.

Outil d'analyse	À quoi il sert	Chapitre où il est approfondi
QQOQCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)	Décrire une situation de façon complète, sans oublier d'aspect	Chapitre 7
Arbre à problèmes et arbre à objectifs	Relier le problème central à ses causes et à ses conséquences, puis en déduire les objectifs	Chapitre 7 (exemples aux figures 1.12 et 1.13)
Diagramme d'Ishikawa (causes et effet)	Classer les causes d'un problème par familles (par exemple : personnes, offre alimentaire, environnement, organisation, budget)	Chapitre 7

Outil d'analyse	À quoi il sert	Chapitre où il est approfondi
Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces)	Évaluer la faisabilité d'un projet : ressources internes et contexte externe	Chapitre 7
Analyse des champs de forces (Lewin)	Identifier les forces favorables et les forces de résistance à un changement	Chapitre 8
Carte mentale	Organiser les idées d'un sujet autour d'un thème central, en équipe ou seul	Chapitres 7 et 15

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le contexte

Valmont est une commune fictive de 38 000 habitants. Le **quartier des Tilleuls** (4 200 habitants) est un **quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)**. Le **centre social des Tilleuls**, agréé par la CAF (« animation collective familles »), dispose d'une **cuisine pédagogique**. Sa référente familles, **Mme Martin** (conseillère en économie sociale et familiale), est la **tutrice** d'Inès. Une diététicienne, **Mme Benali**, intervient au centre social dans le cadre d'une convention avec le CCAS. L'**épicerie solidaire** « Le Panier partagé » (CCAS) est située à 300 mètres. **Calendrier du stage** : période 1 du 31 mai au 11 juin 2027 (2 semaines, fin de 1re année) ; travail de conception en établissement de septembre 2027 à février 2028 ; période 2 du 6 au 31 mars 2028 (4 semaines, 2e année), soit **6 semaines au total** comme le prévoit le référentiel ; épreuve E5 en juin 2028.

Les besoins : la typologie de Bradshaw

Le mot « besoin » est au cœur du diagnostic. Le sociologue britannique **Jonathan Bradshaw** a distingué en **1972** quatre types de besoins sociaux. Cette typologie est classique en santé publique : elle oblige à croiser le regard des professionnels et celui de la population.

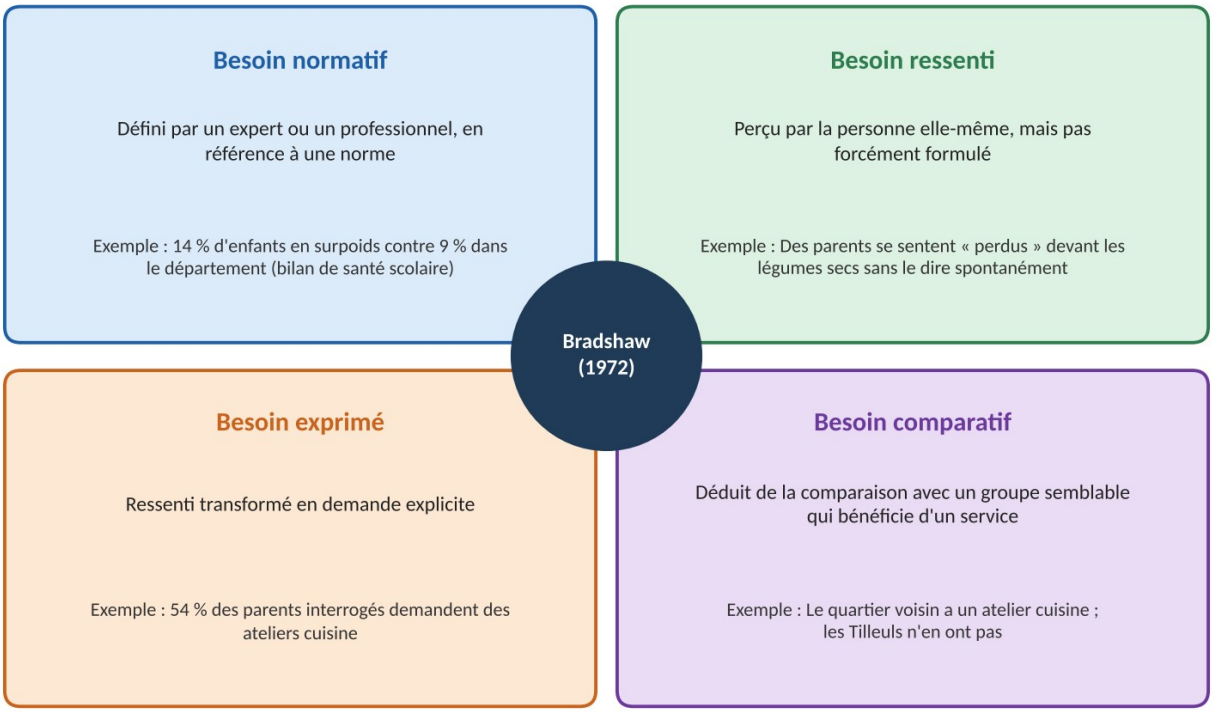


Figure 1.11 bis – Les quatre types de besoins selon Bradshaw (1972), illustrés par le fil rouge

Comprendre le schéma – Figure 1.11 bis

1. **En bleu, le besoin normatif** : un expert le définit en comparant une situation à une **norme** (recommandation, moyenne départementale, repère du PNNS).

2. **En vert, le besoin ressenti** : c'est la population qui le **perçoit**, même si elle ne le dit pas spontanément ; on le fait émerger par des entretiens ou des groupes de parole.
3. **En orange, le besoin exprimé** : c'est un besoin ressenti devenu **demande** (inscriptions, réponses à un questionnaire, demandes au guichet).
4. **En violet, le besoin comparatif** : on le déduit en comparant avec un groupe semblable qui bénéficie déjà d'un service.
5. Un besoin est d'autant plus **prioritaire** qu'il apparaît dans plusieurs cases à la fois.

Erreur fréquente – Attribuer les besoins ressentis aux professionnels

Les besoins **ressentis** sont ceux de la **population**. Ce que constatent ou estiment les professionnels (animatrice, infirmière, PMI) relève du besoin **normatif**, ou de l'**observation**. Écrire « besoins ressentis par les professionnels » est une erreur relevée par les jurys.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.5 bis – Classer des besoins

Pour un projet dans une résidence autonomie (78 résidents), classez chaque information selon Bradshaw.

a) Le médecin coordonnateur note que 17 résidents ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois.

b) Au conseil de la vie sociale, 12 résidents demandent des repas plus variés le soir.

c) Lors d'un entretien, une résidente confie qu'elle « n'a plus envie de cuisiner pour elle seule ».

d) La résidence voisine propose un repas partagé hebdomadaire ; celle-ci non.

Calculez la part de résidents concernés en a) et en b).

Corrigé – Exercice 1.5 bis

a) **Normatif** : la norme est le critère de dénutrition (perte de poids d'au moins 5 % en un mois, HAS 2021). Part : 17 / 78 × 100 = **21,8 %**.

b) **Exprimé** : demande formulée dans une instance. Part : 12 / 78 × 100 = **15,4 %**.

c) **Ressenti** : la résidente perçoit une difficulté sans en faire une demande.

d) **Comparatif** : comparaison avec une structure semblable.

Conclusion : la dénutrition et la convivialité des repas apparaissent dans plusieurs types de besoins ; ce sont des priorités solides pour le projet.

Étape 1 – Analyse de situation et diagnostic (fiche F1)

Pendant la période 1, Inès rassemble plusieurs types de données : les **données objectives** (statistiques du territoire), les **besoins exprimés** par les habitants (leurs demandes), les **besoins ressentis** qu'elle fait émerger dans un groupe de parole, et les **besoins normatifs** repérés par les professionnels au regard des normes (typologie de Bradshaw), auxquels s'ajoutent les **besoins observés** (ce qu'elle constate elle-même).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F1 – Diagnostic de situation (extrait rempli)

Rubrique	Données recueillies	Source
Territoire	Valmont, 38 000 habitants ; QPV des Tilleuls : 4 200 habitants ; 32 % de moins de 18 ans (21 % dans la commune)	Insee, recensement ; sig.ville.gouv.fr (données fictives)

Rubrique	Données recueillies	Source
Situation sociale	Taux de pauvreté 41 % (15 % dans la commune) ; 28 % de familles monoparentales ; taux de chômage 24 %	Insee, Filosofi ; contrat de ville (données fictives)
Santé	14 % d'enfants en surpoids (obésité comprise) lors du bilan de grande section dans les 2 écoles du quartier (9 % en moyenne dans le département)	Service de santé scolaire, bilan 2026 (fictif)
Offre alimentaire	1 supérette, 3 restaurants rapides, 1 boulangerie ; marché le samedi en centre-ville (2,5 km, bus toutes les 30 min)	Observation, repérage à pied
Ressources	Centre social avec cuisine pédagogique ; épicerie solidaire (85 familles inscrites) ; jardin partagé (8 parcelles) ; PMI ; maison de santé ; 2 écoles élémentaires	Entretiens, sites internet
Politiques	PNNS 5 (2026-2030) ; PRS de la région (priorité : nutrition des enfants en QPV) ; CLS de Valmont 2024- 2028, fiche-action « Bien manger dans les quartiers » ; PAT de l'agglomération	Sites ARS, ministère, agglomération
Besoins exprimés (habitants)	Questionnaire à 48 parents (sortie d'école) + groupe de parole de 8 parents : 71 % (34/48) pensent que « manger équilibré coûte cher » ; 58 % (28/48) « ne savent pas cuisiner les légumes secs » ; 63 % (30/48) disent que leurs enfants refusent les légumes ; 54 % (26/48) souhaitent des ateliers cuisine	Enquête d'Inès, juin 2027
Besoins normatifs (repérés par les professionnels)	Animatrice : goûters industriels et sodas fréquents ; épicerie : les légumes secs et les légumes frais restent en rayon ; PMI : allaitement court, diversification précoce	Entretiens semi-directifs (3)
Besoins observés	27 % (13/48) des familles consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine ; 46 % (22/48) déclarent que leurs enfants boivent une boisson sucrée tous les jours	Questionnaire, observation des goûters

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 – Calculer et interpréter des pourcentages du diagnostic

Vérifiez les pourcentages de la fiche F1 (arrondis à l'unité) et calculez combien de familles inscrites à l'épicerie solidaire (85) on peut estimer intéressées par des ateliers cuisine si la proportion observée chez les 48 parents s'applique.

Corrigé

Formule : pourcentage = effectif / effectif total × 100.

- 34 / 48 × 100 = 70,8 % ≈ **71 %** ; 28 / 48 × 100 = 58,3 % ≈ **58 %** ; 30 / 48 × 100 = 62,5 % ≈ **63 %** ; 26 / 48 × 100 = 54,2 % ≈ **54 %** ; 13 / 48 × 100 = 27,1 % ≈ **27 %** ; 22 / 48 × 100 = 45,8 % ≈ **46 %**.
- **Estimation** : 85 × 0,542 = 46,1, soit environ **46 familles** potentiellement intéressées.
- **Interprétation et limite** : cette extrapolation suppose que les parents interrogés à la sortie de l'école ressemblent aux familles de l'épicerie, ce qui n'est pas certain (**biais de sélection**, chapitre 16) ; il s'agit d'un ordre de grandeur pour dimensionner l'action (un cycle de 12 familles est réaliste, avec une liste d'attente).

Étape 2 – Problème central, causes et conséquences (fiche F2)

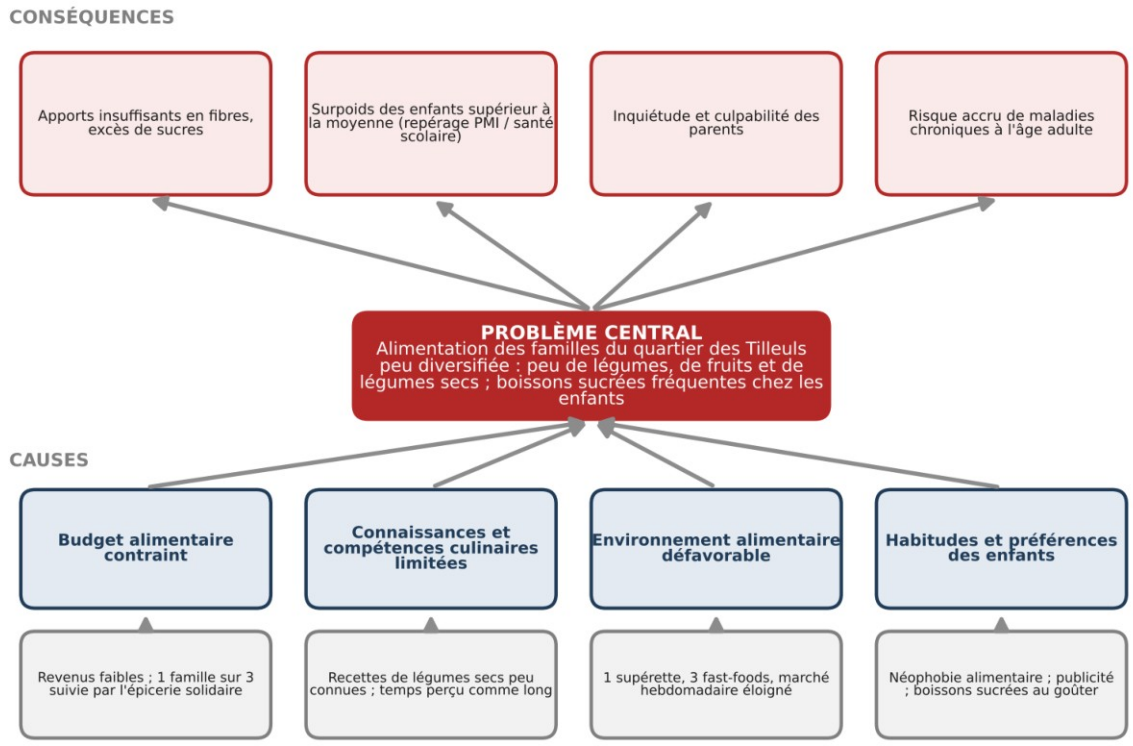


Figure 1.12 – Arbre à problèmes du projet fil rouge (fiche F2)

Comprendre le schéma – Figure 1.12

1. Au centre, le **problème central**, formulé comme une situation négative observable : une alimentation des familles peu diversifiée (peu de légumes, de fruits et de légumes secs, boissons sucrées fréquentes chez les enfants).
2. En bas, les **causes** (racines) : budget contraint, connaissances et compétences culinaires limitées, environnement alimentaire défavorable, habitudes et préférences des enfants ; chaque cause est précisée par un fait issu du diagnostic (encadrés gris).
3. En haut, les **conséquences** (branches) : apports insuffisants en fibres et excès de sucres, surpoids des enfants supérieur à la moyenne, inquiétude des parents, risque de maladies chroniques.
4. Les flèches indiquent la **relation de cause à effet**. L'arbre permet de choisir **sur quelles causes agir** : le centre social peut agir sur les compétences, les habitudes et en partie sur l'accès (partenariat avec l'épicerie), mais pas directement sur les revenus (il peut en revanche **plaider** auprès de la commune).

Étape 3 – Priorités et objectifs (fiche F3)

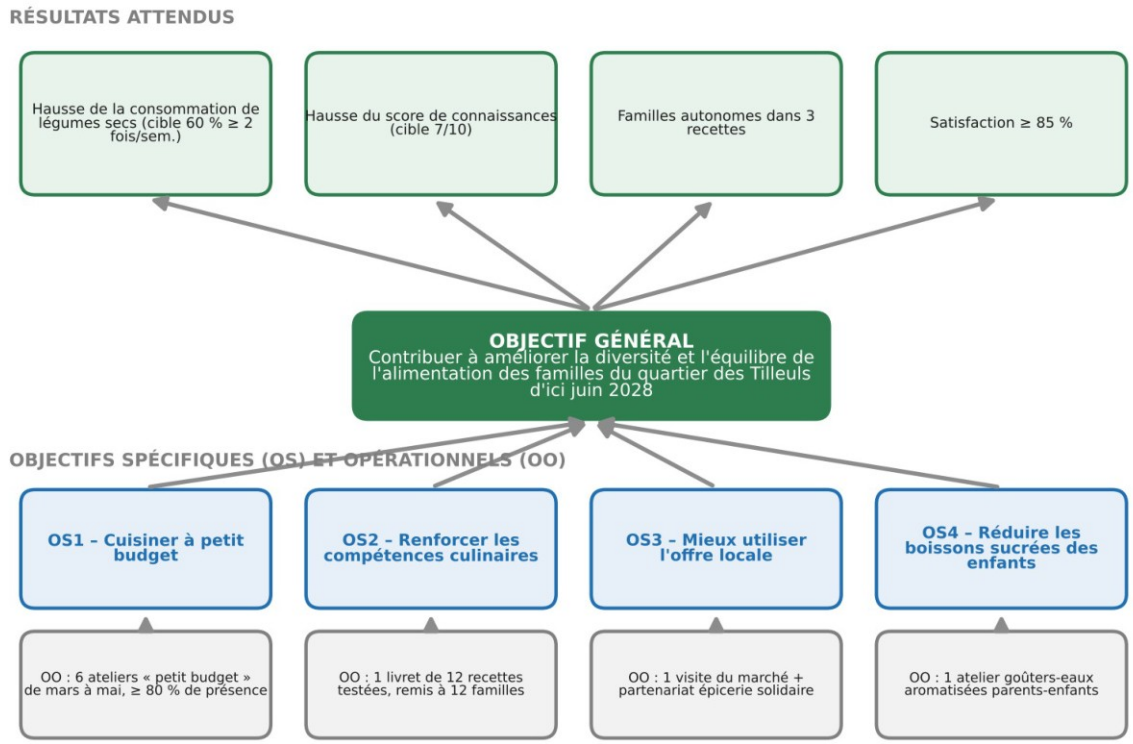


Figure 1.13 – Arbre à objectifs du projet fil rouge (fiche F3)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F3 – Objectifs SMART (extrait rempli)

Niveau	Formulation	Indicateur
Objectif général	Contribuer à améliorer la diversité et l'équilibre de l'alimentation des familles du quartier des Tilleuls d'ici juin 2028	(à long terme, non mesuré par le seul projet)
Objectif spécifique 1	D'ici fin mai 2028, au moins 60 % des familles participantes déclarent consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine (contre 25 % au début du cycle)	% de familles (questionnaire avant/après)
Objectif spécifique 2	À la fin du cycle, le score moyen de connaissances des participants sur l'alimentation à petit budget atteint au moins 7/10	Score moyen au questionnaire
Objectif spécifique 3	D'ici fin mai 2028, les familles participantes savent repérer et utiliser l'offre locale à petit prix (marché, épicerie solidaire)	Participation à la visite ; achats déclarés
Objectif spécifique 4	D'ici fin mai 2028, les familles participantes proposent moins souvent une boisson sucrée au goûter	Fréquence déclarée
Objectif opérationnel	Animer 6 ateliers culinaires de 3 heures, de mars à mai 2028, pour 12 familles, avec un taux de présence d'au moins 80 %	Nombre d'ateliers ; présences / 72

Niveau	Formulation	Indicateur
Objectif opérationnel	Réaliser un livret de 12 recettes testées pendant les ateliers et le remettre aux 12 familles le 27 mai 2028	Livret réalisé et distribué

Méthode pas à pas – Vérifier qu'un objectif est SMART

Spécifique (un seul résultat, un public précis) – **M**esurable (indicateur chiffré) – **A**tteignable (réaliste au regard des moyens) – **R**éaliste / pertinent (répond au problème identifié) – **T**emporel (échéance). Exemple de vérification pour l'objectif spécifique 1 : S = consommer des légumes secs, familles participantes ; M = au moins 60 % ; A = passer de 25 % à 60 % en 3 mois est ambitieux mais possible car 3 ateliers sur 6 portent sur les légumes secs ; R = répond à la cause « compétences culinaires » et au constat de l'épicerie ; T = fin mai 2028. La méthode complète est au chapitre 7.

Étape 4 – Conception : fiche projet, planning et budget (fiches F4, F5, F6)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F4 – Fiche projet / réponse à l'appel à projets de l'ARS (extrait rempli)

Rubrique	Contenu
Intitulé	« Bien manger, petit budget, grand plaisir »
Porteur	Centre social des Tilleuls (association loi 1901), référente : Mme Martin ; conception et animation : Inès (étudiante en BTS Diététique et nutrition) avec l'appui de Mme Benali, diététicienne
Partenaires	Épicerie solidaire « Le Panier partagé » (CCAS) : orientation des familles, produits utilisés ; écoles élémentaires (diffusion) ; PMI (orientation) ; marché de Valmont (visite) ; jardin partagé
Public	12 familles du QPV (parents et, pour l'atelier 4, enfants de 6 à 11 ans)
Inscription dans les politiques	PNNS 5 axe 2 ; PRS (nutrition des enfants en QPV) ; CLS de Valmont, fiche-action 3 ; PAT de l'agglomération
Type d'intervention	Éducation pour la santé (alimentaire, nutritionnelle, sensorielle) au service de la prévention primaire sélective ; démarche de promotion de la santé (participation des familles au choix des recettes, partenariat avec l'épicerie)
Actions	6 ateliers culinaires (mardi 9 h – 12 h) : 1) légumes secs ; 2) légumes de saison ; 3) repas complet petit budget ; 4) goûters et boissons (parents-enfants) ; 5) anti-gaspillage ; 6) recettes du monde choisies par les familles ; visite du marché ; temps fort festif avec remise du livret
Calendrier	7 mars – 27 mai 2028
Évaluation	Processus (présences, ateliers réalisés, budget) et résultats (questionnaire avant/après, consommation déclarée de légumes secs, satisfaction) – fiche F12
Budget	3 510 € (dont 450 € de contributions en nature) ; demande à l'ARS : 1 500 €

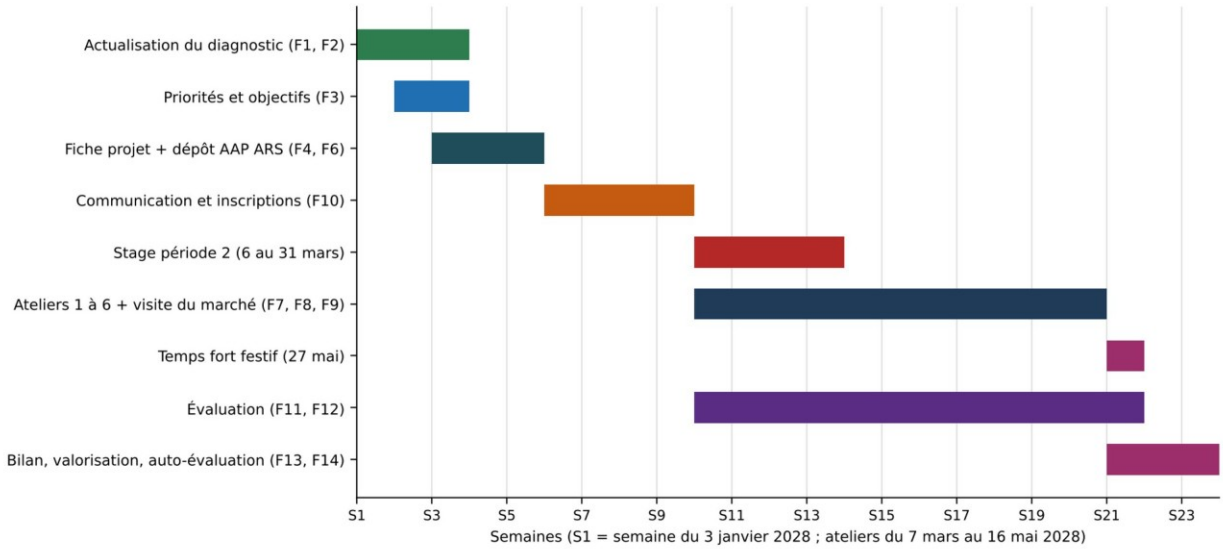


Figure 1.14 – Diagramme de Gantt du projet fil rouge (fiche F5)

Comprendre le schéma – Figure 1.14

1. Chaque barre représente une **tâche**, positionnée selon sa semaine de début et sa durée (S1 = semaine du 3 janvier 2028).
2. Les tâches de conception (diagnostic actualisé, objectifs, fiche projet et dépôt de l'appel à projets) se chevauchent en janvier et février.
3. La barre rouge montre la **période 2 du stage** (6 au 31 mars) : Inès y anime les ateliers 1 à 3 et la visite du marché ; la diététicienne et la référente familles animent les ateliers 4 à 6 en suivant les conducteurs qu'elle a rédigés, et lui transmettent les données d'évaluation.
4. L'**évaluation** court pendant tout le cycle (questionnaire avant au 1er atelier, émargements à chaque séance, questionnaire après au 6e atelier).
5. Le **temps fort festif** (27 mai) et le bilan clôturent le projet.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F5 – Feuille de temps d'Inès, période 2 (extrait)

Activité	Heures	Commentaire
Préparation des ateliers 1 à 6 (conducteurs, fiches techniques, courses)	38	Dont 6 h pour les ateliers 4 à 6 animés par l'équipe
Animation des ateliers 1 à 3 (3 × 3 h)	9	Avec la diététicienne
Visite du marché (samedi 25 mars)	4	Récupération du samedi
Communication (affiches, flyers, messages aux familles)	12	Supports validés par la tutrice
Évaluation (questionnaires, saisie, tableur)	16	Dépouillement complet à réception des questionnaires « après »
Livret de recettes	18	Maquette, relecture FALC
Réunions (tutrice, comité de pilotage, partenaires)	10	Dont 1 comité de pilotage
Rédaction du dossier et auto-évaluation	23	
Total	130	Pour 4 semaines de 35 h, soit 140 h : 10 h de temps d'observation d'autres activités du centre social

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F6 – Budget prévisionnel (calculé dans le tableur, feuille 3)

Charges	Quantité	Coût unitaire	Montant
60 – Denrées alimentaires (6 ateliers + temps fort)	7	30,00 €	210,00 €
60 – Petit matériel de cuisine (balance, ustensiles)	1	180,00 €	180,00 €
60 – Matériel et supports pédagogiques	1	150,00 €	150,00 €
62 – Impression et communication (affiches, flyers, livret)	1	220,00 €	220,00 €
62 – Déplacements (visite du marché)	1	60,00 €	60,00 €
64 – Diététicienne (heures)	40	38,00 €	1 520,00 €
64 – Coordinatrice / animatrice familles (heures)	30	24,00 €	720,00 €
86 – Mise à disposition de locaux (valorisation)	7	30,00 €	210,00 €
86 – Bénévolat (valorisation, heures)	20	12,00 €	240,00 €
Total des charges			3 510,00 €

Produits	Montant
74 – Subvention ARS (appel à projets prévention)	1 500,00 €
74 – Commune / CCAS (contrat de ville)	600,00 €
74 – CAF (animation collective familles)	400,00 €
75 – Participation des familles (2 € × 12 familles × 6 ateliers)	144,00 €
Autofinancement du centre social	416,00 €
87 – Contributions volontaires en nature	450,00 €
Total des produits	3 510,00 €

Corrigé – Les calculs du budget, pas à pas

Étape 1 – Charges : chaque ligne = quantité × coût unitaire ; par exemple, diététicienne : 40 h × 38 € = 1 520 €. Somme : 210 + 180 + 150 + 220 + 60 + 1 520 + 720 + 210 + 240 = **3 510 €**. **Étape 2 – Participation des familles** : 2 € × 12 familles × 6 ateliers = **144 €**. **Étape 3 – Contributions en nature** (comptes 86 et 87, qui doivent être égaux) : 210 + 240 = **450 €**. **Étape 4 – Autofinancement** (montant qui équilibre le budget) : 3 510 − (1 500 + 600 + 400 + 144 + 450) = 3 510 − 3 094 = **416 €**. **Étape 5 – Indicateurs** : part de la subvention ARS dans les produits = 1 500 / 3 510 = 0,427, soit **42,7 %** ; part des financements publics (ARS + commune + CAF) = 2 500 / 3 510 = **71,2 %** ; coût par famille = 3 510 / 12 = **292,50 €** ; part du personnel = (1 520 + 720) / 3 510 = **63,8 %**. **Interprétation** : un budget prévisionnel doit être **équilibré** (total des charges = total des produits) ; un financeur ne finance jamais 100 % d'un projet, d'où la diversité des financeurs ; le poste principal est le **temps humain**, ce qui est habituel en éducation pour la santé.

Étape 5 – Mise en œuvre : l'atelier n° 3 « Repas complet petit budget » (fiches F7, F8, F9)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F7 – Conducteur de séance, atelier n° 3 (mardi 28 mars 2028, 9 h – 12 h)

Horaire	Étape et objectif	Contenu et déroulement	Méthode, outils	Qui
8 h 30 – 9 h	Installation	Plan de travail, ingrédients pesés par recette, affichage des fiches recettes, tenues, désinfection des surfaces	Fiche technique F8	Inès, Mme Benali

Horaire	Étape et objectif	Contenu et déroulement	Méthode, outils	Qui
9 h – 9 h 15	Accueil, émargement	Café, émargement, rappel des règles (hygiène, tablier, cheveux attachés, lavage des mains), présentation du menu	Tour de table « une couleur pour votre humeur »	Inès
9 h 15 – 9 h 35	Représentations	« Pour vous, un repas équilibré à petit prix, c'est… » ; classement de 10 cartes- aliments par prix au kilo puis par prix par portion	Photo-expression, cartes-aliments	Inès
9 h 35 – 11 h 05	Réalisation culinaire	3 groupes de 3-4 personnes : salade de chou-carottes ; parmentier de lentilles corail ; crumble pommes-avoine ; consignes de sécurité (couteaux, four) ; tri des déchets	Fiches recettes illustrées (pictogrammes)	Inès + Mme Benali (1 animatrice pour 2 groupes)
11 h 05 – 11 h 35	Dégustation et analyse sensorielle	Repas partagé ; grille de dégustation (échelle de 1 à 5) ; échanges sur les goûts des enfants	Grille F9	Inès
11 h 35 – 11 h 50	Synthèse	Calcul collectif du coût par personne (1,38 €) ; 3 astuces à retenir ; recette à refaire à la maison	Tableau papier	Inès
11 h 50 – 12 h	Évaluation et clôture	Évaluation « météo » (soleil, nuage, pluie) + 1 mot ; distribution des fiches recettes ; restes partagés dans des boîtes apportées par les familles	Émargement, boîtes	Mme Benali
12 h – 12 h 30	Rangement, bilan à chaud	Vaisselle, nettoyage, tri ; bilan entre animatrices (ce qui a marché, ce qui est à améliorer)	Fiche bilan	Toutes

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F8 – Fiche technique de l'atelier : mise à l'échelle et coût (calculés dans

le tableur, feuille 1) Recettes de base pour 4 portions, préparées pour **12 portions** (10 participants + 2 animatrices). **Coefficient** = portions visées / portions de base = 12 / 4 = **3**.

Ingrédient	Base (4 p.)	Pour 12 p.	Prix	Coût	Qualité
Salade chou-carottes					
Chou blanc	200 g	600 g	1,60 €/kg	0,96 €	saison, local
Carottes	150 g	450 g	1,40 €/kg	0,63 €	saison, local
Huile de colza	15 g	45 g	3,50 €/L	0,16 €	
Vinaigre de cidre	10 g	30 g	2,00 €/L	0,06 €	
Moutarde	5 g	15 g	4,00 €/kg	0,06 €	allergène
Parmentier de lentilles					

Ingrédient	Base (4 p.)	Pour 12 p.	Prix	Coût	Qualité
Lentilles corail sèches	160 g	480 g	3,20 €/kg	1,54 €	
Carottes	300 g	900 g	1,40 €/kg	1,26 €	saison, local
Oignon	100 g	300 g	1,80 €/kg	0,54 €	saison, local
Pommes de terre	600 g	1 800 g	1,30 €/kg	2,34 €	saison, local
Lait demi-écrémé	150 mL	450 mL	1,05 €/L	0,47 €	allergène (lait)
Huile de colza	20 g	60 g	3,50 €/L	0,21 €	
Emmental râpé	40 g	120 g	9,90 €/kg	1,19 €	allergène (lait)
Concentré de tomate	30 g	90 g	4,00 €/kg	0,36 €	
Épices (cumin, paprika)	4 g	12 g	25,00 €/kg	0,30 €	
Crumble pommes-avoine					
Pommes	500 g	1 500 g	2,90 €/kg	4,35 €	saison, local, bio
Flocons d'avoine	60 g	180 g	2,50 €/kg	0,45 €	allergène (gluten)
Farine de blé T65	40 g	120 g	1,60 €/kg	0,19 €	Label Rouge ; gluten
Beurre doux	40 g	120 g	10,00 €/kg	1,20 €	allergène (lait)
Sucre roux	30 g	90 g	1,20 €/kg	0,11 €	
Cannelle	2 g	6 g	30,00 €/kg	0,18 €	

Corrigé – Les calculs de la fiche technique, pas à pas

Étape 1 – Quantité à prévoir = quantité de base × coefficient. Exemple : lentilles corail : 160 g × 3 = **480 g**. **Étape 2 – Coût d'un ingrédient** = quantité (g) / 1 000 × prix (€/kg). Exemple : 480 / 1 000 × 3,20 = **1,536 €** ≈ 1,54 €. **Étape 3 – Coût de chaque recette** (somme des ingrédients, valeurs non arrondies) : salade = 0,96 + 0,63 + 0,1575 + 0,06 + 0,06 = **1,87 €** ; parmentier = 1,536 + 1,26 + 0,54 + 2,34 + 0,4725 + 0,21 + 1,188 + 0,36 + 0,30 = **8,21** € ; crumble = 4,35 + 0,45 + 0,192 + 1,20 + 0,108 + 0,18 = **6,48 €**. **Étape 4 – Coût par portion** = coût de la recette / 12 : salade 1,8675 / 12 = **0,16 €** ; parmentier 8,2065 / 12 = **0,68** € ; crumble 6,48 / 12 = **0,54 €**. **Étape 5 – Coût du repas complet** : 1,8675 + 8,2065 + 6,48 = **16,55 €** pour 12 personnes, soit 16,554 / 12 = **1,38 € par personne**. **Étape 6 – Part des produits de qualité (en valeur)** : produits de saison = 0,96 + 0,63 + 1,26 + 0,54 + 2,34 + 4,35 = 10,08 € ; 10,08 / 16,554 = **60,9 %** (les mêmes produits sont locaux : 60,9 %) ; bio = 4,35 / 16,554 = **26,3 %** ; produits « durables et de qualité » au sens EGalim (bio ou Label Rouge) = (4,35 + 0,192) / 16,554 = **27,4 %**. **Interprétation** : un repas complet, fait maison, coûte **1,38 € par personne en denrées**, ce qui répond directement à la représentation « manger équilibré coûte cher » ; les pommes bio représentent à elles seules 26 % du coût : le choix du bio est possible sur un produit de saison. Si on utilisait le repère EGalim de la restauration collective (50 %), il manquerait 22,6 points : ce repère n'est pas obligatoire pour un atelier, mais il sert de **point de comparaison** pédagogique.

Lien diététique – Lien BPADN : la valeur nutritionnelle d'une portion de parmentier

Une portion contient 40 g de lentilles corail crues, 150 g de pommes de terre, 75 g de carottes, 37,5 mL de lait et 10 g d'emmental. Avec les teneurs en protéines de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) : lentille corail sèche 27,7 g/100 g ; pomme de terre crue sans peau 2,02 g ; carotte crue 0,78 g ; lait demi-écrémé UHT 3,48 g ; emmental râpé 27,6 g. Calcul : 40 × 27,7 / 100 = 11,08 g ; 150 × 2,02 / 100 = 3,03 g ; 75 × 0,78 / 100 = 0,59 g ; 37,5 × 3,48 / 100 = 1,31 g ; 10 × 27,6 / 100 = 2,76 g ; **total ≈ 18,8 g de protéines**, dont (11,08 + 3,03 + 0,59) / 18,77 = 78,3 % d'origine végétale. L'association **légumineuse + produit laitier + féculent** améliore la complémentarité des acides aminés (lysine des légumineuses, acides aminés soufrés des céréales et du lait) : c'est un plat complet adapté au repère « légumes secs au moins 2 fois par semaine ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F8 (suite) – Hygiène, sécurité, éco-gestes et allergènes

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et entre chaque manipulation ; tablier, cheveux attachés ; légumes lavés ; lentilles rincées ; plat cuit servi immédiatement (ou maintenu au-dessus de 63 °C) ; restes refroidis rapidement et conservés au froid (0 à 4 °C) dans des boîtes fermées, à consommer sous 24 heures ; un plat témoin n'est pas obligatoire en atelier familial mais on note les lots des produits utilisés.
- **Sécurité** : couteaux posés à plat, planche stabilisée par un torchon humide, poignées de casseroles tournées vers l'intérieur, gants de cuisine pour le four ; enfants (atelier 4) jamais seuls près des plaques.
- **Éco-gestes** : légumes de saison et locaux ; épluchures de carottes et de pommes compostées au jardin partagé ; eau de cuisson des lentilles réutilisée pour la purée ; four rempli (crumble et parmentier cuits ensemble) ; produits en vrac (lentilles, flocons) ; restes emportés dans des boîtes réutilisables ; pas de vaisselle jetable.
- **Allergènes à déclarer** (14 allergènes du règlement INCO n° 1169/2011) : **lait** (lait, emmental, beurre), **gluten** (farine de blé, flocons d'avoine), **moutarde** ; **sulfites** possibles dans le vinaigre (vérifier l'étiquette). Recueil des allergies à l'inscription (fiche participant) ; variante sans lait (huile d'olive et lait végétal enrichi) prévue.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F9 – Grille de dégustation : résultats de l'atelier n° 3 (10 participants)

Échelle hédonique de 1 (« je n'aime pas du tout ») à 5 (« j'aime beaucoup »).

Préparation	Notes des 10 participants	Moyenne
Salade chou-carottes	3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3	3,3
Parmentier de lentilles	5 – 4 – 4 – 5 – 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 5	4,3
Crumble pommes-avoine	5 – 5 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5	4,7

Calcul : moyenne = somme des notes / nombre de notes. Salade : (3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3) / 10 = 33 / 10 = **3,3** ; parmentier : 43 / 10 = **4,3** ; crumble : 47 / 10 = **4,7**. **Interprétation** : le plat à base de légumes secs est très bien accepté (4,3/5), ce qui est encourageant pour l'objectif spécifique 1 ; la salade de chou est moins appréciée (« trop acide », « chou trop dur ») : ajustement décidé pour le livret : chou émincé très finement et mariné 15 minutes, ajout de pomme râpée et de raisins secs.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F10 – Plan de communication (extrait)

Objectif	Cible	Message	Support et canal	Calendrier
Faire connaître et recruter	Familles du quartier	« Cuisinez bon et pas cher, venez avec nous ! »	Affiches A3 (écoles, épicerie, PMI, centre social) ; flyers illustrés traduits en arabe et en turc ; message sur le groupe de messagerie des parents du centre social	Février 2028
Mobiliser les partenaires	Épicerie, écoles, PMI	Présentation du projet et du rôle de chacun	Mail + réunion de présentation (diaporama de 8 diapositives)	Janvier 2028
Informer les financeurs	ARS, commune, CAF	Avancement et résultats	Fiche projet, bilan intermédiaire, bilan final	Février, avril, juin 2028
Valoriser	Habitants, élus, professionnels	« 12 familles, 12 recettes à moins de 1,50 € par personne »	Livret de recettes (FALC, pictogrammes), article dans le journal municipal, poster au forum santé	Mai-juin 2028

Points de vigilance : littératie (phrases courtes, pictogrammes, police lisible ≥ 12 pt, chapitre 5) ; **précarité numérique** (ne pas compter uniquement sur le numérique) ; **droit à l'image** et **RGPD** (autorisation écrite pour toute photo, pas de nom de famille dans le livret, données d'inscription conservées au centre social et détruites à la fin du projet).

Étape 6 – Évaluation (fiches F11 et F12)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F11 – Questionnaire d'évaluation et dépouillement (calculés dans le

tableur, feuille 5) Le même questionnaire de 10 questions de connaissances (une réponse juste = 1 point) a été rempli au 1er atelier (« avant ») et au 6e atelier (« après ») par les **12** participants, identifiés par un **code anonyme** (P01 à P12). Exemples de questions : « Combien de fois par semaine est-il conseillé de manger des légumes secs ? » ; « Quel est le prix au kilo des lentilles par rapport à celui de la viande hachée ? » ; « Citez deux légumes de saison en mars ».

Statistique	Score avant (/10)	Score après (/10)	Progression
Effectif	12	12	12
Moyenne	4,75	7,17	+ 2,42
Médiane	5	7	2
Écart-type	1,22	0,94	0,51
Minimum – maximum	3 – 7	6 – 9	2 – 3

Corrigé – Le dépouillement, pas à pas

Scores avant : 4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 3, 6, 4, 5. Scores après : 7, 8, 6, 8, 7, 6, 9, 7, 6, 8, 7, 7. **Étape 1 – Moyenne** = somme / effectif. Avant : 57 / 12 = **4,75** ; après : 86 / 12 = **7,17** ; progression moyenne : 7,17 − 4,75 = **+ 2,42 points**. **Étape 2 – Médiane** (valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés ; avec 12 valeurs, moyenne de la 6e et de la 7e). Avant, série ordonnée : 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7 → (5 + 5) / 2 = **5**. Après : 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9 → (7 + 7) / 2 = **7**. **Étape 3 – Écart-type** (dispersion autour de la moyenne ; formule de l'échantillon : $s = \sqrt{[\ (x - \text{moyenne})^2 / \Sigma\ (n - 1)]}$). Avant : $(x - 4{,}75)^2 = 16{,}25$; 16,25 / 11 = 1,477 ; √1,477 = **1,22**. Après : $(x - 7{,}17)^2 = 9{,}67$; 9,67 / 11 = Σ Σ 0,879 ; √0,879 = **0,94**. **Étape 4 – Proportions** : participants ayant progressé = 12 / 12 = **100 %** ; score après ≥ 7 = 9 / 12 = **75 %** ; légumes secs au moins 2 fois par semaine : avant 3 / 12 = **25 %**, après 9 / 12 = **75 %**, soit **+ 50 points** ; satisfaits ou très satisfaits = (7 + 4) / 12 = **91,7 %** ; note moyenne de satisfaction = 42 / 12 = **3,50 / 4**. **Interprétation** : les connaissances progressent pour tous les participants et deviennent plus homogènes (l'écart-type diminue de 1,22 à 0,94) ; l'objectif « score moyen ≥ 7/10 » est atteint (7,17). Limites : petit effectif, données **déclaratives**, pas de groupe témoin, mesure à court terme : on ne peut pas conclure à un changement durable des comportements (chapitre 9).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F12 – Tableau de bord d'évaluation (calculé dans le tableur, feuille 6)

Type	Indicateur	Prévu	Réalisé	Taux d'atteinte	Statut
Processus	Ateliers réalisés	6	6	100 %	Atteint
Processus	Familles inscrites	12	12	100 %	Atteint
Processus	Présences cumulées (11 + 10 + 10 + 9 + 8 + 10)	72	58	80,6 %	Partiellement atteint
Processus	Taux moyen de participation	80 %	80,6 %	100,7 %	Atteint
Processus	Dépenses monétaires (hors contributions en nature)	3 060 €	3 092,90 €	101,1 %	Léger dépassement (+ 32,90 €, chapitre 8)

Type	Indicateur	Prévu	Réalisé	Taux d'atteinte	Statut
Résultat	Score moyen de connaissances après le cycle	7,0	7,17	102,4 %	Atteint
Résultat	Participants ayant progressé	75 %	100 %	133,3 %	Atteint
Résultat	Légumes secs au moins 2 fois par semaine	60 %	75 %	125,0 %	Atteint
Résultat	Participants satisfaits	85 %	91,7 %	107,8 %	Atteint

Calcul du taux d'atteinte = réalisé / prévu × 100. Exemple : présences : 58 / 72 × 100 = **80,6 %** ; ce taux est inférieur à 100 % pour l'indicateur « présences cumulées » (statut « partiellement atteint »), mais il dépasse la cible de 80 % fixée pour le taux de participation : les deux lectures sont cohérentes.

Étape 7 – Valorisation, veille et auto-évaluation (fiches F13 et F14)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F13 – Fiche de veille (exemple rempli)

Rubrique	Contenu
Date de la veille	15 avril 2026 (mise à jour le 26 octobre 2026)
Besoin	Vérifier le programme national de nutrition en vigueur pour la partie « contexte » de la fiche projet
Source	Ministère chargé de la Santé ; Réseau national nutrition santé ; mangerbouger.fr ; ecologie.gouv.fr (SNANC)
Type de source	Institutionnelle nationale (fiabilité élevée)
Information retenue	SNANC 2025-2030 publiée le 11/02/2026 ; PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés le 08/04/2026 ; PNNS 5 : 3 axes, 20 mesures, objectif de − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants
Conséquence pour le projet	Remplacer toutes les références au « PNNS 4 » par le PNNS 5 ; rattacher le projet à l'axe 2 ; citer l'objectif de réduction des inégalités
Diffusion	Note de 5 lignes envoyée à la tutrice et à la diététicienne ; enregistrée dans la base documentaire partagée (dossier « Politiques nutritionnelles »)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F14 – Check-list d'auto-évaluation d'Inès (extrait)

Critère (indicateurs du référentiel)	Auto- évaluation (1 à 4)	Justification, ajustement
Diagnostic posé à partir de données variées et sourcées	3	Données objectives et besoins exprimés solides ; données de santé locales limitées (une seule source)
Objectifs SMART cohérents avec le diagnostic	4	Chaque objectif renvoie à une cause de l'arbre à problèmes
Plan d'action et budget réalistes	3	Budget équilibré ; temps de préparation sous-estimé (38 h au lieu de 25 h prévues)
Communication adaptée au public	3	Flyers traduits appréciés ; message numérique peu efficace pour 3 familles
Évaluation construite et réalisée	3	Questionnaire avant/après exploité ; pas de mesure à distance (prévoir un appel à 3 mois)
Règles éthiques, RGPD, droit à l'image	4	Autorisations écrites, codes anonymes
Posture, écoute active, animation	3	À améliorer : gestion du temps de parole d'un participant très présent

Critère (indicateurs du référentiel)	Auto- évaluation (1 à 4)	Justification, ajustement
Ajustements proposés	—	Salade modifiée ; atelier 4 déplacé le mercredi pour les enfants ; rappel SMS la veille

À retenir – Ce que montre le fil rouge

- Un projet de santé publique part d'un **diagnostic** (données + besoins normatifs, exprimés, ressentis, observés), pas d'une idée du professionnel.
- Il **s'inscrit** dans les politiques en vigueur (PNNS 5, PRS, CLS) et mobilise des **partenaires**.
- Il combine plusieurs **modes d'intervention** (éducation pour la santé au service de la prévention sélective, démarche de promotion de la santé).
- Il est **évalué** avec des indicateurs de processus et de résultats, et ses limites sont reconnues.
- Toutes les fiches F1 à F14 sont **cohérentes entre elles** : c'est ce que le jury de l'épreuve E5 vérifie dans le dossier.

1.4 Approfondissements

1.4.1 Les données probantes en promotion de la santé

Une **donnée probante** est une information issue de la recherche ou de l'évaluation qui montre qu'une intervention est **efficace** (ou non) dans un contexte donné. En promotion de la santé, on combine trois sources : les **résultats de la recherche**, l'**expérience des professionnels** et les **savoirs des personnes concernées**. Santé publique France tient un **registre des interventions probantes ou prometteuses** en prévention et promotion de la santé (par exemple, des programmes de développement des compétences psychosociales à l'école, ou des programmes d'activité physique et de nutrition). Avant de concevoir un projet, il est recommandé de vérifier s'il existe une intervention déjà évaluée que l'on peut **adapter** (transférabilité) plutôt que de tout inventer.

Exemple – Ce que l'on sait de l'efficacité des actions en nutrition

- Les actions **multi-composantes** (éducation + modification de l'environnement + implication des familles) sont plus efficaces que l'information seule.
- Les actions sur l'**environnement** (offre scolaire, prix, étiquetage, reformulation) touchent toute la population et réduisent davantage les inégalités que l'éducation seule.
- Les ateliers culinaires améliorent les **compétences** et la **confiance** en cuisine et, à court terme, certains comportements déclarés (fruits et légumes) ; leurs effets à long terme sont moins documentés, d'où l'importance d'une évaluation bien construite.

Méthode – Trouver et utiliser une intervention probante

Étape 1 – Chercher : consulter le **registre des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France, les fiches de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé et des structures régionales, les synthèses de l'OMS Europe.

Étape 2 – Vérifier : l'intervention a-t-elle été **évaluée** ? Sur quel public, dans quel pays, avec quels résultats ? Les résultats portent-ils sur des **comportements** ou seulement sur des connaissances ?

Étape 3 – Juger la transférabilité : mon public, mon territoire et mes moyens ressemblent-ils à ceux de l'intervention d'origine ? Qu'est-ce qui doit être **adapté** (langue, recettes, horaires) et qu'est-ce qui doit être **gardé** (les « fonctions clés » qui expliquent l'efficacité) ?

Étape 4 – Citer : dans le dossier E5, nommer l'intervention, sa source et sa date ; expliquer en une phrase ce que vous avez adapté.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 bis – Juger une action

Une mairie veut lutter contre le surpoids des enfants. Trois propositions sont faites : A) distribuer un dépliant sur l'équilibre alimentaire à toutes les familles ; B) un programme d'un an associant ateliers culinaires parents-enfants, modification des goûters servis au périscolaire et fontaines à eau dans les écoles ; C) une pesée des enfants en classe avec un courrier aux familles des enfants en surpoids.

1. Classez les propositions de la plus probablement efficace à la moins efficace, en justifiant avec les données probantes.
2. Quelle proposition pose un problème éthique ? Pourquoi ?

Corrigé – Exercice 1.6 bis

1. **B** d'abord : action **multi-composantes** (éducation + environnement + familles), qui touche tous les enfants. Ensuite **A** : l'information seule a peu d'effet sur les comportements et touche surtout les familles déjà sensibilisées (risque d'accroître les inégalités). **C** en dernier : un repérage sans proposition d'accompagnement n'est pas une intervention efficace.
2. **C** : la pesée en classe et le courrier ciblé exposent les enfants à la **stigmatisation** (section 1.4.4) ; le repérage doit se faire dans un cadre médical confidentiel (santé scolaire, médecin traitant), avec une orientation vers une prise en charge.

1.4.2 Les théories du changement de comportement : premier aperçu

Pour comprendre pourquoi « savoir » ne suffit pas, on utilise des modèles qui seront détaillés au chapitre 3 :

- **Modèle des croyances relatives à la santé** (*Health Belief Model*, Rosenstock, années 1950-1970) : une personne adopte un comportement si elle se sent **vulnérable**, si elle perçoit la **gravité** du problème, si elle juge les **bénéfices** supérieurs aux **obstacles**, avec un **déclencheur** à l'action et un sentiment d'**auto-efficacité**.
- **Modèle transthéorique des étapes du changement** (Prochaska et DiClemente, 1983) : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien (et rechute possible). L'action éducative s'adapte à l'étape de la personne.
- **Théorie sociale cognitive** (Bandura, 1977-1986) : le **sentiment d'efficacité personnelle** (« je suis capable de cuisiner des lentilles ») est un levier central ; il se développe par l'expérience réussie (d'où l'intérêt de **faire** en atelier), l'observation de pairs, l'encouragement.

Lien diététique – Dans le fil rouge

Faire cuisiner les familles elles-mêmes (et non leur faire une démonstration) développe l'**auto-efficacité** ; la dégustation partagée et le choix des recettes par le groupe mobilisent l'**influence sociale** positive ; le coût par portion calculé ensemble lève un **obstacle perçu** (« c'est cher »).

1.4.3 Le débat sur les aliments ultra-transformés

La classification **NOVA** (Carlos Monteiro, université de São Paulo, 2009) classe les aliments selon leur **degré de transformation** en quatre groupes : 1) aliments non ou peu transformés ; 2) ingrédients culinaires transformés (huile, sucre, sel) ; 3) aliments transformés (conserves, fromages, pain artisanal) ; 4) **aliments ultra- transformés** (formulations industrielles contenant des ingrédients peu ou pas utilisés en cuisine domestique : additifs cosmétiques, isolats de protéines, sirops…). De nombreuses études d'observation, dont la cohorte NutriNet-

Santé, associent une forte consommation d'ultra-transformés à un risque accru d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de mortalité. Les repères de 2019 recommandent de les **limiter**. Le débat porte sur la **définition** (NOVA est critiquée pour son manque de précision), sur la **causalité** (études observationnelles) et sur l'articulation avec le Nutri-Score (qui mesure la composition nutritionnelle, pas la transformation). Le PNNS 5 reconnaît l'enjeu et confie à l'ANSES l'élaboration d'une définition opérationnelle.

Outil	Ce qu'il mesure	Ce qu'il ne mesure pas	Exemple
Nutri-Score (A à E)	La **composition nutritionnelle** pour 100 g : énergie, sucres, graisses saturées, sel, fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses	Le degré de transformation, les additifs, le mode de production (bio), l'origine	Une boisson « zéro » sucre peut être bien classée tout en étant ultra-transformée
NOVA (groupes 1 à 4)	Le **degré de transformation** et les procédés industriels	La teneur en sucres, en sel ou en graisses	Une huile d'olive (groupe 2) est riche en lipides ; un pain complet artisanal (groupe 3) peut être salé
Label bio (AB, Eurofeuille)	Le **mode de production** agricole	La composition nutritionnelle	Un biscuit bio peut être très sucré

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 ter – Nutri-Score ou NOVA ?

Classez chaque aliment dans un groupe NOVA (1 à 4) : a) lentilles vertes sèches ; b) huile de colza ; c) pain de boulangerie (farine, eau, sel, levure) ; d) céréales du petit déjeuner fourrées au chocolat avec émulsifiant et arôme ; e) yaourt nature ; f) nuggets de poulet panés surgelés avec amidon modifié.

Puis expliquez en deux phrases à un groupe de parents pourquoi un produit classé A au Nutri-Score n'est pas forcément « peu transformé ».

Corrigé – Exercice 1.6 ter

a) Groupe **1** (non transformé). b) Groupe **2** (ingrédient culinaire). c) Groupe **3** (aliment transformé avec des ingrédients de cuisine). d) Groupe **4** (ultra-transformé : additifs cosmétiques). e) Groupe **1** (lait fermenté sans ajout). f) Groupe **4** (ultra-transformé : amidon modifié, procédés industriels).

Exemple d'explication : « Le Nutri-Score regarde ce que contient l'aliment : sucre, sel, gras, fibres. Il ne dit pas comment l'aliment a été fabriqué : pour choisir, regardez aussi la liste des ingrédients ; plus elle est courte et faite d'ingrédients que vous avez dans votre cuisine, mieux c'est. »

1.4.4 Promotion de la santé et non-stigmatisation du poids

La **stigmatisation du poids** (moqueries, discriminations, messages culpabilisants) est elle-même un facteur de risque : elle augmente le stress, les troubles du comportement alimentaire, l'évitement des soins et, paradoxalement, la prise de poids. Une déclaration de consensus internationale (*Nature Medicine*, 2020) appelle à l'éliminer. En pratique : parler de « personne vivant avec une obésité », éviter les images dégradantes, ne pas peser les enfants en public, centrer les actions sur la **santé** et le **plaisir** de manger plutôt que sur le poids, proposer des actions **universelles** (pour tous les enfants) plutôt que de désigner les enfants « en surpoids ».

Formulations à éviter	Formulations à préférer	Pourquoi
« Les obèses », « les gros »	« Les personnes vivant avec une obésité »	On nomme la personne avant la maladie
« Lutter contre l'obésité des enfants » (sur une affiche destinée aux familles)	« Bien manger et bouger en famille »	Le message vise tous les enfants et ne désigne personne
« Aliments interdits », « mauvais aliments »	« Aliments à limiter », « à garder pour les moments de plaisir »	On évite la culpabilité et la moralisation

Formulations à éviter	Formulations à préférer	Pourquoi
Photo d'un corps sans tête, ventre en gros plan	Photo de personnes de corpulences variées en activité	On évite l'image dégradante
« Il faut perdre du poids »	« On peut améliorer sa santé quel que soit son poids »	On centre l'action sur la santé et le plaisir

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 quater – Réécrire un message

Réécrivez ces trois phrases trouvées sur l'affiche d'une action en collège pour qu'elles ne soient pas stigmatisantes : a) « Stop à l'obésité : les sodas sont interdits ! » ; b) « Élèves en surpoids : inscrivez-vous à l'atelier sport » ; c) « Les mauvaises habitudes des familles font grossir les enfants ».

Corrigé – Exercice 1.6 quater

a) « Envie de te désaltérer ? L'eau, c'est gratuit et à volonté : découvre nos eaux aromatisées maison. » b) « Atelier sport pour tous, tous niveaux, le mardi midi : viens essayer ! » c) « Cuisiner ensemble, c'est bon pour toute la famille : découvrez nos ateliers parents-enfants. » Les trois réécritures s'adressent à **tous**, valorisent le **plaisir** et une **action positive**, et ne désignent personne.

1.4.5 Santé publique, alimentation et climat

Le système alimentaire représente environ **un quart de l'empreinte carbone** de la consommation des ménages français (ordre de grandeur cité par l'ADEME et le Haut Conseil pour le climat). Une alimentation plus **végétale**, **de saison**, **locale** quand c'est pertinent, **peu transformée** et **sans gaspillage** est généralement favorable à la fois à la santé et au climat : c'est le principe des « co-bénéfices » qui fonde la SNANC. La commission **EAT-Lancet** (2019) a proposé un « régime de santé planétaire » ; le HCSP (2025) recommande pour le PNNS 5 une diminution d'environ 50 % de la consommation de viande et une augmentation des produits végétaux. Le diététicien veille toutefois à la **couverture des besoins** (fer, vitamine B12, calcium, iode) et à l'**acceptabilité** culturelle et économique des changements.

Calcul – Diversifier les sources de protéines : combien faut-il manger pour obtenir 20 g de protéines ?

Données (table Ciqual 2025, ANSES, pour 100 g d'aliment cuit) : steak haché de bœuf 15 % MG cuit : 23,6 g de protéines, 2,6 mg de fer, 0 g de fibres, 239 kcal ; lentille verte cuite à l'eau : 10,1 g, 2,45 mg, 8,45 g, 125 kcal ; pois chiche cuit à l'eau : 8,31 g, 1,3 mg, 8,2 g, 148 kcal ; tofu nature : 13,4 g, 2,4 mg, fibres < 0,5 g (comptées 0), 147 kcal.

Étape 1 – Quantité pour 20 g de protéines = 20 / teneur × 100. Steak haché : 20 / 23,6 × 100 = **84,7 g** ; lentilles : 20 / 10,1 × 100 = **198,0 g** ; pois chiches : 20 / 8,31 × 100 = **240,7 g** ; tofu : 20 / 13,4 × 100 = **149,3 g**.

Étape 2 – Ce qu'apporte cette quantité : steak haché : 2,2 mg de fer, 0 g de fibres, 203 kcal ; lentilles : 4,9 mg de fer, 16,7 g de fibres, 248 kcal ; pois chiches : 3,1 mg de fer, 19,7 g de fibres, 356 kcal ; tofu : 3,6 mg de fer, 0 g de fibres, 219 kcal.

Interprétation : une assiette de lentilles (environ 200 g cuites) apporte autant de protéines qu'un steak haché, plus de fer et plus de la moitié des 30 g de fibres conseillés par jour. Attention : le fer des végétaux (fer non héminique) est moins bien absorbé que celui de la viande ; on améliore son absorption avec une source de vitamine C dans le repas (crudités, agrumes). C'est un exemple de **co-bénéfice** santé et climat à présenter en atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 quinquies – Argumenter pour un menu végétarien

Le responsable d'une cantine craint que le menu végétarien hebdomadaire « manque de protéines ». Avec les données du calcul ci-dessus, rédigez une réponse de 5 lignes qui cite deux chiffres, un point de vigilance et

une proposition de plat.

Corrigé – Exercice 1.6 quinquies (exemple de réponse)

« Selon la table Ciqual 2025, 200 g de lentilles cuites apportent environ 20 g de protéines, autant qu'un steak haché de 85 g, et en plus 16,7 g de fibres. Le menu végétarien peut donc couvrir le besoin en protéines du repas. Le point de vigilance est le fer, moins bien absorbé : on ajoute une crudité ou un agrume au menu. Je propose un dahl de lentilles corail avec du riz et une salade de carottes au citron. » Le correcteur valorise : deux chiffres sourcés, la vigilance sur le fer, une proposition concrète.

1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'approche par les capabilités (Amartya Sen)

Pour l'économiste Amartya Sen (prix Nobel 1998), la justice sociale ne se mesure pas aux ressources possédées mais aux **capabilités** : les libertés réelles d'une personne d'être et de faire ce qu'elle valorise. Appliquée à l'alimentation, cette approche montre qu'il ne suffit pas de **savoir** ce qu'est une alimentation équilibrée ni même d'avoir un revenu : il faut aussi avoir le **temps**, l'**équipement**, l'**accès physique** aux commerces, les **compétences** et la **liberté** de choisir. Elle fonde la notion de **droit à l'alimentation** et les expérimentations de « sécurité sociale de l'alimentation » débattues en France depuis 2019.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La syndémie mondiale (Swinburn et coll., *The Lancet*, 2019)

La commission du *Lancet* sur l'obésité propose le concept de **syndémie mondiale** : l'obésité, la dénutrition et le changement climatique sont trois pandémies qui **interagissent** et partagent des **déterminants communs** (systèmes alimentaires, transports, urbanisme, utilisation des terres, intérêts commerciaux). Elle appelle à des actions « à double ou triple bénéfice » et à limiter l'influence des grandes industries sur les politiques publiques : c'est le cadre intellectuel des stratégies intégrées comme la SNANC.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer la complexité : l'évaluation réaliste

Les interventions de promotion de la santé sont **complexes** (plusieurs composantes, plusieurs acteurs, contextes variables). L'**évaluation réaliste** (Pawson et Tilley, 1997) ne demande pas seulement « est-ce que ça marche ? », mais « **qu'est-ce qui marche, pour qui, dans quelles circonstances et pourquoi ?** » ; elle formule des configurations **contexte – mécanisme – effet**. Exemple : dans un quartier où les familles se connaissent (contexte), un atelier cuisine crée de l'entraide (mécanisme) qui maintient la pratique culinaire après le projet (effet). Le Medical Research Council britannique a publié en 2021 un cadre de référence actualisé pour le développement et l'évaluation des interventions complexes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La santé dans toutes les politiques et les déterminants commerciaux de la santé

La déclaration d'Helsinki (2013) invite tous les secteurs (agriculture, économie, urbanisme, éducation) à évaluer l'**impact sur la santé** de leurs décisions (**évaluation d'impact sur la santé, EIS**). Plus récemment, l'OMS et *The Lancet* (série 2023) ont mis en avant les **déterminants commerciaux de la santé** : les stratégies des entreprises (marketing, lobbying, formulation des produits, prix) influencent la santé des populations. Ces travaux éclairent les débats sur l'encadrement du marketing alimentaire destiné aux enfants et sur le caractère volontaire du Nutri-Score.

1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et santé publique

Une diététicienne libérale constate que beaucoup d'enfants qu'elle reçoit en consultation pour surpoids viennent de la même école. **Lien** : la consultation (BC1, soin individuel, prévention tertiaire ou secondaire) révèle un **problème de santé publique** ; elle peut alerter la santé scolaire et proposer une action **universelle** dans l'école (BC3) plutôt que de multiplier les consultations. Elle veille à ne pas stigmatiser les enfants et à respecter le **secret professionnel** (aucune information individuelle transmise).

Situation bc1 – De l'ETP à l'atelier ouvert

Un programme d'ETP « diabète » d'un hôpital souhaite proposer un atelier cuisine ouvert aux habitants du quartier. **Lien** : il faut distinguer l'**ETP** (réservée aux patients du programme déclaré à l'ARS) et l'**éducation pour la santé** ouverte à tous (prévention primaire) ; les objectifs, les messages et l'évaluation ne sont pas les mêmes.

Situation bc2 – Restauration scolaire et EGalim

Le diététicien d'une cuisine centrale (BC2) doit atteindre les objectifs EGalim et introduire un deuxième repas végétarien par semaine. **Lien BC3** : accompagner ce changement par une action d'**éducation au goût** dans les écoles (ateliers de dégustation de légumineuses), une **communication** vers les parents (plan de communication) et une **évaluation** (taux de consommation, gaspillage, satisfaction).

Situation bc2 – Former les professionnels

Le CCAS demande de former les aides à domicile à repérer la dénutrition des personnes âgées. **Lien** : compétence C2.6 (former les professionnels) au service d'une action de **prévention secondaire** (repérage précoce), inscrite dans le PNNS 5 (prévention de la dénutrition).

Situation bc3 – Répondre à un appel à projets

L'ARS lance un appel à projets « Nutrition et précarité ». Une association d'aide alimentaire vous sollicite. **Compétences** : C3.1 (diagnostic, objectifs, fiche projet, budget), C3.4 (veille sur les priorités du PRS et du PNNS 5), C3.5 (présentation du projet aux partenaires), C3.6 (dépôt du dossier sur une plateforme sécurisée, gestion des données des bénéficiaires).

Situation bc3 – Une demande inadaptée

Un directeur d'école vous demande une intervention d'une heure « pour expliquer aux enfants en surpoids qu'il faut moins manger ». **Analyse** : la demande est **stigmatisante** et fondée sur l'approche informative ; vous proposez une action **universelle** (toute la classe), **participative** (éducation sensorielle, découverte des fruits et légumes), associée à une action sur l'environnement (goûters, fontaine à eau) et à l'implication des parents, en cohérence avec la Charte d'Ottawa.

Méthode 1 – Présenter le cadre de son action en deux minutes (oral E5)

Le jury de l'épreuve E5 attend que vous situiez votre action dans son **cadre institutionnel et politique** (savoirs « enjeux de santé publique » du guide 2025). Cette présentation tient en deux minutes et suit toujours le même plan, du général au particulier.

Étape	Ce que vous dites	Exemple (fil rouge)	Durée
1. Le problème de santé	Le problème, chiffré et sourcé, au niveau national puis local	« 17 % des 6-17 ans sont en surpoids en France (Esteban 2015) ; 14 % des enfants de grande section des Tilleuls, contre 9 % dans le département (santé scolaire, 2026). »	30 s
2. Les politiques	La stratégie et le programme national, puis le niveau régional et local	« Le PNNS 5 vise une baisse de 30 % du surpoids des enfants, de 20 % chez ceux des familles défavorisées ; le PRS en fait une priorité ; le CLS de Valmont a une fiche-action nutrition. »	30 s
3. Le mode d'intervention	Promotion, prévention (OMS et Gordon), éducation (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle)	« C'est une action de promotion de la santé et de prévention primaire, sélective, avec une éducation alimentaire et sensorielle. »	20 s
4. Les acteurs	Décideur, financeur, opérateurs, partenaires	« L'ARS finance par appel à projets ; le centre social porte le projet ; l'épicerie solidaire et la PMI sont partenaires. »	20 s
5. Votre place	Votre rôle et vos compétences	« J'ai réalisé le diagnostic, conçu et animé les ateliers, et construit l'évaluation (C3.1, C3.2, C3.5). »	20 s

Le jury attend – Les erreurs qui coûtent des points

- Citer un programme **périmé** (PNNS 4 au lieu du PNNS 5) ou présenter comme adopté un texte qui n'est qu'un projet (la SNS 2023-2033, non adoptée en mai 2026).
- Donner un chiffre **sans source ni année**.
- Confondre **promotion de la santé** et **éducation pour la santé**, ou qualifier une action collective d'**ETP**.
- Oublier les **acteurs** et présenter l'action comme celle d'une personne seule.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.7 – Mon cadre en deux minutes

Rédigez, pour votre action de stage (ou, à défaut, pour l'action « Bouge et mange » d'un club sportif d'adolescents), les cinq phrases du tableau ci-dessus. Chronométrez-vous à voix haute : vous devez tenir en deux minutes.

Corrigé – Exercice 1.7 (exemple pour le club sportif)

1. « Selon Esteban, 17 % des 6-17 ans sont en surpoids ; dans le club, 6 adolescents sur 10 sautent le petit déjeuner avant l'entraînement du samedi (questionnaire, mars 2027). » 2. « L'action répond au PNNS 5 (comportements nutritionnels sains et milieux de vie) et à la Stratégie nationale sport-santé ; le PRS de la région cible la santé des jeunes. » 3. « C'est une action de promotion de la santé dans un milieu de vie, de prévention primaire universelle (tous les licenciés), avec une éducation nutritionnelle. » 4. « Le club porte le projet ; la commune et la mutuelle financent ; le comité départemental et l'infirmière du collège sont partenaires. » 5. « J'ai réalisé le questionnaire, animé deux ateliers petit déjeuner et évalué l'action. » Les données du club sont fictives : dans votre dossier, chaque chiffre doit venir de votre propre recueil ou d'une source datée.

Méthode 2 – Lire de façon critique un document de santé publique

Le référentiel (compétence C3.4) demande de **sélectionner des sources fiables** et d'en faire une **analyse critique**. Avant d'utiliser un document (article, rapport, affiche, page web), posez-vous six questions.

Question	Ce que l'on vérifie	Signal d'alerte
Qui ?	L'auteur ou l'organisme, sa compétence, ses liens d'intérêts	Document d'une marque ou d'un lobby présenté comme neutre
Quand ?	La date de publication et la date du recueil des données	Chiffre de plus de 10 ans présenté comme actuel
Quoi ?	Le type de document : étude, avis d'expert, opinion, publicité	Témoignage présenté comme une preuve
Sur qui ?	La population étudiée et son effectif	Résultat sur 30 personnes généralisé à toute la France
Comment ?	La méthode : données mesurées ou déclarées, étude d'observation ou essai	Lien de cause à effet affirmé à partir d'une simple association
Et alors ?	La cohérence avec les recommandations officielles (HCSP, ANSES, Santé publique France)	Conseil contraire aux repères officiels, sans débat scientifique

À vous de jouer – Exercice d'application 1.8 – Analyser un document

Document (fictif, construit pour l'exercice) : une page web d'un fabricant de céréales, datée de 2026, titre « Le petit déjeuner aux céréales rend les enfants plus performants à l'école ». Le texte cite « une étude » menée en 2009 auprès de 42 enfants d'une école privée, dont les parents déclaraient ce que mangeait leur enfant ; les enfants qui mangeaient des céréales avaient de meilleures notes.

1. Appliquez les six questions de la méthode.
2. Pouvez-vous utiliser ce document dans votre dossier E5 ? Si oui, comment ?

Corrigé – Exercice 1.8

1. **Qui ?** Un fabricant : conflit d'intérêts. **Quand ?** Page de 2026, mais données de 2009 (17 ans). **Quoi ?** Un texte promotionnel qui résume une étude non référencée. **Sur qui ?** 42 enfants d'une seule école privée : effectif faible, population non représentative (niveau social plus élevé). **Comment ?** Données déclarées par les parents ; étude d'observation : on ne peut pas conclure que les céréales « rendent » les enfants performants (le niveau social peut expliquer à la fois le petit déjeuner et les notes). **Et alors ?** Les repères officiels recommandent un petit déjeuner, sans privilégier un produit de marque.
2. Pas comme une **source**. On peut l'utiliser comme **exemple** de document à analyser avec le public (atelier d'éducation critique à la publicité), ce qui développe la littératie en santé (chapitre 5).

1.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concepts

- **Santé (OMS, 1946)** : « état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Critique : idéal, statique ; la santé est aussi une capacité d'adaptation et une **ressource de la vie quotidienne** (Ottawa, 1986).
- **Une seule santé / One Health** : santé humaine, animale et des écosystèmes interdépendantes (Quadripartite OMS-FAO-OMSA-PNUE) ; cadre de toute intervention du BC3 (guide 2025).
- **Santé publique** : actions organisées et collectives pour maintenir et améliorer la santé de la population en

agissant sur ses déterminants (Winslow, 1920 ; CSP art. L. 1411-1).

- **Paradoxe de Rose** : un grand nombre de personnes à faible risque produit plus de cas qu'un petit nombre à haut risque : il faut des actions populationnelles.
- **Danger** (capacité à nuire) ≠ **risque** (probabilité, = danger × exposition) ; **facteur de risque** = association, pas forcément cause.

À retenir – Modes d'intervention

- **Surveillance** (recueil continu, analyse, diffusion) et **veille sanitaire** (détection des signaux, alerte) : Santé publique France, ANSES.
- **Promotion de la santé** (Ottawa, 21/11/1986) : processus qui confère aux populations les moyens d'un plus grand contrôle sur leur santé ; **5 domaines** (politique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services) et **3 stratégies** (plaider, conférer les moyens, servir de médiateur).
- **Prévention** (OMS 1948) : primaire (incidence), secondaire (prévalence, dépistage), tertiaire (complications), quaternaire (surmédicalisation) ; Gordon (1983) : universelle, sélective, indiquée.
- **Éducation pour la santé** : nutritionnelle, alimentaire, sensorielle ; approche participative et compétences psychosociales.
- **ETP** : soin, patients atteints de maladie chronique, programme déclaré à l'ARS (BC1) ≠ éducation pour la santé.
- **Universalisme proportionné** (Marmot, 2010) : pour tous, plus intensément pour les plus défavorisés.

À retenir – Acteurs et politiques

- National : DGS (PNNS), DGAL (PNA, EGalim), Santé publique France, ANSES, HAS, HCSP, CNA ; régional : **ARS** (PRS = COS 10 ans + SRS 5 ans + PRAPS ; appels à projets), DRAAF ; local : CLS, PAT, contrats de ville, communes, CCAS, PMI.
- **SNANC 2025-2030** (loi Climat et résilience, art. 265) publiée le **11/02/2026** ; **PNNS 5** et **PNA 4** (2026-2030) lancés le **08/04/2026** ; PNNS 5 : 3 axes, 20 mesures, − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents.
- **Repères 2019** (Santé publique France) : augmenter (fruits et légumes, légumes secs, fruits à coque, activité physique), aller vers (complets, colza-noix-olive, poisson 2/sem., 2 produits laitiers, saison/local/bio), réduire (alcool, boissons sucrées, produits gras-sucrés-salés et ultra-transformés, charcuterie 150 g/sem., viande 500 g/sem., sel, sédentarité).
- **EGalim** : 50 % durables et de qualité dont 20 % bio ; 60 % pour viandes et poissons (2024) ; menu végétarien hebdomadaire à l'école. **Nutri-Score** : facultatif, nouvel algorithme (arrêté du 14/03/2025).

À retenir – Chiffres-clés (à dater et sourcer dans vos écrits)

Donnée	Valeur (source, année)
Obésité de l'adulte	18,1 % (OFÉO, 2024) ; 17 % mesuré (ESTEBAN, 2015)
Surpoids des 6-17 ans	17 % dont 4 % d'obésité (ESTEBAN, 2015)
Précarité alimentaire	16 % (Crédoc, 2022)
Atteinte des 5 fruits et légumes	30 % des adultes, 20 % des enfants (HCSP, 2025)
Fibres < 25 g/jour	90 % des adultes (HCSP, 2025)
Espérance de vie	85,9 ans (F), 80,3 ans (H) (Insee, 2025)
Écart d'espérance de vie selon le revenu	≈ 13 ans chez les hommes (Insee, 2018)
EGalim, achats 2023	≈ 25,5 % durables et de qualité, 12,1 % bio (bilan 2024)

Donnée	Valeur (source, année)
PAT	≈ 450 reconnus (juillet 2025) ; objectif 80 % du territoire (SNANC)
Fil rouge (fictif)	Repas complet à 1,38 €/personne ; score 4,75 → 7,17/10 ; légumes secs 25 % → 75 %

1.8 Entraînement

1.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La définition de la santé de l'OMS date de :

a) 1946 (signature de la Constitution), entrée en vigueur en 1948 **b)** 1978 (Alma-Ata) **c)** 1986 (Ottawa) **d)** 2004 (loi relative à la politique de santé publique)

QCM 2 – Selon la Charte d'Ottawa, la promotion de la santé :

a) vise une maladie précise **b)** confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé **c)** se limite à l'information du public **d)** agit sur les politiques publiques et les milieux de vie

QCM 3 – Parmi ces domaines, lequel n'est PAS l'un des cinq domaines d'action de la Charte d'Ottawa ?

a) Créer des milieux favorables **b)** Renforcer l'action communautaire **c)** Développer le dépistage organisé **d)** Réorienter les services de santé

QCM 4 – La prévention primaire vise à réduire :

a) la prévalence d'une maladie **b)** l'incidence d'une maladie **c)** les complications d'une maladie installée **d)** la surmédicalisation

QCM 5 – Le repérage du rebond d'adiposité précoce sur la courbe de corpulence d'un enfant relève de la prévention :

a) primaire **b)** secondaire **c)** tertiaire **d)** quaternaire

QCM 6 – Une action réservée aux familles d'un quartier prioritaire, sans signe de maladie, est une prévention (Gordon) :

a) universelle **b)** sélective **c)** indiquée **d)** tertiaire

QCM 7 – L'éducation thérapeutique du patient :

a) est une forme d'éducation pour la santé destinée à toute la population **b)** s'adresse à des personnes atteintes d'une maladie chronique **c)** est encadrée par la loi HPST du 21 juillet 2009 **d)** relève de la prévention tertiaire

QCM 8 – Le risque se définit comme :

a) la propriété intrinsèque d'un agent à provoquer un effet néfaste **b)** la probabilité de survenue d'un effet néfaste, compte tenu du danger et de l'exposition **c)** une caractéristique associée à une moindre probabilité de maladie **d)** le nombre de nouveaux cas dans une population

QCM 9 – Les études INCA sont conduites par :

a) Santé publique France **b)** l'ANSES **c)** la HAS **d)** l'Insee

QCM 10 – Le projet régional de santé (PRS) :

a) est élaboré par l'ARS **b)** comprend un cadre d'orientation stratégique sur 10 ans **c)** comprend un schéma régional de santé sur 5 ans **d)** comprend un PRAPS destiné aux personnes les plus démunies

QCM 11 – La SNANC 2025-2030 :

a) est prévue par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 **b)** a été publiée le 11 février 2026 **c)** remplace la loi EGalim **d)** détermine les orientations du PNNS et du PNA

QCM 12 – Le PNNS en vigueur en octobre 2026 est :

a) le PNNS 3 **b)** le PNNS 4 (2019-2023) **c)** le PNNS 5 (2026-2030) **d)** le PNAN 2019-2023

QCM 13 – Selon les repères de Santé publique France (2019), il est recommandé de consommer des légumes secs :

a) au moins une fois par mois **b)** au moins deux fois par semaine **c)** tous les jours obligatoirement **d)** uniquement en remplacement du pain

QCM 14 – La loi EGalim impose en restauration collective :

a) 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits bio **b)** 100 % de produits locaux **c)** un menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire **d)** l'affichage obligatoire du Nutri-Score sur les menus

QCM 15 – Le Nutri-Score :

a) est obligatoire sur tous les produits vendus en France **b)** classe les produits de A à E **c)** a un nouvel algorithme applicable en France depuis l'arrêté du 14 mars 2025 **d)** mesure le degré de transformation des aliments

QCM 16 – L'universalisme proportionné consiste à :

a) cibler uniquement les plus défavorisés **b)** proposer la même action avec la même intensité à tous **c)** proposer une action à tous, avec une intensité proportionnelle au désavantage social **d)** supprimer les actions universelles

QCM 17 – Le paradoxe de la prévention (Rose) signifie que :

a) la prévention est inutile **b)** la majorité des cas provient souvent du grand nombre de personnes à risque faible ou modéré **c)** il faut uniquement traiter les personnes à haut risque **d)** une mesure utile à la population apporte souvent peu à chaque individu

QCM 18 – Lequel de ces organismes assure la veille sanitaire en France ?

a) Santé publique France **b)** le CNA **c)** l'EFSA **d)** la DGCCRF

QCM 19 – Le modèle de Dahlgren et Whitehead :

a) classe les niveaux de prévention **b)** représente les déterminants de la santé en couches concentriques **c)** place au centre l'âge, le sexe et les facteurs héréditaires **d)** montre que les comportements dépendent des conditions de vie

QCM 20 – Une campagne télévisée nationale « Manger Bouger » relève de :

a) l'éducation pour la santé informative **b)** la prévention primaire universelle **c)** l'éducation thérapeutique **d)** la prévention tertiaire

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a. Constitution signée le 22 juillet 1946, entrée en vigueur le 7 avril 1948. Alma-Ata (1978) concerne les soins de santé primaires ; Ottawa (1986) la promotion de la santé.

2. b, d. La promotion de la santé ne vise pas une maladie précise (c'est la prévention) et ne se limite pas à l'information : elle agit sur les politiques, les milieux, la communauté, les aptitudes et les services.

3. c. Le dépistage relève de la prévention secondaire, pas des cinq domaines d'Ottawa.

4. b. La prévention primaire évite l'apparition de nouveaux cas (incidence) ; la secondaire réduit la prévalence ; la tertiaire les complications ; la quaternaire la surmédicalisation.

5. b. Le repérage précoce d'un signe (avant l'installation de l'obésité et de ses complications) est une prévention secondaire.

6. b. Sous-groupe exposé à un risque (précarité), sans signe de maladie : prévention sélective.

7. b, c, d. L'ETP n'est pas de l'éducation pour la santé « tout public » : elle s'adresse aux patients (art. L. 1161-1 du CSP issu de la loi HPST) et relève du soin et de la prévention tertiaire.

8. b. La réponse a définit le danger ; c le facteur de protection ; d l'incidence.

9. b. INCA = études individuelles nationales des consommations alimentaires de l'ANSES (ESTEBAN = Santé publique France).

10. a, b, c, d. Les quatre affirmations sont exactes (art. L. 1434-1 et suivants du CSP).

11. a, b, d. La SNANC ne remplace pas EGalim : elle rappelle et prolonge ses objectifs.

12. c. PNNS 5 lancé le 8 avril 2026. Citer le PNNS 4 comme « en vigueur » serait une erreur de veille.

13. b. Légumes secs au moins 2 fois par semaine (catégorie « augmenter »).

14. a, c. L'affichage du Nutri-Score n'est pas obligatoire ; le « 100 % local » n'existe pas (le critère « local » n'est d'ailleurs pas autorisé en tant que tel par le droit des marchés publics).

15. b, c. Le Nutri-Score est facultatif (droit européen) et mesure la composition nutritionnelle, pas la transformation (c'est la classification NOVA).

16. c. Définition de Marmot (2010).

17. b, d. Le paradoxe justifie les actions populationnelles en complément des actions à haut risque.

18. a. Le CNA est une instance de concertation ; l'EFSA est européenne ; la DGCCRF contrôle la loyauté commerciale.

19. b, c, d. Les niveaux de prévention, c'est la classification de l'OMS.

20. a, b. Communication de masse, informative, destinée à toute la population, avant toute maladie.

1.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les niveaux de prévention

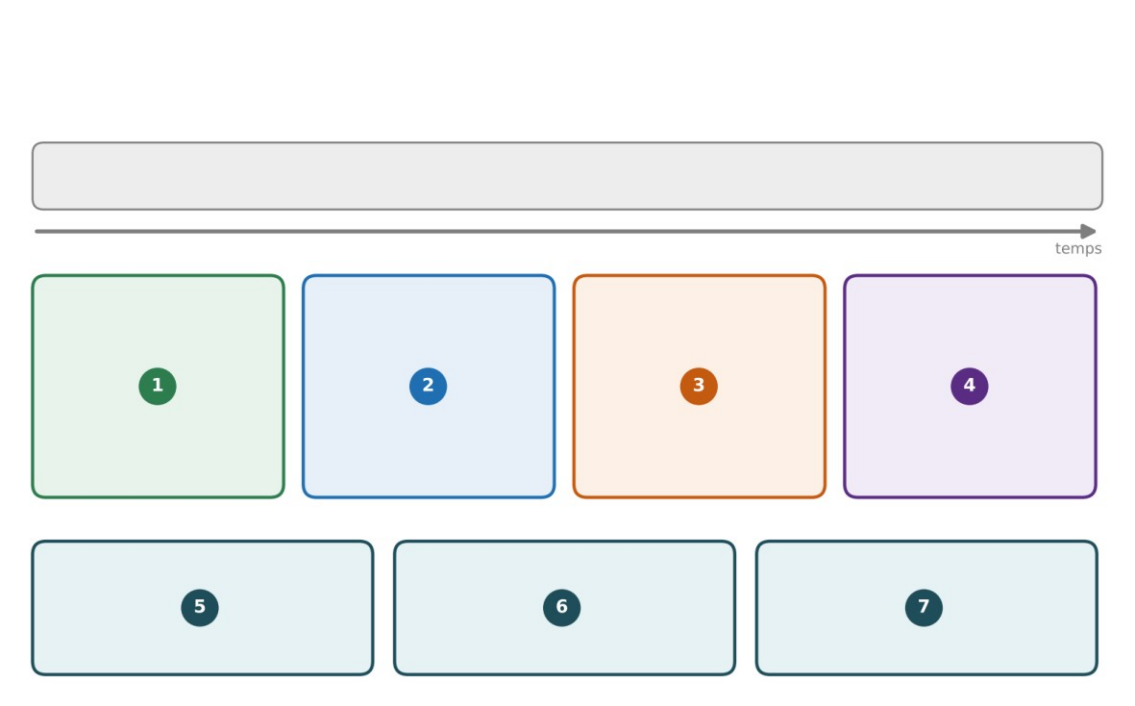


Figure 1.15 – Schéma à légender (niveaux de prévention)

Complétez les légendes 1 à 7 : nom du niveau ou du type de prévention, auteur et date de la classification, indicateur que chaque niveau fait baisser, un exemple en nutrition pour chacun.

Corrigé

1. Prévention primaire (OMS, 1948) : avant la maladie ; diminue l'**incidence** ; exemple : atelier cuisine pour

tous, réduction du sel dans le pain.

2. Prévention secondaire : au début de la maladie ; diminue la **prévalence** par le dépistage ; exemple : repérage du surpoids en santé scolaire, dépistage de la dénutrition.

3. Prévention tertiaire : maladie installée ; diminue les **complications et récidives** ; exemple : suivi diététique de la personne diabétique, ETP.

4. Prévention quaternaire (Jamoulle, 1986) : évite la **surmédicalisation** ; exemple : déconseiller un régime d'éviction sans diagnostic.

5. Prévention universelle (Gordon, 1983) : toute la population ; exemple : repères PNNS.

6. Prévention sélective : sous-groupe exposé ; exemple : familles d'une épicerie solidaire.

7. Prévention indiquée : personnes présentant déjà des facteurs de risque ; exemple : programme pour enfants en surpoids repérés.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les déterminants de la santé

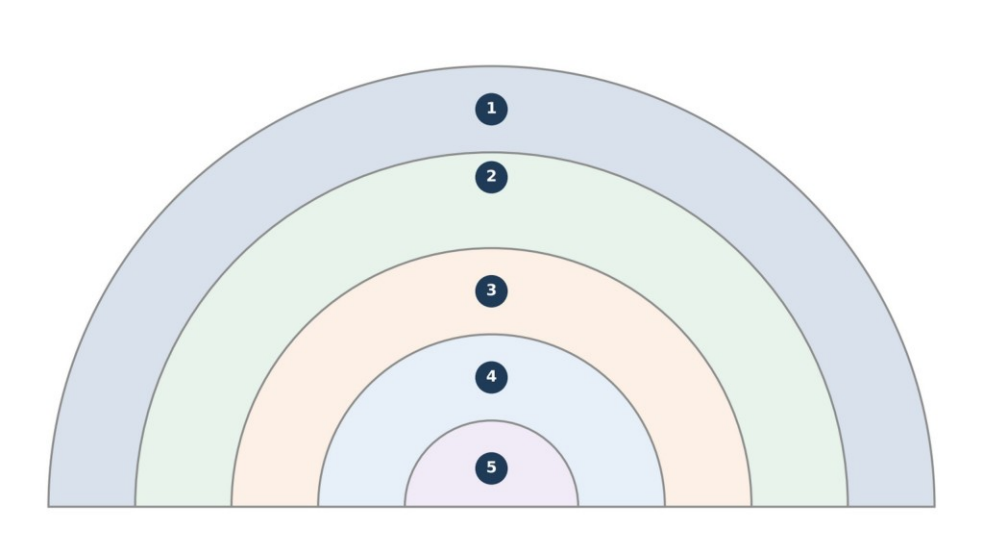


Figure 1.16 – Schéma à légender (modèle des déterminants)

Donnez le nom du modèle et sa date, puis légendez les couches 1 à 5. Pour chaque couche, donnez un exemple de déterminant de l'alimentation d'un enfant vivant dans un quartier prioritaire.

Corrigé

Modèle de **Dahlgren et Whitehead (1991)**.

1. Âge, sexe, facteurs héréditaires : âge de l'enfant (8 ans), préférences innées pour le sucré.

2. Style de vie personnel : grignotage devant les écrans, faible activité physique.

3. Réseaux sociaux et communautaires : habitudes familiales, influence des camarades, soutien des voisins, centre social.

4. Conditions de vie et de travail : logement exigu sans cuisine équipée, offre alimentaire du quartier (supérette, restaurants rapides), cantine, horaires de travail des parents, chômage.

5. Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales : prix des aliments, minima sociaux, politiques alimentaires (EGalim, Nutri-Score), publicité, culture alimentaire.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : l'architecture des politiques

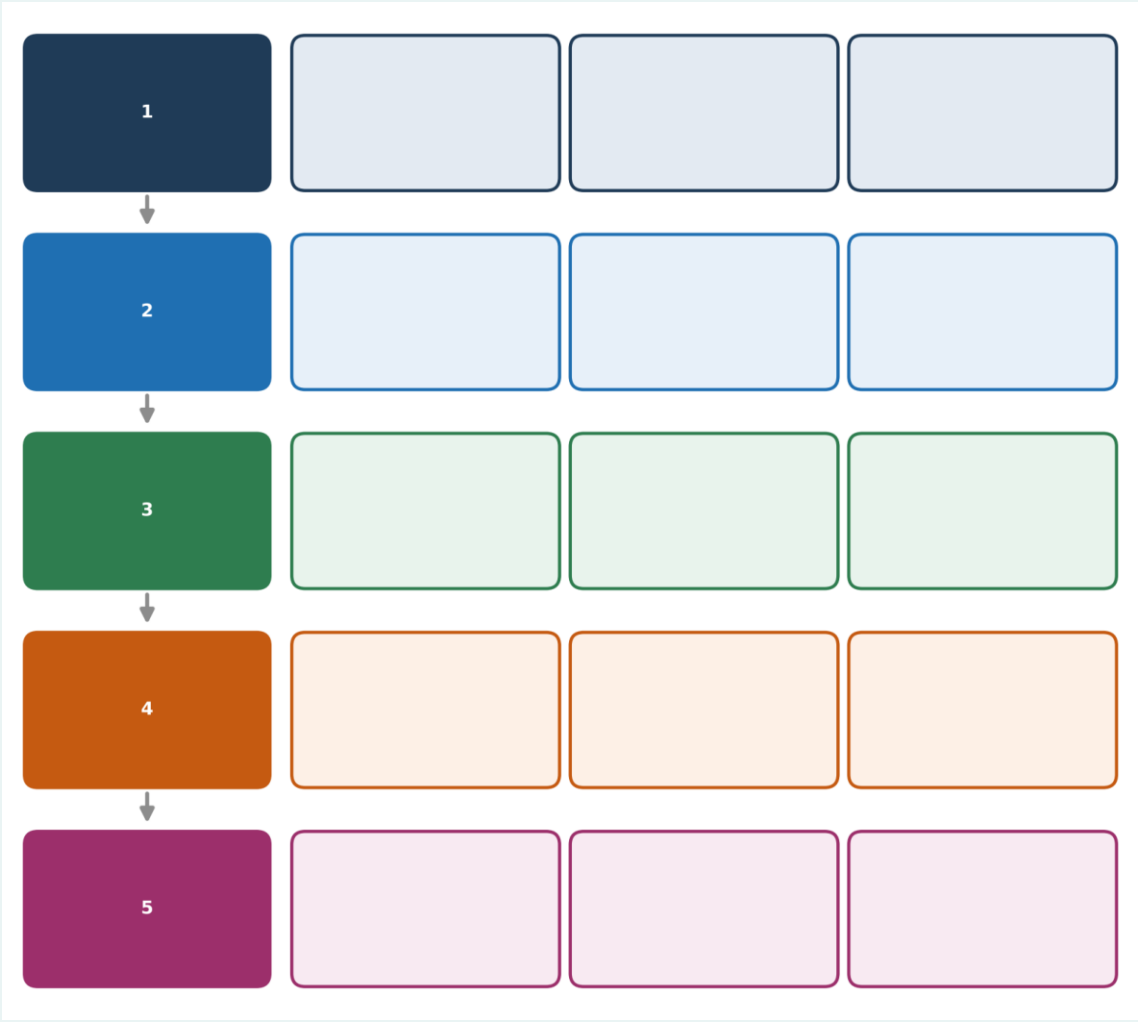


Figure 1.17 – Schéma à légender (architecture des politiques nutritionnelles)

Nommez les 5 niveaux (1 à 5) et placez dans les bonnes cases : OMS ; SNANC 2025-2030 ; PNNS 5 ; PNA 4 ; ARS – PRS ; DRAAF ; CLS ; PAT ; loi EGalim ; Stratégie nationale de santé ; règlement INCO ; centre social ; diététicien.

Corrigé

1. Mondial et européen : OMS ; règlement INCO (Union européenne).

2. National – stratégies : Stratégie nationale de santé (dernière adoptée : 2018-2022) ; SNANC 2025-2030.

3. National – programmes et lois : PNNS 5 ; PNA 4 ; loi EGalim.

4. Régional : ARS – PRS ; DRAAF.

5. Local et terrain : CLS ; PAT ; centre social ; diététicien.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la démarche de projet

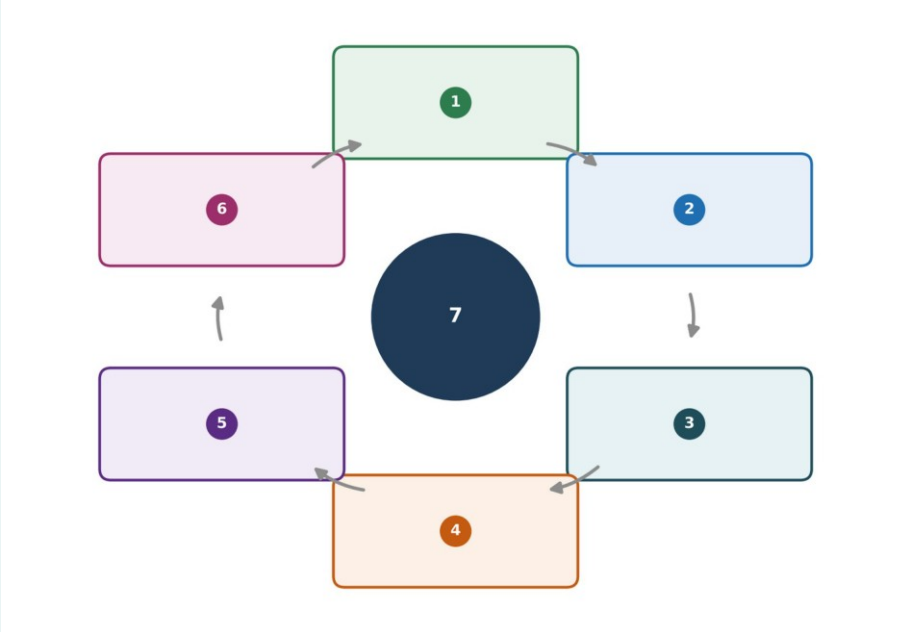


Figure 1.18 – Schéma à légender (démarche de projet)

Nommez les étapes 1 à 6 et le centre 7, puis placez les fiches F1 à F14.

Corrigé

1. Analyse de situation et diagnostic (F1, F2). 2. Priorités et objectifs (F3). 3. Conception et plan d'action (F4, F5, F6). 4. Mise en œuvre et pilotage (F7, F8, F9, F10). 5. Évaluation (F11, F12). 6. Valorisation et ajustements (F13, F14). 7. Démarche de projet en santé publique (cycle).

À vous de jouer – Exercice 5 – Classer des actions (tableau)

Classez les 8 actions suivantes selon le mode d'intervention dominant et le niveau de prévention : a) taxe sur les boissons sucrées ; b) dépistage de la dénutrition à l'admission en EHPAD ; c) classe du goût en CE1 ; d) déclaration d'une TIAC à l'ARS ; e) programme d'ETP « insuffisance rénale » ; f) jardin partagé co-géré par les habitants ; g) enquête Albane ; h) atelier « repas à petit prix » à l'épicerie solidaire.

Corrigé

Action	Mode d'intervention	Prévention
a	Promotion de la santé (politique publique saine, fiscalité)	Primaire, universelle
b	Prévention (dépistage)	Secondaire, sélective (population âgée à risque)
c	Éducation pour la santé (sensorielle)	Primaire, universelle (toute la classe)
d	Veille sanitaire (signal, alerte)	Permet la prévention de nouveaux cas (primaire)
e	ETP (soin, BC1)	Tertiaire
f	Promotion de la santé (action communautaire, milieu favorable)	Primaire, universelle ou sélective selon le quartier
g	Surveillance	– (production de données)
h	Éducation pour la santé (alimentaire)	Primaire, sélective

À vous de jouer – Exercice 6 – Paradoxe de Rose (calcul)

Dans une ville de 50 000 adultes, 4 000 ont un IMC ≥ 35 (risque de diabète sur 5 ans : 60 pour 1 000) et 46 000 ont un IMC < 35 (risque : 8 pour 1 000). a) Calculez le nombre de cas de diabète attendus dans chaque groupe sur 5 ans. b) Quelle part des cas provient du groupe « à faible risque » ? c) Concluez.

Corrigé

a) Groupe à haut risque : 4 000 × 60 / 1 000 = **240 cas**. Groupe à faible risque : 46 000 × 8 / 1 000 = **368 cas**. **b)** Total : 240 + 368 = 608 cas ; part du groupe à faible risque : 368 / 608 = 0,605, soit **60,5 %**. **c)** Même si le risque individuel est 7,5 fois plus élevé dans le groupe IMC ≥ 35 (60 / 8 = 7,5), la majorité des cas vient du groupe le plus nombreux : il faut associer une **stratégie populationnelle** (environnement, éducation pour tous) à la **stratégie à haut risque** (repérage, prise en charge).

À vous de jouer – Exercice 7 – Calculer un taux EGalim et proposer des ajustements

Un restaurant d'entreprise achète 200 000 € HT de denrées par an : bio 30 000 € ; Label Rouge et AOP/IGP 40 000 € ; produits « local mais conventionnel » 25 000 €. Les viandes et poissons représentent 60 000 € dont 30 000 € sous signe de qualité. a) Calculez les taux bio et « durables et de qualité ». b) Le taux pour les viandes et poissons. c) Respect de la loi ? d) Combien faudrait-il réorienter d'achats bio pour atteindre 20 % ?

Corrigé

a) Bio : 30 000 / 200 000 × 100 = **15 %**. Durables et de qualité : (30 000 + 40 000) / 200 000 × 100 = **35 %** (le « local conventionnel » ne compte pas : le local n'est pas un critère EGalim en soi). **b)** Viandes et poissons : 30 000 / 60 000 × 100 = **50 %**. **c)** Non respect : 15 % < 20 % (bio) ; 35 % < 50 % ; 50 % < 60 % (viandes et poissons, obligation depuis le 1er janvier 2024 ; la restauration collective privée est concernée depuis 2024). **d)** Objectif bio : 20 % × 200 000 = 40 000 € ; il faut **10 000 €** d'achats bio supplémentaires (à budget constant, par réorientation d'achats conventionnels).

À vous de jouer – Exercice 8 – Coût d'une recette mise à l'échelle

Une recette de « dahl de lentilles » pour 6 personnes utilise : 300 g de lentilles corail (3,20 €/kg), 400 g de tomates concassées en conserve (2,10 €/kg), 200 mL de lait de coco (4,50 €/L), 150 g d'oignons (1,80 €/kg), 10 g d'épices (25 €/kg), 300 g de riz (1,90 €/kg). Calculez le coût pour 15 personnes et le coût par portion. Vous pouvez vérifier avec la feuille 1 du tableur.

Corrigé

Coefficient = 15 / 6 = **2,5**. Quantités pour 15 : lentilles 750 g ; tomates 1 000 g ; lait de coco 500 mL ; oignons 375 g ; épices 25 g ; riz 750 g. Coûts : lentilles 750 / 1 000 × 3,20 = 2,40 € ; tomates 1 000 / 1 000 × 2,10 = 2,10 € ; lait de coco 0,5 × 4,50 = 2,25 € ; oignons 0,375 × 1,80 = 0,675 € ; épices 0,025 × 25 = 0,625 € ; riz 0,75 × 1,90 = 1,425 €. **Total** = 2,40 + 2,10 + 2,25 + 0,675 + 0,625 + 1,425 = **9,475 € ≈ 9,48 €** pour 15 personnes. **Coût par portion** = 9,475 / 15 = **0,63 €**. Interprétation : un plat complet à base de légumineuses et de céréales coûte moins de 1 € par portion ; le lait de coco est l'ingrédient le plus coûteux (24 % du total : 2,25 / 9,475) et peut être remplacé en partie par du lait ou du yaourt.

À vous de jouer – Exercice 9 – Rédiger des objectifs SMART

Réécrivez ces objectifs pour qu'ils soient SMART : a) « Améliorer l'alimentation des collégiens. » b) « Faire des ateliers sur le petit-déjeuner. » c) « Que les personnes âgées mangent mieux. »

Corrigé

a) Objectif spécifique : « D'ici juin 2028, la proportion d'élèves de 6e du collège Jean-Moulin qui déclarent prendre un petit-déjeuner au moins 5 jours sur 7 passe de 62 % à 75 %. » **b)** Objectif opérationnel : « Animer, entre janvier et mars 2028, 4 ateliers petit-déjeuner d'une heure dans chacune des 5 classes de 6e, avec au moins 90 % des élèves présents. » **c)** Objectif spécifique : « D'ici décembre 2028, 80 % des résidents de la résidence autonomie Les Lilas bénéficient d'une pesée mensuelle et 100 % des résidents ayant perdu 5 % de leur poids en un mois sont orientés vers le médecin traitant. » Chaque objectif comporte un public précis, un indicateur chiffré avec une valeur de départ quand elle est connue, une échéance, et reste réaliste au regard des moyens.

À vous de jouer – Exercice 10 – Tableau de bord

Un projet prévoyait 8 séances, 15 participants par séance, 85 % de satisfaits et un budget de 2 400 €. Réalisé : 7 séances, 94 présences cumulées, 26 satisfaits sur 30 répondants, 2 280 € dépensés. Calculez les taux d'atteinte et concluez.

Corrigé

- Séances : 7 / 8 × 100 = **87,5 %** (partiellement atteint).
- Présences : prévu 8 × 15 = 120 ; 94 / 120 × 100 = **78,3 %** (non atteint, < 80 %). Présence moyenne réelle par séance réalisée : 94 / 7 = 13,4 participants.
- Satisfaction : 26 / 30 = **86,7 %** ; taux d'atteinte 86,7 / 85 × 100 = **102 %** (atteint).
- Budget : 2 280 / 2 400 × 100 = **95 %** (dans le budget ; 120 € non dépensés, cohérent avec la séance annulée).
- **Conclusion** : le projet satisfait les participants mais la participation est insuffisante ; analyser les causes (horaires, communication, séance annulée) et proposer des ajustements (rappels, horaires, implication de relais).

À vous de jouer – Exercice 11 – Interpréter des chiffres

Expliquez pourquoi on ne peut pas conclure que l'obésité a augmenté de 1,1 point entre 2015 (17 %, ESTEBAN) et 2024 (18,1 %, OFÉO).

Corrigé

Les deux études diffèrent par la **méthode** (mesures réalisées par un enquêteur dans ESTEBAN ; poids et taille **déclarés** dans OFÉO, qui ont tendance à sous-estimer l'IMC), par la **population** (18-74 ans pour ESTEBAN ; adultes y compris personnes âgées et outre-mer pour OFÉO) et par l'**échantillonnage**. Une comparaison dans le temps exige la même méthode : c'est l'intérêt des enquêtes répétées comme Albane. On peut seulement dire que l'ordre de grandeur reste d'environ **un adulte sur six**.

1.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi une action d'éducation nutritionnelle « pour tous » peut-elle augmenter les inégalités sociales de santé ? Comment l'éviter ?

Corrigé

Les personnes les plus favorisées ont plus de **ressources** (temps, argent, littératie, réseau) pour s'approprier les messages et changer leurs pratiques : l'écart avec les plus défavorisés peut donc **s'accroître** (effet « Matthieu »). Pour l'éviter : appliquer l'**universalisme proportionné** (renforcer l'action là où les besoins sont plus importants), adapter les supports à la **littératie** (FALC, pictogrammes, langues), agir sur les **déterminants structurels** (prix, offre, cantine à tarification sociale) et impliquer les personnes concernées dans la conception (**participation**).

À vous de jouer – Question 2

Un industriel propose de financer vos ateliers en échange de la distribution de ses céréales du petit-déjeuner. Que faites-vous ?

Corrigé

Il s'agit d'un **conflit d'intérêts** : le diététicien doit délivrer une information **indépendante** et ne pas faire la promotion d'une marque (chapitre 6). On refuse la distribution de produits de marque et la présence du logo sur les supports pédagogiques ; on peut rechercher d'autres financements (ARS, collectivités, fondations sans lien avec les produits concernés) ou, si un partenariat privé est envisagé, l'encadrer par une **convention** garantissant l'indépendance du contenu, conformément aux règles de la structure. On en informe la tutrice et on le mentionne dans le dossier (règles éthiques et déontologiques respectées, C3.1).

À vous de jouer – Question 3

« La santé publique, c'est convaincre les gens de changer leurs comportements. » Discutez cette affirmation.

Corrigé

L'affirmation est **réductrice**. Les comportements sont influencés par de nombreux **déterminants** (Dahlgren et Whitehead) : revenus, offre alimentaire, culture, conditions de travail. La Charte d'Ottawa montre que la santé publique agit aussi sur les **politiques**, les **milieux de vie**, la **communauté** et les **services**, et pas seulement sur les aptitudes individuelles. Une approche uniquement persuasive risque de **culpabiliser** et d'être peu efficace. Toutefois, l'éducation pour la santé reste un levier important lorsqu'elle est **participative** et développe les **compétences** (auto-efficacité). Conclusion : la santé publique combine actions sur l'environnement et développement du pouvoir d'agir.

À vous de jouer – Question 4

En quoi l'approche « Une seule santé » change-t-elle le contenu d'un atelier culinaire ?

Corrigé

L'atelier intègre, en plus de l'équilibre nutritionnel, des critères **environnementaux** (produits de saison, végétalisation, légumineuses, limitation du gaspillage, tri des déchets, énergie) et parfois **animaux** (origine et mode d'élevage des produits animaux). Les messages montrent les **co-bénéfices** (« bon pour moi, bon pour la planète, bon pour le budget ») sans culpabiliser, et l'évaluation peut inclure des indicateurs environnementaux (part de produits de saison, quantité de déchets). C'est l'esprit de la SNANC et des gestes éco-responsables exigés par le référentiel (C3.2).

1.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La commune de Saint-Aubin (12 000 habitants)

La commune rurale de Saint-Aubin vous recrute pour un mois afin de préparer un projet sur l'alimentation des personnes âgées vivant à domicile. Documents : 26 % des habitants ont 65 ans ou plus ; 180 bénéficiaires du portage de repas du CCAS ; 1 supermarché à 8 km, pas de transport en commun ; un club des aînés (60 adhérents) ; une maison de santé pluriprofessionnelle ; 4 hospitalisations pour dénutrition signalées par la MSP l'an dernier. Le CLS de la communauté de communes comporte un axe « bien vieillir ».

1. Identifiez le problème de santé, la population, et justifiez qu'il s'agit d'un problème de santé publique.
2. Quels modes d'intervention et niveaux de prévention pouvez-vous mobiliser ? Donnez un exemple d'action pour chacun.
3. Citez les acteurs et les politiques sur lesquels vous appuyer.
4. Proposez un objectif général, deux objectifs spécifiques SMART et deux indicateurs d'évaluation.
5. Quelles précautions éthiques prenez-vous ?

Corrigé

1. Problème : risque de **dénutrition** des personnes âgées vivant à domicile. **Population** : 65 ans et plus (26 % de 12 000 = **3 120 personnes**), en particulier les 180 bénéficiaires du portage (fragilité). C'est un problème de santé publique car il est **fréquent** (la dénutrition concerne une part importante des personnes âgées, notamment à domicile et en établissement), **grave** (chutes, infections, hospitalisations, mortalité), **coûteux**, **évitable** et socialement inégalitaire (isolement, revenus, ruralité, absence de transport), et une **priorité** du PNNS 5 (prévention de la dénutrition) et du CLS (axe « bien vieillir »).

2. Promotion de la santé : plaider pour un transport à la demande vers le supermarché ou un marché itinérant ; repas partagés au club des aînés (milieu favorable, lien social). **Prévention primaire** : ateliers « bien manger après 70 ans » au club (éducation alimentaire) ; enrichissement des repas portés. **Prévention secondaire** : repérage (pesée mensuelle, questionnaire) par les livreurs de repas formés et la MSP, orientation vers le médecin. **Prévention tertiaire** : prise en charge diététique des personnes dénutries (BC1). **Prévention quaternaire** : éviter les régimes restrictifs inutiles après 75 ans (par exemple, régime sans sel strict non justifié).

3. Acteurs : CCAS (portage), MSP et médecins traitants, club des aînés, conseil départemental (APA), ARS (CLS, appels à projets), caisses de retraite (actions de prévention), associations d'aide à domicile. **Politiques** : PNNS 5, PRS (axe vieillissement), CLS « bien vieillir », recommandations HAS/FFAMCO 2021 sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus.

4. Objectif général : contribuer à prévenir la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile à Saint-Aubin d'ici 2028. **Objectif spécifique 1** : d'ici juin 2028, 100 % des bénéficiaires du portage de repas sont pesés au moins une fois par mois et toute perte de poids ≥ 5 % en un mois est signalée au médecin traitant. **Objectif spécifique 2** : d'ici juin 2028, 70 % des participants aux ateliers déclarent consommer au moins 3 produits laitiers par jour (repère personnes âgées) contre une valeur initiale mesurée au premier atelier. **Indicateurs** : proportion de bénéficiaires pesés mensuellement (processus) ; nombre d'orientations vers le médecin (processus) ; proportion de participants atteignant le repère produits laitiers (résultat).

5. Éthique : consentement des personnes pour la pesée et la transmission d'informations au médecin ; **secret professionnel** et **RGPD** (données de santé = données sensibles) ; respect de l'autonomie (pas d'imposition) ; non-stigmatisation (ne pas parler de « vieux dénutris ») ; attention aux personnes isolées ou atteintes de troubles cognitifs (associer l'aidant).

1.8.5 Mises en situation express

Répondez en 3 à 5 lignes, comme à l'entretien de l'épreuve E5.

Mise en situation – MSE 1

Le jury vous demande : « Votre projet, c'est de la prévention ou de la promotion de la santé ? » (projet d'ateliers cuisine dans un centre social).

Corrigé

C'est d'abord une action d'**éducation pour la santé** (alimentaire et nutritionnelle) au service de la **prévention primaire sélective** (public exposé à un risque du fait de la précarité). Elle s'inscrit dans une **démarche de promotion de la santé** dans la mesure où les familles ont participé au choix des thèmes (pouvoir d'agir), où un partenariat avec l'épicerie solidaire améliore l'accès aux produits (milieu favorable) et où le projet s'inscrit dans le CLS (politique locale).

Mise en situation – MSE 2

Une animatrice vous dit : « Le PNNS 4, c'est bien ce qui est en vigueur ? »

Corrigé

Non : le PNNS 4 couvrait 2019-2023. Depuis le **8 avril 2026**, c'est le **PNNS 5 (2026-2030)**, déclinaison de la **SNANC 2025-2030** publiée le 11 février 2026. Je lui propose une courte note de veille avec les sources (ministère de la Santé, mangerbouger.fr) et je mets à jour nos supports.

Mise en situation – MSE 3

Dans une école, un enseignant veut peser tous les élèves en classe pour « sensibiliser ».

Corrigé

Je déconseille la pesée collective : elle est **stigmatisante**, sans intérêt éducatif et pose un problème de **confidentialité** des données de santé. Le repérage relève du service de santé scolaire, en individuel. Je propose plutôt une action universelle (éducation sensorielle, goûters, activité physique) et un travail avec les parents.

Mise en situation – MSE 4

Une mère dit lors d'un atelier : « De toute façon, chez nous on mange du riz tous les jours, c'est notre culture. »

Corrigé

J'accueille cette remarque sans jugement (posture de **respect culturel**) et je valorise ce qui est favorable (le riz est un féculent, base de repas) ; je propose de **partir de ses recettes** (par exemple, riz associé à des légumes secs et des légumes : plats complets du monde) plutôt que de lui imposer un modèle ; la recette peut être intégrée au livret (atelier « recettes du monde »).

Mise en situation – MSE 5

Vous voulez utiliser des photos de l'atelier pour le livret et le compte du centre social sur un réseau social.

Corrigé

Il faut une **autorisation écrite** de chaque personne photographiée (et des deux titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), précisant les supports, la durée et la finalité (**droit à l'image** et RGPD) ; possibilité de refuser ou de retirer son accord ; photos sans visage (mains, plats) pour ceux qui refusent ; pas de noms de famille.

Mise en situation – MSE 6

L'ARS demande un indicateur de résultat pour votre projet d'ateliers.

Corrigé

Un indicateur de **résultat** mesure un effet sur le public : par exemple, « proportion de participants déclarant consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine, avant et après le cycle » (25 % → 75 % dans le fil rouge). Le nombre d'ateliers ou de participants est un indicateur de **processus**.

Mise en situation – MSE 7

Le directeur d'un EHPAD vous demande une « action de santé publique » sur la dénutrition.

Corrigé

Je précise d'abord le besoin par un **diagnostic** (prévalence de la dénutrition selon les critères HAS/FFAMCO 2021, pesées, organisation des repas, avis des résidents et des soignants). L'action peut associer prévention secondaire (dépistage systématique), primaire (repas enrichis, convivialité, textures adaptées, collations) et formation des soignants (BC2) ; elle s'inscrit dans le PNNS 5 (dénutrition) et les recommandations de la HAS.

Mise en situation – MSE 8

Quelle différence entre surveillance et veille sanitaire ?

Corrigé

La **surveillance** est une collecte **continue et systématique** de données pour décrire et suivre l'état de santé (par exemple, enquêtes INCA, ESTEBAN, Albane). La **veille** vise à **détecter des signaux** inhabituels (TIAC, alerte sur un produit) pour **alerter** rapidement les autorités. En France, Santé publique France assure les deux missions.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Pourquoi parlez-vous d'universalisme proportionné dans votre projet ? »

Corrigé

Parce que le projet propose des actions ouvertes à toutes les familles du quartier (universel) mais renforcées pour les familles de l'épicerie solidaire (gratuité, transport pour la visite du marché, rappels personnalisés, supports traduits) : l'intensité de l'action est **proportionnelle au désavantage**, pour ne pas creuser les inégalités tout en évitant la stigmatisation.

Mise en situation – MSE 10

Un participant à votre atelier vous annonce qu'il est diabétique et vous demande un régime.

Corrigé

L'atelier est une action d'éducation pour la santé collective : je ne prescris pas de régime individuel. Je l'oriente vers son **médecin traitant** et une **consultation diététique** ou un **programme d'ETP** (BC1). Je m'assure que les recettes de l'atelier lui conviennent (pas de contre-indication) et je respecte la confidentialité de son information devant le groupe.

Mise en situation – MSE 11

Où trouvez-vous des données sur l'état de santé de la population de votre lieu de stage ?

Corrigé

Insee (démographie, pauvreté par commune ou par QPV), **Géodes** (Santé publique France), ORS (portraits de territoire, Score-santé), ARS (diagnostic du PRS et du CLS), Drees, CPAM (données de l'Assurance maladie, ALD), service de santé scolaire et PMI (avec leur accord, données agrégées). Je **date** et **source** chaque donnée.

Mise en situation – MSE 12

Votre tutrice vous demande d'envoyer la liste des participants (nom, adresse, allergies) à l'épicerie partenaire par messagerie personnelle.

Corrigé

Les allergies sont des **données de santé** (données sensibles, RGPD). Je ne transmets que les données **strictement nécessaires** et avec l'**accord** des personnes ; j'utilise la messagerie professionnelle de la structure (pas ma messagerie personnelle), un fichier protégé si nécessaire, et je n'envoie pas de données de santé sans finalité justifiée (compétences C3.5 et C3.6 ; chapitres 20 et 21).

Mise en situation – MSE 13

Comment montrez-vous que votre atelier intègre des gestes éco-responsables ?

Corrigé

Choix de produits de **saison** et **locaux** (60,9 % du coût dans l'atelier n° 3), produits en vrac, plat **végétal** principal (légumineuses), compostage des épluchures au jardin partagé, four rempli, restes emportés dans des boîtes réutilisables, pas de vaisselle jetable, consommation d'eau et d'énergie maîtrisée ; j'en fais un indicateur (part de produits de saison, quantité de déchets).

Mise en situation – MSE 14

Une famille allophone ne comprend pas le flyer.

Corrigé

> Je tiens compte de la **littératie** et de la **langue** : flyer illustré avec pictogrammes et photos, traduction dans les langues les plus parlées (avec des habitants relais ou un service d'interprétariat), invitation **orale** par une personne de confiance (animatrice, médiatrice), et animation de l'atelier par le geste et la démonstration (chapitre 5).

1.9 Glossaire

Terme	Définition
Action communautaire	Action dans laquelle les membres d'une communauté (quartier, groupe) participent à l'identification des problèmes, aux décisions et à la mise en œuvre ; domaine 3 de la Charte d'Ottawa
Agence régionale de santé (ARS)	Établissement public créé par la loi HPST (2009) qui pilote la politique de santé en région (PRS, financement de la prévention, appels à projets, CLS)
Appel à projets (AAP)	Procédure par laquelle un financeur (ARS, DRAAF, fondation) définit un cahier des charges et sélectionne des projets à financer
Approche populationnelle	Approche qui vise l'ensemble d'une population pour déplacer la distribution d'un facteur de risque (Rose)
Contrat local de santé (CLS)	Contrat entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le PRS localement
Danger	Propriété intrinsèque d'un agent ou d'une situation capable de provoquer un effet néfaste
Déterminant de santé	Facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence l'état de santé
Éducation pour la santé	Démarche qui vise à ce que chacun acquière les compétences et les moyens de promouvoir sa santé ; nutritionnelle, alimentaire, sensorielle
Éducation thérapeutique du patient (ETP)	Démarche de soin visant à aider les patients atteints de maladie chronique à acquérir des compétences pour gérer leur maladie (art. L. 1161-1 CSP) ; relève du BC1
EGalim	Loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine, durable et accessible à tous
Empowerment (pouvoir d'agir)	Processus par lequel une personne ou un groupe acquiert la capacité de contrôler les décisions qui concernent sa santé
Facteur de protection	Caractéristique associée à une diminution de la probabilité de maladie
Facteur de risque	Caractéristique ou exposition associée à une augmentation de la probabilité de maladie
Gradient social de santé	Dégradation progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale
Incidence	Nombre de nouveaux cas d'une maladie survenus pendant une période dans une population à risque
Indicateur de processus	Indicateur qui mesure la réalisation des activités et des moyens (nombre de séances, de participants, budget)
Indicateur de résultat	Indicateur qui mesure les effets sur le public (connaissances, comportements, état de santé)

Terme	Définition
Inégalités sociales de santé	Différences systématiques, évitables et injustes d'état de santé entre groupes sociaux
Marketing social	Application des techniques du marketing à la promotion de comportements favorables à la santé
Nudge	Modification de l'architecture du choix qui oriente les comportements sans interdiction ni incitation financière
Nutri-Score	Logo nutritionnel facultatif à 5 classes (A à E) ; nouvel algorithme applicable par arrêté du 14 mars 2025
One Health (Une seule santé)	Approche intégrée qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes
Paradoxe de la prévention	Constat de Rose (1985) : une mesure bénéfique à la population apporte peu à chaque individu ; la majorité des cas provient de la population à risque modéré
PNA	Programme national pour l'alimentation (ministère de l'Agriculture) ; PNA 4 : 2026-2030
PNNS	Programme national nutrition santé (ministère de la Santé), depuis 2001 ; PNNS 5 : 2026-2030
Prévalence	Nombre (ou proportion) de cas existants d'une maladie dans une population à un moment donné
Prévention primaire / secondaire / tertiaire	Classification de l'OMS (1948) : avant la maladie (incidence) / au début (prévalence, dépistage) / maladie installée (complications)
Prévention quaternaire	Prévention de la surmédicalisation (Jamoulle, 1986)
Prévention universelle / sélective / indiquée	Classification de Gordon (1983) selon le public : tous / groupe à risque / personnes présentant des facteurs de risque
Projet alimentaire territorial (PAT)	Démarche collective territoriale pour une alimentation locale, durable et accessible (loi du 13 octobre 2014)
Projet régional de santé (PRS)	Document de l'ARS : COS (10 ans), SRS (5 ans), PRAPS
Promotion de la santé	Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci (Ottawa, 1986)
QPV	Quartier prioritaire de la politique de la ville, défini par un critère de revenu des habitants
Risque	Probabilité de survenue d'un effet néfaste, fonction du danger et de l'exposition
Santé (OMS)	État de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (1946)
Santé publique	Ensemble des savoirs et actions organisées et collectives visant à maintenir et améliorer la santé de la population
SMART	Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel : critères de formulation des objectifs
SNANC	Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030 (loi Climat et résilience, art. 265), publiée le 11 février 2026
Surveillance épidémiologique	Collecte systématique et continue, analyse, interprétation et diffusion de données de santé pour orienter l'action
Universalisme proportionné	Actions universelles dont l'intensité est proportionnelle au niveau de désavantage (Marmot, 2010)

Terme	Définition
Veille sanitaire	Détection et évaluation des signaux sanitaires pour alerter les autorités

1.10 Renvois bibliographiques par notion

Les numéros renvoient à la bibliographie numérotée (partie 1.12).

Notion	Références
Définition de la santé, One Health	[1] Constitution de l'OMS ; [3] Charte d'Ottawa ; [5] OHHLEP/Quadripartite ; [6] Huber et coll. ; [21] guide d'accompagnement du BTS
Santé publique, missions	[2] Winslow ; [7] Code de la santé publique art. L. 1411-1 ; [8] loi du 26 janvier 2016 ; [33] Bonita et coll. (OMS)
Paradoxe de la prévention	[9] Rose, 1985
Promotion de la santé	[3] Charte d'Ottawa ; [4] chartes et déclarations ultérieures ; [10] Dahlgren et Whitehead ; [11] Marmot, 2010 ; [32] AFDN, guide santé publique
Prévention	[12] Gordon, 1983 ; [13] Jamoulle ; [14] San Marco
Éducation pour la santé, CPS	[15] Plan national d'éducation pour la santé, 2001 ; [16] Santé publique France, référentiel CPS, 2022
Surveillance, données	[17] Santé publique France, ESTEBAN ; [18] ANSES, INCA 3 ; [19] Albane ; [20] OFÉO ; [26] Insee ; [27] Crédoc
Politiques nutritionnelles	[22] SNANC 2025-2030 ; [23] PNNS 5 ; [24] PNA 4 ; [25] HCSP, avis 2025 ; [28] loi EGalim ; [29] arrêté Nutri-Score 2025 ; [30] repères Santé publique France 2019 ; [31] HCSP, repères 2017
Organisation territoriale	[7] CSP (ARS, PRS, CLS) ; [34] loi HPST ; [35] loi d'avenir pour l'agriculture (PAT)
Diététicien en santé publique	[7] CSP art. L. 4371-1 ; [21] référentiel et guide du BTS ; [32] AFDN
Approfondissements et L3	[38] Sen ; [39] Swinburn et coll. ; [40] Pawson et Tilley ; [41] Monteiro (NOVA) ; [42] consensus sur la stigmatisation du poids ; [43] EAT-Lancet

1.12 Bibliographie numérotée

Liens consultés le 26 octobre 2026. Les textes réglementaires sont consultables sur legifrance.gouv.fr.

Textes fondateurs et définitions

1. Organisation mondiale de la santé. *Constitution de l'Organisation mondiale de la santé*. New York, 22 juillet 1946 (entrée en vigueur le 7 avril 1948). who.int/fr/about/governance/constitution
2. Winslow C.-E. A. « The untilled fields of public health ». *Science*, 1920, 51 (1306), p. 23-33.
3. Organisation mondiale de la santé. *Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé*. Première Conférence internationale pour la promotion de la santé, Ottawa, 21 novembre 1986.
4. Organisation mondiale de la santé. Déclarations d'Alma-Ata (1978), d'Adélaïde (1988 et 2010), de Jakarta (1997), Charte de Bangkok (2005), Déclaration d'Helsinki (2013), de Shanghai (2016), Charte de Genève pour le bien- être (2021).

5. One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP), Adisasmito W. B. et coll. « One Health: A new definition for a sustainable and healthy future ». *PLoS Pathogens*, 2022, 18 (6) ; plan d'action conjoint One Health de la Quadripartite (FAO, PNUE, OMS, OMSA) 2022-2026.

6. Huber M. et coll. « How should we define health? » *BMJ*, 2011, 343:d4163.

7. *Code de la santé publique* : articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1 (politique et stratégie nationale de santé), L. 1434-1 et suivants (PRS), L. 1434-10 (CLS), L. 1161-1 (ETP), L. 4371-1 et suivants (profession de diététicien).

8. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

9. Rose G. « Sick individuals and sick populations ». *International Journal of Epidemiology*, 1985, 14 (1), p. 32-38.

10. Dahlgren G., Whitehead M. *Policies and strategies to promote social equity in health*. Stockholm, Institute for Futures Studies, 1991.

11. Marmot M. et coll. *Fair Society, Healthy Lives (The Marmot Review)*. Londres, 2010.

12. Gordon R. « An operational classification of disease prevention ». *Public Health Reports*, 1983, 98 (2), p. 107-109.

13. Jamoulle M. « Information et informatisation en médecine générale » (concept de prévention quaternaire), 1986 ; Jamoulle M. « Quaternary prevention, an answer of family doctors to overmedicalization ». *International Journal of Health Policy and Management*, 2015.

14. San Marco J.-L. « Définitions » de la prévention, in Bourdillon F., Brücker G., Tabuteau D. (dir.). *Traité de santé publique*. Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 3e éd., 2016.

15. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. *Plan national d'éducation pour la santé*. Paris, 2001.

16. Santé publique France. *Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes*. Saint-Maurice, 2022.

Données et surveillance

17. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (ESTEBAN), 2014-2016 – Volet nutrition – Chapitre corpulence*. 2017.

18. ANSES. *Troisième étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3)*. Avis et rapport, juin 2017.

19. Santé publique France, ANSES. *Albane : enquête de santé, biosurveillance, environnement, alimentation et nutrition* – lancement du cycle 1, communiqué du 10 juin 2025. anses.fr

20. Ligue nationale contre l'obésité. *Étude OFÉO – Prévalence de l'obésité en France*. Dossier de presse, 20 juin 2024. liguecontrelobesite.org

Référentiel, guide et profession

21. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition », *JO* du 17 décembre 2024 ; *Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition*, 29 avril 2025.

Politiques nutritionnelles

22. Gouvernement. *Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030 (SNANC)*. Publiée le 11 février 2026. ecologie.gouv.fr – SNANC 2025-2030

23. Ministère chargé de la Santé. *Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5)*. Lancé le 8 avril 2026. Synthèses : Réseau national nutrition santé, reseau-national-nutrition-sante.fr ; Vidal, « Le cinquième programme national nutrition santé officiellement lancé », avril 2026.

24. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. *Programme national pour l'alimentation 2026-2030 (PNA 4)*. Avril 2026. agriculture.gouv.fr

25. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e Programme national nutrition santé*. Juin 2025. hcsp.fr

26. Insee. *Bilan démographique 2025*. Insee Première n° 2087, janvier 2026 ; Blanpain N. « L'espérance de vie par niveau de vie », Insee Première n° 1687, février 2018.

27. Crédoc. *En forte hausse, la précarité alimentaire s'ajoute à d'autres fragilités*. Consommation et modes de vie, 2023.

28. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim) ; loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; plateforme ma-cantine.agriculture.gouv.fr.

29. Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle (Nutri-Score), modifié par l'arrêté du 14 mars 2025 ; sante.fr – le nouveau Nutri-Score.

30. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. Janvier 2019 ; mangerbouger.fr.

31. Haut Conseil de la santé publique. *Avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les adultes du futur PNNS 2017-2021*. Février 2017 ; *Avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les enfants âgés de 0-36 mois et de 3-17 ans*. Juin 2020 ; ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. Décembre 2016.

Profession, organisation, approfondissements

32. Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). *Le diététicien dans les actions de santé publique*. Version 2, 2022. afdn.org

33. Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. *Éléments d'épidémiologie*. 2e éd., Organisation mondiale de la santé, 2010.

34. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

35. Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (projets alimentaires territoriaux).

36. Lalonde M. *Nouvelle perspective de la santé des Canadiens*. Ottawa, Gouvernement du Canada, 1974.

37. Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS). *Combler le fossé en une génération*. Genève, OMS, 2008.

38. Sen A. *Repenser l'inégalité*. Paris, Seuil, 2000 ; Sen A. *Un nouveau modèle économique*. Paris, Odile Jacob, 2000.

39. Swinburn B. et coll. « The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 791-846.

40. Pawson R., Tilley N. *Realistic Evaluation*. Londres, Sage, 1997 ; Skivington K. et coll. « A new framework for developing and evaluating complex interventions ». *BMJ*, 2021, 374:n2061.

41. Monteiro C. A. et coll. « Ultra-processed foods: what they are and how to identify them ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (5), p. 936-941.

42. Rubino F. et coll. « Joint international consensus statement for ending stigma of obesity ». *Nature Medicine*, 2020, 26, p. 485-497.

43. Willett W. et coll. « Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 447-492.

44. Thaler R., Sunstein C. *Nudge*. New Haven, Yale University Press, 2008.

45. Santé publique France. *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. Ruel J., Allaire C. (dir.), 2018, mise à jour février 2025.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 1.2.2)

46. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

47. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



01

CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique

Promotion de la santé

Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

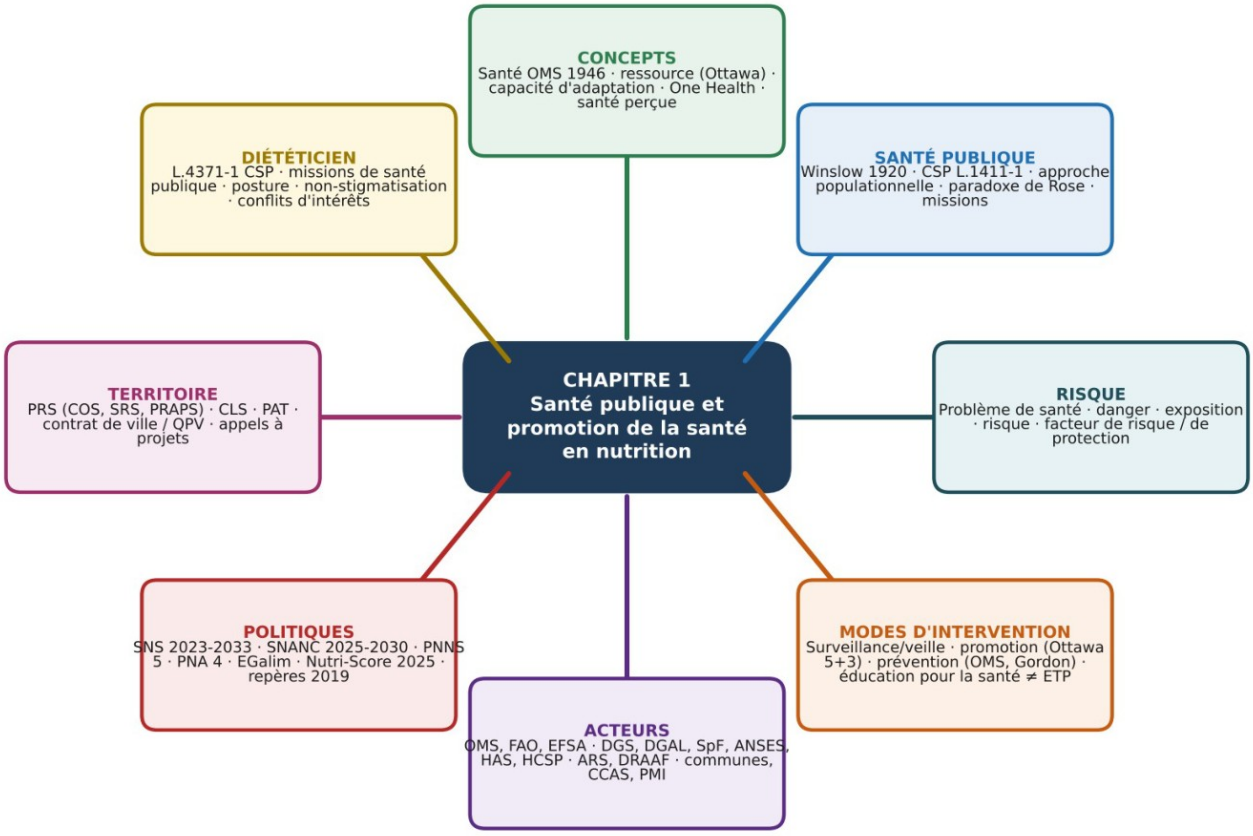
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 1 103
1. Les définitions à savoir par cœur 103
2. Les classifications à ne pas confondre 104
3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3 104
4. Les dates et textes à jour (octobre 2026) 104
5. Chiffres-clés 105
6. Les pièges classiques 105
7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases 105
8. Auto-test (réponses en bas de page) 105
9. Flashcards à découper 106

Fiches-outils du chapitre 1 106
O1.1 – Qualifier mon action 107
O1.2 – Portrait express de mon territoire 107
O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire 108
O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur 108
O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa 109
O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public 109
O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles 110
O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support 110

Fiche de révision du chapitre 1

Santé publique, promotion de la santé et politiques nutritionnelles



Carte mentale du chapitre 1

1. Les définitions à savoir par cœur

Notion	Définition	Source, date
Santé	« État de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »	OMS, Constitution, 1946
Santé (ressource)	« Ressource de la vie quotidienne, et non le but de la vie »	Charte d'Ottawa, 1986
One Health	Approche intégrée visant à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes	OHHLEP / Quadripartite, 2021-2022
Santé publique	Science et art de prévenir les maladies, prolonger la vie et promouvoir la santé par les efforts coordonnés de la communauté	Winslow, 1920
Promotion de la santé	Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci	Charte d'Ottawa, 21/11/1986

Notion	Définition	Source, date
Prévention	Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps	OMS, 1948
Éducation pour la santé	Permettre à chacun d'acquérir les compétences et les moyens de promouvoir sa santé et celle de la collectivité	PNES, 2001
Universalisme proportionné	Actions pour tous, d'intensité proportionnelle au désavantage social	Marmot, 2010
Danger / risque	Danger = capacité à nuire ; risque = probabilité de l'effet néfaste (danger × exposition)	–

2. Les classifications à ne pas confondre

Prévention OMS (moment)	Indicateur visé	Gordon (public)	Exemple
Primaire : avant la maladie	Incidence	Universelle : tous	Repères PNNS, atelier cuisine pour tous
Secondaire : début, dépistage	Prévalence	Sélective : groupe à risque	Ateliers en QPV ; dépistage de la dénutrition
Tertiaire : maladie installée	Complications, récidives	Indiquée : facteurs de risque présents	ETP diabète (BC1) ; programme enfants en surpoids
Quaternaire (Jamoulle)	Surmédicalisation	–	Éviter les régimes inutiles

Patients atteints de maladie Déterminants, milieux, Compétences des personnes Un problème de santé défini chronique, programme déclaré politiques, pouvoir d'agir bien portantes à l'ARS

3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3

- **5 domaines** : politique publique saine – milieux favorables – action communautaire – aptitudes individuelles
- réorientation des services de santé (« **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement »).
- **3 stratégies** : plaider – conférer les moyens – servir de médiateur.

4. Les dates et textes à jour (octobre 2026)

Date	Texte
1946 / 1948	Constitution de l'OMS (signée / entrée en vigueur)
1986	Charte d'Ottawa
2001	PNNS 1
2004	Loi relative à la politique de santé publique (PNNS dans la loi, distributeurs interdits à l'école)
2009	Loi HPST (ARS, ETP)
2014	Loi d'avenir pour l'agriculture (PAT)
2016	Loi de modernisation de notre système de santé (Nutri-Score, 2017)
2018	Loi EGalim (50 % durables et de qualité dont 20 % bio)
2019	Repères alimentaires Santé publique France ; PNNS 4 (2019-2023)
2021	Loi Climat et résilience (art. 265 : SNANC)
14/03/2025	Nouvel algorithme du Nutri-Score (arrêté)

Date	Texte
Juin 2025	Avis du HCSP pour le PNNS 5 ; lancement de l'enquête Albane
11/02/2026	SNANC 2025-2030 publiée
08/04/2026	PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés (One Health Summit, Lyon)

5. Chiffres-clés

- Obésité de l'adulte : **18,1 %** (OFÉO 2024) ; 22,4 % outre-mer ; 24,7 % en cas de difficultés économiques.
- Surpoids des 6-17 ans : **17 %** dont 4 % d'obésité (ESTEBAN 2015).
- Précarité alimentaire : **16 %** (Crédoc 2022).
- 5 fruits et légumes/jour : **30 %** des adultes, 20 % des enfants ; fibres < 25 g/j : 90 % des adultes (HCSP 2025).
- Espérance de vie 2025 : **85,9 ans** (F), **80,3 ans** (H) ; écart de ≈ 13 ans entre hommes aisés et modestes.
- PNNS 5 : **3 axes, 20 mesures**, − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents (− 20 % chez les plus défavorisés).
- EGalim (achats 2023) : ≈ 25,5 % durables et de qualité, 12,1 % bio.

6. Les pièges classiques

Attention

- Citer le **PNNS 4** comme en vigueur → c'est le **PNNS 5 (2026-2030)**.
- Dire que le **Nutri-Score est obligatoire** → il est **facultatif**.
- Classer le **dépistage** en prévention primaire → **secondaire**.
- Appeler « éducation pour la santé » un atelier destiné à des **patients** d'un programme d'ETP → c'est de l'**ETP** (BC1).
- Confondre **incidence** (nouveaux cas) et **prévalence** (cas existants).
- Comparer des chiffres issus de **méthodes différentes** (mesuré / déclaré).
- Oublier les **déterminants** et proposer uniquement de l'information.

7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases

1. Mode d'intervention : « Mon projet est une action d'éducation pour la santé (alimentaire/nutritionnelle/sensorielle)… »

2. Prévention : « … au service de la prévention primaire, sélective, car le public… »

3. Promotion de la santé : « Il s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé car… (participation, milieu favorable, partenariat). »

4. Politiques : « Il répond à l'axe … du PNNS 5 (2026-2030), à l'objectif … du PRS et à la fiche-action … du CLS. »

8. Auto-test (réponses en bas de page)

1. Qui a défini la santé publique en 1920 ?
2. Quels sont les 5 domaines d'action de la Charte d'Ottawa ?
3. Quel niveau de prévention fait baisser l'incidence ?
4. Quelle classification distingue universelle, sélective et indiquée ?
5. Quelle loi prévoit la SNANC ? Quand a-t-elle été publiée ?
6. Combien d'axes et d'actions compte le PNNS 5 ?
7. Quels sont les deux seuils EGalim en restauration collective ?
8. Quel organisme conduit les études INCA ? Et ESTEBAN ?

9. Que contient un PRS ?

10. Calculez le coût par portion d'une recette de 9,60 € pour 12 portions.

11. Une diététicienne anime un atelier pour des patients d'un programme ETP diabète : de quoi s'agit-il ?

12. Donnez la formule du taux d'atteinte d'un indicateur. *Réponses : 1. Winslow – 2. Politique publique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services – 3. Primaire – 4. Gordon (1983) – 5. Loi Climat et résilience (art. 265) ; 11 février 2026 – 6. 3 axes, 20 mesures – 7. 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio (et 60 % pour*

viandes et poissons) – 8. ANSES ; Santé publique France – 9. COS (10 ans), SRS (5 ans), PRAPS – 10. 9,60 / 12 = 0,80 €

- *– 11. ETP, prévention tertiaire (BC1) – 12. Réalisé / prévu × 100.*

9. Flashcards à découper

Recto : Charte d'Ottawa – date et 3 stratégies ?	Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur
Recto : Prévalence ou incidence : laquelle baisse avec la prévention primaire ?	Verso : L'incidence (nouveaux cas)
Recto : Universalisme proportionné : auteur, date, principe ?	Verso : Marmot, 2010 ; pour tous, avec une intensité proportionnelle au désavantage
Recto : PNNS en vigueur et son objectif enfant ?	Verso : PNNS 5 (2026-2030) ; − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents
Recto : Que signifie SMART ?	Verso : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel
Recto : Rôle de l'ARS en prévention ?	Verso : PRS, financement (FIR), appels à projets, CLS, déclaration des programmes d'ETP
Recto : Paradoxe de Rose ?	Verso : Beaucoup de personnes à faible risque produisent plus de cas que peu de personnes à haut risque
Recto : Les 3 formes d'éducation pour la santé du guide BTS ?	Verso : Nutritionnelle, alimentaire, sensorielle

Fiches-outils du chapitre 1

Ces 8 outils complètent les fiches F1 à F14 pour les notions propres au chapitre 1. Ils sont vierges, à imprimer ou à remplir dans Word, et servent en stage (période 1 surtout), en préparation du dossier E5 et en révision.

Outil	Intitulé	Utilité
O1.1	Qualifier mon action	Nommer précisément le mode d'intervention et le niveau de prévention (oral E5)
O1.2	Portrait express de mon territoire	Collecter les données de base du diagnostic (F1)
O1.3	Carte des acteurs de mon territoire	Identifier partenaires, financeurs, ressources
O1.4	Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur	Rédiger la partie « contexte » du dossier
O1.5	Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa	Vérifier que le projet ne se limite pas à l'information
O1.6	Les déterminants de l'alimentation de mon public	Appliquer le modèle de Dahlgren et Whitehead
O1.7	Tableau de veille des politiques nutritionnelles	Tenir à jour les versions des textes (C3.4)
O1.8	Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message	Contrôler un support avant diffusion

O1.1 – Qualifier mon action

Intitulé de l'action

Public (qui, combien, caractéristiques)

Problème de santé visé

Question	☐	Justification
Mode : surveillance / veille sanitaire	☐	
Mode : promotion de la santé (agit sur déterminants, milieux, politiques, pouvoir d'agir)	☐	
Mode : prévention (problème défini)	☐	
Mode : éducation pour la santé – nutritionnelle	☐	
Mode : éducation pour la santé – alimentaire	☐	
Mode : éducation pour la santé – sensorielle	☐	
Attention : s'agit-il d'ETP (patients, programme déclaré à l'ARS) ? → BC1	☐	
OMS : primaire (incidence)	☐	
OMS : secondaire (dépistage, prévalence)	☐	
OMS : tertiaire (complications)	☐	
OMS : quaternaire (surmédicalisation)	☐	
Gordon : universelle	☐	
Gordon : sélective	☐	
Gordon : indiquée	☐	
Approche : informative / persuasive / participative	☐	
Universalisme proportionné appliqué ?	☐	

Ma phrase de qualification pour l'oral (4 phrases : mode, prévention, promotion, politiques)

O1.2 – Portrait express de mon territoire

> **Consigne**
> Pour chaque indicateur, notez la valeur pour votre territoire et une valeur de comparaison (département, région ou France), avec la source et l'année. Sources utiles : Insee (statistiques locales), Géodes (Santé publique France), ORS (Score-santé), ARS (diagnostic du PRS, CLS), *sig.ville.gouv.fr* (QPV), Drees.

Indicateur	Mon territoire	Comparaison	Source	Année
Population totale				
Part des moins de 20 ans / des 65 ans et plus				
Familles monoparentales (%)				
Taux de pauvreté (%)				
Taux de chômage (%)				
Quartier prioritaire (oui/non, nom)				
Espérance de vie / mortalité prématurée				
Surpoids, obésité (enfants, adultes)				

Indicateur	Mon territoire	Comparaison	Source	Année
Diabète traité, maladies cardiovasculaires (ALD)				
Offre alimentaire (commerces, marché, restauration rapide)				
Restauration scolaire (tarification, EGalim)				
Aide alimentaire (épicerie, banque alimentaire)				
Équipements sportifs, espaces verts				
Professionnels de santé (MSP, diététiciens, PMI)				

Trois constats principaux

O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire

Niveau	Acteur (nom exact)	Rôle / missions	Intérêt pour mon projet (données, partenaire, financeur, relais)	Contact (fonction, mail professionnel)
National				
Régional (ARS, DRAAF, Promotion Santé, ORS)				
Départemental (PMI, action sociale)				
Commune / intercommunalité (CCAS, CLS, PAT, politique de la ville)				
Éducation (écoles, collèges, santé scolaire)				
Santé de proximité (MSP, CPTS, médecins)				
Social (centres sociaux, CAF)				
Associations (aide alimentaire, sport, culture, patients)				
Économiques (commerces, marché, producteurs, entreprises)				
Habitants / usagers (groupes, conseils citoyens)				

O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur

> **Consigne**
>
> Vérifiez la **version en vigueur** de chaque texte le jour de la rédaction (fiche O1.7). Citez l'axe, l'action ou l'objectif précis, avec la date.

Texte / dispositif	Axe, action ou objectif auquel mon projet répond	Référence (date, lien)
Stratégie nationale de santé		
SNANC 2025-2030		
PNNS 5 (2026-2030)		

Texte / dispositif	Axe, action ou objectif auquel mon projet répond	Référence (date, lien)
PNA 4 (2026-2030)		
Lois (EGalim, Climat et résilience…)		
PRS de ma région (SRS, PRAPS)		
Contrat local de santé		
Projet alimentaire territorial		
Contrat de ville / QPV		
Projet de la structure d'accueil		

Rédaction du paragraphe « contexte » (5 à 8 lignes)

O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa

1. Élaborer une politique publique saine

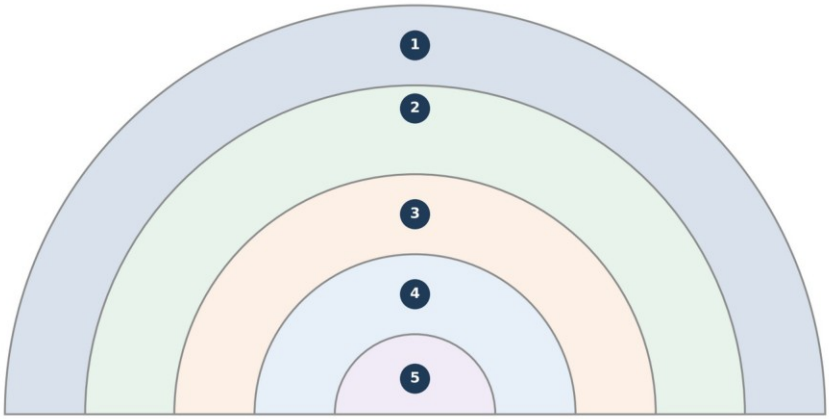
2. Créer des milieux favorables

3. Renforcer l'action communautaire

4. Acquérir des aptitudes individuelles

5. Réorienter les services de santé

O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public



Modèle de Dahlgren et Whitehead (1991) – à légender

Couche du modèle	Déterminants observés chez mon public	Levier d'action possible
1. Âge, sexe, hérédité		
2. Style de vie personnel		
3. Réseaux sociaux et communautaires		
4. Conditions de vie et de travail		

Couche du modèle	Déterminants observés chez mon public	Levier d'action possible
5. Conditions socio-économiques, culturelles, environnementales		

O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles

Texte	Version vérifiée	Date de vérification	Statut (en vigueur, en révision, abrogé)	Source (lien) et changement repéré
SNANC	2025-2030 (11/02/2026)	05/10/2026	En vigueur	ecologie.gouv.fr
PNNS	PNNS 5 2026-2030 (08/04/2026)	05/10/2026	En vigueur	sante.gouv.fr ; mangerbouger.fr
PNA	PNA 4 2026-2030	05/10/2026	En vigueur	agriculture.gouv.fr
Repères alimentaires adultes	Santé publique France, 2019	05/10/2026	En vigueur, révision annoncée	mangerbouger.fr
Nutri-Score	Arrêté du 14/03/2025	05/10/2026	En vigueur (transition 2 ans)	sante.fr
EGalim, bilan « ma cantine »				
PRS de ma région				

O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support

Critère	Oui / Non	Correction à apporter
Le message est positif et valorise ce que les personnes peuvent faire		
Il évite les mots culpabilisants (« mauvais aliments », « il faut », « interdit »)		
Il n'associe pas poids et valeur de la personne ; pas d'images dégradantes		
Il tient compte des contraintes (budget, temps, équipement)		
Il respecte les cultures et les pratiques religieuses		
Il est lisible (littératie : phrases courtes, pictogrammes, police ≥ 12 pt)		
Il est traduit ou accompagné oralement si nécessaire		
Les informations sont validées, datées et sourcées (repères officiels)		
Aucune marque n'est promue ; pas de conflit d'intérêts		
Les images de personnes ont une autorisation écrite (droit à l'image)		
Aucune donnée personnelle ou de santé n'apparaît		
Le support a été testé auprès de quelques personnes du public		

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



01

CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique

Promotion de la santé

Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 1 114
Mode d'emploi du cahier 114
Partie 1 – Les concepts de santé 115
Exercice 1.1 – Légender l'évolution des concepts de santé (10 points) 116
Exercice 1.2 – Reconnaître un modèle de santé dans un discours (10 points) 117
Exercice 1.3 – Discuter la définition de l'OMS (10 points) 118
Exercice 1.4 – Interpréter un indicateur de santé perçue (12 points) 119
Exercice 1.5 – « Une seule santé » appliquée à la restauration scolaire (12 points) 120
Exercice 1.6 – Rédiger l'introduction d'un dossier E5 (16 points) 122
Corrigés de la partie 1 124
Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 126
Exercice 2.1 – Légender les missions de la santé publique (9 points) 127
Exercice 2.2 – Approche clinique ou approche de santé publique ? (10 points) 129
Exercice 2.3 – Calculer le paradoxe de la prévention (14 points) 130
Exercice 2.4 – Distinguer incidence et prévalence (10 points) 132
Exercice 2.5 – Les missions de la santé publique face à une toxi-infection alimentaire collective (12 points) 133
Exercice 2.6 – Convaincre des élus d'une action populationnelle (16 points) 134
Corrigés de la partie 2 136
Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection 138
Exercice 3.1 – Légender la chaîne du risque (12 points) 139
Exercice 3.2 – Classer les notions (10 points) 140
Exercice 3.3 – Calculer et interpréter un risque (12 points) 141
Exercice 3.4 – La listériose chez la femme enceinte (12 points) 142
Exercice 3.5 – Facteurs de risque et facteurs de protection dans un quartier (12 points) 143
Exercice 3.6 – Hiérarchiser des problèmes de santé (16 points) 144
Corrigés de la partie 3 146
Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique 148
Exercice 4.1 – Légender les niveaux de prévention (12 points) 149
Exercice 4.2 – Les 5 domaines et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa (14 points) 151
Exercice 4.3 – Qualifier une action (12 points) 153
Exercice 4.4 – Appliquer l'universalisme proportionné à la cantine (14 points) 154
Exercice 4.5 – Choisir une approche éducative (12 points) 155
Exercice 4.6 – Construire une réponse combinant les quatre modes (16 points) 156
Corrigés de la partie 4 157
Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 159
Exercice 5.1 – Légender la carte des acteurs (10 points) 160
Exercice 5.2 – Qui fait quoi ? (10 points) 162
Exercice 5.3 – Trouver la bonne source de données (12 points) 163
Exercice 5.4 – Construire un plan de financement (12 points) 164
Exercice 5.5 – Repérer un conflit d'intérêts (12 points) 165
Exercice 5.6 – Construire la carte des partenaires d'un projet (16 points) 166
Corrigés de la partie 5 168
Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale 170
Exercice 6.1 – Légender l'architecture de la politique régionale de santé (10 points) 171
Exercice 6.2 – Reconnaître les outils d'une politique publique (10 points) 173
Exercice 6.3 – Les étapes d'une politique publique : l'exemple du PNNS 5 (12 points) 174
Exercice 6.4 – Analyser une fiche-action de contrat local de santé (12 points) 175
Exercice 6.5 – Relier une action locale aux politiques (12 points) 176

Exercice 6.6 – Répondre à un appel à projets de l'ARS (16 points) 177
Corrigés de la partie 6 179
Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique 181
Exercice 7.1 – Légender la frise des politiques nutritionnelles (8 points) 182
Exercice 7.2 – Présenter le PNNS 5 et la SNANC (12 points) 183
Exercice 7.3 – Calculer les taux EGalim d'une cantine (12 points) 184
Exercice 7.4 – Utiliser les repères alimentaires (12 points) 185
Exercice 7.5 – Le Nutri-Score (12 points) 186
Exercice 7.6 – Argumenter une diversification des protéines (16 points) 187
Corrigés de la partie 7 189
Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet 191
Exercice 8.1 – Légender la démarche de projet (10 points) 192
Exercice 8.2 – Le cadre réglementaire de la profession (10 points) 194
Exercice 8.3 – Posture et déontologie en situation (12 points) 195
Exercice 8.4 – Rédiger des objectifs mesurables (12 points) 196
Exercice 8.5 – Classer les besoins selon Bradshaw (10 points) 197
Exercice 8.6 – Cas de synthèse : la santé alimentaire des étudiants d'un campus (30 points) 198
Corrigés de la partie 8 200
Bilan : grille d'auto-évaluation 203

Cahier d'exercices – Chapitre 1

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 1 : concepts de santé, santé publique, danger et risque, modes d'intervention, acteurs, politiques de santé et politiques nutritionnelles, place du diététicien (référentiel du 27 novembre 2024, savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas (concepts de santé, « Une seule santé », missions, niveaux de prévention, Charte d'Ottawa, acteurs, projet régional de santé, frise des politiques nutritionnelles, démarche de projet).
- Calculer et interpréter des indicateurs simples (pourcentages, écarts, rapports, nombres de cas évités) et les relier à une décision d'action.
- Qualifier une action de santé publique et l'inscrire dans les politiques en vigueur en octobre 2026.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de textes), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes et chiffres locaux des mises en situation sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les données nationales, les textes et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026.

Partie 1 – Les concepts de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la santé selon l'OMS (1946), en citer les apports et les limites.
- Distinguer modèle biomédical, modèle biopsychosocial, santé comme ressource (Charte d'Ottawa) et approche « Une seule santé ».
- Distinguer santé objective, santé perçue et santé positive ; interpréter un indicateur de santé perçue.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Constitution signée le 22 juillet 1946, en vigueur le 7 avril 1948.
- Modèle biopsychosocial : George Engel, 1977. Charte d'Ottawa (1986) : la santé est « une ressource de la vie quotidienne, et non le but de la vie ».
- Santé comme capacité d'adaptation : Machteld Huber et coll., BMJ, 2011.
- « Une seule santé » (One Health) : principes de Manhattan (2004) ; définition du panel OHHLEP (2021) adoptée par la Quadripartite (OMS, FAO, OMSA, PNUE) ; plan d'action conjoint 2022-2026.
- Santé perçue : déclarée par la personne ; elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux.

Exercice 1.1 – Légender l'évolution des concepts de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez l'introduction de votre dossier E5 et vous voulez montrer au jury que votre projet s'appuie sur une conception actuelle de la santé.

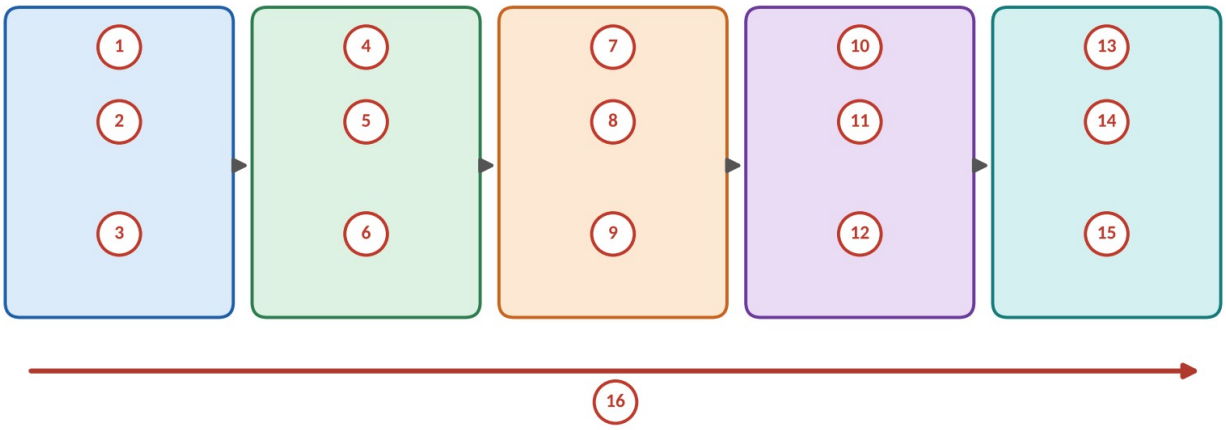


Figure 1.1 – Document 1 – L'évolution des concepts de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 16 du document 1 (nom du modèle, date ou auteur, idée principale). (6 pts)
2. Expliquez le sens de la flèche rouge placée sous le schéma. (2 pts)
3. Indiquez quel modèle justifie qu'un diététicien agisse sur les menus d'une cantine plutôt que seulement en consultation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.2 – Reconnaître un modèle de santé dans un discours (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de préparation d'un forum santé dans une commune, vous notez les phrases prononcées par les participants.

Document 1 – Phrases entendues pendant la réunion

a) Le médecin : « Les habitants dont la glycémie est normale sont en bonne santé, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. »

b) L'adjointe aux affaires sociales : « Sans logement correct et sans revenu, on ne peut pas parler de santé. »

c) Une habitante qui a un diabète de type 1 depuis 20 ans : « Je cours des semi-marathons, je travaille, je me sens bien : je suis en bonne santé. »

d) Le responsable de la restauration scolaire : « En servant moins de viande et plus de légumineuses, on agit pour les enfants, pour les élevages et pour le climat. »

e) La psychologue du centre médico-psychologique : « Le stress au travail et l'isolement expliquent une partie des grignotages que nous voyons. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque phrase à un modèle ou à un concept de santé ; justifiez en une phrase. (5 × 1,5 pt)

2. Montrez, à partir de la phrase c, une limite de la définition de l'OMS. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.3 – Discuter la définition de l'OMS (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Madame L., 34 ans, a une maladie cœliaque diagnostiquée il y a 8 ans. Elle suit un régime strict sans gluten, ses anticorps sont négatifs, elle travaille à temps plein et anime une association de patients. Elle vous dit : « Selon la définition officielle, je ne serai jamais en bonne santé, puisque je suis malade à vie. »

Document 1 – Deux définitions

Définition de l'OMS (1946) : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

Proposition de M. Huber et coll. (BMJ, 2011) : la santé comme « capacité à s'adapter et à se prendre en charge face aux défis sociaux, physiques et émotionnels ».

À vous de jouer – Questions

1. Citez les trois apports de la définition de l'OMS qui l'ont rendue novatrice en 1946. (3 pts)
2. Présentez trois critiques de cette définition. (3 pts)
3. Montrez que la proposition de Huber permet de considérer que Madame L. est en bonne santé. (2 pts)
4. Indiquez ce que cette réflexion change dans la façon d'animer un atelier pour des personnes atteintes d'une maladie chronique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.4 – Interpréter un indicateur de santé perçue (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire de la santé d'une agglomération (données fictives) a interrogé 2 800 adultes, répartis en quatre groupes égaux de revenus (quartiles). Vous devez présenter ces résultats au comité de pilotage d'un projet « Alimentation et santé » de l'agglomération.

Document 1 – Adultes se déclarant en bonne ou très bonne santé, selon le revenu (enquête fictive, 2025)

Quartile de revenu	Effectif interrogé	Adultes se déclarant en bonne ou très bonne santé
Quartile 1 (25 % les plus modestes)	700	412
Quartile 2	700	498
Quartile 3	700	553
Quartile 4 (25 % les plus aisés)	700	602

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la santé perçue et indiquez pourquoi c'est un indicateur utile en santé publique. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque quartile, la part des adultes en bonne ou très bonne santé. (4 pts)
3. Calculez l'écart absolu (en points) et le rapport entre le quartile 4 et le quartile 1 ; interprétez. (3 pts)
4. Nommez le phénomène mis en évidence et indiquez une conséquence pour la conception du projet. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.5 – « Une seule santé » appliquée à la restauration scolaire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage auprès du service de restauration d'une commune de 18 000 habitants (structure fictive). Les élus veulent présenter au conseil municipal le passage à deux repas végétariens par semaine dans les écoles et l'achat de volailles élevées sans antibiotiques. Ils vous demandent un schéma et un argumentaire « Une seule santé ».

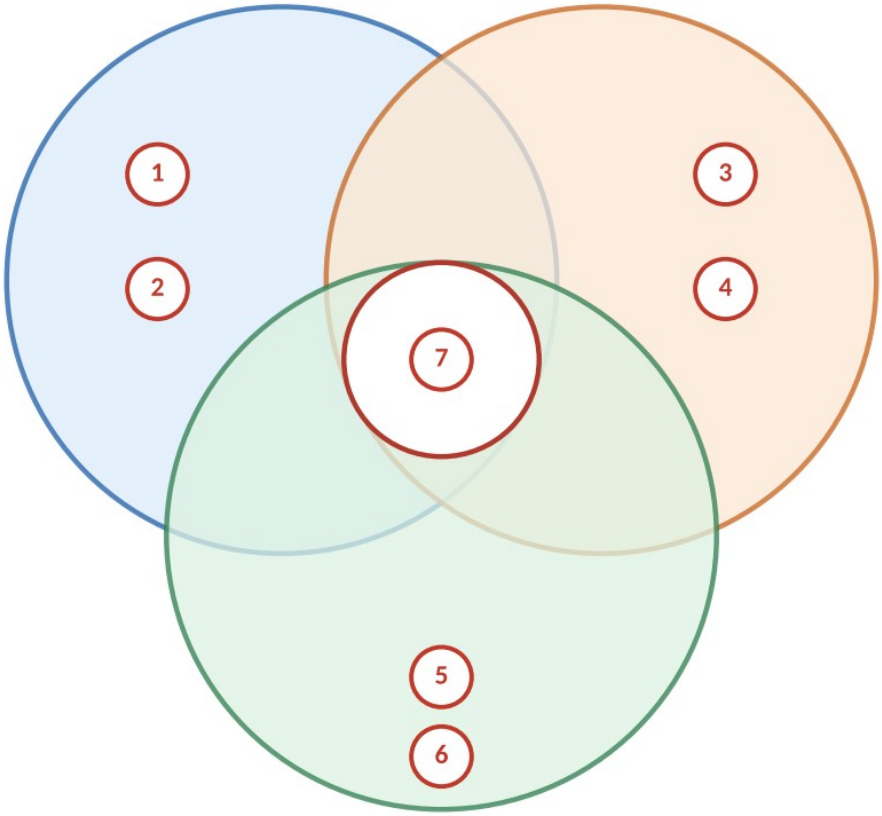


Figure 1.2 – Document 1 – « Une seule santé » (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (3,5 pts)
2. Donnez la définition de l'approche « Une seule santé » et citez les quatre organisations de la Quadripartite. (2,5 pts)
3. Montrez, pour chacune des deux mesures, ses effets attendus sur les trois santés. (4 pts)
4. Indiquez deux points de vigilance nutritionnelle qui relèvent du diététicien pour les repas végétariens des enfants. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 1.6 – Rédiger l'introduction d'un dossier E5 (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans un centre social qui accueille des familles d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (structure fictive). Votre projet porte sur un « café des parents » consacré à l'alimentation des enfants de 3 à 6 ans. Votre tutrice vous demande de rédiger l'introduction du dossier, d'une demi-page, en montrant au lecteur que l'action ne se limite pas à « donner des conseils ».

Document 1 – Notes prises pendant l'observation

- 28 familles inscrites au centre social ont un enfant de 3 à 6 ans ; 11 familles vivent dans un logement sans four.
- Les parents disent manquer de temps et d'argent ; certains se sentent jugés par l'école sur le contenu du goûter.
- Le marché du quartier a lieu le samedi ; la supérette la plus proche vend peu de fruits et légumes frais.
- Les parents demandent des idées de goûters « que les enfants aiment et qui ne coûtent pas cher ».

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez, dans le document 1, les éléments qui relèvent de chacune des trois dimensions du modèle biopsychosocial. (4,5 pts)
2. Montrez que la situation illustre la santé comme « ressource de la vie quotidienne » au sens de la Charte d'Ottawa. (3 pts)
3. Rédigez l'introduction du dossier (une demi-page) : définition de la santé retenue, justification de l'approche, annonce du projet. (6 pts)
4. Relevez une phrase du document 1 qui doit vous alerter sur le risque de stigmatisation et indiquez comment vous en tenez compte. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 1.1

1. Légendes : 1 Modèle biomédical ; 2 XIXe siècle – milieu du XXe ; 3 Santé = absence de maladie, action curative et individuelle ; 4 Définition de l'OMS ; 5 1946 (en vigueur en 1948) ; 6 Bien-être physique, mental et social, droit fondamental ; 7 Modèle biopsychosocial ; 8 Engel, 1977 ; 9 Interaction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux ; 10 Charte d'Ottawa ; 11 1986 ; 12 Santé = ressource de la vie quotidienne, promotion de la santé ; 13 Une seule santé ; 14 Principes de Manhattan, 2004 ; 15 Santé humaine, animale et des écosystèmes liées ; 16 De l'individu malade à la population, puis à la planète.
2. La flèche montre l'élargissement du regard : on passe d'une santé définie chez l'individu malade (soigner) à une santé de la population, dépendant de ses conditions de vie (prévenir, promouvoir), puis à une santé liée à celle des animaux et des écosystèmes (alimentation durable).
3. Le modèle biopsychosocial et la Charte d'Ottawa : la santé dépend des conditions de vie et des milieux (ici le milieu scolaire). Agir sur les menus, c'est « créer des milieux favorables », un des cinq domaines d'action de la Charte.

Corrigé – Exercice 1.2

1. a) Modèle biomédical : la santé est réduite à un résultat biologique normal ; on ignore le vécu et les déterminants. b) Charte d'Ottawa : le logement et le revenu font partie des conditions préalables à la santé (paix, abri, éducation, nourriture, revenu, écosystème stable, ressources durables, justice sociale et équité). c) Santé comme capacité d'adaptation (Huber, 2011) et santé perçue : malgré une maladie chronique, la personne fonctionne et se sent bien. d) « Une seule santé » : la mesure agit sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement. e) Modèle biopsychosocial : des facteurs psychologiques (stress) et sociaux (isolement) expliquent un comportement alimentaire.
2. Selon l'OMS, la santé est un état de « complet » bien-être : une personne qui a une maladie chronique ne pourrait jamais être en bonne santé. Or l'habitante de la phrase c mène une vie pleinement satisfaisante. La définition décrit un idéal figé et ne tient pas compte de la capacité d'adaptation.

Corrigé – Exercice 1.3

1. Apports : définition positive (le bien-être et pas seulement l'absence de maladie) ; multidimensionnelle (physique, mentale, sociale) ; la santé est un droit fondamental de tout être humain.
2. Critiques : le « complet » bien-être est un idéal presque inatteignable ; c'est un état figé alors que la santé est un équilibre dynamique ; la définition ne dit rien de la capacité d'adaptation et exclut les personnes qui vivent bien avec une maladie chronique ; elle est difficile à mesurer.
3. Madame L. s'adapte à sa maladie : elle suit son régime, ses anticorps sont négatifs, elle travaille et s'engage dans une association. Selon Huber, elle a la capacité de faire face aux défis physiques, sociaux et émotionnels : elle est en bonne santé, même si elle a une maladie chronique.
4. L'atelier part des ressources et des compétences des participants, et pas seulement de leurs « problèmes » ; il valorise ce qu'ils savent déjà faire, cherche à renforcer leur autonomie (pouvoir d'agir) et évite un discours centré sur la maladie et les interdits.

Corrigé – Exercice 1.4

1. La santé perçue est l'état de santé déclaré par la personne elle-même (« Comment jugez-vous votre état de santé ? »). Elle est simple à recueillir, comparable entre groupes et dans le temps, et elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux. Elle est utilisée dans le Baromètre de Santé publique France et l'enquête européenne EHIS.
2. Calculs (nombre de réponses / 700 × 100) : quartile 1 : 412 / 700 × 100 = 58,9 % ; quartile 2 : 498 / 700 × 100 = 71,1 % ; quartile 3 : 553 / 700 × 100 = 79,0 % ; quartile 4 : 602 / 700 × 100 = 86,0 %.

3. Écart absolu = 86,0 − 58,9 = 27,1 points. Rapport = 86,0 / 58,9 = 1,46. Les adultes les plus aisés sont 1,46 fois plus nombreux, en proportion, à se déclarer en bonne santé que les plus modestes.

4. La part des adultes en bonne santé augmente à chaque quartile de revenu : c'est un gradient social de santé, expression des inégalités sociales de santé. Conséquence : le projet doit être ouvert à tous mais renforcé pour les plus modestes (universalisme proportionné), en agissant aussi sur l'accès (prix, proximité) et pas seulement sur l'information.

Corrigé – Exercice 1.5

1. Légendes : 1 Santé humaine ; 2 maladies chroniques, carences, antibiorésistance ; 3 Santé animale ; 4 élevage, bien-être animal, zoonoses ; 5 Santé des écosystèmes ; 6 climat, sols, eau, biodiversité ; 7 Alimentation durable.

2. Définition (OHHLEP, 2021) : « une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes ». Quadripartite : OMS, FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), OMSA (Organisation mondiale de la santé animale), PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement).

3. Repas végétariens : santé humaine (plus de fibres, moins d'acides gras saturés si le menu est équilibré) ; écosystèmes (moins d'émissions de gaz à effet de serre, les légumineuses fixent l'azote de l'air) ; santé animale (moindre pression sur l'élevage intensif). Volailles sans antibiotiques : santé animale (élevage qui doit prévenir les maladies autrement) ; santé humaine (limitation de la sélection de bactéries résistantes) ; écosystèmes (moins de résidus et de bactéries résistantes dans les sols et l'eau).

4. Vigilance : apport en protéines (associer légumineuses et céréales, prévoir œufs ou produits laitiers) et en fer (légumineuses avec une source de vitamine C) ; acceptabilité par les enfants (recettes, goût, textures) pour éviter le gaspillage ; grammages adaptés à l'âge.

Corrigé – Exercice 1.6

1. Dimension biologique : enfants de 3 à 6 ans (besoins de croissance, goût en construction). Dimension psychologique : parents qui se sentent jugés ; envie de faire plaisir à l'enfant. Dimension sociale : manque d'argent et de temps, logement sans four (11 familles sur 28, soit 39,3 %), offre alimentaire du quartier pauvre en produits frais.

2. La santé des enfants dépend de ressources de la vie quotidienne : revenu, logement équipé, commerces accessibles, temps disponible, confiance des parents. L'action doit renforcer ces ressources (compétences, accès, soutien entre parents) et pas seulement transmettre des informations.

3. Exemple d'introduction : « Depuis la Charte d'Ottawa (1986), la santé n'est plus seulement l'absence de maladie : c'est une ressource de la vie quotidienne, qui dépend des conditions de vie autant que des comportements. Au centre social, les familles disent manquer de temps et d'argent ; 11 des 28 familles ayant un enfant de 3 à 6 ans n'ont pas de four, et l'offre de fruits et légumes frais du quartier est limitée. Dans ce contexte, des conseils seuls ne suffiraient pas. Le projet « café des parents » propose donc un espace d'échange et de pratique, construit avec les familles, pour partager des idées de goûters simples, appréciés des enfants et peu coûteux, et pour faciliter l'accès aux produits frais du marché. »

4. Phrase : « certains se sentent jugés par l'école sur le contenu du goûter ». On évite tout message culpabilisant (« bons » et « mauvais » goûters), on part de ce que font déjà les parents, on valorise les réussites, on relit les supports avec la check-list éthique et non-stigmatisation.

Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la santé publique (Winslow, 1920) et la politique de santé (article L. 1411-1 du code de la santé publique).
- Distinguer l'approche clinique et l'approche de santé publique.
- Citer les missions de la santé publique et les relier à des actions concrètes en nutrition.
- Expliquer et calculer le paradoxe de la prévention (Rose, 1985) ; distinguer incidence et prévalence.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Santé publique : ensemble des savoirs, des savoir-faire et des actions organisées qui visent à maintenir et améliorer la santé de la population, en agissant collectivement sur ses déterminants (Winslow, 1920 : « la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé… »).
- Neuf missions : observer et surveiller ; veiller et alerter ; protéger ; promouvoir ; prévenir ; éduquer et informer ; organiser ; former, chercher, évaluer ; gouverner.
- Paradoxe de la prévention (Geoffrey Rose, 1985) : un grand nombre de personnes exposées à un petit risque peut produire plus de cas qu'un petit nombre de personnes à haut risque.
- Prévalence = cas existants / population à un moment donné. Incidence = nouveaux cas pendant une période / population à risque au début de la période.

Exercice 2.1 – Légender les missions de la santé publique (9 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une affiche pour présenter la santé publique aux étudiants de première année lors d'une journée portes ouvertes.

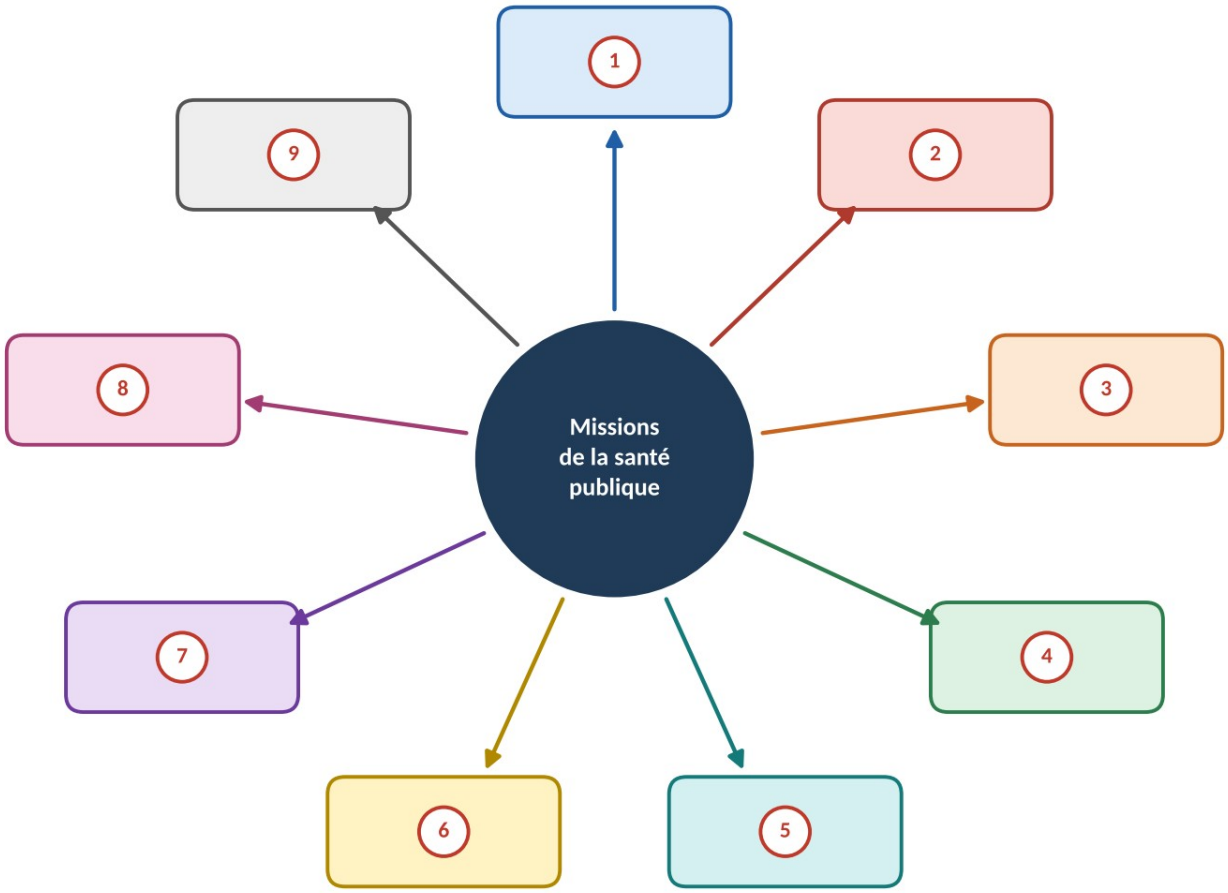


Figure 2.1 – Document 1 – Les missions de la santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)

2. Pour les missions 1, 2, 4, 5 et 6, donnez un exemple d'action en nutrition. (4,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.2 – Approche clinique ou approche de santé publique ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive), vous relevez les activités de la diététicienne pendant une semaine.

Document 1 – Activités de la semaine

a) Consultation d'un patient diabétique adressé par son médecin.

b) Analyse des données de corpulence des enfants des 4 écoles de la commune, transmises par la santé scolaire.

c) Animation d'un atelier « petits-déjeuners » pour toutes les classes de CE2 de la commune.

d) Bilan nutritionnel d'une patiente dénutrie à domicile.

e) Réunion avec la mairie pour installer des fontaines à eau dans les écoles.

f) Rédaction d'un plan de soins diététiques pour un patient insuffisant rénal.

g) Participation au comité de pilotage du contrat local de santé.

h) Conception d'un questionnaire sur l'alimentation des seniors de la commune.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque activité dans l'approche clinique ou dans l'approche de santé publique. (4 pts)
2. Comparez les deux approches selon 6 critères : cible, point de départ, objectif, leviers, acteurs, évaluation. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.3 – Calculer le paradoxe de la prévention (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agglomération de 60 000 adultes (données fictives) veut réduire le nombre d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Deux stratégies sont proposées au conseil communautaire : un programme intensif pour les personnes hypertendues, ou une action sur toute la population pour réduire la consommation de sel (pain, restauration collective, ateliers).

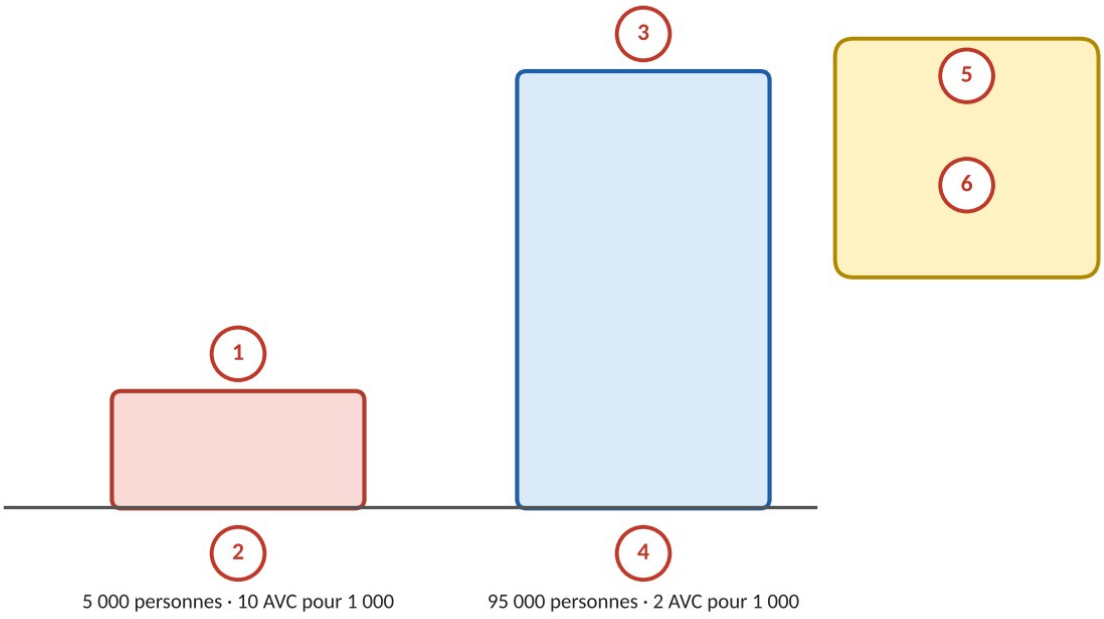


Figure 2.2 – Document 1 – Le paradoxe de la prévention, exemple du cours (schéma à légender)

Document 2 – Données de l'agglomération (fictives, risque sur 10 ans)

Groupe	Effectif	AVC attendus sur 10 ans pour 1 000 personnes
Hypertension sévère (haut risque)	6 000	12
Pression artérielle normale ou modérément élevée (faible risque)	54 000	3

Stratégie A (haut risque) : le programme intensif réduit de 30 % le risque des seules personnes à haut risque.

Stratégie B (population) : l'action sur le sel réduit de 10 % le risque de toute la population.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez le document 1. (3 pts)
2. Calculez le nombre d'AVC attendus sur 10 ans dans chaque groupe, puis au total. (3 pts)
3. Calculez la part des AVC qui surviennent dans le groupe à faible risque ; concluez. (2 pts)
4. Calculez le nombre d'AVC évités par la stratégie A et par la stratégie B. (3 pts)
5. Argumentez le choix d'une stratégie en citant le paradoxe de Rose et une limite de chaque stratégie. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.4 – Distinguer incidence et prévalence (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé scolaire d'une circonscription (données fictives) suit 2 400 enfants de CM1. En septembre, 312 enfants sont en surpoids (obésité comprise). En juin, 48 nouveaux enfants sont en surpoids parmi ceux qui ne l'étaient pas en septembre.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la prévalence et l'incidence. (2 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids en septembre. (2 pts)
3. Calculez l'incidence cumulée du surpoids entre septembre et juin, en précisant la population à risque. (3 pts)
4. Indiquez quel indicateur une action de prévention primaire cherche à faire baisser, et quel indicateur baisse avec une prévention secondaire ; justifiez. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.5 – Les missions de la santé publique face à une toxi-infection alimentaire collective (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un jeudi, 23 élèves et 2 agents d'une école primaire (structure fictive) présentent des vomissements et des diarrhées 4 à 6 heures après le déjeuner servi par la cuisine centrale. La directrice appelle le médecin scolaire.

Document 1 – Ce qui se passe dans les jours suivants

a) Le médecin déclare la toxi-infection alimentaire collective (TIAC) à l'agence régionale de santé.

b) Les plats témoins conservés par la cuisine centrale sont analysés.

c) La direction départementale chargée de la protection des populations inspecte la cuisine centrale.

d) Santé publique France intègre l'épisode dans la surveillance nationale des TIAC.

e) Le maire suspend la préparation des plats concernés jusqu'au rapport d'inspection.

f) La diététicienne de la cuisine centrale anime une formation sur le maintien en température pour les agents.

g) Une lettre d'information est envoyée aux familles.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la TIAC (au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire) et rappelez qu'elle est une maladie à déclaration obligatoire. (2 pts)
2. Associez chaque action du document 1 à une mission de la santé publique. (7 pts)
3. Indiquez le rôle du diététicien dans la prévention des TIAC en restauration collective. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2.6 – Convaincre des élus d'une action populationnelle (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

En stage au service santé d'une ville de 35 000 habitants (structure fictive), vous devez préparer une note d'une page pour les élus. Le projet propose de travailler avec les boulangers volontaires de la ville pour réduire progressivement le sel du pain, et de réduire le sel des plats servis dans les cantines et au portage de repas des seniors. Un élu objecte : « Seuls les hypertendus sont concernés ; il suffit que leurs médecins s'en occupent. »

Document 1 – Extraits de textes

- Article L. 1411-1 du code de la santé publique : la politique de santé « tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales [...] ».
- OMS : recommandation de moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.
- Le pain fait partie des principaux contributeurs de l'apport en sel en France (études de consommation de l'ANSES).

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez à l'élu, avec le paradoxe de Rose, pourquoi une action sur toute la population est pertinente. (4 pts)
2. Montrez que le projet répond à la définition de la politique de santé du document 1. (3 pts)
3. Identifiez les missions de la santé publique mobilisées par le projet. (3 pts)
4. Rédigez la note d'une page aux élus : contexte, objectif, actions, partenaires, évaluation. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 2.1

1. Légendes : 1 Observer et surveiller ; 2 Veiller et alerter ; 3 Protéger ; 4 Promouvoir la santé ; 5 Prévenir ; 6 Éduquer et informer ; 7 Organiser le système de santé ; 8 Former, chercher, évaluer ; 9 Gouverner.
2. Exemples : observer et surveiller : étude ESTEBAN ou INCA, enquêtes de santé scolaire ; veiller et alerter : déclaration d'une TIAC, nutrivigilance des compléments alimentaires ; promouvoir : installation de fontaines à eau, charte « Ville active du PNNS » ; prévenir : dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD ; éduquer et informer : atelier de lecture d'étiquettes, campagne « Manger Bouger ».

Corrigé – Exercice 2.2

1. Approche clinique : a, d, f. Approche de santé publique : b, c, e, g, h.
2. Comparaison :

Critère	Approche clinique	Approche de santé publique
Cible	Un individu, le patient	Une population ou un groupe
Point de départ	Une demande de soin, une prescription	Un diagnostic de situation (données, besoins)
Objectif	Guérir, soulager, accompagner	Maintenir et améliorer la santé du groupe, réduire les inégalités
Leviers	Bilan, diagnostic diététique, plan de soins, ETP	Environnements, politiques, communication, éducation, partenariats
Acteurs	Équipe soignante	Équipe pluridisciplinaire et intersectorielle
Évaluation	Évolution clinique du patient	Indicateurs de processus et de résultats sur le groupe

Corrigé – Exercice 2.3

1. Légendes du document 1 : 1 50 AVC ; 2 Groupe à haut risque ; 3 190 AVC ; 4 Groupe à faible risque ; 5 Paradoxe de la prévention ; 6 La majorité des cas vient du grand nombre de personnes à faible risque.
2. AVC attendus = effectif × risque / 1 000. Haut risque : 6 000 × 12 / 1 000 = 72 AVC. Faible risque : 54 000 × 3 / 1 000 = 162 AVC. Total : 72 + 162 = 234 AVC.
3. Part dans le groupe à faible risque = 162 / 234 × 100 = 69,2 %. Plus des deux tiers des AVC surviennent chez des personnes à faible risque, simplement parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses.
4. Stratégie A : 72 × 0,30 = 21,6, soit environ 22 AVC évités. Stratégie B : 234 × 0,10 = 23,4, soit environ 23 AVC évités.
5. La stratégie B évite autant ou un peu plus d'AVC alors que la réduction du risque individuel est faible (10 %) : c'est le paradoxe de Rose, une mesure qui apporte peu à chaque personne apporte beaucoup à la population. Limites : la stratégie A ne touche que 10 % de la population et ignore la majorité des cas ; la stratégie B apporte un bénéfice individuel faible, donc peu motivant, et doit être maintenue longtemps. Le mieux est de combiner les deux.

Corrigé – Exercice 2.4

1. Prévalence : nombre de cas existants dans une population à un moment donné, rapporté à cette population. Incidence : nombre de nouveaux cas apparus pendant une période, rapporté à la population à risque (non malade) au début de la période.
2. Prévalence en septembre = 312 / 2 400 × 100 = 13,0 %.
3. Population à risque = enfants sans surpoids en septembre = 2 400 − 312 = 2 088. Incidence cumulée = 48 /

2 088 × 100 = 2,3 % sur l'année scolaire.

4. La prévention primaire évite l'apparition de nouveaux cas : elle fait baisser l'incidence. La prévention secondaire repère et prend en charge tôt les cas existants, ce qui raccourcit la durée du problème : elle fait baisser la prévalence.

Corrigé – Exercice 2.5

1. TIAC : apparition d'au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. C'est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS.

2. a) Veiller et alerter ; b) observer (investigation, recherche de l'agent) et protéger ; c) protéger (contrôle de la sécurité sanitaire) ; d) observer et surveiller ; e) protéger (mesure de gestion du risque) ; f) éduquer et former ; g) informer.

3. Le diététicien participe au plan de maîtrise sanitaire (méthode HACCP, bonnes pratiques d'hygiène), forme les agents, vérifie les températures et la traçabilité, conserve les plats témoins, choisit des recettes et des procédés à moindre risque et participe à l'investigation en cas de TIAC.

Corrigé – Exercice 2.6

1. L'hypertension et ses complications ne surviennent pas seulement chez les personnes déjà hypertendues : comme l'a montré Rose, le grand nombre de personnes à risque faible ou modéré produit une grande partie des cas. Réduire un peu le sel consommé par tous (pain, cantines, portage) déplace vers le bas la pression artérielle moyenne de toute la population et évite davantage de cas que l'action sur les seuls hypertendus. Les médecins restent indispensables pour les personnes à haut risque : les deux actions se complètent.

2. Le projet crée des conditions de vie favorables à la santé (pain et repas moins salés, sans effort individuel) ; il vise l'amélioration de l'état de santé de la population ; il réduit les inégalités, car il bénéficie à tous, y compris aux personnes qui ont moins accès à la prévention individuelle (seniors portés à domicile, enfants des cantines).

3. Promouvoir (environnement alimentaire), prévenir (prévention primaire universelle de l'hypertension), protéger, éduquer et informer (ateliers, communication), observer et évaluer (mesure du sel), gouverner (décision des élus, partenariat avec les boulangers).

4. Exemple de note : contexte (l'OMS recommande moins de 5 g de sel par jour ; le pain est un contributeur majeur ; l'hypertension est un facteur de risque majeur d'AVC) ; objectif (réduire progressivement la teneur en sel du pain des boulangeries volontaires et des repas de la restauration municipale en 2 ans) ; actions (charte avec les boulangers, réduction par paliers pour préserver le goût, adaptation des recettes en cuisine centrale, ateliers « goût sans sel » avec les herbes et les épices, information des habitants) ; partenaires (boulangers, chambre de métiers, cuisine centrale, CCAS, ARS au titre du CLS) ; évaluation (teneur en sel mesurée ou déclarée, nombre de boulangeries engagées, ventes, satisfaction des convives, suivi des plaintes sur le goût).

Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir problème de santé, danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection et population à risque.
- Identifier ces notions dans une situation professionnelle et calculer un risque simple.
- Hiérarchiser des problèmes de santé avec des critères explicites.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Danger : propriété intrinsèque d'un agent ou d'une situation capable de provoquer un effet néfaste.
- Exposition : contact entre la population et le danger (dose, durée, fréquence).
- Risque : probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition (risque = danger × exposition).
- Facteur de risque : caractéristique associée à une probabilité accrue de maladie, sans être forcément la cause. Facteur de protection : associé à une probabilité réduite.
- Critères de priorité d'un problème de santé : fréquence, gravité, évolution, coût, existence de moyens d'action efficaces, demande de la population.

Exercice 3.1 – Légender la chaîne du risque (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance de formation pour les animateurs d'un centre de loisirs sur la sécurité des goûters et l'alimentation des enfants.

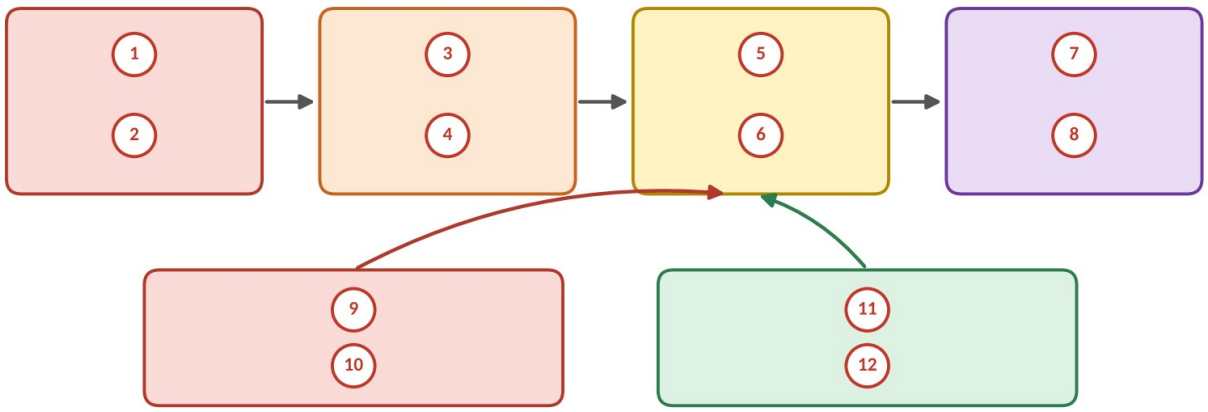


Figure 3.1 – Document 1 – Du danger au problème de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (6 pts)
2. Appliquez la chaîne au cas d'un enfant allergique à l'arachide qui participe à un goûter d'anniversaire : danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi, avec le même danger, le risque peut être nul. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.2 – Classer les notions (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix éléments relevés dans des situations de stage

a) Listeria monocytogenes. b) Consommation quotidienne de plats préparés riches en sel. c) Probabilité de développer une hypertension dans une population qui mange très salé. d) Allaitement maternel. e) Femmes enceintes face à la listériose. f) Sédentarité. g) Obésité des enfants d'un quartier, mesurée par la santé scolaire. h) Soutien social d'une personne âgée vivant seule. i) Faible revenu. j) Consommation de fruits, de légumes et de fibres.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque élément : problème de santé, danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection ou population à risque. (10 × 1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.3 – Calculer et interpréter un risque (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional (données fictives) a suivi pendant 3 ans 1 200 adolescents de 12 ans sans surpoids au départ. Au début du suivi, 400 adolescents buvaient chaque jour au moins une boisson sucrée ; 800 n'en buvaient pas chaque jour.

Document 1 – Résultats après 3 ans

Groupe	Effectif au départ	Adolescents en surpoids après 3 ans
Boisson sucrée chaque jour	400	64
Pas de boisson sucrée chaque jour	800	72

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de devenir en surpoids en 3 ans dans chaque groupe. (3 pts)
2. Calculez le rapport des deux risques (risque relatif) et interprétez-le. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la boisson sucrée quotidienne est un facteur de risque, mais pas forcément la cause unique du surpoids ; citez deux autres facteurs qui peuvent intervenir. (3 pts)
4. Proposez une action de promotion de la santé et une action d'éducation pour la santé qui découlent de ce résultat. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.4 – La listériose chez la femme enceinte (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez avec la sage-femme de la PMI une séance collective pour des femmes enceintes. L'une d'elles dit : « Ma mère a mangé du fromage au lait cru pendant toutes ses grossesses et nous allons très bien. »

Document 1 – Informations de référence

La listériose est une infection due à Listeria monocytogenes, une bactérie présente dans l'environnement qui peut se multiplier au réfrigérateur. Elle est rare mais grave : chez la femme enceinte, elle peut provoquer une fausse couche, un accouchement prématuré ou une infection grave du nouveau-né. Les personnes les plus exposées à une forme grave sont les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Les aliments à éviter pendant la grossesse comprennent notamment les fromages au lait cru, les charcuteries à la coupe, les poissons fumés et les graines germées crues.

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez le danger, l'exposition, le risque et la population à risque. (4 pts)
2. Expliquez à cette femme pourquoi l'expérience de sa mère ne prouve pas l'absence de risque (rareté de l'événement, probabilité). (3 pts)
3. Proposez quatre conseils pratiques de prévention, formulés de façon positive. (4 pts)
4. Indiquez le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon) de cette séance. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.5 – Facteurs de risque et facteurs de protection dans un quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un quartier prioritaire (données fictives), la santé scolaire observe que 21 % des élèves de CM2 sont en surpoids, contre 15 % dans le reste de la ville. Un élu en conclut : « Le quartier rend les enfants gros. »

Document 1 – Observations du diagnostic de quartier

- Deux supermarchés discount et une supérette ; le marché a lieu une fois par semaine.
- Un city-stade fermé depuis deux ans ; peu d'espaces verts.
- Taux de chômage élevé ; beaucoup de familles monoparentales.
- Une association de parents très active ; un jardin partagé créé en 2024 ; une école qui participe à un programme de fruits à la récréation.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart de prévalence entre le quartier et le reste de la ville, en points et en rapport. (2 pts)

2. Expliquez pourquoi la phrase de l'élu est une erreur de raisonnement. (3 pts)

3. Classez les observations du document 1 en facteurs de risque et en facteurs de protection. (4 pts)

4. Proposez deux actions qui renforcent les facteurs de protection existants. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.6 – Hiérarchiser des problèmes de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage du contrat local de santé d'une communauté de communes (données fictives) dispose d'un budget pour une seule action de nutrition en 2027. Quatre problèmes ont été repérés. Votre tutrice vous demande de construire une grille de priorisation et de présenter un choix argumenté.

Document 1 – Notes attribuées par le groupe de travail (1 = faible, 3 = élevé)

Problème	Fréquence	Gravité	Évolution et coût	Faisabilité (moyens efficaces disponibles)	Demande de la population
Surpoids des enfants	3	2	2	2	2
Dénutrition des seniors à domicile	2	3	2	3	1
Insécurité alimentaire des familles	3	2	2	2	3
Faible consommation de légumineuses	3	1	1	3	1

Pondération retenue : fréquence × 2 ; gravité × 3 ; évolution et coût × 1 ; faisabilité × 2 ; demande × 1.

À vous de jouer – Questions

1. Citez les critères habituels de priorisation d'un problème de santé et justifiez la pondération plus forte de la gravité. (3 pts)
2. Calculez le score pondéré de chaque problème et classez-les. (5 pts)
3. Discutez le résultat : écart entre les scores, subjectivité des notes, problème qui touche peu de personnes mais qui est grave. (4 pts)
4. Rédigez la recommandation au comité de pilotage en 5 lignes. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 3.1

1. Légendes : 1 Danger ; 2 propriété d'un agent capable de nuire ; 3 Exposition ; 4 contact : dose, durée, fréquence ; 5 Risque ; 6 probabilité de survenue de l'effet néfaste ; 7 Problème de santé ; 8 mesuré par des indicateurs ; 9 Facteurs de risque ; 10 augmentent la probabilité (sédentarité, boissons sucrées, faible revenu) ; 11 Facteurs de protection ; 12 diminuent la probabilité (fibres, activité physique, soutien social).
2. Danger : l'arachide (allergène). Exposition : ingestion de gâteaux ou de biscuits contenant de l'arachide ou des traces, au goûter. Risque : probabilité d'une réaction allergique grave (anaphylaxie) pendant le goûter. Facteur de risque : produits faits maison sans liste d'ingrédients, absence d'information des animateurs. Facteur de protection : projet d'accueil individualisé connu de l'équipe, lecture des étiquettes, goûter de l'enfant fourni par la famille, trousse d'urgence disponible.
3. Si l'exposition est nulle (aucun produit contenant de l'arachide n'est consommé), le risque est nul même si le danger existe : risque = danger × exposition.

Corrigé – Exercice 3.2

a) Danger. b) Exposition. c) Risque. d) Facteur de protection. e) Population à risque. f) Facteur de risque. g) Problème de santé. h) Facteur de protection. i) Facteur de risque. j) Facteur de protection.

Corrigé – Exercice 3.3

1. Risque = nouveaux cas / effectif au départ. Boisson sucrée quotidienne : 64 / 400 = 0,16, soit 16 %. Sans boisson sucrée quotidienne : 72 / 800 = 0,09, soit 9 %.
2. Risque relatif = 0,16 / 0,09 = 1,78. Les adolescents qui boivent une boisson sucrée chaque jour ont 1,78 fois plus de risque de devenir en surpoids en 3 ans que les autres.
3. Une association statistique ne prouve pas la causalité : les adolescents qui boivent des boissons sucrées chaque jour peuvent aussi avoir d'autres caractéristiques (sédentarité, temps d'écran, sommeil court, revenus plus faibles, grignotage) qui expliquent une partie de l'écart. Ces facteurs de confusion doivent être pris en compte (chapitre 16).
4. Promotion de la santé : fontaines à eau et suppression de l'offre de boissons sucrées dans les lieux fréquentés par les jeunes (milieux favorables). Éducation pour la santé : atelier sur le sucre caché dans les boissons et fabrication d'eaux aromatisées maison.

Corrigé – Exercice 3.4

1. Danger : Listeria monocytogenes. Exposition : consommation d'aliments pouvant être contaminés (fromages au lait cru, charcuteries à la coupe, poissons fumés, graines germées crues). Risque : probabilité de listériose et de ses complications (fausse couche, prématurité, infection du nouveau-né). Population à risque : les femmes enceintes (ainsi que les personnes âgées et immunodéprimées).
2. La listériose est rare : la plupart des femmes qui consomment ces aliments n'auront pas de listériose, mais celles qui l'ont peuvent avoir des conséquences très graves. L'absence d'accident chez une personne ne prouve pas l'absence de risque : c'est une probabilité, faible, avec une gravité élevée. On ne dramatise pas, on explique.
3. Conseils positifs : « Choisissez les fromages à pâte pressée cuite (comté, emmental) et les fromages pasteurisés » ; « Préférez la charcuterie préemballée et consommez-la rapidement après ouverture » ; « Faites bien cuire viandes et poissons » ; « Nettoyez le réfrigérateur régulièrement et vérifiez sa température (4 °C au plus) » ; « Lavez soigneusement les légumes et les herbes aromatiques ».
4. Prévention primaire (OMS) ; prévention sélective (Gordon), car elle vise un groupe exposé à un risque particulier, sans maladie.

Corrigé – Exercice 3.5

1. Écart absolu = 21 − 15 = 6 points ; rapport = 21 / 15 = 1,4. La prévalence est 1,4 fois plus élevée dans le quartier.

2. Habiter le quartier est associé à une prévalence plus forte, mais ce n'est pas le quartier en lui-même qui cause le surpoids : ce sont des déterminants (revenus, offre alimentaire, espaces d'activité physique, stress, temps disponible) plus fréquents dans le quartier. Confondre association et causalité conduit à des actions inefficaces et stigmatisantes.

3. Facteurs de risque : offre alimentaire limitée (discount, supérette, marché hebdomadaire) ; city-stade fermé, peu d'espaces verts ; chômage et monoparentalité (ressources et temps limités). Facteurs de protection : association de parents active (soutien social, action communautaire) ; jardin partagé ; programme de fruits à la récréation.

4. Exemples : s'appuyer sur l'association de parents pour co-construire des ateliers de cuisine avec les légumes du jardin partagé ; plaider auprès de la mairie pour rouvrir le city-stade avec des animations sportives gratuites ; étendre le programme de fruits à toutes les écoles du quartier.

Corrigé – Exercice 3.6

1. Critères : fréquence (prévalence, incidence), gravité (mortalité, handicap, qualité de vie), évolution et coût, existence de moyens d'action efficaces et faisables, demande et acceptabilité de la population, inégalités. La gravité est pondérée plus fortement, car un problème grave a des conséquences lourdes (décès, perte d'autonomie) même s'il touche moins de personnes.

2. Scores pondérés (fréquence × 2 + gravité × 3 + évolution × 1 + faisabilité × 2 + demande × 1) : surpoids des enfants : 3 × 2 + 2 × 3 + 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 1 = 20 ; dénutrition des seniors : 2 × 2 + 3 × 3 + 2 × 1 + 3 × 2 + 1 × 1 = 22 ; insécurité alimentaire : 3 × 2 + 2 × 3 + 2 × 1 + 2 × 2 + 3 × 1 = 21 ; légumineuses : 3 × 2 + 1 × 3 + 1 × 1 + 3 × 2 + 1 × 1 = 17. Classement : dénutrition des seniors (22), insécurité alimentaire (21), surpoids des enfants (20), légumineuses (17).

3. Les trois premiers scores sont très proches (22, 21, 20) : un point de différence sur une seule note changerait le classement. Les notes sont subjectives et doivent être justifiées par des données (prévalences, demandes recueillies). La dénutrition touche moins de personnes, mais sa gravité (chutes, hospitalisations, perte d'autonomie) explique son rang. Le groupe peut aussi chercher une action qui répond à deux problèmes à la fois (par exemple l'insécurité alimentaire des seniors isolés).

4. Recommandation : « La grille place en tête la dénutrition des seniors à domicile (22 points), suivie de près par l'insécurité alimentaire des familles (21) et le surpoids des enfants (20). Nous recommandons une action de repérage et de prévention de la dénutrition, avec le portage de repas, le CCAS et les infirmiers libéraux, car le problème est grave et des moyens efficaces existent. Les scores étant proches, l'insécurité alimentaire sera traitée en 2028 ; les notes seront révisées avec les données du diagnostic. »

Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer et distinguer les quatre modes d'intervention : surveillance et veille, promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé.
- Classer une action selon les niveaux de prévention de l'OMS et selon Gordon.
- Citer les 5 domaines d'action et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa et les illustrer en nutrition.
- Appliquer l'universalisme proportionné ; choisir une approche éducative participative et non stigmatisante.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Prévention primaire : avant la maladie, réduit l'incidence. Secondaire : maladie débutante, réduit la prévalence (dépistage). Tertiaire : maladie installée, réduit les complications et les récidives (ETP). Quaternaire (Jamoulle, 1986) : éviter la surmédicalisation.
- Gordon (1983) : universelle (toute la population), sélective (groupe à risque sans signe), indiquée (personnes présentant des facteurs de risque ou des signes).
- Charte d'Ottawa (21 novembre 1986) : 5 domaines (politique publique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services de santé) et 3 stratégies (plaider, conférer les moyens, servir de médiateur).
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : action pour tous, intensité proportionnelle au désavantage.
- Éducation pour la santé : nutritionnelle, alimentaire, sensorielle ; approches informative, persuasive, participative.

Exercice 4.1 – Légender les niveaux de prévention (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter, en réunion d'équipe d'une PMI, les classifications de la prévention pour qualifier les actions du service.

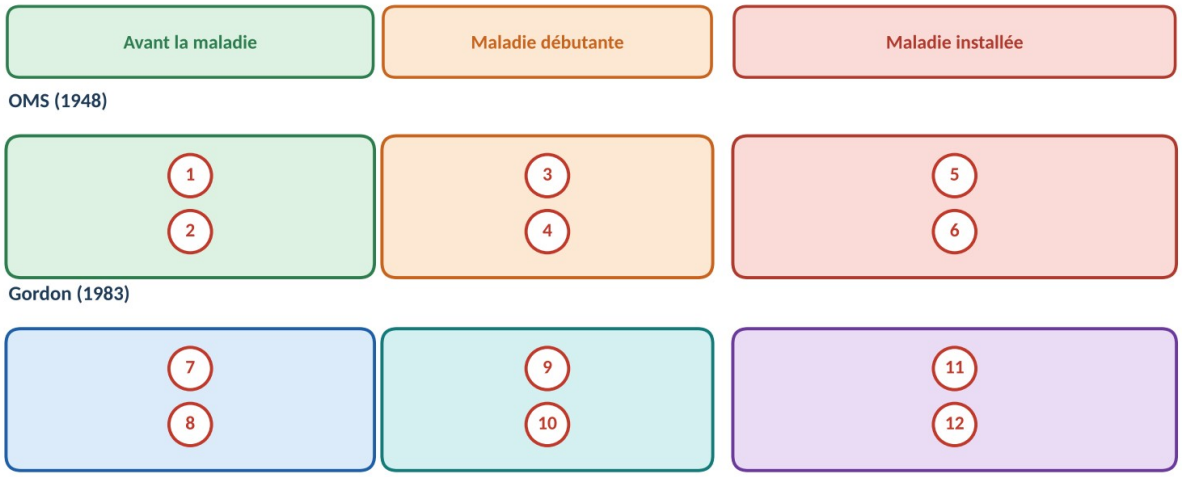


Figure 4.1 – Document 1 – Les niveaux de prévention selon l'OMS et selon Gordon (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Pour chacun des trois niveaux de l'OMS, donnez un exemple d'action en nutrition. (3 pts)
3. Définissez la prévention quaternaire et donnez un exemple en nutrition. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.2 – Les 5 domaines et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville de 25 000 habitants (structure fictive) a signé la charte « Ville active du PNNS ». Vous devez montrer aux élus que leur plan d'action couvre bien les cinq domaines de la Charte d'Ottawa.

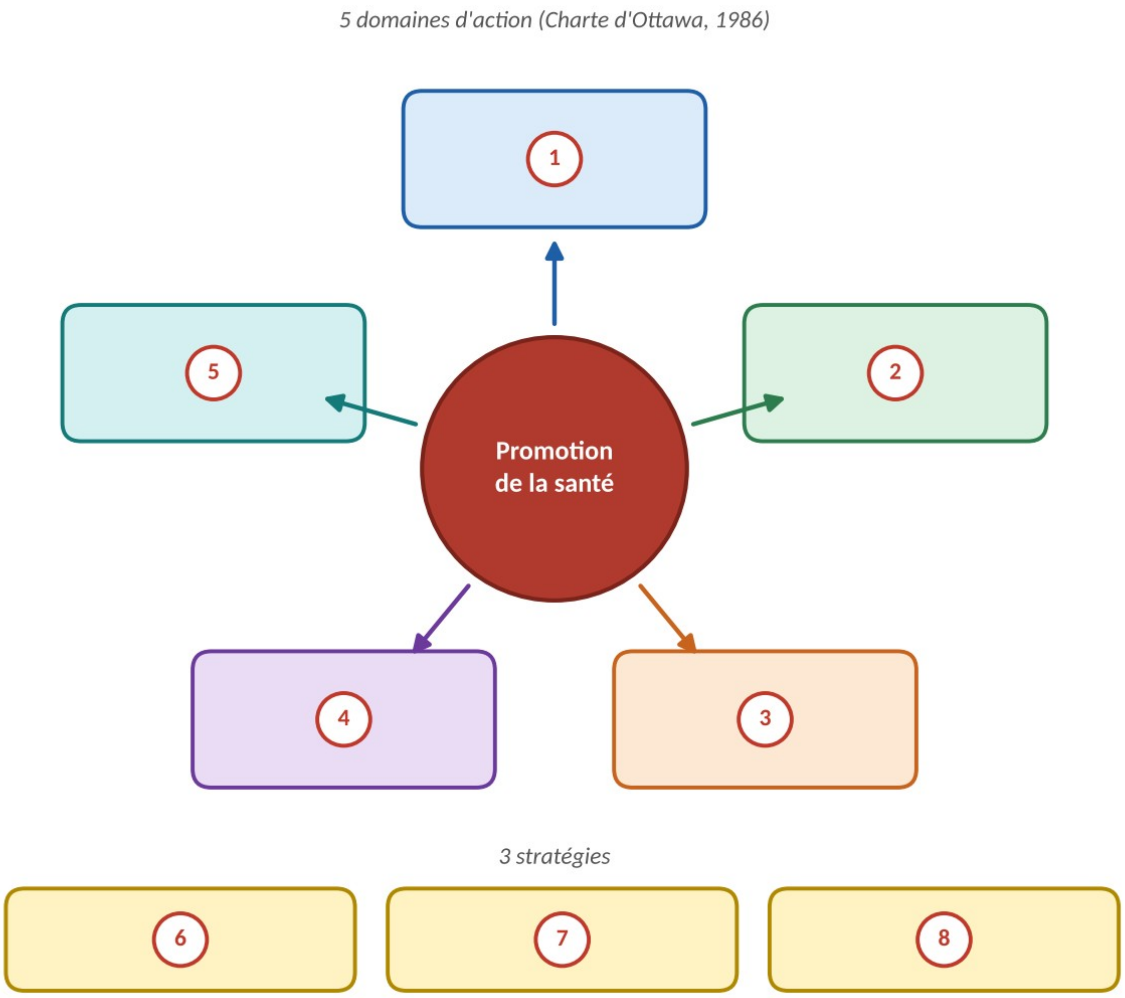


Figure 4.2 – Document 1 – La Charte d'Ottawa (schéma à légender)

Document 2 – Actions du plan municipal

a) Fontaines à eau dans toutes les écoles. b) Ateliers « cuisine du marché » pour les habitants. c) Jardin partagé géré par une association d'habitants. d) Délibération du conseil municipal fixant 50 % de produits durables dont 20 % de bio en restauration scolaire. e) Consultation de prévention nutritionnelle à la maison de santé. f) Rencontres entre maraîchers, cuisine centrale et parents d'élèves pour choisir les produits. g) Formation des animateurs périscolaires à l'éducation au goût. h) Présentation aux élus des données de corpulence des enfants pour obtenir le financement.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (4 pts)

2. Classez chaque action du document 2 dans un domaine d'action de la Charte. (5 pts)
3. Associez les actions f et h à une des trois stratégies ; justifiez. (2 pts)
4. Rappelez la définition de la promotion de la santé selon la Charte d'Ottawa. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.3 – Qualifier une action (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Six actions observées sur un territoire

a) Une campagne nationale de radio rappelle les repères du PNNS.

b) La santé scolaire mesure le poids et la taille des élèves de grande section et oriente les enfants dont la courbe de corpulence remonte tôt.

c) Une diététicienne anime 6 ateliers « petit budget » pour les familles bénéficiaires d'une épicerie sociale.

d) Un service de diabétologie organise un programme d'éducation thérapeutique déclaré à l'ARS.

e) Santé publique France publie les résultats d'une enquête nationale sur la corpulence.

f) Un EHPAD pèse chaque résident à l'entrée puis tous les mois et dose l'albumine sur prescription.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque action, indiquez le mode d'intervention, le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon), quand c'est possible. (9 pts)
2. Expliquez pourquoi l'action d ne relève pas de l'éducation pour la santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.4 – Appliquer l'universalisme proportionné à la cantine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une commune (données fictives) facture actuellement le repas de cantine 3,00 € à toutes les familles. Elle étudie une tarification sociale en quatre tranches selon le quotient familial. Un enfant mange 140 repas par an à la cantine.

Document 1 – Tarification étudiée et revenus types

Tranche	Revenu mensuel type de la famille	Prix du repas proposé
Tranche 1	1 300 €	1,00 €
Tranche 2	2 200 €	2,20 €
Tranche 3	3 400 €	3,40 €
Tranche 4	5 500 €	4,50 €

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'universalisme proportionné et citez son auteur. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque tranche, le coût annuel de la cantine et sa part dans le revenu annuel, avec le tarif unique de 3,00 € puis avec la tarification proposée. (6 pts)
3. Interprétez les résultats : quelle tarification est la plus équitable ? (3 pts)
4. Montrez que la tarification sociale est une action universelle d'intensité proportionnée ; proposez une autre mesure qui renforce l'accès des familles de la tranche 1. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.5 – Choisir une approche éducative (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collège veut agir sur la consommation de boissons sucrées des élèves de 5e. Trois propositions sont faites.

Document 1 – Trois propositions

Proposition 1 : une affiche montrant un adolescent en surpoids avec le slogan « Le soda, c'est ça qui t'attend ».

Proposition 2 : un dépliant indiquant la quantité de sucre de 10 boissons et les repères du PNNS.

Proposition 3 : trois séances où les élèves mesurent le sucre de leurs boissons préférées, inventent des recettes d'eaux aromatisées, les font goûter aux autres classes et proposent au conseil d'administration l'installation d'une fontaine.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez l'approche éducative de chaque proposition et indiquez sa principale limite ou son principal intérêt. (6 pts)
2. Réécrivez le slogan de la proposition 1 pour qu'il soit positif et non stigmatisant. (2 pts)
3. Montrez que la proposition 3 combine plusieurs domaines de la Charte d'Ottawa et développe des compétences psychosociales. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.6 – Construire une réponse combinant les quatre modes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle régionale (structure fictive) vous recrute en stage. Elle veut un programme « Bien manger au travail » pour les 1 200 salariés de ses adhérents entreprises, et un programme pour ses adhérents atteints de diabète de type 2. Le directeur pense « faire la même chose pour tout le monde, avec une conférence et un livret ».

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez au directeur pourquoi les deux publics relèvent de modes d'intervention différents. (4 pts)
2. Proposez, pour les salariés, une action relevant de chacun des quatre modes d'intervention (surveillance et veille, promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé). (6 pts)
3. Indiquez, pour les adhérents diabétiques, le cadre réglementaire de l'éducation thérapeutique et le rôle possible du diététicien. (3 pts)
4. Critiquez l'idée d'une conférence et d'un livret identiques pour tous, en citant deux principes de la promotion de la santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 4.1

1. Légendes : 1 Prévention primaire ; 2 réduit l'incidence ; 3 Prévention secondaire ; 4 réduit la prévalence ; 5 Prévention tertiaire ; 6 réduit les complications et récidives ; 7 Universelle ; 8 toute la population ; 9 Sélective ; 10 groupe à risque, sans signe ; 11 Indiquée ; 12 personnes présentant des signes.
2. Primaire : atelier cuisine, repères du PNNS, réduction du sel dans le pain. Secondaire : dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD, repérage du rebond d'adiposité précoce. Tertiaire : prise en charge diététique d'un diabète, ETP.
3. La prévention quaternaire (Marc Jamoulle, 1986) protège les personnes de la surmédicalisation et des interventions inutiles ou nocives. Exemple : éviter un régime d'exclusion du gluten sans diagnostic de maladie cœliaque, ou des compléments alimentaires inutiles.

Corrigé – Exercice 4.2

1. Légendes : 1 Élaborer une politique publique saine ; 2 Créer des milieux favorables ; 3 Renforcer l'action communautaire ; 4 Acquérir des aptitudes individuelles ; 5 Réorienter les services de santé ; 6 Plaider ; 7 Conférer les moyens ; 8 Servir de médiateur.
2. a) Milieux favorables. b) Aptitudes individuelles. c) Action communautaire. d) Politique publique saine. e) Réorientation des services de santé. f) Action communautaire (et politique publique). g) Aptitudes individuelles (des professionnels relais) et réorientation des services. h) Politique publique saine, par le plaidoyer.
3. f : servir de médiateur, car on concilie les intérêts des producteurs, de la cuisine et des familles. h : plaider, car on présente des données aux décideurs pour obtenir une décision et des moyens.
4. « La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. »

Corrigé – Exercice 4.3

1. a) Éducation pour la santé informative et prévention primaire universelle. b) Prévention secondaire (repérage précoce), type indiqué, car les enfants repérés présentent un signe ; elle s'appuie sur la surveillance. c) Éducation pour la santé (alimentaire) et prévention primaire sélective. d) Éducation thérapeutique du patient : soin et prévention tertiaire. e) Surveillance épidémiologique (pas de niveau de prévention : elle produit les données). f) Prévention secondaire : dépistage de la dénutrition.
2. L'ETP s'adresse à des patients atteints d'une maladie chronique, pour les aider à gérer leur maladie et leur traitement ; elle relève du soin, est encadrée par l'article L. 1161-1 du code de la santé publique (loi HPST du 21 juillet 2009) et se fait dans des programmes déclarés à l'ARS. L'éducation pour la santé vise des personnes bien portantes.

Corrigé – Exercice 4.4

1. Universalisme proportionné (Michael Marmot, 2010) : les actions sont destinées à toute la population, mais leur intensité augmente avec le niveau de désavantage social.
2. Coût annuel = 140 × prix ; revenu annuel = revenu mensuel × 12 ; part = coût / revenu annuel × 100.

Tranche	Revenu annuel	Tarif unique : coût	Tarif unique : part du revenu	Tarif proposé : coût	Tarif proposé : part du revenu
1	15 600 €	420 €	2,69 %	140 €	0,90 %
2	26 400 €	420 €	1,59 %	308 €	1,17 %
3	40 800 €	420 €	1,03 %	476 €	1,17 %
4	66 000 €	420 €	0,64 %	630 €	0,95 %

3. Avec le tarif unique, l'effort demandé est 4 fois plus lourd pour la tranche 1 (2,69 %) que pour la tranche 4 (0,64 %) : 2,69 / 0,64 = 4,2. Avec la tarification proposée, l'effort est proche pour toutes les familles (de 0,90 % à 1,17 %). La tarification sociale est plus équitable : elle réduit le frein financier pour les familles modestes.

4. La cantine reste ouverte à tous (universelle), mais l'aide est plus forte pour les familles les plus modestes (intensité proportionnée). Mesure complémentaire : information des familles et inscription simplifiée par le CCAS, petit-déjeuner à l'école dans les quartiers prioritaires, ou aide aux repas des vacances scolaires.

Corrigé – Exercice 4.5

1. Proposition 1 : approche persuasive par la peur ; elle culpabilise, stigmatise les adolescents en surpoids et peut renforcer les inégalités. Proposition 2 : approche informative ; utile, mais savoir ne suffit pas à changer un comportement. Proposition 3 : approche participative ; elle part des élèves, développe leurs compétences et leur pouvoir d'agir, mais demande du temps et des compétences d'animation.

2. Exemple : « L'eau, ça se personnalise : invente ta boisson ! » ou « Envie de fraîcheur ? Teste nos eaux aux fruits. »

3. Domaines d'Ottawa : aptitudes individuelles (mesurer le sucre, cuisiner), action communautaire (élèves acteurs auprès des autres classes), milieux favorables et politique de l'établissement (fontaine votée au conseil d'administration). Compétences psychosociales : pensée critique (analyse des boissons et de la publicité), créativité (recettes), communication et coopération (présentation aux autres classes), prise de décision (proposition au conseil d'administration).

Corrigé – Exercice 4.6

1. Les salariés sont des personnes a priori bien portantes : l'action relève de la promotion de la santé, de la prévention primaire et de l'éducation pour la santé. Les adhérents diabétiques sont des patients : l'accompagnement de leur maladie relève de l'éducation thérapeutique, donc du soin et de la prévention tertiaire, avec des objectifs, des méthodes et un cadre différents.

2. Surveillance et veille : questionnaire anonyme sur les habitudes alimentaires au travail, suivi des données de la restauration ; veille sur les recommandations. Promotion de la santé : amélioration de l'offre de la restauration d'entreprise et des distributeurs, pauses repas protégées, espaces pour déjeuner. Prévention : dépistage proposé du risque cardiovasculaire lors d'une journée santé, avec orientation vers le médecin (prévention secondaire), ou action sur le sel (primaire). Éducation pour la santé : ateliers « gamelle équilibrée », lecture d'étiquettes, défis collectifs.

3. Cadre : article L. 1161-1 du code de la santé publique (loi HPST du 21 juillet 2009), recommandations de la HAS (2007), programmes déclarés à l'ARS. Le diététicien formé à l'ETP peut participer au bilan éducatif partagé et animer des séances (adapter son alimentation, lire les étiquettes, gérer les repas à l'extérieur).

4. Une conférence et un livret pour tous relèvent d'une approche informative, peu efficace seule ; ils ne partent pas des besoins de chaque public. Principes à citer : participation des personnes concernées dès le diagnostic ; action sur les milieux et pas seulement sur les comportements ; universalisme proportionné ; non-stigmatisation.

Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les acteurs aux niveaux international, européen, national, régional et local, et citer leur rôle en nutrition.
- Trouver la bonne source de données pour un diagnostic.
- Construire un plan de financement et une carte des partenaires d'un projet.
- Repérer les conflits d'intérêts dans un outil ou un partenariat.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Santé publique France (créée le 1er mai 2016) : surveillance, veille et alerte, prévention et promotion de la santé, « Manger Bouger », Nutri-Score, ESTEBAN, Géodes.
- ANSES (2010) : évaluation des risques, références nutritionnelles, études INCA, table Ciqual, Oqali, nutrivigilance.
- HAS (2004) : recommandations de bonne pratique, ETP. HCSP (2004) : expertise et avis (repères alimentaires, recommandations pour le PNNS 5). CNA (1985) : concertation.
- DGS (ministère chargé de la santé) : pilote le PNNS. DGAL (ministère chargé de l'agriculture) : pilote le PNA, sécurité sanitaire des aliments. DGCCRF : loyauté, étiquetage.
- ARS (loi HPST du 21 juillet 2009, créées en 2010) : projet régional de santé, financement de la prévention, contrats locaux de santé. DRAAF : PNA en région, projets alimentaires territoriaux.

Exercice 5.1 – Légender la carte des acteurs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dès la première semaine de stage, votre tutrice vous demande d'établir la carte des acteurs qui interviennent en nutrition, du niveau international au niveau local.

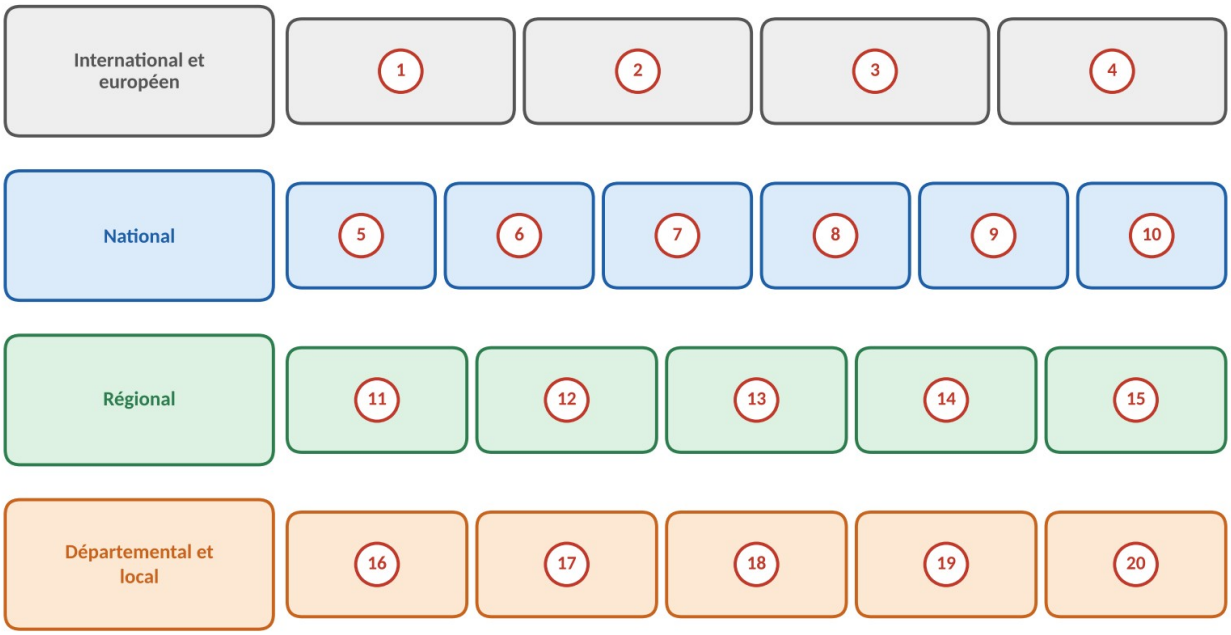


Figure 5.1 – Document 1 – Les acteurs de la santé publique en nutrition (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 20 du document 1, sachant que : la ligne 1 comprend deux agences des Nations unies, l'autorité européenne d'évaluation des risques et l'institution qui propose la réglementation européenne ; la ligne 2 comprend la direction qui pilote le PNNS, deux agences sanitaires, deux instances d'expertise et la direction qui pilote la sécurité sanitaire des aliments ; la ligne 3 comprend l'agence qui pilote la santé en région, la collectivité qui gère les lycées, le service de l'État chargé de l'alimentation en région, l'observatoire et la structure d'appui méthodologique ; la ligne 4 comprend les acteurs de proximité. (10 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.2 – Qui fait quoi ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix missions

a) Publier les références nutritionnelles et réaliser les études INCA. b) Gérer en France le logo Nutri-Score et le programme « Manger Bouger ». c) Publier une recommandation de bonne pratique sur la dénutrition. d) Rendre un avis d'expertise sur les repères alimentaires des enfants. e) Réunir producteurs, distributeurs, consommateurs et professionnels de santé pour rendre des avis. f) Contrôler la loyauté de l'étiquetage d'un produit. g) Évaluer les risques alimentaires au niveau européen. h) Signer un contrat local de santé avec une commune. i) Reconnaître un projet alimentaire territorial. j) Piloter le programme national pour l'alimentation.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque mission à l'organisme qui en est chargé. (10 × 1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.3 – Trouver la bonne source de données (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez le diagnostic d'un projet « Bien manger, bien grandir » dans une communauté d'agglomération. Vous devez trouver des données nationales de comparaison et des données locales.

Document 1 – Données recherchées

a) Prévalence de l'obésité mesurée chez les adultes en France. b) Consommations alimentaires détaillées des enfants et des adultes. c) Part de la population sous le seuil de pauvreté dans l'agglomération. d) Causes médicales de décès dans le département. e) Corpulence des élèves de grande section, de CM2 et de 3e. f) Composition nutritionnelle des aliments servis à la cantine. g) Indicateurs de santé déjà rassemblés pour le territoire. h) Données de santé consultables en ligne et cartographiées.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez, pour chaque donnée, une source et l'organisme qui la produit. (8 pts)

2. Expliquez pourquoi ESTEBAN (2014-2016) reste citée en 2026 et ce que changera l'enquête Albane. (2 pts)

3. Indiquez trois règles pour citer une donnée dans un dossier E5. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.4 – Construire un plan de financement (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (structure fictive) prépare un projet d'ateliers « Cuisine et budget » pour 40 familles sur un an. Le budget total est de 12 400 €. Vous devez compléter le plan de financement à joindre aux demandes de subvention.

Document 1 – Financements obtenus ou demandés

Financeur	Montant
ARS (appel à projets prévention)	5 000 €
Commune (au titre du contrat local de santé)	3 000 €
CAF	2 500 €
DREETS (programme « Mieux manger pour tous »)	1 400 €
Fonds propres du centre social	500 €

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez que le plan de financement est équilibré et calculez la part de chaque financeur. (4 pts)

2. Justifiez la légitimité de chaque financeur pour ce projet. (5 pts)

3. Indiquez ce que le centre social devra fournir à ses financeurs en fin de projet. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.5 – Repérer un conflit d'intérêts (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de produits laitiers sucrés propose gratuitement à une école un « kit pédagogique sur le petit-déjeuner », avec des affiches, un jeu et des échantillons de ses produits. La directrice vous demande votre avis.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez un conflit d'intérêts et expliquez pourquoi ce kit en présente un. (3 pts)
2. Proposez cinq critères pour évaluer la qualité d'un outil pédagogique en nutrition. (5 pts)
3. Indiquez où trouver des outils pédagogiques validés et sans lien commercial. (2 pts)
4. Rédigez la réponse à la directrice en 4 lignes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.6 – Construire la carte des partenaires d'un projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service développement durable d'une communauté de communes rurale (structure fictive) qui porte un projet alimentaire territorial. Le projet veut augmenter la part de produits locaux dans les 6 cantines du territoire et créer des ateliers cuisine pour les familles. Vous devez identifier les partenaires et leur rôle.

Document 1 – Acteurs rencontrés

Élus de la communauté de communes ; cuisinières des 6 cantines ; parents d'élèves ; chambre d'agriculture ; 12 maraîchers et éleveurs ; DRAAF ; ARS (délégation départementale) ; enseignants ; centre social ; épicerie sociale ; association de jardiniers ; supermarché du bourg.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les acteurs dans une matrice « pouvoir de décision / intérêt pour le projet » (quatre cases) ; indiquez la stratégie d'implication pour chaque case. (6 pts)
2. Précisez le rôle attendu de la DRAAF, de l'ARS et de la chambre d'agriculture. (3 pts)
3. Proposez une instance de pilotage et sa composition. (3 pts)
4. Montrez que le projet est intersectoriel et qu'il s'inscrit dans l'approche « Une seule santé ». (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 5.1

Ligne 1 : 1 OMS ; 2 FAO ; 3 EFSA ; 4 Commission européenne. Ligne 2 : 5 Ministère chargé de la santé (DGS) ; 6 Santé publique France ; 7 ANSES ; 8 HAS ; 9 HCSP ; 10 Ministère chargé de l'agriculture (DGAL). Ligne 3 : 11 ARS ; 12 Conseil régional ; 13 DRAAF ; 14 ORS ; 15 Promotion Santé (ex-IREPS). Ligne 4 : 16 Conseil départemental (PMI) ; 17 Communes et CCAS ; 18 Éducation nationale ; 19 CPTS, maisons de santé ; 20 Associations. L'ordre des cases d'une même ligne n'est pas exigé si les acteurs sont justes.

Corrigé – Exercice 5.2

a) ANSES. b) Santé publique France. c) HAS (avec la FFN pour la dénutrition de la personne âgée, 2021). d) HCSP (avis de 2020 sur les repères des enfants). e) CNA. f) DGCCRF. g) EFSA. h) ARS. i) DRAAF (ministère chargé de l'agriculture). j) DGAL (ministère chargé de l'agriculture).

Corrigé – Exercice 5.3

1. a) ESTEBAN, Santé publique France (2014-2016 : 17 % d'obésité chez les 18-74 ans). b) INCA 3, ANSES (2014-2015). c) Insee (taux de pauvreté, données locales). d) CépiDc de l'Inserm (causes médicales de décès). e) Enquêtes de santé scolaire, Drees. f) Table Ciqual, ANSES. g) ORS (portraits de territoire) ou diagnostic du contrat local de santé. h) Géodes, Santé publique France.
2. ESTEBAN fournit les dernières données de corpulence mesurée (et non déclarée) en population générale. L'enquête Albane, lancée en 2025 par Santé publique France et l'ANSES, associera régulièrement questionnaires, mesures et examens : elle remplacera ESTEBAN et INCA pour suivre l'état nutritionnel.
3. Citer l'organisme, le titre de l'étude et l'année de recueil ; vérifier que c'est la donnée la plus récente ; distinguer donnée mesurée et déclarée ; préciser le champ (âge, territoire).

Corrigé – Exercice 5.4

1. Total = 5 000 + 3 000 + 2 500 + 1 400 + 500 = 12 400 € : le plan est équilibré. Parts (montant / 12 400 × 100) : ARS 40,3 % ; commune 24,2 % ; CAF 20,2 % ; DREETS 11,3 % ; fonds propres 4,0 %.
2. ARS : finance la prévention et la promotion de la santé (fonds d'intervention régional), en lien avec le projet régional de santé. Commune : porteuse du contrat local de santé et de l'action sociale (CCAS). CAF : finance les centres sociaux et le soutien aux familles. DREETS : programme « Mieux manger pour tous » (aide alimentaire de qualité). Fonds propres : montrent l'engagement du porteur.
3. Bilan d'activité (actions réalisées, participants), bilan d'évaluation (indicateurs de résultats), bilan financier (dépenses réelles justifiées), supports produits, perspectives.

Corrigé – Exercice 5.5

1. Un conflit d'intérêts existe quand un intérêt secondaire (ici commercial : vendre des produits laitiers sucrés) peut influencer un objectif principal (l'éducation des enfants). Le kit fait la promotion de la marque et risque de présenter ses produits comme indispensables au petit-déjeuner.
2. Critères : auteur identifié et indépendant, sans lien commercial ; contenu exact et à jour (repères du PNNS) ; adapté à l'âge et à la culture du public ; démarche participative, non culpabilisante ; objectifs pédagogiques explicites ; évalué ou testé ; absence de marque et de publicité.
3. Pédagothèques et centres de ressources des structures régionales Promotion Santé, outils de Santé publique France (mangerbouger.fr), outils de l'Éducation nationale (Éduscol).
4. « Ce kit est fourni par une entreprise qui vend les produits présentés : il présente un conflit d'intérêts et ne doit pas être utilisé, en particulier les échantillons. Je vous propose des outils indépendants des pédagothèques de Promotion Santé et de Santé publique France, que je peux adapter avec les

enseignants. »

Corrigé – Exercice 5.6

1. Matrice : pouvoir fort et intérêt fort (élus, DRAAF financeur du PAT) : associer étroitement, co-décider. Pouvoir fort et intérêt plus faible (ARS, supermarché du bourg) : tenir informés, solliciter sur des points précis. Pouvoir faible et intérêt fort (cuisinières, parents, maraîchers et éleveurs, centre social, épicerie sociale, association de jardiniers, enseignants) : faire participer aux groupes de travail. Pouvoir faible et intérêt faible : informer régulièrement. Le classement se discute ; l'important est de le justifier.

2. DRAAF : reconnaissance du PAT et financements du programme national pour l'alimentation. ARS : volet santé (financement d'ateliers, lien avec le contrat local de santé). Chambre d'agriculture : mise en relation avec les producteurs, structuration de l'offre locale.

3. Comité de pilotage présidé par l'élu référent : élus, DRAAF, ARS, chambre d'agriculture, représentant des cuisinières, représentant des parents, producteurs, centre social ; réunion 2 fois par an ; groupes de travail thématiques.

4. Intersectoriel : agriculture, éducation, santé, social, économie locale, environnement. « Une seule santé » : santé humaine (qualité des repas), santé des écosystèmes (produits de saison, circuits courts, moins de transport, agriculture durable), santé animale (conditions d'élevage des éleveurs locaux).

Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir une politique publique et distinguer loi, règlement, stratégie, plan et financement.
- Décrire les étapes d'une politique publique, de la mise à l'agenda à l'évaluation.
- Expliquer l'architecture SNS, PRS (COS, SRS, PRAPS), CLS, et situer le PAT et le contrat de ville.
- Relier une action locale aux politiques nationales et régionales ; répondre à un appel à projets.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Stratégie nationale de santé (article L. 1411-1-1 du code de la santé publique) : dernière adoptée 2018-2022 ; projet 2023-2033 non adopté en mai 2026.
- Projet régional de santé (article L. 1434-1) élaboré par l'ARS : cadre d'orientation stratégique sur 10 ans, schéma régional de santé sur 5 ans, PRAPS (programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis).
- Contrat local de santé (article L. 1434-10) : contrat entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants.
- Projet alimentaire territorial : loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 ; reconnu par le ministère chargé de l'agriculture.
- Étapes : mise à l'agenda, élaboration, décision, mise en œuvre, pilotage et suivi, évaluation.

Exercice 6.1 – Légender l'architecture de la politique régionale de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la partie « contexte » de votre dossier E5 et voulez montrer au jury comment votre action locale s'inscrit dans la politique de santé.

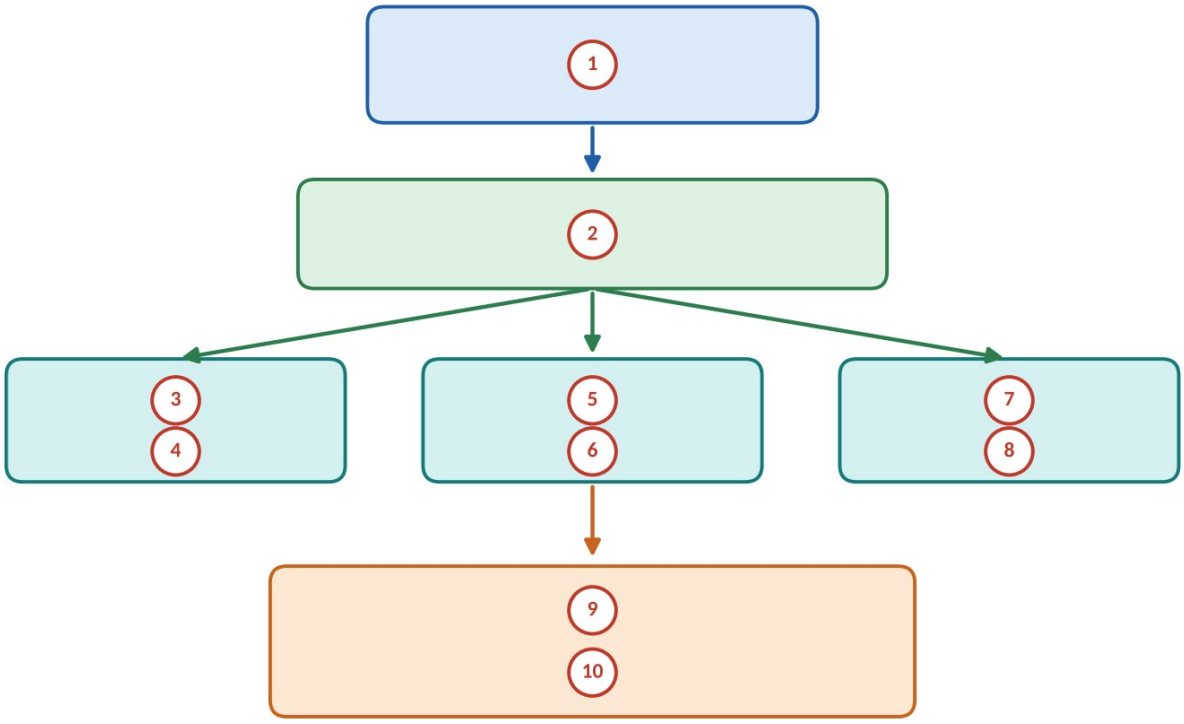


Figure 6.1 – Document 1 – De la stratégie nationale au contrat local de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (5 pts)

2. Expliquez le rôle du PRAPS pour un projet auprès de personnes en situation de précarité. (2 pts)

3. Indiquez où trouver le PRS de votre région et le contrat local de santé de votre lieu de stage. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.2 – Reconnaître les outils d'une politique publique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix textes et dispositifs

a) Loi EGalim du 30 octobre 2018. b) Arrêté du 14 mars 2025 sur le Nutri-Score. c) Projet de stratégie nationale de santé 2023-2033. d) PNNS 5 (2026-2030). e) Fonds d'intervention régional des ARS. f) SNANC 2025-2030. g) Décret du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas scolaires. h) Loi Climat et résilience du 22 août 2021. i) Programme « Mieux manger pour tous ». j) PNA 4 (2026-2030).

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque élément : loi, règlement (décret ou arrêté), stratégie, plan ou programme, financement. (10 × 1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.3 – Les étapes d'une politique publique : l'exemple du PNNS 5 (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Événements dans le désordre

a) Le HCSP publie en juin 2025 ses recommandations pour le futur programme. b) Les ARS financent en région des actions qui déclinent le programme. c) Les données de surveillance montrent depuis les années 1990 une hausse du surpoids des enfants et un fort gradient social. d) Le programme est présenté le 8 avril 2026. e) Un comité de suivi examine chaque année des indicateurs (part des produits affichant le Nutri-Score, allaitement à la naissance). f) Une évaluation indépendante du programme préparera le PNNS suivant. g) Le PNNS 4 (2019-2023) est évalué, et une concertation réunit ARS, associations et chercheurs.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les événements dans l'ordre des étapes d'une politique publique, en nommant chaque étape. (7 pts)
2. Citez trois instances capables d'évaluer une politique de santé. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'évaluation est le début du cycle suivant. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.4 – Analyser une fiche-action de contrat local de santé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice coordonne le contrat local de santé d'une intercommunalité (structure fictive). Elle vous demande de relire une fiche-action avant le comité de pilotage.

Document 1 – Fiche-action n° 4 « Bien manger à tout âge » (extrait)

Constat : « Les habitants mangent mal. » Objectif : « Sensibiliser la population à l'alimentation. » Actions : conférences dans les mairies ; distribution de dépliants ; un stand au forum des associations. Porteur : à définir. Partenaires : tous. Budget : à voir. Indicateurs : « nombre de personnes sensibilisées ». Calendrier : 2025-2028.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre faiblesses de la fiche-action. (4 pts)
2. Réécrivez le constat et l'objectif à partir de données de diagnostic que vous inventerez de façon réaliste (en les signalant comme fictives). (4 pts)
3. Proposez trois indicateurs (processus, résultat, satisfaction) avec une valeur cible. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.5 – Relier une action locale aux politiques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans une PMI d'un département (structure fictive), vous animez des ateliers « premiers repas de bébé » pour des parents en situation de précarité.

À vous de jouer – Questions

1. Reliez cette action à chacun des niveaux suivants, en citant un texte ou un dispositif précis : international, national (stratégie), national (programme), régional, local. (6 pts)
2. Rédigez la phrase d'inscription du projet dans les politiques, telle qu'elle figurera dans votre dossier. (3 pts)
3. Indiquez les sources que le jury attend pour ces références et la vérification à faire avant de les citer. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.6 – Répondre à un appel à projets de l'ARS (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide à domicile (structure fictive) veut répondre à l'appel à projets « Prévention et promotion de la santé » de l'ARS pour prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'elle accompagne. Elle suit 420 personnes de 75 ans et plus ; un repérage fait par les aides à domicile a montré que 63 d'entre elles ont perdu du poids récemment selon leurs proches.

Document 1 – Budget prévisionnel envisagé

Formation des 30 aides à domicile au repérage (2 sessions × 650 €) ; ateliers « repas plaisir » en petits groupes (12 ateliers × 180 €) ; balances pour le suivi du poids (15 × 40 €) ; livret pour les aidants (420 exemplaires × 1,50 €) ; coordination par une diététicienne (60 heures × 35 €).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des personnes repérées et indiquez la limite de ce repérage. (2 pts)
2. Calculez le budget total et la part de chaque poste. (4 pts)
3. Montrez l'inscription du projet dans les politiques en vigueur (PNNS 5, PRS, recommandations de la HAS). (3 pts)
4. Formulez l'objectif général et deux objectifs spécifiques. (4 pts)
5. Indiquez les engagements éthiques du projet (consentement, données de poids, non-stigmatisation). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 6.1

1. Légendes : 1 Stratégie nationale de santé ; 2 Projet régional de santé (élaboré par l'ARS) ; 3 Cadre d'orientation stratégique ; 4 10 ans ; 5 Schéma régional de santé ; 6 5 ans ; 7 PRAPS (plus démunis) ; 8 5 ans ; 9 Contrat local de santé ; 10 ARS + collectivité (article L. 1434-10 du CSP).
2. Le PRAPS fixe les actions régionales pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies : un projet auprès d'un public précaire peut s'y référer pour justifier sa priorité et demander un financement.
3. PRS : site internet de l'ARS de la région (rubrique « Projet régional de santé »). CLS : site de l'ARS ou de la collectivité, ou demande auprès du coordinateur du CLS ; vérifier les dates de validité.

Corrigé – Exercice 6.2

Loi : a, h. Règlement : b (arrêté), g (décret). Stratégie : c (encore à l'état de projet en mai 2026), f. Plan ou programme : d, j. Financement : e, i (programme de financement de l'aide alimentaire).

Corrigé – Exercice 6.3

1. Ordre : c) mise à l'agenda (des données font du problème un problème public) ; g) puis a) élaboration (évaluation du programme précédent, concertation, expertise du HCSP) ; d) décision et adoption ; b) mise en œuvre ; e) pilotage et suivi ; f) évaluation.
2. HCSP, IGAS, Cour des comptes (et des équipes de recherche indépendantes).
3. L'évaluation mesure ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné ; ses conclusions servent de diagnostic pour le programme suivant : c'est un cycle d'amélioration continue.

Corrigé – Exercice 6.4

1. Faiblesses : constat vague et jugeant, sans donnée chiffrée ni source ; objectif non mesurable et sans échéance ; actions uniquement informatives (conférences, dépliants), peu efficaces seules ; porteur, partenaires et budget non définis ; indicateur imprécis ; aucun public prioritaire.
2. Exemple (données fictives) : constat : « Dans l'intercommunalité, 19 % des élèves de CM2 sont en surpoids (contre 15 % dans le département, santé scolaire 2025) et 42 % des seniors de plus de 75 ans vivent seuls (Insee). » Objectif : « D'ici fin 2028, faire participer 300 familles et 150 seniors des communes prioritaires à au moins 3 ateliers d'éducation alimentaire et améliorer de 20 % la part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 4 fois par semaine. »
3. Processus : nombre d'ateliers réalisés (cible : 40 sur 4 ans). Résultat : part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 4 fois par semaine (cible : + 20 %). Satisfaction : part des participants satisfaits ou très satisfaits (cible : 80 %).

Corrigé – Exercice 6.5

1. International : recommandation de l'OMS d'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. National, stratégie : SNANC 2025-2030 (accès de tous à une alimentation plus saine) (la SNS 2023-2033 n'est encore qu'un projet). National, programme : PNNS 5 (2026-2030), actions sur les « 1000 premiers jours » et l'allaitement ; programme « 1000 premiers jours » lancé en 2020. Régional : PRS de l'ARS et son PRAPS. Local : missions de PMI du conseil départemental ; contrat local de santé si la commune en a un.
2. Exemple : « Ce projet s'inscrit dans le programme des 1000 premiers jours et dans le PNNS 5 (2026-2030), qui fait des enfants et de la réduction des inégalités sociales en nutrition une priorité, ainsi que dans le PRAPS du projet régional de santé, qui vise l'accès à la prévention des personnes en situation de

précarité. »

3. Sources officielles et datées : site du ministère chargé de la santé, mangerbouger.fr, site de l'ARS, Légifrance. Vérifier que le texte est en vigueur à la date de l'épreuve, citer son titre exact et sa date, éviter les synthèses non officielles pour les chiffres.

Corrigé – Exercice 6.6

1. Part repérée = 63 / 420 × 100 = 15,0 %. Limite : perte de poids rapportée par les proches, sans pesée ni critère validé ; il faut un repérage selon les critères de la HAS (2021) et une orientation vers le médecin traitant pour le diagnostic.

2. Formation : 2 × 650 = 1 300 € ; ateliers : 12 × 180 = 2 160 € ; balances : 15 × 40 = 600 € ; livret : 420 × 1,50 = 630 € ; coordination : 60 × 35 = 2 100 €. Total = 1 300 + 2 160 + 600 + 630 + 2 100 = 6 790 €. Parts : formation 19,1 % ; ateliers 31,8 % ; balances 8,8 % ; livret 9,3 % ; coordination 30,9 % (la somme fait 99,9 % à cause des arrondis).

3. PNNS 5 : prévention de la dénutrition des personnes âgées parmi ses mesures ; PRS : axe de prévention de la perte d'autonomie ; HAS et FFN (2021) : diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus.

4. Objectif général : prévenir la dénutrition des personnes de 75 ans et plus accompagnées par l'association. Objectifs spécifiques : d'ici 12 mois, 100 % des aides à domicile savent repérer les signes d'alerte de la dénutrition et orienter ; d'ici 12 mois, 80 % des personnes repérées ont été orientées vers leur médecin traitant et ont participé à au moins un atelier.

5. Information et consentement de la personne (et de l'aidant), pesée seulement avec accord et dans le respect de la dignité, données de poids conservées de façon confidentielle et sécurisée et transmises uniquement au médecin avec accord, messages valorisant le plaisir de manger et non culpabilisants, respect des habitudes et des choix.

Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Retracer l'histoire des politiques nutritionnelles, du PNNS 1 (2001) au PNNS 5 (2026-2030).
- Présenter la SNANC 2025-2030, le PNNS 5 et le PNA 4, et leurs liens.
- Calculer les taux EGalim d'une restauration collective ; utiliser les repères alimentaires de Santé publique France.
- Présenter le Nutri-Score et ses limites ; argumenter une diversification des protéines.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- PNNS 1 (2001-2005), PNNS 2 (2006-2010), PNNS 3 (2011-2015, prolongé jusqu'en 2018), PNNS 4 (2019-2023), PNNS 5 (2026-2030, lancé le 8 avril 2026 : 3 axes, 20 mesures).
- SNANC 2025-2030 : article 265 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 ; publiée le 11 février 2026 ; elle oriente le PNNS (ministère chargé de la santé) et le PNA (ministère chargé de l'agriculture).
- Loi EGalim (30 octobre 2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio, en valeur d'achat hors taxes ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire.
- Nutri-Score : logo facultatif de A à E, adopté par l'arrêté du 31 octobre 2017 ; nouvel algorithme rendu applicable par l'arrêté du 14 mars 2025.
- Repères adultes (Santé publique France, 2019) : augmenter (fruits et légumes, légumes secs, fruits à coque, activité physique), aller vers (féculents complets, huiles de colza, de noix, d'olive, poisson, 2 produits laitiers par jour, produits de saison), réduire (alcool, boissons sucrées, produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés, charcuterie 150 g par semaine, viande hors volaille 500 g par semaine, sel).

Exercice 7.1 – Légender la frise des politiques nutritionnelles (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

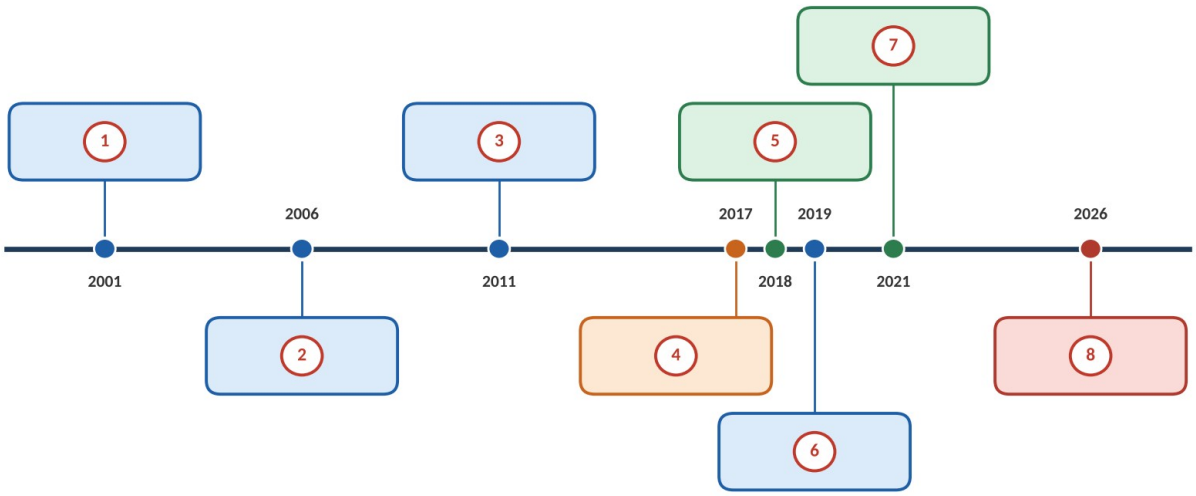


Figure 7.1 – Document 1 – Les grandes étapes des politiques nutritionnelles en France (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 8 de la frise : nom du programme ou du texte et sa date ou sa période. (8 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.2 – Présenter le PNNS 5 et la SNANC (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

En réunion d'équipe, une animatrice vous demande : « Le PNNS, la SNANC, le PNA, c'est la même chose ? Lequel il faut citer ? »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le lien entre la SNANC, le PNNS 5 et le PNA 4 (texte de référence, ministère pilote, période). (4 pts)
2. Citez les trois axes du PNNS 5. (3 pts)
3. Citez trois objectifs chiffrés annoncés pour le PNNS 5. (3 pts)
4. Indiquez la précaution à prendre avant de citer un chiffre du PNNS 5 dans votre dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.3 – Calculer les taux EGalim d'une cantine (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de restauration scolaire d'une commune (données fictives). La commune doit télédéclarer ses achats de l'année sur la plateforme « ma cantine ».

Document 1 – Achats de denrées de l'année (hors taxes)

Catégorie d'achats	Montant
Total des achats de denrées	184 000 €
dont produits issus de l'agriculture biologique	31 280 €
dont produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP, IGP), non bio	29 440 €
dont produits de la pêche avec écolabel, non bio	11 040 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de produits bio et le taux de produits durables et de qualité (le bio en fait partie). (4 pts)
2. Comparez aux obligations de la loi EGalim et calculez, à budget constant, le montant d'achats à faire basculer pour atteindre chaque seuil. (4 pts)
3. Proposez deux leviers pour atteindre les objectifs sans augmenter le prix du repas. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.4 – Utiliser les repères alimentaires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un stand de prévention dans une entreprise, un salarié de 45 ans décrit sa semaine habituelle.

Document 1 – Semaine habituelle déclarée

Charcuterie : 300 g par semaine. Viande hors volaille : 700 g par semaine. Légumes secs : jamais. Fruits et légumes : 3 portions par jour. Boissons sucrées : 2 verres par jour. Pain : uniquement blanc. Poisson : une fois par mois. Huile : tournesol uniquement. Produits laitiers : 2 par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Comparez chaque élément aux repères de Santé publique France ; calculez les dépassements de charcuterie et de viande. (6 pts)
2. Proposez trois changements prioritaires, formulés de façon positive et réaliste. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi ce conseil individuel, donné sur un stand, ne suffit pas et ce que l'entreprise peut faire de plus. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.5 – Le Nutri-Score (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier en supermarché, une participante vous dit : « Les céréales de mon fils sont notées A, donc elles ne sont pas transformées et il peut en manger autant qu'il veut. »

Document 1 – Objectifs annoncés du PNNS 5 sur le Nutri-Score

Part des Français utilisant le Nutri-Score : de 33 % à 40 %. Part du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score : de 62 % à 75 %.

À vous de jouer – Questions

1. Présentez le Nutri-Score : ce qu'il mesure, son caractère obligatoire ou non, les textes français, les changements du nouvel algorithme. (4 pts)
2. Relevez les deux erreurs de la participante et corrigez-les. (3 pts)
3. Calculez la hausse en points et en pourcentage pour chacun des deux objectifs du document 1. (3 pts)
4. Proposez une activité d'atelier pour apprendre à utiliser le Nutri-Score. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 7.6 – Argumenter une diversification des protéines (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale (structure fictive) sert 450 repas par jour dans les écoles d'une commune, 36 semaines par an. Elle sert déjà un menu végétarien par semaine. Le comité du projet alimentaire territorial propose un deuxième repas végétarien hebdomadaire, à base de légumineuses, et de réinvestir l'économie réalisée dans des produits bio locaux.

Document 1 – Données de coût (prix construits pour le sujet)

Plat carné remplacé : 70 g de viande crue par enfant, à 12,00 € le kg. Plat de légumineuses : 60 g de lentilles sèches par enfant, à 3,60 € le kg. On néglige les autres ingrédients, identiques dans les deux plats.

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les obligations de la loi EGalim et de la loi Climat et résilience sur les menus végétariens et la diversification des protéines en restauration scolaire. (3 pts)
2. Calculez le coût de la portion de viande et de la portion de lentilles, l'économie par repas, puis l'économie annuelle. (5 pts)
3. Présentez les arguments « Une seule santé » et SNANC du projet. (4 pts)
4. Indiquez les conditions de réussite nutritionnelles et d'acceptabilité qui relèvent du diététicien. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 7.1

1 PNNS 1 (2001-2005) ; 2 PNNS 2 (2006-2010) ; 3 PNNS 3 (2011-2015, prolongé) ; 4 Nutri-Score (arrêté du 31 octobre 2017) ; 5 Loi EGalim (30 octobre 2018) ; 6 PNNS 4 (2019-2023) ; 7 Loi Climat et résilience (22 août 2021) ; 8 SNANC (11 février 2026) et PNNS 5 (2026-2030).

Corrigé – Exercice 7.2

1. La SNANC 2025-2030, prévue par l'article 265 de la loi Climat et résilience et publiée le 11 février 2026, fixe les orientations de la politique de l'alimentation durable et de la nutrition. Elle est déclinée par deux programmes 2026-2030 : le PNNS 5, piloté par le ministère chargé de la santé (DGS), et le PNA 4, piloté par le ministère chargé de l'agriculture. Dans un dossier, on cite la SNANC comme cadre et le PNNS 5 (et le PNA 4 si l'action concerne l'offre ou la restauration) comme programme.
2. Axes : « garantir à tous l'accès à des environnements nutritionnels durables favorables à la santé » ; « encourager des comportements nutritionnels sains et durables » ; « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé ».
3. Objectifs annoncés : réduire de 30 % la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (20 % chez ceux de familles défavorisées) ; 85 % d'enfants allaités à la naissance ; 40 % des Français utilisant le Nutri-Score ; 75 % du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score ; 12 % de consommation de produits bio.
4. Vérifier chaque chiffre dans le texte intégral officiel (site du ministère chargé de la santé, mangerbouger.fr) et non dans une synthèse secondaire ; citer la date.

Corrigé – Exercice 7.3

1. Taux de bio = 31 280 / 184 000 × 100 = 17,0 %. Produits durables et de qualité = 31 280 + 29 440 + 11 040 = 71 760 € ; taux = 71 760 / 184 000 × 100 = 39,0 %.
2. Bio : objectif d'au moins 20 %, non atteint ; montant à atteindre = 0,20 × 184 000 = 36 800 € ; il manque 36 800 − 31 280 = 5 520 €. Durables et de qualité : objectif d'au moins 50 %, non atteint ; montant à atteindre = 0,50 × 184 000 = 92 000 € ; il manque 92 000 − 71 760 = 20 240 €.
3. Leviers : diversification des protéines (plats de légumineuses moins chers) ; réduction du gaspillage (grammages adaptés, pesée des restes) ; achat de produits bio de saison ; marchés publics allotis pour permettre aux producteurs locaux de répondre ; travail avec le projet alimentaire territorial.

Corrigé – Exercice 7.4

1. Charcuterie : 300 g pour un repère de 150 g au plus, dépassement de 300 − 150 = 150 g (le double). Viande hors volaille : 700 g pour 500 g au plus, dépassement de 700 − 500 = 200 g. Légumes secs : jamais, pour au moins 2 fois par semaine. Fruits et légumes : 3 portions pour au moins 5. Boissons sucrées : 2 verres pour au plus 1 verre par jour. Pain blanc seulement : aller vers des féculents complets au moins une fois par jour. Poisson : une fois par mois pour 2 fois par semaine, dont 1 poisson gras. Huile de tournesol : aller vers les huiles de colza, de noix et d'olive. Produits laitiers : 2 par jour, conforme.
2. Exemples : « Remplacer 2 repas de viande par semaine par un plat de lentilles ou de pois chiches » ; « Ajouter un fruit au petit-déjeuner et des crudités au déjeuner » ; « Garder une boisson sucrée pour le week-end et boire de l'eau aromatisée en semaine ».
3. Le conseil individuel touche une personne et dépend de sa volonté ; ses effets sont limités si l'environnement ne change pas. L'entreprise peut améliorer l'offre de sa restauration (plats de légumineuses, poisson, pain complet, fruits), modifier les distributeurs, mettre des fontaines à eau, aménager les pauses : c'est créer un milieu favorable.

Corrigé – Exercice 7.5

1. Le Nutri-Score classe les aliments de A (meilleure qualité nutritionnelle) à E selon leur composition pour 100 g (éléments à limiter : énergie, sucres, acides gras saturés, sel ; éléments à favoriser : fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses). Il est facultatif (le droit européen ne permet pas de l'imposer). Il a été adopté par l'arrêté du 31 octobre 2017 ; le nouvel algorithme est rendu applicable par l'arrêté du 14 mars 2025, avec 2 ans de transition : meilleur classement des huiles riches en acides gras insaturés, des poissons gras et des céréales complètes, classement plus sévère des produits salés, sucrés et des boissons édulcorées.

2. Erreur 1 : le Nutri-Score ne mesure pas le degré de transformation (c'est la classification NOVA qui le fait) ; un produit noté A peut être ultra-transformé. Erreur 2 : il compare des produits d'une même catégorie et ne dit rien de la quantité à consommer ; un aliment A ne se mange pas « autant qu'on veut ».

3. Utilisation : 40 − 33 = 7 points ; 7 / 33 × 100 = 21,2 % de hausse. Affichage : 75 − 62 = 13 points ; 13 / 62 × 100 = 21,0 % de hausse.

4. Exemple : jeu de classement de 6 paquets de céréales du petit-déjeuner par Nutri-Score, puis comparaison des listes d'ingrédients et des prix au kilo, et choix d'un petit-déjeuner complet.

Corrigé – Exercice 7.6

1. Loi EGalim (2018) : menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire, pérennisé par la loi Climat et résilience (2021) ; plan pluriannuel de diversification des protéines obligatoire au-delà de 200 couverts par jour (la cuisine centrale, avec 450 repas, est concernée).

2. Portion de viande : 0,070 × 12,00 = 0,84 €. Portion de lentilles : 0,060 × 3,60 = 0,216 €, soit 0,22 €. Économie par repas = 0,84 − 0,216 = 0,624 €, soit 0,62 €. Nombre de repas concernés par an : 450 × 36 = 16 200. Économie annuelle = 16 200 × 0,624 = 10 108,80 €.

3. Une seule santé : santé humaine (plus de fibres, apport de protéines végétales, moins d'acides gras saturés) ; santé des écosystèmes (moins d'émissions de gaz à effet de serre, légumineuses qui enrichissent le sol en azote) ; santé animale (moindre pression sur l'élevage intensif). SNANC : réduire l'impact de l'alimentation sur le climat, permettre l'accès à une alimentation plus saine, soutenir les agriculteurs (économie réinvestie dans le bio local).

4. Nutrition : équivalence protéique (associer légumineuses et céréales, compléter par un produit laitier ou un œuf), apport en fer (vitamine C dans le repas), grammages adaptés à l'âge. Acceptabilité : recettes testées avec les enfants, introduction progressive, présentation attractive, formation des cuisiniers aux cuissons des légumineuses, communication aux familles, suivi des restes pour mesurer l'acceptation.

Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer le cadre réglementaire de la profession (article L. 4371-1 du code de la santé publique) et ses missions en santé publique.
- Adopter une posture professionnelle éthique : non-stigmatisation, secret professionnel, RGPD, conflits d'intérêts.
- Décrire les étapes de la démarche de projet et rédiger des objectifs mesurables.
- Mobiliser toutes les notions du chapitre dans un cas complet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Article L. 4371-1 du CSP : le diététicien dispense des conseils nutritionnels, participe sur prescription médicale à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients, contribue à la qualité de l'alimentation en collectivité et aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
- Le titre de diététicien est protégé (enregistrement au RPPS) ; le terme « nutritionniste » ne l'est pas.
- Démarche de projet : analyse et diagnostic, priorités et objectifs, plan d'action et moyens, communication, mise en œuvre, évaluation, valorisation et ajustements ; au centre : éthique, déontologie et participation.
- Besoins selon Bradshaw : normatif (défini par l'expert), ressenti (perçu par la personne), exprimé (ressenti devenu demande), comparatif (comparaison avec un groupe semblable).

Exercice 8.1 – Légender la démarche de projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

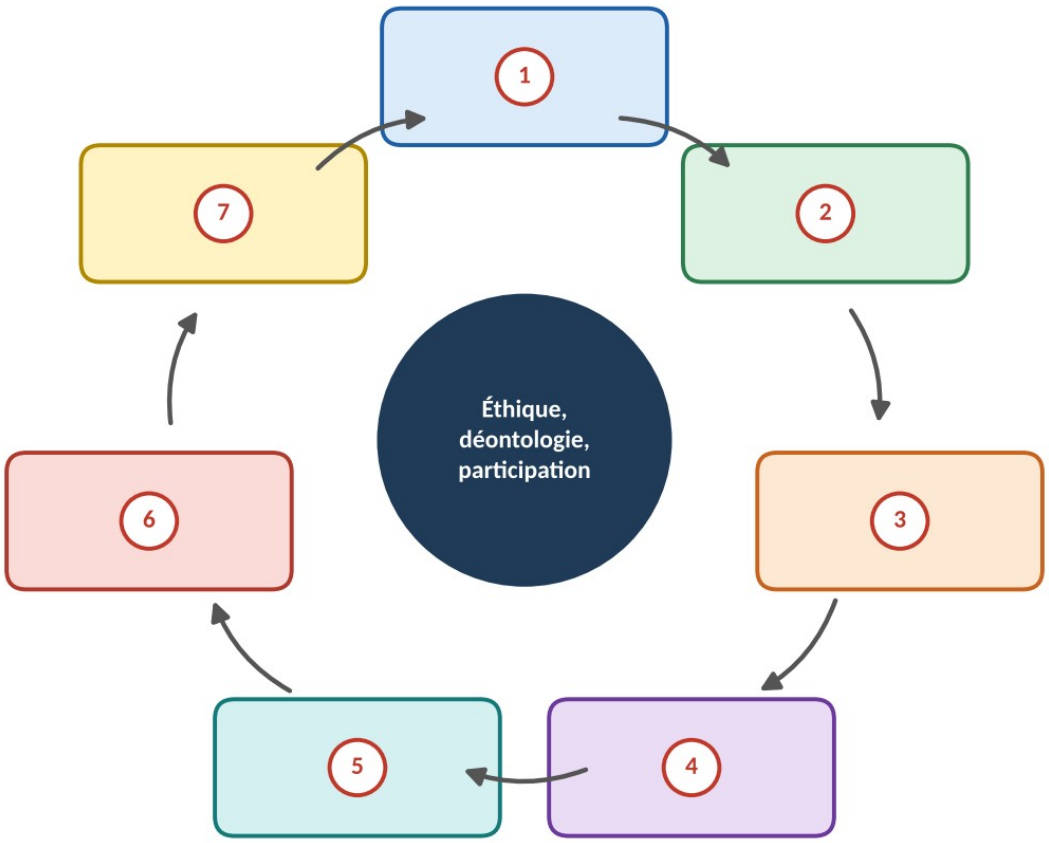


Figure 8.1 – Document 1 – La démarche de projet en santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Associez à chaque étape un outil ou un document que vous produisez pendant le stage. (3,5 pts)
3. Expliquez pourquoi la démarche est représentée comme un cycle et ce que contient le disque central. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.2 – Le cadre réglementaire de la profession (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu vous demande pourquoi la commune devrait recruter une diététicienne plutôt qu'un « coach en nutrition » pour son projet de santé publique.

À vous de jouer – Questions

1. Citez les quatre champs d'exercice du diététicien définis par l'article L. 4371-1 du CSP. (4 pts)

2. Expliquez la différence entre « diététicien » et « nutritionniste » et le rôle du RPPS. (3 pts)

3. Citez trois employeurs possibles d'un diététicien en santé publique et une mission pour chacun. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.3 – Posture et déontologie en situation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Six situations de stage

a) À la fin d'un atelier, une participante vous demande de lui écrire un régime pour son diabète.

b) Votre tutrice veut publier sur le site de la structure les photos de l'atelier, où l'on voit les visages des enfants.

c) Une marque de compotes propose de financer les ingrédients des ateliers en échange de son logo sur les affiches.

d) Une animatrice dit devant le groupe : « Avec ton poids, tu devrais éviter le fromage. »

e) Vous recevez par courriel la liste des familles inscrites avec leurs revenus et leurs problèmes de santé.

f) Un participant ne mange pas de porc et n'ose pas le dire.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, identifiez le principe éthique ou réglementaire en jeu et indiquez la conduite à tenir. (12 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.4 – Rédiger des objectifs mesurables (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Objectifs proposés par un stagiaire

a) « Faire prendre conscience aux familles de l'importance de bien manger. »

b) « Améliorer la santé des enfants. »

c) « Organiser des ateliers. »

d) « Que les gens mangent plus de légumes. »

e) « Diminuer l'obésité dans le quartier de 50 % en 3 mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez ce que signifie un objectif SMART. (2 pts)
2. Pour chaque objectif, indiquez son défaut et réécrivez-le de façon mesurable, en précisant s'il s'agit d'un objectif général, spécifique ou opérationnel. (10 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.5 – Classer les besoins selon Bradshaw (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous menez le diagnostic d'un projet dans une épicerie sociale (structure fictive). Vous avez noté les informations ci-dessous.

Document 1 – Informations recueillies

a) 12 bénéficiaires ont demandé à la responsable des recettes avec les produits de l'épicerie. b) Selon les repères de Santé publique France, il faut consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine ; seuls 3 bénéficiaires interrogés sur 20 le font. c) Plusieurs bénéficiaires disent se sentir fatigués et « mal manger », sans rien demander. d) L'épicerie sociale de la commune voisine propose des ateliers cuisine depuis 3 ans ; celle-ci n'en propose pas. e) Une bénévole pense que « les gens ne savent pas cuisiner ».

À vous de jouer – Questions

1. Définissez les quatre types de besoins de Bradshaw. (4 pts)
2. Classez les informations a à d. (4 pts)
3. Indiquez comment traiter l'information e dans le diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 8.6 – Cas de synthèse : la santé alimentaire des étudiants d'un campus (30 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 30*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au service de santé étudiante d'une université (structure fictive) qui accueille 14 000 étudiants sur un campus en périphérie d'une ville moyenne. Le restaurant universitaire du CROUS est ouvert le midi en semaine. La direction du service vous confie un projet sur l'alimentation des étudiants, à mener avec l'association étudiante et le CROUS.

Document 1 – Enquête en ligne du service de santé étudiante (données fictives, mars 2026, 640 répondants)

Item	Nombre de « oui »
A sauté au moins un repas par manque d'argent au cours du dernier mois	243
Mange moins de 3 portions de fruits et légumes par jour	371
N'a pas de cuisine équipée dans son logement	154
Souhaite des ateliers « cuisine étudiante »	422

Document 2 – Moyens disponibles

Budget de 3 000 € sur l'année universitaire ; salle avec cuisine pédagogique à la maison des étudiants (8 postes) ; épicerie solidaire étudiante gérée par l'association ; réseaux sociaux de l'université et de l'association ; un diététicien du service à mi-temps.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les indicateurs de l'enquête et commentez la représentativité (taux de réponse, mode de recueil). (4 pts)
2. Qualifiez l'action (mode d'intervention, niveau de prévention, type selon Gordon) et classez les besoins selon Bradshaw. (4 pts)
3. Identifiez les déterminants en jeu en vous appuyant sur le modèle biopsychosocial. (3 pts)
4. Citez les acteurs et partenaires à mobiliser, du national au local, et la politique dans laquelle s'inscrit le projet. (4 pts)
5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels. (4 pts)
6. Proposez un plan d'action avec un budget détaillé qui respecte les 3 000 €. (4 pts)
7. Construisez l'évaluation et le plan de communication (précarité numérique, réseaux sociaux, e-réputation). (4 pts)
8. Indiquez trois points de vigilance éthique. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 8.1

1. Légendes : 1 Analyse et diagnostic de situation ; 2 Priorités et objectifs ; 3 Plan d'action et moyens ; 4 Plan de communication ; 5 Mise en œuvre ; 6 Évaluation ; 7 Valorisation et ajustements.
2. Exemples : diagnostic (fiche de diagnostic, arbre à problèmes) ; objectifs (arbre à objectifs, objectifs SMART) ; plan d'action (fiche projet, diagramme de Gantt, budget) ; communication (plan de communication, affiches) ; mise en œuvre (conducteur de séance, fiche technique, grille de dégustation) ; évaluation (questionnaire, tableau de bord) ; valorisation (bilan, tableau de veille, auto-évaluation).
3. L'évaluation produit des résultats qui alimentent un nouveau diagnostic et l'amélioration du projet : c'est un cycle. Au centre, l'éthique, la déontologie et la participation des personnes concernées s'appliquent à toutes les étapes.

Corrigé – Exercice 8.2

1. Dispenser des conseils nutritionnels ; participer, sur prescription médicale, à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients (bilan diététique, éducation diététique) ; contribuer à la qualité de l'alimentation servie en collectivité ; participer aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
2. Le titre de diététicien est protégé : il est réservé aux titulaires des diplômes reconnus (BTS Diététique et nutrition, BUT Génie biologique parcours diététique et nutrition, ou autorisation d'exercice), enregistrés au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), ce qui permet de vérifier leur qualification. « Nutritionniste » n'est pas un titre protégé : n'importe qui peut l'utiliser. C'est une garantie de compétence et de respect des règles professionnelles pour la commune.
3. Exemples : commune ou CCAS (coordination du volet nutrition d'un contrat local de santé) ; conseil départemental (ateliers des 1000 premiers jours en PMI) ; mutuelle ou entreprise (programme de prévention pour les salariés).

Corrigé – Exercice 8.3

a) Limite de compétence et cadre de l'atelier : on ne prescrit pas de régime en atelier collectif ; on oriente vers le médecin traitant et une consultation diététique. b) Droit à l'image et RGPD : autorisation écrite des parents, possibilité de refuser, à défaut photos sans visage. c) Conflit d'intérêts : refuser la présence de la marque sur les supports ; chercher des financements publics ou des dons sans contrepartie publicitaire. d) Non-stigmatisation et respect : reprendre l'animatrice en privé, rappeler qu'on ne commente jamais le poids d'une personne en public. e) Confidentialité et minimisation des données : ces données sont excessives pour un atelier ; ne pas les diffuser, demander à les supprimer, conserver seulement ce qui est nécessaire. f) Respect des cultures et des choix : prévoir des alternatives dans les recettes et demander les habitudes alimentaires de façon discrète à l'inscription.

Corrigé – Exercice 8.4

1. SMART : spécifique, mesurable, atteignable (ambitieux mais réaliste), réaliste (pertinent au regard des moyens), temporellement défini.
2. a) Vague, non mesurable. Objectif spécifique : « D'ici 6 mois, 70 % des familles ayant participé à au moins 3 ateliers citent deux repères du PNNS et une recette qu'elles ont refaite. » b) Trop large : c'est un objectif général, à préciser : « Contribuer à améliorer l'alimentation des enfants de 3 à 6 ans des familles du centre social. » c) C'est une activité, pas un objectif : objectif opérationnel : « Animer 6 ateliers de 2 heures pour 10 familles entre janvier et juin. » d) Non mesurable, sans public ni échéance : « D'ici fin juin, faire passer de 25 % à 40 % la part des familles participantes qui servent des légumes au moins une fois par jour. » e) Irréaliste (durée trop courte, ampleur excessive, un projet local ne mesure pas la prévalence

d'un quartier) : reformuler sur des comportements à court terme et laisser la prévalence à un objectif général de long terme.

Corrigé – Exercice 8.5

1. Normatif : défini par un expert à partir d'une norme. Ressenti : perçu par la personne, pas forcément exprimé. Exprimé : besoin ressenti transformé en demande. Comparatif : déduit de la comparaison avec un groupe semblable qui bénéficie d'un service.

2. a) Exprimé. b) Normatif (3 / 20 × 100 = 15,0 % suivent le repère). c) Ressenti. d) Comparatif.

3. C'est une représentation d'un professionnel ou d'un bénévole, pas un besoin du public : elle doit être vérifiée auprès des bénéficiaires (entretiens, questionnaire) et ne doit pas orienter seule le projet, au risque d'un jugement stigmatisant.

Corrigé – Exercice 8.6

1. Indicateurs (nombre / 640 × 100) : repas sautés par manque d'argent 243 / 640 = 38,0 % ; moins de 3 portions de fruits et légumes 371 / 640 = 58,0 % ; pas de cuisine équipée 154 / 640 = 24,1 % ; souhait d'ateliers 422 / 640 = 65,9 %. Taux de réponse = 640 / 14 000 × 100 = 4,6 % : très faible ; enquête en ligne avec réponses volontaires, donc les étudiants intéressés par le sujet ont pu répondre davantage et ceux sans connexion fiable moins. Les résultats sont une première indication, pas une mesure représentative.

2. Promotion de la santé (accès, milieux de vie) et éducation pour la santé (compétences culinaires) ; prévention primaire ; type sélectif pour les étudiants en précarité, universel pour l'offre ouverte à tous (universalisme proportionné). Besoins : normatif (moins de 3 portions de fruits et légumes pour un repère d'au moins 5) ; exprimé (65,9 % demandent des ateliers) ; ressenti (faim, fatigue, stress) ; comparatif (offre d'autres campus, données nationales de précarité étudiante).

3. Biologique : jeunes adultes, besoins énergétiques élevés. Psychologique : stress des examens, isolement, perte des repères familiaux. Social : budget limité, logement sans cuisine (24,1 %), campus en périphérie, horaires des cours, offre du restaurant universitaire limitée au midi en semaine.

4. National : ministère chargé de l'enseignement supérieur, CROUS (restauration et action sociale), PNNS 5 (axe 3 : « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé », dont l'enseignement supérieur) et SNANC. Régional : ARS (prévention, appels à projets). Local : université et service de santé étudiante, association étudiante et épicerie solidaire, CROUS local, commune, banques alimentaires. Le projet s'inscrit dans l'axe 3 du PNNS 5, qui mobilise les établissements d'enseignement supérieur comme promoteurs de santé.

5. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et à réduire l'insécurité alimentaire des étudiants du campus. Objectifs spécifiques : d'ici juin, 70 % des étudiants ayant suivi au moins 2 ateliers savent préparer 3 repas complets à moins de 2 € ; d'ici juin, 90 % des étudiants qui déclarent sauter des repas faute d'argent et qui consultent le service sont orientés vers l'épicerie solidaire ou une aide du CROUS. Objectifs opérationnels : animer 8 ateliers « cuisine étudiante » de 10 places ; organiser 2 marchés de produits frais à prix solidaire ; former 4 étudiants relais à l'orientation vers les aides.

6. Budget : 8 ateliers × 120 € = 960 € ; 2 marchés × 300 € (paniers de produits frais subventionnés) = 600 € ; communication 350 € ; formation des étudiants relais 2 × 400 € = 800 € ; évaluation 150 € ; total = 960 + 600 + 350 + 800 + 150 = 2 860 €, soit une réserve de 3 000 − 2 860 = 140 €.

7. Évaluation : processus (nombre d'ateliers et de participants, paniers distribués) ; résultats (compétences déclarées avant-après, orientations réalisées, repas sautés déclarés dans une nouvelle enquête) ; satisfaction. Communication : réseaux sociaux de l'association (canal principal des étudiants), affiches au restaurant universitaire et à la bibliothèque, relais des étudiants formés, information orale en amphithéâtre ; prise en compte de la précarité numérique (forfaits limités, absence d'ordinateur) par des supports papier et des inscriptions sur place ; e-réputation : pas de photo d'étudiant identifiable associée à la précarité, accord écrit, modération des commentaires.

8. Non-stigmatisation des étudiants en précarité (ateliers ouverts à tous) ; confidentialité des informations

sociales et de santé (RGPD, accès limité au service) ; absence de lien commercial avec des marques ; participation des étudiants à la conception du projet.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la santé (OMS, Ottawa, Huber) et distinguer les modèles de santé	1.1 à 1.6			
2	Définir la santé publique, ses missions ; calculer le paradoxe de Rose, une prévalence, une incidence	2.1 à 2.6			
3	Distinguer danger, exposition, risque, facteurs de risque et de protection ; calculer un risque ; hiérarchiser des problèmes	3.1 à 3.6			
4	Qualifier une action (mode, OMS, Gordon) ; utiliser la Charte d'Ottawa ; appliquer l'universalisme proportionné	4.1 à 4.6			
5	Situer les acteurs ; trouver une source de données ; construire un plan de financement ; repérer un conflit d'intérêts	5.1 à 5.6			
6	Expliquer SNS, PRS, CLS ; relier une action locale aux politiques ; répondre à un appel à projets	6.1 à 6.6			
7	Présenter PNNS 5, SNANC, PNA 4 ; calculer des taux EGalim ; utiliser les repères et le Nutri-Score	7.1 à 7.6			
8	Adopter une posture éthique ; rédiger des objectifs SMART ; classer les besoins ; traiter un cas complet	8.1 à 8.6			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique | Promotion de la santé | Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 1 206
Mode d'emploi du cahier d'annales 206
Ce que le jury attend sur ce chapitre 206
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 207
S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale 207
S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants 210
S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier 213
Partie II – Les corrigés détaillés 215
Corrigé S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale 215
Corrigé S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants 221
Corrigé S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier 226
Grille d'auto-évaluation 230

Cahier d'annales E5 – chapitre 1

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent donc la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des territoires sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales, elles, sont réelles et datées.

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 1 donne le cadre de toute l'épreuve : définir la santé et la santé publique, distinguer prévention, promotion et éducation pour la santé, situer son action dans les politiques en vigueur (PNNS 5 2026-2030, SNANC, projet régional de santé, contrat local de santé) et nommer les acteurs. Le jury vérifie que le candidat qualifie correctement son action (mode d'intervention, niveau de prévention, approche populationnelle ou individuelle), qu'il part d'un diagnostic chiffré et sourcé, qu'il formule des objectifs hiérarchisés et mesurables, et qu'il évalue ce qu'il fait. Il vérifie aussi l'éthique : non-stigmatisation, consentement, confidentialité, sécurité des données.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner les chiffres, le public, les contraintes (budget, durée, matériel, nombre de participants) et le verbe de chaque consigne. Pendant : une idée par paragraphe ; chaque objectif avec un indicateur, une valeur cible et une échéance ; chaque calcul posé (formule, application numérique, résultat avec unité). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage de santé publique de 2e année, pendant six semaines, à la Mission locale du Val d'Arvel (structure fictive), qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire vers l'emploi, la formation, le logement et la santé. Votre tutrice est la conseillère référente santé de la structure. Le directeur vous confie une demande : « Beaucoup de jeunes arrivent le ventre vide aux ateliers du matin, certains font des malaises, d'autres nous disent qu'ils sautent des repas pour payer leur forfait téléphone. On voudrait faire quelque chose sur l'alimentation, mais sans faire la morale. » Vous devez concevoir le projet, en réaliser une partie pendant votre stage, et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure et ses moyens

La mission locale suit 1 350 jeunes par an sur une communauté de communes semi-rurale de 41 000 habitants (deux bourgs et 23 villages). Elle accueille chaque matin un groupe de 10 à 14 jeunes en « contrat d'engagement jeune » (CEJ, dispositif national en vigueur depuis le 1er mars 2022, 15 à 20 heures d'activités par semaine, allocation versée sous conditions de ressources). Locaux : une salle de réunion, un espace détente avec réfrigérateur, bouilloire et four à micro-ondes, aucun équipement de cuisson. À 300 m, le centre social dispose d'une cuisine pédagogique (2 plaques à induction, 1 four, 8 postes de travail) prêtable le mercredi après-midi. Budget accordé par la communauté de communes au titre du contrat local de santé : 1 800 € pour six mois, matériel compris. Personnes ressources : conseillère référente santé, deux conseillers emploi, animatrice du centre social, bénévoles de l'épicerie sociale. Minibus de 9 places disponible le mardi.

Document 2 – Portrait du territoire (données fictives construites pour le sujet)

Indicateur	Communauté de communes	Département	Source fictive, année
Part des 15-24 ans ni en emploi, ni en études, ni en formation	17 %	13 %	Observatoire régional, 2024
Taux de pauvreté des moins de 30 ans	24 %	19 %	Observatoire régional, 2023
Supermarchés à moins de 10 min à pied d'un arrêt de bus	2	–	Diagnostic du CLS, 2025
Fréquence des bus vers le bourg principal	4 allers-retours par jour	–	Diagnostic du CLS, 2025
Jeunes de 16-25 ans sans permis de conduire parmi les jeunes suivis	58 %	–	Mission locale, 2025

Le contrat local de santé (CLS) 2024-2028 de la communauté de communes, signé avec l'agence régionale de santé, comprend un axe « Alimentation, précarité et santé des jeunes ».

Document 3 – Enquête flash réalisée par la mission locale (données fictives)

Questionnaire anonyme sur papier, rempli en salle d'attente pendant deux semaines de mars 2026 par 212 jeunes, sur les 1 350 suivis.

Question (sur les 7 derniers jours ou le dernier mois)	Nombre de « oui » (n = 212)
A sauté le petit-déjeuner au moins 4 jours sur 7	97
A mangé des fruits ou des légumes chaque jour	53
A bu une boisson sucrée ou énergisante chaque jour	89
A renoncé à au moins un repas faute d'argent au cours du dernier mois	74
N'a pas de quoi cuisiner chez lui (pas de plaque ni de four)	38
Souhaite apprendre à cuisiner « vite et pas cher »	121

Document 4 – Extraits du groupe de parole organisé par la conseillère (6 jeunes)

« Le matin je prends un energy drink, ça coupe la faim et ça réveille. » (Kenza, 19 ans)

« Je vis chez ma tante, je n'ose pas me servir dans le frigo. » (Théo, 18 ans)

« Les légumes c'est cher et ça pourrit avant que je les mange. » (Yanis, 22 ans)

« Je sais faire des pâtes, c'est tout. Ma mère ne m'a jamais montré. » (Lina, 17 ans)

« Les flyers sur manger-bouger, on les jette. Mais une vidéo de 30 secondes sur Insta, je regarde. » (Malik, 21 ans)

« Moi je veux bien venir cuisiner si on mange ce qu'on fait et si on peut l'emporter. » (Inès, 24 ans)

Document 5 – Ce que propose l'équipe de la mission locale

Un conseiller propose : « On pourrait peser les jeunes au début et à la fin pour voir si ça marche, et créer un groupe WhatsApp où ils envoient les photos de leurs assiettes. On mettra les photos sur la page Facebook de la mission locale pour valoriser le projet. »

Document 6 – Cadre des politiques publiques (données réelles)

Le programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5) a été lancé le 8 avril 2026 ; il compte 3 axes et 20 mesures. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), prévue par l'article 265 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, a été publiée le 11 février 2026. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) visent à relocaliser l'alimentation sur un territoire ; 450 PAT étaient reconnus au 1er juillet 2025. Le contrat local de santé est prévu par l'article L. 1434-10 du code de la santé publique : il décline localement le projet régional de santé.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Qualifiez l'action demandée : mode d'intervention, niveau de prévention, type d'approche, place dans les politiques publiques du document 6. (1 pt)
2. À partir des documents 2 à 4, calculez les indicateurs de l'enquête flash en pourcentage ; calculez le taux de participation ; posez le diagnostic de situation en distinguant les besoins exprimés, ressentis, normatifs et comparatifs (Bradshaw) ; construisez l'arbre à problèmes. (2 pts)
3. Formulez l'objectif général, deux ou trois objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. Justifiez vos priorités. (1,5 pt)

4. Présentez le plan d'action sur six mois (actions, public, partenaires, calendrier) et un budget détaillé qui respecte les 1 800 €. (1,5 pt)

5. Présentez le plan de communication en tenant compte de la précarité numérique et de la littératie en santé du public. (1 pt)

6. Construisez la démarche d'évaluation (processus, résultats, impact) avec les outils de recueil. (1 pt)

7. Proposez les modalités de valorisation du projet et les ajustements possibles. (1 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

8. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de jeunes ayant renoncé à un repas faute d'argent, puis le nombre de jeunes à interroger pour obtenir une précision de ± 5 points. (1,5 pt)

9. Identifiez les biais de l'enquête flash et proposez un protocole d'enquête de suivi (population, échantillonnage, outil, recueil, traitement, éthique). (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

10. Organisez une veille sur l'alimentation des jeunes en situation de précarité : besoins, sources fiables, outils, fréquence, diffusion à l'équipe. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

11. Analysez la proposition du document 5 sur les plans éthique, juridique et de la sécurité numérique ; proposez une alternative. (1,5 pt)

12. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (enrichissement et calcul nutritionnel), adaptée au format du temps 2 de l'E5 du référentiel 2024.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La plateforme d'accompagnement et de répit des aidants de la ville de Bressac (structure fictive) accompagne des personnes qui s'occupent chaque jour d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. L'équipe a constaté que beaucoup d'aidants « mangent sur le pouce », sautent des repas, perdent du poids et se sentent épuisés. Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire de 2 heures, dans le cadre du programme « Prendre soin de soi », avec un double objectif : montrer qu'on peut préparer en 30 minutes un plat complet, bon et peu coûteux, qui convient à la fois à l'aidant et au proche ; et montrer comment adapter ce plat lorsque le proche a des troubles de la mastication.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 aidants de 52 à 81 ans (6 femmes, 2 hommes) ; 2 aidants ont un diabète de type 2 traité par metformine ; 1 aidant a une hypertension artérielle ; 1 aidante de 81 ans a perdu 4 kg en 6 mois (poids actuel 52 kg).
- 3 proches ont des difficultés de mastication et mangent des textures hachées ; un proche est allergique à l'arachide (il ne participe pas à l'atelier mais l'aidante veut pouvoir refaire la recette chez elle).
- Les aidants disposent chez eux d'une cuisine standard ; plusieurs disent « ne plus avoir envie de cuisiner pour deux ».
- Atelier : salle d'animation avec cuisine pédagogique (4 plaques à induction, 1 four mixte, 1 mixeur plongeant, 1 robot coupe, 1 réfrigérateur, 1 lave-vaisselle), 4 postes de travail de 2 personnes.
- Budget denrées : 30 € pour l'atelier, soit 10 portions (8 aidants et 2 animateurs).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 heures, de 14 h 00 à 16 h 00. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Recette imposée de base (pour 10 portions) et dessert

Plat : gratin de pâtes complètes, brocolis et poulet, sauce blanche enrichie.

Dessert : coupe de fromage blanc, compote pomme-poire minute et biscuit sec émietté.

Le candidat doit réaliser le plat ; le dessert peut être réalisé par les participants. Il doit aussi présenter une version du plat en texture hachée, adaptée au proche qui a des troubles de la mastication (niveau IDDSI 5 « haché et humide »).

Document 3 – Grammages bruts, coefficients et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Coefficient de perte (brut → net)	Prix (2026)
Pâtes alimentaires complètes, sèches	60 g	sans perte	1,90 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Coefficient de perte (brut → net)	Prix (2026)
Brocoli frais	120 g	35 % de perte	2,80 € le kg
Filet de poulet cru	70 g	sans perte	11,50 € le kg
Lait demi-écrémé	100 mL	sans perte	1,05 € le litre
Lait en poudre écrémé	8 g	sans perte	12,00 € le kg
Farine de blé	8 g	sans perte	1,10 € le kg
Huile de colza	6 g	sans perte	3,20 € le litre (1 L = 920 g)
Emmental râpé	15 g	sans perte	9,80 € le kg
Fromage blanc nature 3 % de matière grasse	100 g	sans perte	2,60 € le kg
Pommes	60 g	20 % de perte	2,40 € le kg
Poires	60 g	20 % de perte	3,20 € le kg
Biscuit sec type petit-beurre	8 g	sans perte	4,50 € le kg
Sel, poivre, muscade, citron	–	–	forfait 0,60 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pâtes sèches, au blé complet, cuites, sans sel ajouté	179	7,35	31,3	1,4	5,1	0,055
Brocoli, cuit (aliment moyen)	30	3,17	1,79	0,6	2,59	0,036
Poulet, filet sans peau grillé/poêlé	141	30,1	0	2	0	0,14
Lait demi-écrémé, UHT	47,7	3,48	5	1,56	0	0,088
Lait en poudre, écrémé	361	35,3	54	0,7	0	1,32
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains)	350	9,03	73,7	1	3,2	< 0,13
Huile de colza	900	0	0	100	0	< 0,0028
Emmental ou emmenthal, râpé	368	27,6	0,58	28,2	0,042	0,68
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088
Pomme, chair sans peau, crue (aliment moyen)	51,3	0,26	11,9	0,24	2,39	0,0064
Poire, chair, crue (aliment moyen)	49,7	0,25	11,4	< 0,5	3,1	< 0,013
Biscuit sec petit beurre	450	7,78	73,4	13,3	2,54	1,04

Rendements de cuisson donnés pour le sujet : 60 g de pâtes sèches complètes donnent 120 g de pâtes cuites ; 70 g de filet de poulet cru donnent 56 g de poulet poêlé ; on compte 120 g de brocoli cuit par portion. On admet que 100 mL de lait pèsent 100 g. Les valeurs ne comprennent pas le sel ajouté à la cuisson. Une teneur notée « < » (inférieure au seuil de mesure) ou « traces » est comptée 0 dans les calculs.

Source : ANSES, table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025,

mis en ligne le 19 novembre 2025) ; énergie calculée selon le règlement (UE) n° 1169/2011 ; protéines N × facteur de Jones.

Document 5 – Repères pour le public

- Repères du PNNS pour les adultes (Santé publique France, 2019 ; mangerbouger.fr) : féculents complets au moins une fois par jour, au moins 5 fruits et légumes par jour, 2 produits laitiers par jour, réduire le sel.
- Personnes âgées à risque de dénutrition : HAS et FFN, recommandations de 2021 sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus ; apport protéique conseillé autour de 1,0 à 1,2 g par kg de poids et par jour chez la personne âgée.
- IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) : niveau 5 « haché et humide » = morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, humides, sans liquide qui se sépare, qui s'écrasent facilement à la fourchette.

Travail à faire

Partie 1 – Conception de l'atelier (8 points)

1. Identifiez les besoins, les objectifs et les spécificités du public ; formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques de l'atelier. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande en deux exemplaires pour 10 portions : quantités nettes, quantités brutes, unités d'achat, coût total et coût par portion ; vérifiez le respect du budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat (ingrédients, techniques, étapes, points critiques, températures) et la fiche de la version hachée. (2 pts)
4. Calculez, avec la table Ciqual, l'apport en énergie, protéines, glucides, lipides, fibres et sel d'une portion du plat ; comparez l'apport protéique au besoin de l'aidante de 81 ans ; proposez deux techniques d'enrichissement supplémentaires. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (mise en place, accueil, animation, dégustation, évaluation, remise en état), avec la répartition des tâches entre les binômes. (2 pts)
6. Choisissez les méthodes d'animation et les outils pédagogiques ; préparez la grille de dégustation. (2 pts)
7. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (méthode des 5 M, températures, allergènes, conservation des restes) et les gestes éco-responsables. (2 pts)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (6 points)

8. Réalisez le gratin et sa version hachée ; dressez deux assiettes témoins. (4 pts : techniques maîtrisées, qualité organoleptique, texture conforme, hygiène pendant la production)
9. Proposez la démarche d'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, intention de refaire la recette) et l'auto-évaluation de votre animation. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au service de santé au travail du centre hospitalier de Valmont (structure fictive), 1 900 agents, dont 310 travaillent de nuit en postes de 10 heures (de 21 h 00 à 7 h 00). Le médecin du travail constate chez ces agents des plaintes de fatigue, de troubles digestifs et une prise de poids. Le restaurant du personnel est fermé la nuit : seuls deux distributeurs automatiques sont accessibles. La direction des ressources humaines souhaite une action « Bien manger quand on travaille de nuit », inscrite dans la démarche de qualité de vie et des conditions de travail de l'établissement.

Document 1 – Données nationales (données réelles)

- En 2012, 15,4 % des salariés travaillaient la nuit, de façon habituelle ou occasionnelle (DARES, Analyses, 2014).
- L'ANSES (avis et rapport de juin 2016 sur le travail de nuit) conclut à des effets avérés sur la somnolence et la qualité du sommeil, et à des effets probables sur le syndrome métabolique, les troubles psychiques, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Document 2 – Enquête du service de santé au travail (données fictives)

Questionnaire en ligne envoyé aux 310 agents de nuit ; 124 réponses.

Item	Nombre de réponses « oui »
Ne prend pas de vrai repas pendant la nuit	68
Achète au moins une fois par nuit au distributeur (barres, sodas, chips)	81
Boit plus de 4 cafés ou boissons caféinées par nuit	43
Déclare une prise de poids depuis le passage de nuit	57
Souhaite des idées de repas à préparer à l'avance	96

Document 3 – Moyens disponibles

Salle de pause de chaque service : réfrigérateur, four à micro-ondes, bouilloire. Cuisine du restaurant du personnel prêtée un après-midi par mois pour un atelier de 10 personnes (2 plaques à induction, 1 four mixte, 1 cellule de refroidissement rapide, 5 postes de travail). Budget annuel : 2 500 €. Le prestataire des distributeurs accepte de modifier 30 % de l'offre.

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête et le taux de réponse ; posez le diagnostic et ses limites. (4 pts)
2. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, avec une action sur l'environnement (distributeurs) et une action éducative. (5 pts)
3. Présentez le plan de communication, en tenant compte des horaires décalés, et la démarche d'évaluation. (4 pts)

4. Proposez une revue de la littérature sur l'alimentation et le travail de nuit : équation de recherche, bases de données, critères de sélection. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et de sécurité numérique d'un questionnaire en ligne de santé au travail. (2 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Contexte imposé : atelier de 1 h 30 pour 10 agents de nuit, dans la cuisine du restaurant du personnel. Thème : « Ma boîte de nuit » : préparer à l'avance un repas de nuit facile à réchauffer ou à manger froid, et un en-cas de fin de nuit. Contraintes : coût des denrées au plus 3,50 € par participant ; repas transportable au réfrigérateur dans une boîte réutilisable ; pas de friture.

Préparations imposées : salade-repas en bocal (lentilles, carottes, œuf, vinaigrette à l'huile de colza) et houmous maison de pois chiches avec bâtonnets de légumes.

Document 4 – Données pour le temps 2 (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Salade-repas, grammages nets par portion : lentilles vertes sèches 60 g (150 g cuites, rendement de cuisson donné) ; carottes 80 g (15 % de perte à l'épluchage) ; 1 œuf (50 g sans coquille) ; huile de colza 10 g ; vinaigre de cidre, moutarde, persil, échalote (forfait 1,00 € pour 10 portions).

Prix : lentilles vertes 3,60 € le kg ; carottes 1,40 € le kg ; œufs 0,30 € pièce ; huile de colza 3,20 € le litre (1 L = 920 g).

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau	125	10,1	16,2	0,58	8,45
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9
Oeuf dur	134	13,5	0,52	8,62	0
Huile de colza	900	0	0	100	0

Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0 dans les calculs.

7. Identifiez les besoins et les objectifs de l'atelier ; justifiez le choix des préparations au regard du travail de nuit. (3 pts)
8. Établissez le bon de commande et la fiche technique de la salade-repas pour 10 portions ; calculez son apport en énergie, protéines et fibres avec la table Ciqual. (5 pts)
9. Présentez le déroulé de l'atelier, les techniques d'animation et la grille de dégustation. (4 pts)
10. Présentez les règles d'hygiène pour un repas préparé à l'avance et transporté (refroidissement, conservation à 4 °C au plus, durée de conservation, réchauffage) et les éco-gestes. (4 pts)
11. Réalisez les deux préparations et évaluez l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale

que le jury attend

Le jury ne cherche pas un projet parfait : il évalue une démarche. Il attend un diagnostic chiffré et sourcé, des objectifs cohérents avec ce diagnostic, des actions réalistes avec les moyens réellement disponibles (1 800 €, une cuisine prêtée le mercredi, un minibus le mardi), une évaluation prévue dès la conception et un regard critique sur ce qui a été fait. Il pénalise la morale (« il faut manger cinq fruits et légumes »), la stigmatisation (pesée), les objectifs sans indicateur et le manque de sources.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Qualifier l'action (1 pt)

- Mode d'intervention : promotion de la santé (charte d'Ottawa, 1986), qui associe une action sur les compétences des jeunes (éducation pour la santé : savoir cuisiner simple et pas cher, lire une étiquette) et une action sur l'environnement (petit-déjeuner disponible à la mission locale, accès à l'épicerie sociale, transport le mardi). On parle de promotion et non seulement d'éducation, car le problème principal est d'abord un problème de ressources et d'accès.
- Niveau de prévention : prévention primaire (classification de l'OMS), car on agit avant l'apparition de pathologies ; en classification de Gordon, prévention sélective, car on vise un groupe exposé à un risque plus élevé (jeunes en précarité).
- Approche : approche de population ciblée, participative (les jeunes sont associés dès le diagnostic), avec une logique d'universalisme proportionné : l'offre est ouverte à tous les jeunes suivis mais renforcée pour les plus fragiles.
- Place dans les politiques : déclinaison locale du PNNS 5 (2026-2030) et de la SNANC (février 2026) ; inscription dans l'axe « Alimentation, précarité et santé des jeunes » du contrat local de santé (article L. 1434-10 du code de la santé publique), lui-même décliné du projet régional de santé de l'ARS ; lien possible avec le projet alimentaire territorial s'il en existe un.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Confondre prévention et promotion de la santé ; parler de « prévention secondaire » alors qu'aucun dépistage n'est fait ; citer le PNNS 4 (2019-2023) comme programme en cours ; oublier que le CLS est l'outil de déclinaison locale.

Question 2 – Diagnostic de situation (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête flash

Pourcentage = nombre de « oui » / effectif × 100.

- Petit-déjeuner sauté au moins 4 jours sur 7 : 97 / 212 × 100 = 45,8 %.
- Fruits ou légumes chaque jour : 53 / 212 × 100 = 25,0 %.
- Boisson sucrée ou énergisante chaque jour : 89 / 212 × 100 = 42,0 %.
- Renoncement à un repas faute d'argent dans le mois : 74 / 212 × 100 = 34,9 %.
- Pas d'équipement de cuisson : 38 / 212 × 100 = 17,9 %.
- Souhait d'apprendre à cuisiner : 121 / 212 × 100 = 57,1 %.

Taux de participation = 212 / 1 350 × 100 = 15,7 %.

Analyse. Plus d'un jeune sur trois renonce à des repas pour raisons financières : c'est une situation d'insécurité alimentaire. Près d'un jeune sur deux saute le petit-déjeuner, ce qui est cohérent avec les malaises signalés le matin. Un jeune sur quatre seulement mange des fruits ou des légumes chaque jour. Quatre jeunes sur dix boivent chaque jour une boisson sucrée ou énergisante (caféine, sucre), souvent pour « couper la faim » (document 4). Près d'un jeune sur cinq ne peut pas cuisiner chez lui. Le territoire cumule les difficultés : plus de jeunes sans emploi ni formation et plus de pauvreté chez les moins de 30 ans que dans le département, peu de commerces accessibles en bus, 58 % des jeunes suivis sans permis.

Les besoins selon Bradshaw :

Type de besoin	Définition	Dans la situation
Normatif	Défini par des experts à partir d'une norme	Repères du PNNS : au moins 5 fruits et légumes par jour, limiter les boissons sucrées ; 25,0 % seulement en mangent chaque jour
Ressenti	Perçu par la personne, pas toujours dit	Faim le matin, fatigue, gêne à se servir chez un proche (Théo)
Exprimé	Ressenti transformé en demande	57,1 % veulent apprendre à cuisiner « vite et pas cher » ; Inès veut emporter ce qu'elle cuisine
Comparatif	Écart avec un groupe semblable qui bénéficie d'un service	Taux de pauvreté des moins de 30 ans de 24 % contre 19 % dans le département ; peu d'accès aux commerces

Arbre à problèmes. Problème central : une alimentation insuffisante et déséquilibrée chez les jeunes suivis. Causes : ressources faibles et arbitrages budgétaires (forfait téléphone) ; absence d'équipement de cuisson ; manque de compétences culinaires ; isolement géographique et transport rare ; logement chez un tiers ; marketing des boissons énergisantes. Effets : malaises et baisse de la concentration en atelier, absentéisme, fatigue, risque de prise de poids ou de carences, perte d'estime de soi, freins à l'insertion.

Limites – Limites à citer

Taux de participation de 15,7 % ; questionnaire en salle d'attente (les jeunes les plus en difficulté viennent peut-être moins) ; données déclaratives ; groupe de parole de 6 jeunes non représentatif. Le diagnostic est donc une première estimation qui doit être complétée (partie B).

Question 3 – Priorités et objectifs (1,5 pt)

Priorités retenues : le petit-déjeuner (lien direct avec les malaises, action rapide et visible), les compétences culinaires à petit budget (demande exprimée par 57,1 % des jeunes) et l'accès aux ressources alimentaires (insécurité alimentaire de 34,9 %). Les boissons énergisantes sont traitées dans les ateliers, sans action séparée.

- Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation des jeunes suivis par la mission locale du Val d'Arvel, en renforçant leurs compétences et en améliorant leur accès à une alimentation suffisante et équilibrée, d'ici 6 mois.
- Objectif spécifique 1 : d'ici 6 mois, réduire de 45,8 % à 30 % la part des jeunes en CEJ qui sautent le petit-déjeuner au moins 4 jours sur 7.
- Objectif spécifique 2 : d'ici 6 mois, 70 % des jeunes ayant suivi au moins 3 ateliers déclarent savoir préparer seuls au moins 2 repas complets pour moins de 2 € par portion.
- Objectif spécifique 3 : d'ici 6 mois, 80 % des jeunes ayant déclaré renoncer à des repas ont été orientés vers une aide alimentaire adaptée (épicerie sociale, CCAS).
- Objectifs opérationnels : mettre en place un petit-déjeuner partagé deux matins par semaine dès le mois 1 ; animer 6 ateliers culinaires de 2 h le mercredi au centre social, de 8 jeunes chacun ; organiser 4 sorties en minibus à l'épicerie sociale et au marché ; produire 6 vidéos de 30 secondes de recettes avec les jeunes ; former les conseillers au repérage de l'insécurité alimentaire (1 séance de 1 h 30).

Chaque objectif a un indicateur, une valeur cible et une échéance : c'est ce qui le rend évaluable.

Question 4 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Mois	Action	Partenaires
1	Comité de pilotage ; présentation aux jeunes ; formation des conseillers au repérage	Direction, conseillère santé, coordinatrice du CLS
1 à 6	Petit-déjeuner partagé le mardi et le jeudi (12 jeunes)	Épicerie sociale (dons), jeunes volontaires
2 à 5	6 ateliers culinaires « vite et pas cher » le mercredi, 8 jeunes, recettes sans four pour les jeunes non équipés	Centre social, diététicien
2 à 5	4 sorties en minibus le mardi : épicerie sociale, marché, lecture des prix au kilo	Bénévoles, épicerie sociale
3 à 6	Tournage de 6 vidéos de 30 secondes par les jeunes	Animatrice numérique du centre social
6	Évaluation, restitution, valorisation	Toute l'équipe, élus du CLS

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Petit-déjeuner : 2 matins × 24 semaines = 48 petits-déjeuners × 12 jeunes = 576 petits-déjeuners × 0,90 € = 518,40 €.
- Ateliers : 6 ateliers × 10 personnes (8 jeunes et 2 animateurs) × 2,00 € = 120 € ; boîtes réutilisables pour emporter : 48 boîtes × 2,50 € = 120 €.
- Petit matériel pour les ateliers et le petit-déjeuner (bouilloire, mixeur plongeant, plaque à induction mobile, ustensiles) : 420 €.
- Impressions (affiches, livret de recettes de 12 pages en 60 exemplaires) : 180 €.
- Carburant du minibus : 4 sorties × 25 € = 100 €.
- Récompenses symboliques et goûter de restitution : 150 €.

Total = 518,40 + 120 + 120 + 420 + 180 + 100 + 150 = 1 608,40 €, soit une marge de 1 800 − 1 608,40 = 191,60 € pour les imprévus.

Question 5 – Plan de communication (1 pt)

- Cibles : les jeunes (bénéficiaires), les conseillers (relais), les partenaires et les élus (financeurs).
- Messages : positifs, sans culpabilisation (« Cuisiner pour 2 € », « Un petit-déjeuner pour bien commencer l'atelier »), centrés sur le goût, le budget et l'autonomie.
- Supports adaptés à la littératie en santé : affiches très visuelles avec pictogrammes, recettes en 5 étapes illustrées, vidéos courtes tournées par les jeunes, message oral des conseillers lors des entretiens. Une vidéo de 30 secondes correspond aux usages (document 4).
- Précarité numérique : forfaits limités, téléphones partagés, peu d'ordinateurs ; on ne compte donc pas que sur le numérique. Les vidéos sont diffusées en salle d'attente sur un écran, les recettes existent aussi sur papier, le QR code renvoie à une page légère.
- Calendrier : lancement au mois 1, rappel avant chaque atelier, restitution au mois 6.

Question 6 – Démarche d'évaluation (1 pt)

Niveau	Indicateurs	Outils
Processus	Nombre d'ateliers réalisés sur 6 prévus ; nombre de participants par atelier ; nombre de petits-déjeuners servis ; budget consommé ; respect du calendrier	Feuilles d'émargement, tableau de suivi, factures
Résultats	Part des jeunes qui sautent le petit-déjeuner (comparaison avec 45,8 %) ; part des jeunes qui savent préparer 2 repas à moins de 2 € ; nombre de jeunes orientés vers l'aide alimentaire	Même questionnaire qu'au départ (avant-après), fiche de compétences remplie en fin d'atelier, registre des orientations

Niveau	Indicateurs	Outils
Satisfaction	Appréciation des ateliers et des recettes	Questionnaire à smileys, mur d'expression
Impact (à plus long terme)	Malaises signalés en atelier ; assiduité aux activités du CEJ	Registre de la mission locale, sur un an

L'évaluation est prévue dès le début, avec les mêmes questions avant et après pour pouvoir comparer.

Question 7 – Valorisation et ajustements (1 pt)

Valorisation : restitution aux élus et aux partenaires du CLS ; livret de recettes réalisé par les jeunes ; diffusion des vidéos avec l'accord écrit des jeunes ; article dans le bulletin de la communauté de communes ; présentation au réseau régional des missions locales ; reprise possible dans le PAT.

Ajustements : si les jeunes ne viennent pas le mercredi, déplacer l'atelier juste après une activité obligatoire du CEJ ; si la cuisine du centre social n'est pas disponible, ateliers sans cuisson (bocaux, salades, tartines) dans l'espace détente ; si le budget du petit-déjeuner est dépassé, solliciter les dons de l'épicerie sociale ou des commerces.

Partie B – Recherche appliquée

Question 8 – Intervalle de confiance et taille d'échantillon (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance à 95 % d'une proportion

p = 74 / 212 = 0,349 ; n = 212.

Erreur = 1,96 × racine carrée de [p × (1 − p) / n] = 1,96 × racine carrée de (0,349 × 0,651 / 212) = 0,064.

IC à 95 % = [0,349 − 0,064 ; 0,349 + 0,064] = [28,5 % ; 41,3 %].

Interprétation : si l'échantillon était représentatif, la vraie proportion de jeunes suivis ayant renoncé à un repas se situerait entre 28,5 % et 41,3 %, avec un risque d'erreur de 5 %.

Taille d'échantillon pour une précision de ± 5 points : n = 1,96 × 1,96 × p × (1 − p) / (0,05 × 0,05) = 3,8416 × 0,349 × 0,651 / 0,0025 = 349,1 ; on arrondit toujours au nombre entier supérieur : 350 jeunes.

Question 9 – Biais et protocole de suivi (1,5 pt)

Biais : biais de sélection (jeunes présents en salle d'attente pendant deux semaines, 15,7 % de participation, absence probable des plus isolés) ; biais de désirabilité sociale (questionnaire rempli dans les locaux de la structure) ; biais de mémoire (dernier mois) ; questions non validées.

Protocole : population = tous les jeunes suivis en CEJ ; échantillonnage = recueil systématique pendant les entretiens individuels sur une période définie (tous les jeunes reçus), avec un objectif de 350 réponses ; outil = questionnaire court, anonyme, avec des questions issues d'outils validés (par exemple un indicateur d'insécurité alimentaire reconnu) et testé auprès de 5 jeunes ; recueil avant le projet et 6 mois après, sur papier ou sur tablette hors ligne ; traitement = tableur, pourcentages et intervalles de confiance, comparaison avant-après ; éthique = information claire, participation libre, anonymat, pas de donnée nominative ni de donnée de santé identifiante, données conservées sur un poste sécurisé et détruites à la fin de l'étude, conformité au RGPD (minimisation des données).

Partie C – Veille

Question 10 – Organiser la veille (2 pts)

- Besoins : suivre les données sur l'alimentation et la précarité des jeunes, les dispositifs d'aide alimentaire, les recommandations nutritionnelles et les outils d'intervention.
- Sources fiables : Santé publique France et mangerbouger.fr (repères, outils), ministère chargé de la santé (PNNS 5), ministère chargé de l'agriculture (SNANC, PAT, programme national pour l'alimentation), ANSES (études INCA, avis), Drees et Insee (pauvreté), Observatoire régional de la santé, IREPS et Promotion Santé (outils pédagogiques, interventions probantes), Haut Conseil de la santé publique.

- Outils : alertes par mots-clés, abonnements aux lettres d'information, flux RSS, agrégateur, tableau de veille partagé (date, source, résumé en 3 lignes, intérêt pour le projet).
- Fréquence : 30 minutes par semaine, bilan mensuel.
- Diffusion : une fiche de veille d'une page par mois à l'équipe, présentée en réunion ; seule l'information utile au projet est diffusée.
- Évaluation de la veille : nombre d'informations utilisées dans le projet, avis de l'équipe.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 11 – Analyse de la proposition du document 5 (1,5 pt)

- Peser les jeunes : la pesée n'est pas un objectif du projet (il ne s'agit pas d'un projet de perte de poids), elle est stigmatisante, elle peut éloigner les jeunes et elle produit une donnée de santé. Elle est donc à refuser.
- Groupe WhatsApp avec photos d'assiettes : messagerie privée hors du système d'information de la structure, numéros de téléphone visibles par tous, jugement possible des assiettes entre pairs, pas de maîtrise de la conservation des données.
- Publication sur Facebook : droit à l'image (accord écrit nécessaire, accord des parents pour les mineurs comme Lina, 17 ans), e-réputation des jeunes (un employeur peut voir qu'ils fréquentent une mission locale ou ont des difficultés alimentaires), données excessives au regard du RGPD.
- Alternative : évaluer par questionnaire anonyme ; partager les recettes et non les assiettes ; outil de messagerie choisi par la structure, avec un compte professionnel ; photos de mains et de plats, sans visage, publiées seulement avec un accord écrit et la possibilité de le retirer ; mots de passe forts et double authentification pour les comptes de la structure.

Question 12 – Trame de l'exposé et questions du jury (1,5 pt)

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

- 0 min 00 à 1 min 00 : présentation de la structure, de la demande et de mon rôle de stagiaire.
- 1 min 00 à 3 min 00 : diagnostic (3 chiffres clés de l'enquête, contexte territorial, besoins selon Bradshaw, limites).
- 3 min 00 à 4 min 00 : priorités et objectifs (un objectif spécifique détaillé avec son indicateur).
- 4 min 00 à 6 min 30 : actions réalisées pendant le stage (par exemple 2 ateliers et 6 petits-déjeuners), outils et partenariats.
- 6 min 30 à 8 min 00 : évaluation (premiers résultats chiffrés) et communication.
- 8 min 00 à 9 min 30 : analyse critique : ce qui a fonctionné, difficultés, ajustements, éthique.
- 9 min 30 à 10 min 00 : conclusion et ce que ce projet m'a appris pour mon métier.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Pourquoi parlez-vous de promotion de la santé et pas seulement d'éducation ? On agit aussi sur l'environnement et l'accès, pas seulement sur les connaissances.
2. Quel est le niveau de prévention ? Primaire (OMS), sélective (Gordon).
3. Votre enquête est-elle représentative ? Non : 15,7 % de participation, recueil en salle d'attente ; il faut un recueil systématique et 350 réponses.
4. Comment avez-vous calculé votre intervalle de confiance ? Formule de la proportion, 1,96 pour 95 %.
5. Pourquoi ne pas avoir pesé les jeunes ? Ce n'est pas un objectif, c'est stigmatisant, c'est une donnée de santé.
6. Quel lien avec le PNNS 5 ? Déclinaison locale par le CLS ; repères alimentaires et lutte contre les inégalités sociales de santé.
7. Qu'est-ce qu'un CLS ? Contrat entre l'ARS et une collectivité pour décliner le projet régional de santé sur un territoire (article L. 1434-10 du CSP).
8. Comment avez-vous pris en compte la précarité numérique ? Supports papier, écran en salle d'attente,

page légère, pas d'application à télécharger.

9. Quels partenaires et pourquoi ? Centre social (cuisine), épicerie sociale (accès, dons), CLS (financement), bénévoles (sorties).
10. Comment avez-vous adapté vos recettes aux jeunes sans équipement ? Recettes sans cuisson ou au four à micro-ondes, petit matériel prêté.
11. Votre objectif spécifique 1 est-il réaliste ? Justifier par la durée, la fréquence du petit-déjeuner et l'évaluation intermédiaire.
12. Quels sont les effets des boissons énergisantes ? Apport de sucre et de caféine, sensation de faim masquée, troubles du sommeil ; l'ANSES (avis de 2013) les déconseille aux enfants et aux adolescents.
13. Comment avez-vous associé les jeunes ? Groupe de parole, choix des recettes, tournage des vidéos.
14. Quels documents réglementaires pour les photos ? Autorisation de droit à l'image, accord parental pour les mineurs, RGPD.
15. Qu'avez-vous fait pour sécuriser les données de l'enquête ? Anonymat, poste avec session personnelle, mot de passe, destruction en fin d'étude.
16. Que changeriez-vous ? Une réponse argumentée, honnête, avec un ajustement concret.
17. Comment le projet peut-il durer après votre stage ? Recettes et vidéos réutilisables, conseillers formés, inscription dans le CLS.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte ; plan d'action et moyens réalistes ; plan de communication adapté ; démarche d'évaluation construite ; valorisation ; ajustements envisagés (C3.1)	9
B – Recherche	Méthodes et outils de collecte pertinents ; traitement et analyse des données ; règles de déontologie et d'éthique (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; technique de veille adaptée ; sources fiables ; diffusion organisée ; pertinence évaluée (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés au public ; précarité numérique ; e-réputation ; identité numérique ; environnement numérique sécurisé (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants

que le jury attend

Le temps 2 évalue une seule compétence, C3.2, mais avec tous ses indicateurs : besoins du public identifiés, techniques culinaires adaptées, adaptation à une alimentation particulière (ici la texture), documents techniques exacts, animation, organisation, qualité des préparations, dégustation, hygiène, éco-gestes et évaluation. Un plat réussi sans animation ni évaluation ne suffit pas ; une animation brillante avec un plat mal cuit non plus.

Partie 1 – Conception de l'atelier

Question 1 – Besoins, objectifs et spécificités du public (2 pts)

Besoins et spécificités : public adulte et âgé, en situation de charge mentale et physique importante (risque d'épuisement de l'aidant) ; repas sautés et perte d'envie de cuisiner « pour deux » ; risque de dénutrition (aidante de 81 ans qui a perdu 4 kg en 6 mois, soit 4 / 56 × 100 = 7,1 % de son poids initial de 56 kg) ; diabète de type 2 chez 2 aidants (féculents complets et fibres, répartition des glucides) ; hypertension chez 1 aidant (sel limité) ; proches avec troubles de la mastication (texture hachée) ; allergie à l'arachide chez un proche (vérifier les étiquettes, en particulier du biscuit et de l'huile) ; peu de temps disponible.

Définition – Perte de poids et dénutrition (HAS et FFN, 2021)

Chez la personne de 70 ans et plus, une perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois est un critère phénotypique de dénutrition. La perte de 7,1 % en 6 mois de l'aidante n'atteint pas ce seuil, mais elle justifie une vigilance et une orientation vers son médecin traitant ; l'atelier n'est pas un acte de diagnostic.

- Objectif général : permettre aux aidants de préparer facilement, chez eux, des repas complets, agréables et peu coûteux, adaptés à eux-mêmes et à leur proche.
- Objectif pédagogique 1 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait réaliser un plat complet en 30 minutes, avec un féculent complet, un légume et une source de protéines.
- Objectif pédagogique 2 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait citer et utiliser deux techniques d'enrichissement simples (lait en poudre, fromage râpé, œuf).
- Objectif pédagogique 3 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait adapter la texture du plat pour un proche qui mâche difficilement (hacher, humidifier, vérifier à la fourchette).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Quantités brutes et coût des denrées pour 10 portions

Quantité nette pour 10 portions = grammage net × 10. Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

- Brocoli : net = 120 × 10 = 1 200 g ; brut = 1 200 / (1 − 0,35) = 1 200 / 0,65 = 1 846 g, soit 1,85 kg ; coût = 1,846 × 2,80 = 5,17 €.
- Pommes : net = 600 g ; brut = 600 / 0,80 = 750 g ; coût = 0,750 × 2,40 = 1,80 €.
- Poires : net = 600 g ; brut = 750 g ; coût = 0,750 × 3,20 = 2,40 €.
- Huile de colza : 60 g = 60 / 920 = 0,065 L ; coût = 0,065 × 3,20 = 0,21 €.
- Autres denrées (sans perte) : pâtes 0,600 kg × 1,90 = 1,14 € ; poulet 0,700 kg × 11,50 = 8,05 € ; lait 1,000 L × 1,05 = 1,05 € ; lait en poudre 0,080 kg × 12,00 = 0,96 € ; farine 0,080 kg × 1,10 = 0,09 € ; emmental 0,150 kg × 9,80 = 1,47 € ; fromage blanc 1,000 kg × 2,60 = 2,60 € ; petit-beurre 0,080 kg × 4,50 = 0,36 €.
- Forfait condiments : 0,60 €.

Total = 25,90 € ; coût par portion = 25,90 / 10 = 2,59 €. Le budget de 30 € est respecté (marge de 4,10 €).

Denrée	Quantité nette	Quantité brute à commander	Unité d'achat	Prix unitaire	Coût
Pâtes complètes sèches	600 g	0,600 kg	kg	1,90 €	1,14 €
Brocoli frais	1 200 g	1,850 kg	kg	2,80 €	5,17 €
Filet de poulet cru	700 g	0,700 kg	kg	11,50 €	8,05 €
Lait demi-écrémé	1 000 mL	1 L	L	1,05 €	1,05 €
Lait en poudre écrémé	80 g	0,080 kg	kg	12,00 €	0,96 €
Farine de blé	80 g	0,080 kg	kg	1,10 €	0,09 €
Huile de colza	60 g	0,065 L	L	3,20 €	0,21 €
Emmental râpé	150 g	0,150 kg	kg	9,80 €	1,47 €
Fromage blanc 3 % MG	1 000 g	1,000 kg	kg	2,60 €	2,60 €
Pommes	600 g	0,750 kg	kg	2,40 €	1,80 €
Poires	600 g	0,750 kg	kg	3,20 €	2,40 €
Petit-beurre	80 g	0,080 kg	kg	4,50 €	0,36 €
Sel, poivre, muscade, citron	–	–	forfait	–	0,60 €
Total					25,90 €

Le bon de commande est établi en deux exemplaires (un pour le fournisseur ou le magasin, un conservé pour le contrôle à réception). En pratique, on arrondit les quantités aux conditionnements du commerce ; le coût affiché ici est le coût matière des quantités utilisées.

Question 3 – Fiche technique du plat et de la version hachée (2 pts)

Modèle à recopier – Fiche technique – Gratin de pâtes complètes, brocolis et poulet, sauce blanche enrichie (10 portions)

Matériel : 2 casseroles de 5 L, 1 sauteuse, 1 casserole à fond épais, fouet, plat à gratin de 30 × 40 cm, thermomètre-sonde, planche et couteau réservés aux viandes crues (code couleur).

1. Mise en place : se laver les mains ; sortir les denrées au dernier moment ; laver les brocolis, détailler en petites fleurettes, éplucher et émincer les tiges.
2. Cuire les pâtes dans une grande quantité d'eau bouillante peu salée (environ 1 L par 100 g), 2 minutes de moins que le temps indiqué ; égoutter.
3. Cuire les brocolis à l'eau bouillante ou à la vapeur 6 à 8 minutes ; ils restent légèrement fermes et bien verts.
4. Détailler le poulet en dés de 1,5 cm sur la planche réservée ; le saisir dans la sauteuse avec un filet d'huile jusqu'à cuisson complète à cœur (chair blanche jusqu'au centre, contrôle au thermomètre-sonde) ; laver la planche et les mains aussitôt.
5. Sauce blanche enrichie : chauffer l'huile, ajouter la farine, cuire le roux 2 minutes sans coloration ; délayer hors du feu le lait froid mélangé au lait en poudre ; porter à ébullition en fouettant ; cuire 2 minutes ; assaisonner (muscade, poivre, peu de sel).
6. Mélanger pâtes, brocolis, poulet et sauce ; verser dans le plat ; parsemer d'emmental.
7. Gratiner au four à 200 °C pendant 10 à 15 minutes.
8. Servir aussitôt ou maintenir à 63 °C au moins jusqu'au service.

Points critiques : volaille crue (contamination croisée, cuisson complète) ; sauce au lait (attacher, grumeaux) ; maintien en température.

Version hachée (IDDSI niveau 5) : prélever 2 portions avant de gratiner ; hacher au robot coupe par impulsions courtes le poulet et les pâtes, écraser les brocolis à la fourchette ; ajouter de la sauce chaude pour obtenir un

mélange humide, sans liquide qui se sépare ; morceaux de 4 mm au plus ; parsemer de fromage qu'on fait fondre sans croûte dure ; test à la fourchette (le mélange s'écrase facilement avec une pression légère, il tient dans la fourchette sans couler). Dresser en deux zones de couleur pour garder l'envie de manger.

Question 4 – Analyse nutritionnelle et enrichissement (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion de gratin (table Ciqual 2025, document 4)

Apport = quantité (g) × teneur pour 100 g / 100.

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pâtes complètes cuites	120 g	214,8	8,82	37,56	1,68	6,12	0,07
Brocoli cuit	120 g	36,0	3,80	2,15	0,72	3,11	0,04
Poulet poêlé	56 g	79,0	16,86	0	1,12	0	0,08
Lait demi-écrémé	100 g	47,7	3,48	5,00	1,56	0	0,09
Lait en poudre écrémé	8 g	28,9	2,82	4,32	0,06	0	0,11
Farine T55	8 g	28,0	0,72	5,90	0,08	0,26	0
Huile de colza	6 g	54,0	0	0	6,00	0	0
Emmental râpé	15 g	55,2	4,14	0,09	4,23	0,01	0,10
Total d'une portion		544	40,7	55,0	15,5	9,5	0,48

Exemple de ligne : pâtes = 120 × 179 / 100 = 214,8 kcal ; poulet = 56 × 30,1 / 100 = 16,86 g de protéines.

Part de l'énergie apportée par les protéines = 40,7 × 4 / 544 × 100 = 29,9 %.

Interprétation : la portion apporte environ 544 kcal et 40,7 g de protéines ; c'est un plat complet, riche en protéines et en fibres (9,5 g), avec peu de sel apporté par les ingrédients (0,48 g, sans compter le sel de cuisson, qu'on limite pour l'aidant hypertendu). Pour l'aidante de 81 ans (52 kg), le besoin protéique est d'environ 52 × 1,0 = 52 g à 52 × 1,2 = 62,4 g par jour : la portion couvre 40,7 / 62,4 × 100 = 65,2 % à 40,7 / 52 × 100 = 78,3 % de ce besoin. Le dessert ajoute 8,2 g de protéines et 172 kcal (fromage blanc 100 g : 7,28 g ; pomme et poire : 0,31 g ; petit-beurre 8 g : 0,62 g). Les glucides (55,0 g) viennent surtout des pâtes complètes, riches en fibres : c'est adapté aux aidants diabétiques, avec une portion de féculents à garder stable d'un repas à l'autre. Remarque : avec la table Ciqual 2025, les pâtes complètes cuites sont moins hydratées que dans l'édition 2020 (179 kcal pour 100 g au lieu de 127) ; il faut donc toujours citer l'édition de la table utilisée.

Attention – Portion et appétit

Une portion de 544 kcal peut être trop volumineuse pour une personne âgée qui a peu d'appétit : on peut servir une demi-portion enrichie (un jaune d'œuf ou 10 g de fromage en plus) et fractionner avec une collation.

Techniques d'enrichissement supplémentaires : ajouter un œuf battu ou un jaune d'œuf à la sauce hors du feu ; ajouter de la poudre de lait ou du fromage râpé dans une purée ou un potage ; utiliser de la crème fraîche ou un filet d'huile dans les légumes ; proposer un dessert lacté enrichi. On enrichit sans augmenter le volume de l'assiette, car l'appétit est souvent faible.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
13 h 00 – 13 h 30	Réception et contrôle des denrées (températures, dates, état) ; rangement ; mise en place des 4 postes ; affichage de la recette	–
13 h 30 – 14 h 00	Pré-cuissons de démonstration prêtes (eau à ébullition) ; préparation de la grille de dégustation	–
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, présentation, brise-glace « mon plat de réconfort », rappel du lavage des mains	Lavage des mains, tablier, charlotte
14 h 15 – 14 h 25	Démonstration du roux et de la sauce enrichie	Observation, questions
14 h 25 – 15 h 00	Guidage des binômes	Binôme 1 : pâtes ; binôme 2 : brocolis ; binôme 3 : poulet ; binôme 4 : sauce et dessert
15 h 00 – 15 h 15	Assemblage, gratinage, préparation de la version hachée avec démonstration du test à la fourchette	Assemblage, test de texture
15 h 15 – 15 h 40	Dégustation guidée et échanges : « comment le refaire chez moi pour deux ? », congélation des portions	Dégustation, grille
15 h 40 – 16 h 00	Évaluation, remise de la fiche recette, temps d'échange sur le répit	Questionnaire de fin d'atelier
16 h 00 – 16 h 30	Remise en état, plonge, tri des déchets, gestion des restes, bilan écrit	–

Question 6 – Animation, outils pédagogiques et grille de dégustation (2 pts)

Méthodes : méthode active (les participants font), démonstrative pour les gestes techniques (roux, test IDDSI), interrogative pour partir de leurs habitudes, travail en binômes pour rompre l'isolement. Posture : écoute active, valorisation, aucune remarque sur le poids. Outils : fiche recette illustrée en grands caractères, carte « 3 techniques d'enrichissement », photo des 4 niveaux de texture, astuces « cuisiner une fois, manger deux fois » (portions congelées).

Critère	1 (pas du tout)	2	3	4 (tout à fait)
Aspect et couleurs				
Odeur				
Goût (sel, épices)				
Texture du gratin				
Texture de la version hachée				
Envie de refaire la recette				

Question 7 – Hygiène, sécurité et éco-gestes (2 pts)

Méthode des 5 M : main-d'œuvre (lavage des mains à l'arrivée, après la manipulation du poulet cru, après être allé aux toilettes ; tenue propre, cheveux couverts, pas de bijoux ; personne malade exclue de la manipulation) ; matériel (planches à code couleur, thermomètre-sonde désinfecté, plan de nettoyage) ; matières premières (contrôle à réception, respect de la chaîne du froid, dates limites, étiquettes vérifiées pour l'arachide) ; milieu (marche en avant dans le temps : légumes, puis viande crue, puis nettoyage ; plans de travail désinfectés) ; méthode (cuisson à cœur, maintien à 63 °C au moins, refroidissement rapide des restes de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures, conservation entre 0 et 3 °C, conformément à l'arrêté du 21 décembre 2009).

Allergènes : informer sur les 14 allergènes à déclaration obligatoire présents (gluten, lait) ; l'arachide n'est pas dans la recette, mais on vérifie les mentions « peut contenir » du biscuit.

Restes : les participants n'emportent pas de plat chaud resté à température ambiante ; on propose des boîtes remplies et refroidies aussitôt.

Éco-gestes : produits de saison, épluchures de brocoli utilisées (tiges émincées), cuisson couvercle posé, eau de cuisson réutilisée pour la plonge, tri des déchets, boîtes réutilisables, lave-vaisselle plein.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Critères de réussite de la réalisation (4 pts)

Pâtes fermes et non collantes ; brocolis verts et légèrement croquants ; poulet cuit à cœur et tendre ; sauce lisse, nappante, sans grumeaux ; gratin doré, sans brûlé ; version hachée humide et homogène, conforme au test IDDSI ; deux assiettes témoins dressées proprement, à bonne température ; poste propre pendant toute la production.

Question 9 – Évaluation de l'atelier et auto-évaluation (2 pts)

Évaluation : questionnaire de satisfaction à 4 niveaux ; quiz oral de 3 questions sur les objectifs (citer 2 techniques d'enrichissement, décrire le test à la fourchette, nommer les 3 composantes du plat complet) ; intention de refaire la recette ; appel ou question au début de l'atelier suivant (« l'avez-vous refaite ? »).

Auto-évaluation : respect du minutage, participation de tous les binômes, qualité des préparations, incidents d'hygiène, ajustements à prévoir (par exemple prévoir un poste assis pour un aidant fatigué).

Barème – Barème du temps 2 (C3.2)

Indicateur du référentiel	Points
Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés	2
Documents techniques rédigés et contenus argumentés (bon de commande, fiche technique, analyse nutritionnelle)	4
Techniques d'adaptation de l'alimentation standard maîtrisées (texture hachée, enrichissement)	2
Organisation de l'atelier cohérente ; méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés ; techniques de dégustation	4
Pratique des techniques culinaires et qualité organoleptique	4
Règles d'hygiène et de sécurité ; gestes éco-responsables	2
Démarche d'évaluation de l'atelier	2
Total	20

Corrigé S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier

que le jury attend

Le sujet mixte vérifie la cohérence : l'atelier du temps 2 doit découler du diagnostic et des objectifs du temps 1. Le jury attend aussi une vraie prise en compte du travail de nuit (horaires décalés pour la communication, conservation au froid des repas préparés à l'avance, caféine, rythme des repas), et non un discours général sur l'équilibre alimentaire.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs, diagnostic et limites (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 124)

Taux de réponse = 124 / 310 × 100 = 40,0 %.

- Pas de vrai repas la nuit : 68 / 124 × 100 = 54,8 %.
- Au moins un achat au distributeur par nuit : 81 / 124 × 100 = 65,3 %.
- Plus de 4 boissons caféinées par nuit : 43 / 124 × 100 = 34,7 %.
- Prise de poids déclarée depuis le passage de nuit : 57 / 124 × 100 = 46,0 %.
- Souhait d'idées de repas préparés à l'avance : 96 / 124 × 100 = 77,4 %.

IC à 95 % de la proportion « pas de vrai repas » : p = 0,548 ; erreur = 1,96 × racine carrée de (0,548 × 0,452 / 124) = 0,088 ; IC = [46,1 % ; 63,6 %].

Diagnostic : plus d'un agent de nuit sur deux ne prend pas de vrai repas ; deux sur trois achètent au distributeur des produits gras, sucrés ou salés ; un sur trois consomme beaucoup de caféine ; près d'un sur deux déclare une prise de poids. Le besoin exprimé est fort (77,4 % veulent des idées de repas). L'environnement est défavorable : restaurant fermé, offre des distributeurs pauvre. Ces constats sont cohérents avec les effets probables du travail de nuit sur le syndrome métabolique décrits par l'ANSES en 2016.

Limites : taux de réponse de 40,0 % (les agents les plus concernés ont pu répondre davantage) ; données déclaratives ; prise de poids non mesurée ; pas de groupe de comparaison avec les agents de jour.

Question 2 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des agents de nuit du centre hospitalier, en agissant sur leurs compétences et sur leur environnement alimentaire, d'ici 12 mois.
- Objectif spécifique 1 (comportement) : d'ici 12 mois, faire passer de 54,8 % à 35 % la part des agents de nuit qui ne prennent pas de vrai repas pendant leur poste.
- Objectif spécifique 2 (environnement) : d'ici 6 mois, 30 % de l'offre des distributeurs est remplacée par des produits de meilleure qualité nutritionnelle (Nutri-Score A ou B, fruits, produits laitiers nature, eau).
- Objectifs opérationnels : 10 ateliers « Ma boîte de nuit » de 10 agents sur l'année (un par mois sauf juillet et août) ; un cahier des charges des distributeurs rédigé avec le prestataire au mois 2 ; une affiche et un livret « repas de nuit » diffusés dans tous les services au mois 3 ; un réfrigérateur et un four à micro-ondes vérifiés dans chaque salle de pause.

Période	Action	Acteurs
Mois 1	Comité de pilotage : médecin du travail, DRH, cadres de nuit, représentants du personnel, diététicien, restauration	Service de santé au travail
Mois 2	Cahier des charges des distributeurs	Restauration, prestataire, acheteur
Mois 2 à 12	Ateliers culinaires mensuels	Diététicien, cuisinier du restaurant du personnel

Période	Action	Acteurs
Mois 3	Livret et affiches ; stand de nuit dans le hall à 23 h et à 4 h	Communication, service de santé au travail
Mois 6 et 12	Évaluation intermédiaire et finale	Comité de pilotage

Budget indicatif sur 2 500 € : denrées des ateliers 10 × 10 agents × 3,50 € = 350 € ; boîtes réutilisables 100 × 4,00 € = 400 € ; livret et affiches 600 € ; petit matériel des salles de pause 700 € ; temps de stand de nuit et goûters de lancement 300 € ; réserve 150 €. Total = 350 + 400 + 600 + 700 + 300 + 150 = 2 500 €.

Question 3 – Communication et évaluation (4 pts)

Communication adaptée aux horaires décalés : relais par les cadres de nuit pendant les transmissions ; affiches dans les salles de pause ; message sur l'intranet et la messagerie professionnelle ; stand tenu la nuit, et non seulement en journée ; inscription aux ateliers possible par téléphone ou formulaire papier ; atelier placé en début d'après-midi un jour de repos, rémunéré comme temps de formation si l'établissement l'accepte.

Évaluation : processus (nombre d'ateliers réalisés, nombre de participants, part de l'offre des distributeurs modifiée, ventes des nouveaux produits fournies par le prestataire) ; résultats (même questionnaire à 6 et 12 mois : part des agents qui prennent un repas, consommation de caféine, achats au distributeur) ; satisfaction (questionnaire en fin d'atelier) ; impact à plus long terme (données de la visite d'information et de prévention, sans transmission de données individuelles hors du service de santé au travail).

Question 4 – Revue de la littérature (3 pts)

- Question : quelles interventions nutritionnelles améliorent l'alimentation et la santé métabolique des travailleurs de nuit ?
- Équation de recherche en anglais : ("night work" OR "shift work" OR "night shift") AND (diet OR nutrition OR "meal timing" OR "eating behavior") AND (intervention OR program) ; en français : « travail de nuit » ET (alimentation OU nutrition).
- Bases : PubMed (MEDLINE), Cochrane Library, Google Scholar pour la littérature grise, sites de l'ANSES, de l'INRS et de Santé publique France.
- Critères d'inclusion : publications de moins de 10 ans, adultes travailleurs de nuit, études d'intervention ou revues systématiques, langues française et anglaise ; exclusion : études animales, travailleurs de jour seuls.
- Lecture : sélection sur titre, puis résumé, puis texte complet ; tableau de synthèse (auteur, année, pays, type d'étude, population, intervention, résultats, niveau de preuve) ; références selon une norme unique (Vancouver ou APA).

Question 5 – Éthique et sécurité numérique (2 pts)

Questionnaire de santé au travail : participation libre, information sur le but et l'usage des réponses, anonymat réel (aucun recoupement possible entre service, âge et sexe dans un petit service), données de santé hébergées sur un outil validé par le délégué à la protection des données de l'établissement et non sur un outil grand public, accès réservé au service de santé au travail, durée de conservation fixée, résultats présentés seulement de façon globale. Côté sécurité : lien envoyé par la messagerie professionnelle, jamais de mot de passe demandé, vigilance contre l'hameçonnage (un faux questionnaire peut imiter l'enquête), poste verrouillé, export des données sur un espace sécurisé.

Temps 2

Question 7 – Besoins, objectifs et choix des préparations (3 pts)

Besoins : un repas de nuit facile, rassasiant sans être lourd, qui se garde au réfrigérateur et se mange froid ou réchauffé en quelques minutes ; un en-cas de fin de nuit qui évite le distributeur ; réduire la caféine dans la seconde moitié du poste pour préserver le sommeil de récupération.

Objectifs de l'atelier : à la fin, chaque participant sait préparer à l'avance une salade-repas complète en moins de 20 minutes, sait la conserver en sécurité, et sait réaliser un en-cas maison.

Choix : la salade de lentilles associe un féculent riche en fibres et en protéines végétales, un légume et un œuf ; elle tient bien au corps, se conserve et coûte peu. Le houmous avec bâtonnets de légumes est un en-cas riche en fibres, qui se garde au froid et remplace les chips du distributeur.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique et analyse nutritionnelle (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande de la salade-repas (10 portions)

- Lentilles vertes sèches : 60 × 10 = 600 g ; coût = 0,600 × 3,60 = 2,16 €.
- Carottes : net = 80 × 10 = 800 g ; brut = 800 / (1 − 0,15) = 800 / 0,85 = 941 g ; coût = 0,941 × 1,40 = 1,32 €.
- Œufs : 10 œufs × 0,30 = 3,00 €.
- Huile de colza : 10 × 10 = 100 g = 100 / 920 = 0,109 L ; coût = 0,109 × 3,20 = 0,35 €.
- Forfait assaisonnement : 1,00 €.

Total = 2,16 + 1,32 + 3,00 + 0,35 + 1,00 = 7,83 € ; soit 0,78 € par portion. Il reste 3,50 − 0,78 = 2,72 € par participant pour le houmous et les bâtonnets.

Modèle à recopier – Fiche technique – Salade-repas en bocal (10 portions)

1. Trier et rincer les lentilles ; les cuire départ eau froide, sans sel, 20 à 25 minutes à frémissement ; saler en fin de cuisson ; égoutter.
2. Cuire les œufs 10 minutes à l'eau bouillante ; refroidir aussitôt à l'eau froide ; écaler ; couper en quartiers.
3. Laver, éplucher et râper les carottes sur un poste réservé aux légumes.
4. Vinaigrette : moutarde, vinaigre, échalote ciselée, huile de colza, persil.
5. Refroidir les lentilles en cellule de refroidissement rapide (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures).
6. Montage en bocal, du bas vers le haut : vinaigrette, lentilles, carottes, œuf ; fermer ; étiqueter (nom, date de fabrication, date limite).
7. Conserver entre 0 et 4 °C ; consommer dans les 48 heures ; transport en sac isotherme avec pain de glace ; mettre au réfrigérateur du service dès l'arrivée ; mélanger au moment de manger.

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

- Lentilles vertes cuites 150 g : énergie 150 × 125 / 100 = 187,5 kcal ; protéines 15,15 g ; fibres 12,68 g.
- Carottes 80 g : 24,2 kcal ; protéines 0,62 g ; fibres 2,32 g.
- Œuf dur 50 g : 67,0 kcal ; protéines 6,75 g ; fibres 0 g.
- Huile de colza 10 g : 90,0 kcal ; protéines 0 g ; fibres 0 g.

Total : 369 kcal ; 22,5 g de protéines ; 15,0 g de fibres.

Interprétation : la salade apporte un repas de nuit modéré en énergie (369 kcal, à compléter par du pain et un fruit ou un laitage selon la faim), riche en protéines (22,5 g) et très riche en fibres (15,0 g, soit 15,0 / 30 × 100 = 50,0 %, la moitié des 30 g par jour conseillés pour un adulte par l'ANSES). L'huile de colza apporte des acides gras oméga 3. Les fibres et les protéines prolongent la satiété, ce qui aide à éviter le distributeur.

Question 9 – Déroulé, animation et dégustation (4 pts)

Durée	Contenu	Méthode
10 min	Accueil, tour de table « ma nuit type et ce que je mange »	Interrogative, photolangage
10 min	Repères : rythme des repas en horaires décalés, caféine, hydratation, conservation	Exposé court et interactif
40 min	Réalisation en 5 binômes : lentilles, œufs, carottes, vinaigrette, houmous	Active, démonstration de la cuisson et du montage

Durée	Contenu	Méthode
15 min	Dégustation guidée et comparaison avec un produit de distributeur	Grille de dégustation, comparaison de l'étiquette
15 min	Évaluation, remise du livret, chaque agent repart avec son bocal refroidi	Questionnaire, engagement « ce que je refais cette semaine »

Grille de dégustation : aspect, couleur, odeur, goût, texture des lentilles (fondantes, non éclatées), assaisonnement, satiété ressentie, envie de refaire, notés de 1 à 4.

Question 10 – Hygiène et éco-gestes (4 pts)

Hygiène : lavage des mains et tenue ; marche en avant dans le temps (légumes terreux lavés avant le reste) ; œufs manipulés à part, mains lavées après ; refroidissement rapide des préparations cuites (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures, arrêté du 21 décembre 2009) ; conservation à 4 °C au plus ; bocaux propres et étiquetés ; consommation dans les 48 heures ; réchauffage éventuel d'un plat chaud à cœur, une seule fois ; ne jamais laisser le repas à température ambiante pendant la nuit dans le vestiaire. Allergènes à signaler : œuf, moutarde, sésame (tahin du houmous).

Éco-gestes : légumineuses (protéines végétales, faible impact climatique, en cohérence avec la SNANC), bocaux et boîtes réutilisables, légumes de saison, épluchures compostées, eau de cuisson des pois chiches (aquafaba) valorisée, lave-vaisselle plein.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Critères de réussite : lentilles cuites mais entières ; œufs durs sans cercle vert (pas trop cuits) ; carottes râpées fines et fraîches ; vinaigrette émulsionnée ; houmous lisse, bien assaisonné ; bocaux propres, bien montés et étiquetés ; refroidissement contrôlé et noté. Évaluation de l'atelier : satisfaction, quiz de 3 questions (durée de conservation, température du réfrigérateur, deux alternatives au distributeur), intention de refaire, nombre de bocaux préparés à la maison déclaré lors de l'atelier suivant.

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : diagnostic 4 ; objectifs et plan d'action 5 ; communication et évaluation 4 ; recherche bibliographique 3 ; éthique et sécurité numérique 2 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et objectifs 3 ; documents techniques et calculs 5 ; organisation, animation et dégustation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Qualifier une action (mode, niveau de prévention, approche, politiques)	S1, S3			
C3.1	Calculer et interpréter les indicateurs d'un diagnostic ; classer les besoins (Bradshaw)	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance	S1, S3			
C3.1	Construire un budget et un calendrier réalistes	S1, S3			
C3.1	Construire une évaluation de processus, de résultats et d'impact	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes	S2, S3			
C3.2	Rédiger une fiche technique avec points critiques	S2, S3			
C3.2	Calculer un apport nutritionnel avec la table Ciqual	S2, S3			
C3.2	Adapter une texture (IDDSI) et enrichir un plat	S2			
C3.2	Organiser et animer un atelier minuté ; mener une dégustation	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (5 M, températures, allergènes) et les éco-gestes	S2, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon ; repérer les biais	S1, S3			
C3.3	Construire une équation de recherche bibliographique	S3			
C3.4	Organiser une veille et la diffuser	S1			
C3.5	Adapter la communication au public (littératie, précarité numérique, horaires)	S1, S3			
C3.6	Protéger les données et l'image des personnes ; repérer les risques numériques	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B (devoir 2) pour l'enrichissement et le calcul nutritionnel ; E5.A 2023 pour l'analyse des risques par les 5 M. Les contextes de ces sujets (centre maternel, EHPAD, enfants cœliaques, etc.) ne sont pas repris.